



الجمهورية العربية السورية
وزارة الصحة
المعهد التقاني الصحي بدمشق

صحة الفرد والمجتمع

الطبعة الثانية



تأليف

الدكتور حسان علي

أستاذ في قسم الصحة العامة

8	مقدمة عامة
9	مفهوم صحة الفرد والمجتمع:
9	دور الفرد والمجتمع في تعزيز الصحة العامة:
10	تعزيز الصحة الفردية والمجتمعية:
10	مفهوم الصحة:
11	مفهوم الصحة الجيدة:
11	مفهوم المرض:
11	أنواع الأمراض:
11	طرق انتقال العدوى:
11	المشاكل الصحية الشائعة في القطر العربي السوري:
12	الخدمات الصحية في القطر العربي السوري:
12	برنامج التلقيح الوطني:
13	الصحة الإنجابية:
13	تعزيز صحة المراهقين:
14	برنامج الترصد التغذوي:
14	برنامج القرى الصحية:
14	برنامج تعزيز الصحة ومكافحة التدخين:
15	برنامج الزيارات المنزلية:
15	طب الأسرة:
16	التغذية والغذاء
17	مقدمة:
17	أنواع المغذيات:
22	إرشادات للتغذية الصحية:
22	التوصيات الرئيسية:
23	الوجبة الغذائية اليومية:
24	مشعرات التغذية:
24	مشعر كتلة الجسم (BMI):
25	التقييم العالمي الموضوعي (SGA):
25	لجنة الإجماع الدولية للمبادئ التوجيهية (ICGC):
26	بيان إجماع أكاديمية التغذية وعلم التغذية والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والتغذية المعوية:
26	بيان إجماع الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (ESPEN):
27	مبادرة القيادة العالمية بشأن سوء التغذية (GLIM):
27	سوء التغذية:
29	العمل والإعفاء
30	مقدمة:
30	أعراض توقف الميتوكوندريا:

31	الإرهاق الوظيفي (الاحتراق الوظيفي):
31	أسباب الاحتراق الوظيفي:
31	أعراض الاحتراق الوظيفي:
32	مراحل الاحتراق الوظيفي:
33	التخلص من الاحتراق الوظيفي:
33	الاستراحة والنوم:
34	مراحل النوم:
35	نصائح إيجاد وقت للنوم:
36	الاضطرابات المتعلقة بالنوم:
39	النظافة الفردية
40	كيفية الحفاظ على نظافة الجسم:
40	المزايا المكتسبة إذا كان لديك جسم نظيف:
40	كيفية الاستحمام للجسم:
41	روتين الاستحمام:
41	كيفية العناية بالجلد:
41	المزايا المكتسبة إذا كان لديك عناية بالجلد:
41	كيفية الحصول على بشرة جميلة:
43	كيفية العناية بالشعر:
43	المزايا المكتسبة إذا كان لديك شعر مُهندم:
43	كيفية الحصول على شعر نظيف والحفاظ عليه:
45	كيفية الحفاظ على نظافة الفم:
45	المزايا المكتسبة من العناية الجيدة بالأسنان والفم:
46	كيفية العناية بالأسنان والفم:
48	صحة الأجهزة والحواس
48	1
49	صحة جهاز التنفس:
49	الجهاز التنفسي:
49	جهاز الصوت:
49	القصبات الهوائية:
49	التنفس:
50	حماية جهاز التنفس:
51	استخدام معدات الوقاية الشخصية في الرعاية الصحية:
52	أنواع معدات الحماية الشخصية:
52	أمراض الجهاز التنفسي:
53	حماية الجهاز التنفسي:
54	صحة جهاز الهضم – صحة الفم:

54	جهاز الهضم:
55	أمراض الجهاز الهضمي:
57	حماية الجهاز الهضمي:
58	بعض النصائح للمساعدة في تحسين عملية الهضم:
58	النشاطات البدنية:
59	صحة الأجهزة والحواس
59	2
60	الهيكل العظمي:
60	مكونات العظام:
60	الخلايا العظمية:
61	أمراض العظام:
62	طرق الحفاظ على صحة الهيكل العظمي:
62	جهاز الدوران والقلب:
63	العوامل المؤثرة على الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية:
64	من العوامل المساهمة أخرى:
65	أمراض القلب والأوعية:
66	الحفاظ على صحة جهاز الدوران:
68	صحة الأجهزة والحواس
68	3
69	الجهاز البولي:
69	الكلى:
69	الغدة الكظرية:
69	الحالب:
69	المثانة:
69	الإحليل:
70	أمراض الجهاز البولي:
70	التهاب المسالك البولية (UTIs):
70	حصاة الكلى:
70	احتباس البول:
70	تضخم البروستات الحميد:
71	مشاكل التحكم في المثانة والتبول اللاإرادي عند الأطفال:
71	الحفاظ على صحة الجهاز البولي:
72	صحة الحواس (العين والأذن):
72	العين:
72	الحفاظ على صحة العين:
72	الأذن:

73	الوقاية من فقدان السمع:
74	الصحة العقلية
75	الصحة العقلية وعلاقتها بالصحة العامة:
76	تصنيف الاضطرابات العقلية:
77	أنواع مخططات التصنيف:
77	ICD-10:
78	DSM-IV:
79	تصنيفات أخرى:
79	الاضطرابات العقلية:
81	وبائيات الأمراض العقلية:
81	الحفاظ على الصحة العقلية:
82	التربية الصحية
83	مقدمة:
83	اعتقادات الإنسان الأولية عن الصحة والمرض:
83	التراث الاجتماعي والقيم الاجتماعية وعلاقتها بمفهوم الصحة والمرض:
84	تعريف التربية الصحية وأهدافها:
85	تعريف الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية:
86	صحة الإنسان:
86	النمو الجسدي والعقلي والاجتماعي:
87	أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان:
92	المحافظة على صحة الإنسان:
93	وسائل التربية الصحية:
93	دور المؤسسات العامة والخاصة في التثقيف الصحي:
93	دور الإعلام في التثقيف الصحي:
94	دور المشافي في التثقيف الصحي:
94	دور المثقف الصحي ومواصفاته:
96	صحة البيئة
97	مقدمة:
97	البيئة وأنواعها:
98	الأسباب التي أدت إلى وجود التحديات البيئية:
98	التلوث وأنواعه:
98	طرق التخلص والوقاية من التلوث الهوائي:
99	طرق مواجهة نقص المياه:
99	صحة الغذاء:
100	إرشادات غذائية للتقليل والسيطرة على الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية:
100	صحة السكن:
101	مفهوم السكن غير اللائق:

101	 معايير السكن اللائق:
102	 تأثير السكن غير اللائق على الصحة العامة:
103	 التخلص من الفضلات والنفايات والقمامة:
103	 المخلفات:
104	 النفايات:
105	 الإدارة المستدامة للمخلفات والنفايات:
106	 الوقاية من الأمراض:
107	 الوقاية من الأمراض الإنتانية:
107	 الكوليرا:
107	 شلل الأطفال:
108	 الحصبة:
109	 مرض المكورات السحائية:
109	 التهاب الدماغ الياباني:
110	 الخناق (الدفتيريا):
110	 التهاب الكبد الوبائي أ:
111	 الوقاية من الأمراض الغير إنتانية:
111	 عوامل الخطر ومحدداته:
112	 خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية:
115	 الرعاية الصحية الأولية:
116	 مفهوم الرعاية الصحية الأولية:
117	 مكونات خدمات الرعاية الصحية:
117	 عناصر الرعاية الصحية الأولية:
118	 مبادئ الرعاية الصحية الأولية (PHC):
118	 المؤشرات الصحية الأساسية:
118	 خصائص المؤشرات:
119	 أنواع المؤشرات:
120	 الفريق الصحي:
121	 خصائص الفريق الصحي:
121	 الصفاة القيادية:
122	 رعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة:
123	 مقدمة:
123	 المفاهيم الأساسية لتمريض صحة الأم والوليد والمرأة:
123	 الرعاية المُركزة على الأسرة:
124	 اضطرابات الدورة الشهرية:
124	 انقطاع الطمث:
125	 عسر الطمث:
125	 نزيف الرحم غير الطبيعي:

126	الحمل:
126	إرشادات للرعاية ما قبل الحمل:
127	آلام الحمل:
128	عملية المخاض والولادة:
128	مرحلة حديثي الولادة:
128	الانتقال الفيزيولوجي:
128	توفير الرعاية العامة لحديثي الولادة:
130	الصحة المدرسية:
131	تعريف الصحة المدرسية:
131	أهمية الصحة المدرسية:
131	أهداف الصحة المدرسية:
132	مكونات الصحة المدرسية:
132	تنظيمات الصحة المدرسية في القطر العربي السوري:
134	البناء المدرسي:
138	صحة الطالب في المدرسة:
139	الوقاية من الأمراض التي تشاهد في المدارس:
140	العيادة الطبية المدرسية:
140	عمل الطبيب والمساعد الصحي في الصحة المدرسية:
141	دور المطعم في الصحة المدرسية:
143	الصحة الريفية:
144	مقدمة:
144	تفسيرات الريف:
144	المجتمعات الريفية:
145	صحة سكان الريف:
145	توفير الرعاية الصحية الريفية:
146	المجتمعات الريفية والتثقيف الصحي:
147	الصحة المهنية:
148	مقدمة:
148	القوانين واللوائح:
148	مدونات الممارسات المعتمدة:
149	ملاحظات إرشادية:
149	القانون المدني:
149	الواجبات العامة لأصحاب العمل:
150	الواجبات العامة للأشخاص المسؤولين عن إدارة المباني:
150	عمليات تفتيش الصحة والسلامة:
151	إدارة إجراءات التنفيذ:
152	الشيخوخة ورعاية المسنين:

153		مقدمة:
153		التقييم الشامل للشيخوخة:
153		التقييم الوظيفي:
154		التقييم الطبي:
154		التقييم الاجتماعي:
154		التقييم الروحي:
154		المشاكل الصحية الشائعة لدى كبار السن:
154		الحركة والسقوط:
154		الإدراك:
154		الاكتئاب:
155		ضعف البصر:
155		ضعف السمع:
155		إساءة معاملة كبار السن:
155		السلامة أثناء القيادة:
155		الحفاظ على نمط حياة صحي:
155		النشاط البدني بالنسبة لكبار السن:
156		التغذية:
156		تعاطي الكحول:
156		الإقلاع عن التدخين:
156		الأمراض المنقولة جنسياً:
157		المراجع:

مقدمة عامة

مفهوم صحة الفرد والمجتمع:

يعد الفرد هو أساس البناء..... كل بناء أو منظومة تكون من ذرات ووحدات مستقلة، تسخر طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق الجمال والكمال وبالتالي فإن التكامل مع الذرات والوحدات الأخرى في جزيئة أو مركب أو منظومة أو بناء أو مجتمع أو مؤسسة قائم على التناسق والتعاون والاتفاق، فالأولوية في أي بناء هي الفرد وليس الجماعة فقط.

إن الذات المبدعة والعقل المبدع والنفس المبدعة هي المؤسسة للفكر والنظرة والقيم التي تتلقفها الجماعة، كسلع جاهزة للاستعمال أو الاستثمار للحصول على منافع جديدة. فكل مفردة أو ذرة أو جزيئة في الحياة الراهنة، هي في الأصل ثمرة جهد فردي وفكر فردي ومعاناة نفس فردية ونبوءة فرد. وكثير من تلك الأفكار والمعالم لقيت من الاستهجان والسخرية الكثير قبل إدراك منافعها والاعتراف بفضائلها على سابقتها.

التطور أو الحياة الإنسانية قادرة على التجدد والازدهار بقدر تمتع الفرد في ممارسة حياته الشخصية واستثمار طاقاته وإمكاناته الفردية المتنوعة، لخدمة المجرى العام للتطور والإنسانية وهنا تكمن أهمية الإنسان.

الفرد: هو أي شيء محدد، يشكل كينونة مستقلة بحد ذاتها، أي أنه غير قابل للانقسام والتجزئة، فيعامل ككل واحد. وبحسب المفهوم الشائع بين الناس فإن لفظة فرد التي مجموعها أفراد تشير إلى الأشخاص، ويشكل مجموع الأفراد نواة المجتمع.

الأسرة: تعرف على أنها هي المجموعة الأساسية في المجتمع، وهي رابطة اجتماعية تتكون من الأب والأم والأبناء.

المجتمع: يطلق بشكل عام على المجموعة من الأفراد الذين تربطهم روابط واحدة، تثبتتها الأوضاع والمؤسسات الاجتماعية ويكفلها القانون أو الرأي العام بحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفها أو ينحرف عنها وإلا عرض نفسه للعقاب أو السخط أو اللوم وقد يصل إلى حد الاستبعاد. ويطلق لفظ المجتمعات على المجموعات في الأسرة أو القرية أو القبيلة أو المدينة، فهناك المجتمع القروي أو القبلي أو المدني أو الصناعي أو الزراعي أو الطلابي.

لكل مجتمع من المجتمعات ظواهر عامة مشتركة بين جميع أفراده، وهي لا تميل إلى الظواهر النفسية الفردية، لأن الاجتماع يولد في نفوس الأفراد حوافز جديدة من الشعور والتفكير والإرادة يمكن أن يطلق عليها اسم الوعي الاجتماعي أو قد يولد عكس ذلك بما يسمى القهر الاجتماعي وعليه فإن الأفراد مسؤولون كمسؤولية المجتمع عن كل ما يحدث فيه.

دور الفرد والمجتمع في تعزيز الصحة العامة:

يساهم كل شخص وكل أسرة في المحافظة على صحة المجتمع وتعزيزها بإتباع العادات الحسنة والسلوك الصحي الجيد وما يقوم به الفرد ينعكس على المجتمع والعكس بالعكس وما يربطهما ببعضهما البعض هو العامل الصحي والبيئي.

تعزيز الصحة الفردية والمجتمعية:

- ممارسة السلوك الصحي السليم وترك العادات السيئة.
- اتباع طرق الوقاية من الأمراض وأخذ اللقاحات والاهتمام بالنظافة الشخصية والاهتمام بالمأكل والملبس والمنزل ونظافة الشارع والحي والبيئة والمجتمع.
- الكشف المبكر عن الأمراض كي لا تتطور لحالات أشد (جائحة أو وباء).

● عناصر الصحة البدنية:

- التغذية: يدعم الغذاء المتكامل المتوازن جسم الإنسان بالمواد الغذائية التي تساعد على البناء والنمو والحفاظ على الصحة. حيث تصنف إلى خمس مجموعات إضافة إلى الماء. وهذه المجموعات هي: السكريات - الدهون - البروتينات - الفيتامينات - المعادن.
- الرياضة البدنية: تعمل على بقاء الجسم صحيحا وسليما، وتقوية عضلات الجسم، وتحسين عضلة القلب والعقل والتنفس والهضم والحركة والرياضة تمنع المشاكل البدنية وتخفف من الانفعالات.
- الراحة والنوم: الراحة تقلل التعب وتزيد من النشاط والحيوية والقوة. فالكبار يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من الأطفال وبالتالي فإن قلة النوم تؤدي إلى مشاكل بدنية ونفسية.
- النظافة الشخصية: تساعد النظافة على منع البكتيريا والأمراض الجلدية على الجلد كما أن الاعتناء بالأسنان وتنظيفها يوميا بالفرشاة والمعجون والعناية بالثة يعتبر أمرا مهما للحفاظ على صحة الجسم.

● عناصر الصحة العقلية:

- النمو الانفعالي: تتأثر صحة الإنسان العقلية بالخبرات التي تحدث في حياة الشخص في الصغر وبالمواقف والتجارب السعيدة والحزينة.
- التصرف مع الضغوط النفسية: لا يمكن للإنسان الابتعاد عن الضغط النفسي ولمساعدة الإنسان على التعامل مع الضغوط يجب القيام بالتمارين الرياضية، والنوم لمدة مناسبة، والجري والراحة والمشي والتأمل والتدبر والاسترخاء والانشغال.
- العلاقات الاجتماعية: تتأثر الصحة العقلية بالعلاقات الاجتماعية للإنسان، وتمنح العلاقات الشخصية الحميمة مع الأصدقاء والأقارب فرصا كبيرة للانفعال والدعم والشجاعة والتحدي والمشاركة والنجاح والعطاء والمساهمة في شؤون الحياة المختلفة.

إن الصحة مهمة للإنسان حيث يجب الاهتمام بها عن طريق الرياضة التي تجعل القلب والرئة والعظام والأربطة سالمة ودائمة النشاط والقوة. والحفاظ على الصحة تزيد من مرونة الجسم والتحكم في وزن الجسم وتساعد الجسم على الصبر والتحمل.

مفهوم الصحة:

هي حالة من السلامة الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية للفرد تمكنه أن يكون فردا منتجا في المجتمع أي ليس من الضروري أن تعني الصحة غياب المرض أو العجز فبعض الأفراد المنتجين والمبدعين والنافعين في المجتمع يمكن أن يكونوا مصابين بمرض أو إعاقة ما.

مفهوم الصحة الجيدة:

لكي ندرك مفهوم الصحة الجيدة يجب أن ندرك أهمية مشاركة الجوانب المختلفة لدى كل فرد للوصول إلى الهدف وهذه الجوانب هي:

1. الجانب الجسدي: وهو الشكل الملموس للجسم والحواس الخمسة التي تجعلنا نلمس، نسمع، نشم، نرى، نتذوق وذلك يتطلب تغذية جيدة، وزن مناسب، تمارين هادفة، راحة كافية.
2. الجانب النفسي: هو مجموعة العواطف والمشاعر المختلفة مثل الشعور بالخوف والغضب والحب والفرح.
3. الجانب العقلي: الأفكار، المعرفة، التصرفات، المعتقدات، التحليل النفسي حيث يجب أن تكون لك آرائك وأفكارك الخاصة بك والنظر للنفس بنظرة إيجابية.
4. الجانب الذاتي: له علاقة بالنفس، الإبداع، الهدف في الحياة. كلها تحتاج إلى هدوء داخلي، الانفتاح على الإبداع والثقة في المعرفة الداخلية.

من كل ما سبق نجد أن هذه الجوانب ترتبط ببعضها البعض وبشكل وثيق. مثال: إذا التزمت الفراش بسبب ألم تعاني منه في الظهر (جسدي) يمكن أن يؤدي إلى حالة من الإحباط (نفسية). أو إذا تجاهلت حالة غضبك من شيء ما (نفسية) يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالصداع (جسدي).

مفهوم المرض:

هو خلل يصيب وظائف معينة من الجسم بسبب عامل ممرض (جراثيم – طفيليات – فيروسات) أو بسبب تبدلات غير طبيعية في أعضاء الجسم وأنسجته بأسباب معروفة متعلقة بالوراثة أو بشكل الغذاء أو المهنة أو البيئة المحيطة.

أنواع الأمراض:

- أمراض معدية: تسببها الجراثيم والفيروسات والطفيليات تسبب علامات وأعراض معينة (صداع – حرارة – مغص وإسهال) وتسبب العدوى.
- الأمراض غير المعدية: (السكري – الضغط – الأورام – الحوادث) لا تسببها الأحياء الدقيقة الأخرى وتتعلق بأسباب وراثية أو سلوكيات ونمط حياتهم وعاداتهم وغذائهم.

طرق انتقال العدوى:

- عبر الطريق التنفسي.
- عبر الطريق الهضمي.
- عبر التماس المباشر.
- عبر الطريق التناسلي.
- عن طريق المشيمة.
- عن طريق الدم.

المشاكل الصحية الشائعة في القطر العربي السوري:

على الرغم من الأهمية الكبيرة لتوفير الخدمات الصحية للأمراض غير المعدية، تم العثور على مقالات وموارد بحثية محدودة للغاية تغطي هذه القضية. نشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) تقريراً في عام 2016 بشأن انتشار الأمراض غير المعدية بين السكان الذين يعيشون داخل سوريا. وكانت لأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى نسبة من الأمراض غير المعدية مع ما يقرب من 25% من جميع الحالات، 9% كانت سرطانات، 2% أمراض تنفسية مزمنة، 1% داء السكري، 5% مصابات بأمراض معدية أو في الفترة

المحيطة بالولادة والتغذية، و8٪ للأمراض غير المعدية الأخرى، في حين بلغت نسبة الإصابات المرتبطة بالحرب نسبة عالية جدًا بلغت حوالي 50٪.

أوجدت الحرب السورية الظروف المثالية لانتشار وتفشي الأمراض المعدية والقابلة للعلاج، وانقطاع برنامج التطعيم، وتدمير البنية التحتية الصحية، وهجرة العاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب الحركة الجماعية للاجئين إلى دول أخرى. والعيش بدون ظروف صحية مناسبة في مخيمات اللاجئين حيث توجد أسباب مهمة لأوبئة العدوى مثل السل وداء الليشمانيات وشلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى، بين اللاجئين وداخل المجتمعات المضيفة.

نظرًا لأن شلل الأطفال ينتعش في ظروف غير صحية ومزدحمة وبين الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فقد تم إعلان حالة طوارئ صحية عامة في سوريا، مما يتطلب جهودًا وتضامنًا دوليًا لمنع تفشي وباء عالمي.

الرقم	المرض	التكرار	نسبة المرض %
1	امراض الجهاز الهضمي	71609	14.0
2	أذيات التسمم	70210	13.7
3	أمراض الجهاز التنفسي	62873	12.3
4	أمراض الجهاز الدوراني	54433	10.6
5	اعراض وعلامات أخرى	43917	8.6
6	أمراض الجهاز البولي	36074	7.0
7	امراض الدم والأعضاء المكونة له	23098	4.5
8	الأورام (الخبينة والحميدة)	22514	4.4
9	مسببات خارجية للمرض والوفاة	20995	4.1
9	أمراض العين وملحقاتها	18103	3.5
10	حالات خاصة تبدأ في فترة الولادة	17191	3.4
11	باقي الأمراض الأخرى	70956	13.9
	المجموع	511973	100.0

الخدمات الصحية في القطر العربي السوري:

برنامج التلقيح الوطني:

يشمل التلقيح الوطني في سورية كافة الأطفال في الحضر والريف والبادية فهو يهدف إلى إنقاص معدلات المرض والوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات من العمر من خلال التلقيح المنهجي للأطفال باللقاحات التي تحميهم من الأمراض التالية:

- مرض شلل الأطفال.
- مرض السل.
- مرض الكزاز.
- مرض الحصبة.

- مرض الحصبة الألمانية.
- مرض الدفتريا.
- مرض النكاف.
- بعض انواع التهاب السحايا.
- مرض السعال الديكي.
- بعض التهاب الكبد البائي.
- الأمراض التي تسببها المستدمية النزلية (ذات الرئة-انتان الدم -التهاب الأذن الوسطى).

وبذلك يكون مجموع اللقاحات المعتمدة في برنامج التلقيح الوطني في سورية أحد عشر لقاحاً.

تسعى وزارة الصحة إلى تأمين أفضل اللقاحات الموجودة في العالم وتوفيرها في جميع المراكز الصحية في المحافظات والفرق الجواله وبشكل مجاني ولجميع المواطنين. وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى بعض الأطفال غير الملقحين وكذلك القضاء على الأمراض المستهدفة واستئصالها.

الصحة الإنجابية:

هي حالة من الرفاه والسلامة جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً في كافة الأمور المتعلقة بعملية الإنجاب وأجهزتها ووظائفها وليس مجرد غياب الأمراض والإعاقة المرتبطة بها. وتعد جزءاً من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب ويتم تقديم الرعاية الصحية للمرأة خلال فترة حياتها كاملة وليس فقط فترة الإنجاب.

أهداف برنامج الصحة الإنجابية:

- خفض معدل وفيات الأمومة إلى 45 / 100 ألف ولادة حية.
- خفض معدل وفيات الرضع إلى 16/1000 ولادة حية.
- زيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين الأزواج إلى 60%.
- خفض معدل المراضة لدى السيدات ولاسيما في سن الإنجاب.
- المحافظة على المعدل الحالي لانتشار متلازمة عوز المناعة المكتسب والمقدر 7/100 ألف من السكان.

تعزير صحة المراهقين:

يشكل المراهقون شريحة مهمة من حيث العدد والانتماء إلى كل فئة من فئات المجتمع، ومن حيث كونهم آباء الغد وأمهات المستقبل فهم جيل المستقبل وبناء حضارة مجتمع مبدع ومتجدد باستمرار، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة منذ الآن يسهم في جعلهم أشخاص أسوياء وأصحاء. والمراهقة مرحلة نمو شامل ينتقل خلالها الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد.

حددت الفئة العمرية للمراهقين ما بين (10 – 19 سنة) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية والتي تشكل حوالي (25 %) من مجموع السكان.

يتداخل على هذه الشريحة الآباء والأمهات والكثير من الأقارب ومن الضروري العمل على تثقيف هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع. ونظراً إلى حاجتهم الملحة إلى التزود والتوجيه بالمعلومات والمهارات من

أجل تبني سلوك صحيح يعينهم في المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار قدرتهم على تفهم واقع المجتمع وفق معايير الثقافة والاجتماعية والأخلاقية بما فيها من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ وتعاطف وتعاون وتكافل، وبناء على هذا الأساس تم وضع إستراتيجية خاصة لتعزيز صحة المراهقين في وزارة الصحة.

برنامج الترصد التغذوي:

يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية للأطفال دون الخمس سنوات والوقاية منه ويشمل البرنامج أخذ قياسات الوزن والطول وقياس محيط منتصف العضد (MUAC) وكذلك تحري الودمة وأخذ معلومات عن الرضاعة الطبيعية وجرعات فيتامين (أ) والإحالة إلى مراكز التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد أو المشافي.

كما يتم توزيع المنتجات الوقائية من سوء التغذية مثل زبدة الفستق الوقائية وظروف الفيتامينات والبسكويت عالي الطاقة.

تبذل وزارة الصحة مديرية الرعاية الصحية – دائرة التغذية جهود حثيثة للتغلب على ظروف الأزمة وعدم ارتفاع معدلات انتشار سوء التغذية من خلال اعتماد برنامج التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد (CMAM) حيث تتم معالجة المصابين بزبدة الفستق العلاجية والتكميلية وإحداث قسم في المشفى الوطني في كل محافظة مجهز ومدرّب على تدبير سوء التغذية الحاد الشديد والمختلط.

برنامج القرى الصحية:

برنامج مجتمعي تنموي وقائي تشاركي يديره المجتمع ويموله جزئيا من أجل تحسين أوضاعه الصحية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أهدافه:

- زيادة الوعي داخل المجتمع فيما يتعلق بالصحة والاحتياجات التنموية.
- تدريب المجتمع وتأهيله لوضع أولوياته من خلال التعرف على واقعه، وممارسة الإدارة الذاتية بشكل منهجي.
- حماية وتعزيز الصحة للمجموعات عالية الخطورة (النساء والأطفال).
- تعزيز المفهوم التنموي عن طريق التخطيط من القاعدة إلى القمة (قلب الهرم التنموي بالاعتماد على الدور القيادي للمجتمع).

برنامج تعزيز الصحة ومكافحة التدخين:

بدأ البرنامج في السنوات الماضية بالتركيز على نشر الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والتي تشمل: التغذية الملائمة وأهمية الرياضة ومخاطر التدخين على الصحة، إضافة إلى نشر الوعي الصحي في الجوانب الأخرى ضمن خدمات الرعاية الصحية ومنها صحة الطفل والصحة الإنجابية وصحة الكبار واليافعين وصحة البيئة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والصحة المهنية والصحة النفسية وغيرها. وذلك بالتعاون مع الخدمات الصحية للرعاية وشملت الأنشطة التثقيفية.

برنامج الزيارات المنزلية:

يهدف برنامج الرعاية الصحية المنزلية إلى رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع المحلي من خلال تزويده بأهم الرسائل الصحية في كافة مجالات الرعاية الصحية لتصبح المعرفة الصحية جزءاً من حياة كل فرد منا بدلاً من أن تصبح أمراً طارئاً نسعى إليه عند حدوث الإصابات المرضية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة التردد على المراكز الصحية وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية.

طب الأسرة:

إن برنامج صحة الأسرة هو برنامج حديث الفكرة في سوريا هدفه متشابه في الدول المطبقة له وهو تطوير النظام الصحي التكامل للخدمات المقدمة وفق آلية توافقية متناغمة بين مستويات الرعاية الصحية بحيث تؤمن خدمات نوعية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المختلفة.

التغذية والغذاء

مقدمة:

يمكن تعريف الغذاء على أنه جميع ما يمكن للإنسان أن يتناوله من أطعمة وأشربة. وهو مهم جدا لجسم الإنسان, فهو لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون غذاء, لكن ليس كل ما يتناوله الإنسان مفيدا, بل هنالك بعض الأطعمة الضارة بالصحة والتي من الواجب تجنبها والجوء إلى الغذاء الصحي.

تم تقسيم الغذاء الصحي إلى عدد من المجموعات, وهي:

الحبوب – الخضار – الفواكه – الحليب ومشتقاته – اللحوم – الدهون – السكريات.

علم التغذية هو علم يشرح علاقة الطعام مع نشاطات الكائنات الحية. ومن ضمن ذلك:

- تناول الطعام.
- طرد الفضلات.
- انطلاق الطاقة من الجسم.
- عمليات التخليق.

فالطعام والشراب يمدان الإنسان بالطاقة لكل وظائف الجسم الحيوية، فتثبت درجة حرارته عند 37 درجة مئوية المناسبة لوظائف الجسم الحيوية، سواء أثناء اليقظة أم أثناء النوم. وبالطاقة المستخلصة من الطعام يؤدي الإنسان جميع نشاطاته الحركية، والفكرية. كذلك فإن الطعام يزود الإنسان بالمواد التي يحتاج إليها جسمه من أجل بناء جسمه وإصلاح أنسجته، ولكي ينظم عمل أعضائه وأجهزته. ويؤثر ما نأكله من غذاء على صحتنا مباشرة.

الغذاء الصحي هو الذي يفيد الإنسان ويمده بالطاقة التي تلزمه يوميا للقيام بأعماله بنشاط وحيوية. ويساعد على منع الإصابة ببعض الأمراض كما أنه يساعد على الشفاء من أمراض أخرى. وأية وجبة غير صحية أو غير مناسبة تزيد من مخاطر أمراض مختلفة قد تصيب الإنسان. وتناول الوجبات المتناسقة المتوازنة أفضل طريقة لضمان تلقي الجسم كافة المواد الغذائية التي يحتاج إليها. وأفضل المصادر التي يحصل منها الإنسان على احتياجاته من جميع المواد الغذائية والفيتامينات، والأملاح المعدنية هي الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى الأسماك وأنواع اللحوم المختلفة، ومنتجات الألبان.

أنواع المغذيات:

• الماء:

خصائصه الفيزيائية مناسبة بشكل فريد لاستدامة الحياة، بما في ذلك حياة الإنسان على الأرض. من الصعب المبالغة في تقدير أهمية الماء كمغذٍ أساسي.

- **ناقل:** يعمل الماء كناقل لجميع العناصر الغذائية والنفايات في الجسم. حيث يسلم المكونات الدقيقة التي تتطلبها كل خلية ويحمل المنتجات النهائية لتفاعلاتها التي تحافظ على الحياة.
- **المذيب:** فهو يذيب الأحماض الأمينية والجلوكوز والمعادن والعديد من المواد الأخرى التي تحتاجها الخلايا.

- **عامل التطهير:** فالماء هو أيضا عامل تطهير للجسم. حيث تذوب الجزيئات الصغيرة، مثل نفايات النيتروجين المتولدة أثناء استقلاب البروتين، في الدم المائي ثم تُزال قبل أن تتراكم إلى تركيزات سامة.
 - **مادة تزليق ودعم:** تقاوم جزيئات الماء التكسّر معًا. بفضل عدم الانضغاط، يمكن أن يعمل الماء كمادة تشحيم ووسادة للمفاصل، ويمكنه حماية الأنسجة الحساسة مثل النخاع الشوكي من الصدمات.
 - **مبرد:** يساعد الماء أيضًا في الحفاظ على درجة حرارة الجسم - فماء العرق هو سائل تبريد الجسم. تنتج الحرارة كمنتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي للطاقة ويمكن أن تتراكم بشكل خطير في الجسم.
- يمكن تلخيص فوائد الماء:

1. يحمل العناصر الغذائية في جميع أنحاء الجسم.
2. يعمل كمذيب للمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز والجزيئات الصغيرة الأخرى.
3. يشارك بنشاط في العديد من التفاعلات الكيميائية.

• الكربوهيدرات (السكريات):

تعتبر الكربوهيدرات من العناصر الغذائية المثالية لتلبية احتياجات الجسم من الطاقة، وتغذية الدماغ والجهاز العصبي، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وضمن حدود السرعات الحرارية، للمساعدة في تغذية النشاط البدني والحفاظ على الجسم رشيقًا. تضيف الكربوهيدرات القابلة للهضم، إلى جانب الدهون والبروتينات، كميات كبيرة من الأطعمة وتوفر الطاقة والفوائد الأخرى للجسم.

الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، والتي تحتوي على معظم الألياف في الأطعمة، تنتج القليل من الطاقة أو لا تنتج أي طاقة ولكنها توفر فوائد مهمة أخرى. فجميع الكربوهيدرات ليست متساوية من حيث التغذية.

• الدهون (الليبيدات):

تنقسم الدهون في الأطعمة وفي جسم الإنسان، على الرغم من كثرة عددها وتنوعها في الوظائف، إلى ثلاث فئات. حوالي 95% من الدهون الثلاثية والفئات الرئيسية الأخرى للدهون هي الفسفوليبيدات والستيرولات (الكوليسترول هو أشهرها). ومن فوائد الدهون:

- **مخازن للوقود:** حيث توفر الدهون معظم الطاقة اللازمة لأداء عمل عضلات الجسم. فالدهون هي أيضًا شكل التخزين الرئيسي في الجسم للطاقة من الطعام الذي يتم تناوله بشكل زائد عن الحاجة.
- **مانع صدمة وبناء أغشية الخلايا:** تعمل وصادات الدهون المحيطة بالأعضاء الداخلية الحيوية كمنع للصدمات. بفضل هذه الواصلات الدهنية، يمكنك ممارسة الرياضة أو ركوب دراجة نارية لساعات عديدة دون إصابات داخلية خطيرة. تعمل البطانية الدهنية الموجودة تحت الجلد أيضًا على عزل الجسم وإبطاء فقدان الحرارة في درجات الحرارة الباردة، مما يساعد في التحكم في المناخ الداخلي. كما تلعب الدهون أيضًا أدوارًا مهمة في جميع خلايا الجسم كجزء من الأغشية المحيطة بها. تساعد الدهون أيضًا في إرسال رسائل الإشارات الخلوية التي تساعد في التحكم في وظائف الخلية.
- **النقل:** دهون المواد الخام والمواد الخام حول الجسم مع الدهون الأخرى. بمجرد وصول الدهون إلى وجهتها، قد تكون بمثابة مادة خام لصنع عدد من المنتجات اللازمة، من بينها فيتامين د، الذي يساعد

في بناء العظام والحفاظ عليها؛ الصفراء التي تساعد في الهضم. والهرمونات الدهنية التي تنظم وظائف الأنسجة.

• البروتينات (الأحماض الأمينية):

تمكن بنية البروتينات من أداء العديد من الوظائف الحيوية. يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية عن الكربوهيدرات والدهون في أن البروتينات تحتوي على ذرات نيتروجين بالإضافة إلى ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين التي تحتوي عليها جميع العناصر الغذائية الثلاثة المنتجة للطاقة.

- **التركيب والحركة:** توجد معظم بروتينات الجسم (حوالي 40 بالمائة) في الأنسجة العضلية. حيث تسمح هياكل البروتين العضلي المتخصصة للجسم بالحركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبروتينات العضلات إطلاق بعض أحماضها الأمينية، إذا أصبحت الحاجة إلى الطاقة شديدة. وتمنح البروتينات الهيكلية الأخرى الشكل والقوة للعظام والأسنان والجلد والأوتار والغضاريف والأوعية الدموية والأنسجة الأخرى. كلها مهمة لعمل الجسم السليم.

- **الإنزيمات والهرمونات والمركبات الأخرى:** من بين البروتينات التي تشكلها الخلايا الحية، تعتبر الإنزيمات بمثابة خلايا عمل أفضلية. يعمل الإنزيم كمحفز فهو يسرع التفاعل الذي قد يحدث على أي حال، ولكن بشكل أبطأ بكثير. توجد آلاف الإنزيمات داخل خلية واحدة، ويسهل كل منها تفاعلاً كيميائياً معيناً.

- **الأجسام المضادة:** من بين جميع البروتينات الموجودة في الكائنات الحية، تُظهر الأجسام المضادة بشكل أفضل أن البروتينات خاصة بكائن حي واحد. تميز الأجسام المضادة الجسيمات الغريبة (عادة البروتينات) عن جميع البروتينات التي تنتمي إلى أجسامها. فعندما يتعرفون على دخيل، فإنهم يضعون علامة عليه كهدف للهجوم. قد يكون البروتين الغريب جزءاً من بكتيريا، أو فيروس، أو سموم، أو قد يكون موجوداً في طعام يسبب رد فعل تحسسي.

- **نظام النقل:** تخصص مجموعة كبيرة من البروتينات في نقل المواد الأخرى، مثل الدهون والفيتامينات والمعادن والأكسجين، في جميع أنحاء الجسم. وللقيام بوظائفهم، يجب أن تنتقل هذه المواد داخل مجرى الدم وإلى داخل الخلايا وخارجها.

- **توازن السوائل والكهارل:** تساعد البروتينات في الحفاظ على التوازن من خلال تنظيم كميات السوائل في أجزاء الجسم. للبقاء على قيد الحياة، يجب أن تحتوي الخلية على حجم ثابت من السائل الداخلي. فقد يؤدي الكثير من السوائل إلى تمزق الخلية؛ القليل جداً سيقصصها، مما يجعلها غير قادرة على العمل.

- **توازن الحمض - القاعدة:** تنتج العمليات الطبيعية للجسم باستمرار الأحماض والقواعد المعاكسة لها، والتي يجب أن يحملها الدم إلى أعضاء الإخراج. يجب أن يقوم الدم بذلك دون أن يؤثر على توازنه الحمضي القاعدي. تعمل بروتينات الدم كمواد عازلة للحفاظ على درجة الحموضة الطبيعية في الدم.

- **تخثر الدم:** لمنع فقدان الدم بشكل خطير، تستجيب بروتينات الدم الخاصة للإصابة عن طريق تخثر الدم. ففي سلسلة من الأحداث الكيميائية، تشكل هذه البروتينات شبكة خيطية تحبس خلايا الدم لتكوين جلطة. حيث تعمل الجلطة بمثابة سدادة لوقف تدفق الدم من الجرح. وفي وقت لاحق، عندما يلتئم الجرح، ينهي بروتين الكولاجين المهمة عن طريق استبدال الجلطة بنسيج ندبي.

• الفيتامينات:

تنقسم الفيتامينات بشكل طبيعي إلى فئتين:

✓ قابلة للذوبان في الدهون.

✓ قابلة للذوبان في الماء.

الذوبان يمنح الفيتامينات العديد من خصائصها. وهي تحدد كيفية امتصاص الجسم لها ونقلها وتخزينها وإخراجها.

- **فيتامين أ:** هو فيتامين متعدد الاستخدامات، له دور في التعبير الجيني، والرؤية، والحفاظ على بطانات الجسم والجلد، والدفاعات المناعية، ونمو الجسم، والتطور الطبيعي للخلايا. فهو يعد ذو أهمية حاسمة لكل من الوظائف التناسلية للذكور والإناث وللتنمية الطبيعية للجنين.
- **فيتامين د:** يعتبر فريداً من بين العناصر الغذائية حيث أنه بمساعدة أشعة الشمس، يمكن للجسم تجميع كل ما يحتاجه. وبهذا المعنى، فإن فيتامين (د) ليس من العناصر الغذائية الأساسية - فبالنظر إلى أشعة الشمس الكافية كل يوم، يمكن لمعظم الناس أن يصنعوا ما يكفي لتلبية احتياجاتهم من هذا المصدر.
- **فيتامين ي:** هو أحد مضادات الأكسدة وبالتالي يعمل كحارس شخصي ضد الأكسدة. يحدث هذا الضرر عندما تنفجر الجزيئات غير المستقرة للغاية المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي تشكل أثناء التمثيل الغذائي الطبيعي للخلايا. وإذا تركت الجذور الحرة دون رادع، فإنها تخلق تفاعلاً متسلسلاً مدمراً يمكن أن يدمر الدهون المتعددة غير المشبعة في أغشية الخلايا والبروتينات الدهنية، والحمض النووي في المادة الوراثية والبروتينات العاملة في الخلايا.
- **فيتامين ك:** تتمثل الوظيفة الرئيسية له في المساعدة في تنشيط البروتينات التي تساعد على تجلط الدم. تقيس المستشفيات وقت تخثر دم الشخص قبل الجراحة، وإذا لزم الأمر، تقدم مكملات فيتامين ك لتقليل النزيف أثناء العملية. لا يحسن فيتامين ك التخثر لدى المصابين باضطرابات نزفية أخرى، مثل مرض الهيموفيليا الوراثي.
- **فيتامين س:** الاسم الذي أطلق لاحقاً على الفيتامين هو "حمض الأسكوربيك"، يعني حرفياً "حمض الأسقربوط". يساعد على تشكيل الأنسجة الضامة، كما يعمل بطريقة أكثر عمومية كمضاد أكسدة.
- **فيتامين ب:** تعمل فيتامينات ب كأجزاء من الإنزيمات المساعدة. كل من فيتامينات ب له طبيعته الخاصة.
- ❖ **فيتامين ب 6:** يشارك في أكثر من 100 تفاعل في أنسجة الجسم وهو ضروري للمساعدة في تحويل نوع واحد من الأحماض الأمينية، التي توجد بكثرة في الخلايا، إلى أحماض أمينية غير أساسية أخرى تفتقر إليها الخلايا.
- ❖ **فيتامين ب 9:** يساعد على تكوين خلايا جديدة، حيث يجب أن تحتوي الأنسجة على حمض الفوليك. يجب أن تكون كل خلية جديدة مجهزة بمواد وراثية جديدة - نسخ من الحمض النووي للخلية الأم - ويساعد حمض الفوليك في تصنيع الحمض النووي وتنظيم أنشطته. يشارك حمض الفوليك أيضاً في عملية التمثيل الغذائي لفيتامين ب 12 والعديد من الأحماض الأمينية.
- ❖ **فيتامين ب 12:** يرتبط فيتامين ب 12 وحمض الفوليك ارتباطاً وثيقاً: يعتمد كل منهما على الآخر من أجل التنشيط. يعمل فيتامين ب 12 أيضاً كجزء من الإنزيمات المساعدة اللازمة لتكاثر الخلايا، ويساعد في الحفاظ على الأغصان الواقية التي تحيط بالألياف العصبية وتحميها، مما يسمح لها بالعمل بشكل صحيح.

● المعادن:

تساعد جميع المعادن الرئيسية في الحفاظ على توازن السوائل، ولكن لكل منها أيضًا بعض المهام الخاصة. ولا يعني التمييز بين المعادن الكثيرة والنادرة أن مجموعة واحدة أكثر أهمية في الجسم من الأخرى.

- **الكالسيوم:** هو إلى حد بعيد أكثر المعادن وفرة في الجسم. تعتبر أدوار الكالسيوم ضرورية لعمل الجسم، ولكن العديد من البالغين والمراهقين وحتى بعض الأطفال لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم. ومعظم الذين يلبون احتياجاتهم يفعلون ذلك عن طريق تناول مكملات الكالسيوم.
- **الفوسفور:** هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم. تم العثور على أكثر من 80 في المائة من الفوسفور في الجسم مع الكالسيوم في بلورات العظام والأسنان. الباقي في كل مكان آخر.
- **المغنيزيوم:** يعتبر معدنًا رئيسيًا بحكم متطلباته الغذائية، ولكن يوجد حوالي 1 أونصة فقط في جسم شخص يزن 130 رطلاً، وأكثر من نصفه في العظام. ومعظم الباقي في العضلات والقلب والكبد والأنسجة الرخوة الأخرى، مع 1 في المائة فقط في سوائل الجسم. يمكن للجسم الاستفادة من إمدادات المغنيسيوم في العظام للحفاظ على مستوى ثابت في الدم كلما انخفض المدخول الغذائي بشكل كبير.
- **الصوديوم:** هو الأيون الموجب في مركب كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ويشكل 40 في المائة من وزنه ويحتوي غرام الملح على 400 ملليغرام من الصوديوم.
- **البوتاسيوم:** بما أن الصوديوم هو الأيون الموجب الرئيسي خارج خلايا الجسم، فإن البوتاسيوم يلعب دور الأيون الرئيسي موجب الشحنة داخل خلايا الجسم. تحتوي جميع الخلايا الحية السليمة على البوتاسيوم.
- **كلوريد:** يشكل الكلور، في شكله الأولي، غازًا أخضر قاتلاً. أما في الجسم، يلعب أيون الكلوريد دورًا مهمًا باعتباره الأيونات السالبة الرئيسية. في السوائل خارج الخلايا، يصاحب الصوديوم ويساعد في الحفاظ على أرصدة السوائل الحاسمة (أرصدة القاعدة الحمضية والكهارل). يلعب أيون الكلوريد أيضًا دورًا خاصًا كجزء من حمض الهيدروكلوريك، الذي يحافظ على حموضة المعدة القوية اللازمة لهضم البروتين.
- **الكبريت:** هو الشكل المؤكسد للكبريت الموجود في الطعام والماء. يحتاج الجسم إلى كبريتات لتخليق العديد من المركبات المهمة المحتوية على الكبريت. ويلعب الكبريت الحاوي على الأحماض الأمينية دورًا مهمًا في مساعدة خيوط البروتين على اتخاذ أشكالها الوظيفية. تحتوي البشرة والشعر والأظافر على بعض البروتينات الأكثر صلابة في الجسم والتي تمتلك محتويات عالية من الكبريت.
- **اليود:** يحتاج الجسم فقط إلى آثار من اليود، ولكن هذه الكمية لا غنى عنها للحياة. بمجرد امتصاصه، فإن شكل اليود الذي يقوم بعمل الجسم هو الشكل الأيوني (ميودن).
- **الحديد:** كل خلية حية سواء كانت نباتية أو حيوانية تحتوي على الحديد. معظم الحديد في الجسم هو مكون لبروتينين: الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء والميوغلوبين في خلايا العضلات.
- **الزنك:** يوجد بكمية صغيرة جدًا في جسم الإنسان، ولكنه يحدث في كل عضو ونسيج. يعمل كعامل مساعد لأكثر من 2700 إنزيم من أجل: ■ حماية الهياكل الخلوية من التلف الناتج عن الأكسدة. ■ تجميع أجزاء من المادة الجينية للخلايا. ■ توليف الهيموجلوبين.
- **السيلينيوم:** جذب انتباه علماء العالم. إن التلميحات حول علاقته بالأمراض المزمنة تجعل السيلينيوم مضافًا شائعًا، ولكنه غير ضروري إلى حد كبير، في المكملات الغذائية.

- **الفلوريد:** يوجد في جميع أنواع التربة وإمدادات المياه والنباتات والحيوانات تقريبًا. يتم تقييمه في النظام الغذائي بسبب قدرته على منع تطور تسوس الأسنان لدى الأطفال والبالغين.
- **الكروم:** معدن أساسي يعمل كعامل مساعد للإنزيمات التي تتوسط في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون. الكروم الموجود في الأطعمة آمن وضروري للصحة. الكروم الصناعي هو مادة ملوثة سامة، ومادة مسرطنة معروفة تتلف الحمض النووي.
- **النحاس:** مثل معظم المعادن النادرة الأخرى، يلعب النحاس دورًا حيويًا كعامل مساعد للعديد من الإنزيمات. من بين مهامها، تساعد هذه الإنزيمات في امتصاص واستخدام الحديد، وفي تخليق البروتينات مثل الهيموجلوبين والكولاجين.

إرشادات للتغذية الصحية:

كانت التغذية عنصرًا أساسيًا في الوقاية من الأمراض وعلاجها منذ زمن بعيد. وتعد مهمة لجميع الكائنات الحية. وتعد التوصيات المتعلقة بالمغذيات هي مجموعة من المعايير التي يمكن على أساسها قياس مآخذ الناس من المغذيات والطاقة. يستخدم خبراء التغذية التوصيات لتقييم المدخول وتقديم المشورة بشأن الكميات التي يجب استهلاكها. قد يستخدمها الأفراد لتحديد كمية العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها وكم هي أكثر من اللازم.

في عالم مثالي، تمنع التغذية الجيدة الحاجة إلى الرعاية الصحية، لكن وصولنا المحدود إلى المعلومات الغذائية أثناء التعليم المهني يقلل من إمكانات التغذية لتحسين صحتنا. قد تكون المعرفة التغذوية للأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية غير كافية لسببين على الأقل.

- السبب الأول هو أن جوهر المواد التي يتم تدريسها في العديد من المدارس المهنية، بما في ذلك كليات الطب ومدارس التمريض، محدود.
- السبب الثاني هو أن هناك تطورات مستمرة في المجال تجعل تحديث معرفة الفرد بالتغذية مسؤولية مستمرة. هناك بالطبع دورات تعليمية مستمرة تقدم تحديثات لأحدث المعارف في علم التغذية وممارسات التغذية.

التوصيات الرئيسية:

- اتباع نمط غذائي صحي في كل مرحلة من مراحل الحياة:
في كل مرحلة من مراحل الحياة - الرضاعة، والطفولة، والمراهقة، والبلوغ، والحمل، والرضاعة، والبلوغ الأكبر - لا يكون أبدًا مبكرًا أو متأخرًا جدًا لتناول الطعام الصحي.
- لحوالي 6 أشهر الأولى من العمر: إطعام الرضع حصريًا حليب الإنسان. والاستمرار في إطعام الرضع خلال السنة الأولى من العمر على الأقل، وأطول إذا رغب. تغذية الرضع حليب الأطفال المدعم بالحديد خلال السنة الأولى من العمر عندما يكون لبن الأم غير متوفر. إمداد الرضع بالفيتامينات التكميلية D تبدأ بعد الولادة بقليل.

- في حوالي 6 أشهر: تعريف الرضّع على الأغذية القاسية المكملّة. تشجيع الرضّع والأطفال الصغار على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية. إدخال الأطعمة الغنية في الحديد والزنك، وخاصة بالنسبة للرضع الذين يتغذون على لبن الأم.
- من 12 شهرًا حتى سن الرشد: اتباع نمط غذائي صحي على مدى العمر لتلبية الاحتياجات الغذائية، مما يساعد في تحقيق وزن صحي للجسم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

- التخصيص والتمتع بخيارات الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية: يمكن أن يفيد النمط الغذائي الصحي جميع الأفراد بغض النظر عن العمر أو العرق أو الحالة الصحية الحالية. توفر إرشادات الحمية إطارًا يمكن أن يتم تخصيصه وفقًا للاحتياجات والتفضيلات الفردية، بالإضافة إلى الطرق الغذائية للثقافات المتنوعة.

- التركيز على تلبية احتياجات المجموعة الغذائية والبقاء ضمن حدود السرعات الحرارية: الفرضية الأساسية للمبادئ التوجيهية الغذائية هي أن الاحتياجات الغذائية يجب تلبيتها في المقام الأول من الأطعمة والمشروبات - على وجه التحديد، الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية. توفر الأطعمة الغنية بالمغذيات الفيتامينات والمعادن والمكونات الأخرى المعززة للصحة ولا تحتوي على سكريات مضافة أو تحتوي على القليل من السكريات والدهون المشبعة والصوديوم. يتكون النمط الغذائي الصحي من كثيف المغذيات.

- التقليل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والصوديوم: في كل مرحلة من مراحل الحياة، يتطلب تلبية توصيات مجموعة الطعام، معظم احتياجات الفرد اليومية من السرعات الحرارية وتحديد الصوديوم. لا يحتوي النمط الغذائي الصحي على مساحة كبيرة للسكريات المضافة أو الدهون المشبعة أو الصوديوم - أو للمشروبات الكحولية. يمكن إضافة كمية صغيرة من السكريات المضافة أو الدهون المشبعة أو الصوديوم إلى الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية للمساعدة في تلبية توصيات مجموعة الطعام، ولكن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من هذه المكونات يجب أن تكون محدودة.

الوجبة الغذائية اليومية:

يوصي خبراء التغذية بأن الوجبة اليومية يجب أن تشمل على عدد معين من الأطعمة من بين مجموعات خمس وهي:



- الخضراوات.
- الفواكه.
- الخبز والأرز والفتائر والمأكولات القمحية.
- الحليب واللبن الزبادي والجبن.
- اللحوم والدواجن والسمك والبقول الجافة والبالاء، والبيض والمكسرات.

وينسق العاملون في مجال التغذية خدمات الطعام المدرسي، كما يخصصون وجبات المرضى بالمستشفيات، ويقدمون استشارات في التغذية للأفراد، ويديرون أنظمة غذاء عالمية كما يفحصون العلاقة بين الوجبات والصحة، ويبحثون عن طرق لتحسين تعبئة الأطعمة وتوزيعها وكذلك يبتكرون أغذية جديدة.

مشعرات التغذية:

باستخدام الطول والوزن إضافة لأعمار الأطفال تم الحصول على مؤشرات قياسية متعلقة بالنمو الفيزيائي للطفأ ووصف الحالة التغذوية للطفل الذي يعتبر من أكثر المؤشرات حساسية للتغيرات المفاجئة للوضع الصحي.

وهذه المؤشرات هي:

- الوزن بالنسبة للعمر: وهو مؤشر مركب لا يميز بين سوء التغذية مزمنًا كان أم حادًا.
- الطول بالنسبة للعمر: وهو مقياس للحالة التغذوية الماضية وانخفاض قيمة هذا المؤشر يسمى بقصر القامة (Stunting) وهذا يعود إلى نقص مزمن في تناول الأغذية أو تكرار الإصابة بالمرض.

مشعر كتلة الجسم (BMI):

$$BMI = \frac{Weight (kg)}{\{Height (m)\}^2}$$

يشار إلى هذا المؤشر كمقياس للحالة التغذوية للبالغين. كمقياس للنحافة أو نقص الوزن. يمكن أن يكون انخفاض مؤشر كتلة الجسم مرتبطًا بالنحافة البنيوية؛ ومع ذلك، فإنه هذه الحالة أقل من 5%.

BMI	Classification
<18.5	Under Weight
18.5 - 24.9	Normal
25 - 29.9	Over Weight
30 - 34.9	Obesity (Class I)
35 - 39.9	Obesity (Class II)
> 40	Extreme Obesity

التقييم العالمي الموضوعي (SGA):

تم التعرف على هذا التقييم، باعتباره المعيار الذهبي في تشخيص سوء التغذية. قام الفاحصون المدربون بتطوير أداة لتصنيف المرضى على أنهم يعانون من سوء التغذية الخفيف أو سوء التغذية الحاد أو التغذية الجيدة. وارتبطت الأداة جيدًا بالتقييمات الموضوعية التي تضمنت المقاييس المخبرية والقياسية البشرية. كما ارتبطت سوء التغذية بزيادة حدوث العدوى، واستخدام المضادات الحيوية، وطول مدة الإقامة في المستشفى، والتي تم اختيارها كعلامات للمراضة السريرية.

Subjective Global Assessment Guidance For Body Composition

SUBCUTANEOUS FAT

Physical examination	Normal	Mild/Moderate	Severe
Under the eyes	Slightly bulging area	Somewhat hollow look, slightly dark circles	Hollowed look, depression, dark circles
Triceps	Large space between fingers	Some depth to fat tissue, but not ample. Loose fitting skin	Very little space between fingers, or fingers touch
Ribs, lower back, sides of trunk	Chest is full, ribs do not show. Slight to no protrusion of the iliac crest	Ribs obvious, but indentations are not marked. Iliac Crest somewhat prominent	Indentation between ribs very obvious. Iliac crest very prominent

MUSCLE WASTING

Physical examination	Normal	Mild/Moderate	Severe
Temple	Well-defined muscle	Slight depression	Hollowing, depression
Cervical	Not visible in males; may be visible but not prominent in females	Some protrusion; may not be all the way along	Protruding/prominent bone
Shoulder	Rounded	No square look, acromion process may protrude slightly	Square look; bones prominent
Scapula/ribs	Bones not prominent; no significant depressions	Mild depressions or bone may show slightly, not all areas	Bones prominent; significant depressions
Quadriceps	Well defined	Depression/atrophy medially	Prominent knee, Severe depression medially
Interosseous muscle between thumb and forefinger (back of hand)**	Muscle protrudes; could be flat in females	Slightly depressed	Flat or depressed area

FLUID RETENTION

Physical examination	Normal	Mild/Moderate	Severe
Edema	None	Pitting edema of extremities / pitting to knees, possible sacral edema if bedridden	Pitting beyond knees, sacral edema if bedridden, may also have generalized edema
Ascites	Absent	Present (may only be present on imaging)	

A - Well-nourished no decrease in food/nutrient intake; < 5% weight loss; no/minimal symptoms affecting food intake; no deficit in function; no deficit in fat or muscle mass **OR** *an individual with criteria for SGA B or C but with recent adequate food intake, non-fluid weight gain, significant recent improvement in symptoms allowing adequate oral intake, significant recent improvement in function, and chronic deficit in fat and muscle mass but with recent clinical improvement in function.

B - Mildly/moderately malnourished definite decrease in food/nutrient intake; 5% - 10% weight loss without stabilization or gain; mild/some symptoms affecting food intake, moderate functional deficit or recent deterioration; mild/moderate loss of fat and/or muscle mass **OR** *an individual meeting criteria for SGA C but with improvement (but not adequate) of oral intake, recent stabilization of weight, decrease in symptoms affecting oral intake, and stabilization of functional status.

C - Severely malnourished severe deficit in food/nutrient intake; > 10% weight loss which is ongoing; significant symptoms affecting food/nutrient intake, severe functional deficit **OR** *recent significant deterioration obvious signs of fat and/or muscle loss.

Cachexia - If there is an underlying predisposing disorder (e.g. malignancy) and there is evidence of reduced muscle and fat and no or limited improvement with optimal nutrient intake, this is consistent with cachexia.

Sarcopenia - If there is an underlying disorder (e.g. aging) and there is evidence of reduced muscle and strength and no or limited improvement with optimal nutrient intake.

**In the elderly prominent tendons and hollowing is the result of aging and may not reflect malnutrition.

Canadian Nutrition Task Force / Le Groupe de travail canadien sur la nutrition
Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

Subjective Global Assessment Form

MEDICAL HISTORY

Patient name: _____ Date: ____/____/____

NUTRIENT INTAKE

1. ☐ No change; adequate
2. ☐ Inadequate; duration of inadequate intake: _____
3. ☐ Suboptimal solid diet ☐ Full fluids or only oral nutrition supplements ☐ Minimal intake, clear fluids or starvation

3. **Nutrient intake in past 2 weeks***
☐ Adequate ☐ Improved but not adequate ☐ No improvement or inadequate

WEIGHT

Usual weight: _____ Current weight: _____

1. **Non fluid weight change past 6 months** Weight loss (kg): _____
☐ <5% loss or weight stability ☐ 5-10% loss without stabilization or increase ☐ >10% loss and ongoing
If above not known, has there been a subjective loss of weight during the past six months?
☐ None or mild ☐ Moderate ☐ Severe

2. **Weight change past 2 weeks*** Amount (if known): _____
☐ Increased ☐ No change ☐ Decreased

SYMPTOMS

(Experiencing symptoms affecting oral intake)

1. ☐ Pain on eating ☐ Nausea ☐ Bloating ☐ Vomiting ☐ Constipation ☐ Dysphagia ☐ Diarrhea
☐ Dental problems ☐ Feels full quickly ☐ Nausea ☐ Constipation ☐ Dysphagia ☐ Diarrhea

2. ☐ None ☐ Mild/moderate/severe

3. **Symptoms in the past 2 weeks***
☐ Resolution of symptoms ☐ Improving ☐ No change or worsened

FUNCTIONAL CAPACITY

(Fatigue and progressive loss of function)

1. ☐ No dysfunction
2. ☐ Reduced capacity; duration of change: _____
☐ Difficulty with usual/normal activities ☐ Bed/chair-bound

3. **Functional Capacity in the past 2 weeks***
☐ Improved ☐ No change ☐ Decreased

METABOLIC REQUIREMENT

High metabolic requirement ☐ No ☐ No

PHYSICAL EXAMINATION

Loss of body fat ☐ No ☐ Mild/Moderate ☐ Severe
Loss of muscle mass ☐ No ☐ Mild/Moderate ☐ Severe
Presence of edema/ascites ☐ No ☐ Mild/Moderate ☐ Severe

SGA RATING

☐ A Well-nourished Normal ☐ B Mildly/moderately malnourished Some progressive nutritional loss ☐ C Severely malnourished Evidence of wasting and progressive symptoms

CONTRIBUTING FACTOR

☐ CACHEXIA - fat and muscle wasting due to disease and inflammation ☐ SARCOPENIA - reduced muscle mass and strength

*See page 2 SGA Rating for more description.
April 2017

Canadian Nutrition Task Force / Le Groupe de travail canadien sur la nutrition
Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

لجنة الإجماع الدولية للمبادئ التوجيهية (ICGC):

في عام 2010، اقترحت مجموعة من خبراء التغذية السريرية الدوليين نهجًا قائمًا على المسببات لتشخيص سوء التغذية لدى البالغين في البيئة السريرية حيث أدركت اللجنة الدور المهم للالتهاب في سوء التغذية المرتبط بالأمراض. حيث يؤدي الالتهاب إلى زيادة استهلاك الطاقة أثناء الراحة وإفراز النيتروجين، مما يؤثر على متطلبات الطاقة والبروتين.

الالتهاب الحاد الناتج عن مرض أو إصابة خطيرة له تأثير تقويضي شديد على الكتلة الخالية من الدهون. وفي المرض المزمن، تتأثر العملية الالتهابية بتطور المرض وشدته. فعندما تؤدي شدة المرض / استمرار الالتهاب إلى انخفاض الكتلة النحيلة التي تسبب ضعفًا وظيفيًا، فإن سوء التغذية يعتبر مرتبطًا بالمرض.

تنص لجنة المبادئ التوجيهية للإجماع على أنه يمكن تشخيص المرضى بأكثر من سبب واحد لسوء التغذية، وقد يتغيرون أيضاً من سبب إلى آخر. من المخاطر بشكل خاص المريض المصاب بالجوع أو سوء التغذية المرتبط بمرض مزمن، حيث يمكن أن تتدهور حالته التغذوية بسرعة أكبر خلال مرض حاد أو حدث مرتبط بالإصابة.

أقرت اللجنة أن تطبيق هذا النهج التشخيصي في الممارسة السريرية سيتطلب تقييماً وأن معايير دعم هذه التشخيصات ستحتاج إلى مزيد من التطوير.

بيان إجماع أكاديمية التغذية وعلم التغذية والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والتغذية المعوية:
في عام 2009، أنشأت أكاديمية التغذية وعلم التغذية (Academy) والجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية (ASPEN) مجموعة عمل لتحديد وتوحيد مؤشرات الحالة التغذوية مقابل الاستجابة الالتهابية المرتبطة بالأمراض و / أو الحالات. وقررت مجموعة العمل أن هذه المؤشرات يجب أن تتمتع بالسمات التالية:

- أن تكون قليلة العدد.
 - تدعم تشخيص التغذية.
 - تميز شدة سوء التغذية.
 - تتغير مع تغير الحالة التغذوية.
 - تكون مبنية على الأدلة عندما يكون ذلك ممكناً أو مشتقة بالإجماع عند عدم وجود أدلة كافية.
 - تكون قادرة على التغيير بمرور الوقت مع ظهور دليل على الصلاحية.
- اقترح بيان الإجماع مجموعة من الخصائص التشخيصية وأوصى بوجود اثنين أو أكثر من الخصائص الست التالية لتشخيص سوء التغذية.

1. عدم كفاية تناول الطاقة.
2. فقدان الوزن.
3. فقدان الدهون تحت الجلد.
4. فقدان كتلة العضلات.
5. تراكم السوائل الموضعي أو العام الذي قد يخفي أحياناً فقدان الوزن.
6. تضائل الحالة الوظيفية وفقاً لقياس قوة قبضة اليد.

بيان إجماع الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (ESPEN):
في عام 2012، عينت ESPEN مجموعة من الخبراء لتقديم توافق في الآراء بشأن معايير تشخيصية بسيطة وواضحة لسوء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المجموعة بتحديد العلاقة بين الفحص وعملية التشخيص. قررت المجموعة أن الفحص الغذائي يجب أن يكون إلزامياً للمرضى في جميع البيئات السريرية. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن تشخيص سوء التغذية يجب أن يستند إلى نتيجة تقييم الفحص، وبالتالي فإن التدابير التشخيصية مطلوبة فقط للمرضى الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لمخاطر غذائية من خلال أداة فحص التغذية المعتمدة.

لم يتم تقديم أي توصيات بشأن أداة الفحص التي يجب استخدامها، ولكن فقط يجب التحقق من صحة الأداة للإعداد الذي يتم تطبيقه فيه.

مبادرة القيادة العالمية بشأن سوء التغذية (GLIM):

في عام 2016، شكل ممثلون عن ASPEN و ESPEN واتحاد أمريكا اللاتينية للعلاج الغذائي والتغذية السريرية والتمثيل الغذائي (FELANPE) وجمعية التغذية الوريدية والمعوية في آسيا (PENSA) لجنة قيادية لإنشاء مبادرة القيادة العالمية بشأن سوء التغذية (GLIM).

أنشأت لجنة القيادة الأساسية مجموعة عمل داعمة أكبر لتشمل أعضاء يمكنهم توفير تنوع وخبرات إضافية من أجل تطوير إجماع عالمي على نهج موحد لتشخيص سوء التغذية في الممارسة السريرية. يروج تقرير الإجماع الذي نُشر في عام 2019 لنموذج من خطوتين.

1. يجب تحديد الأفراد المعرضين لخطر سوء التغذية من خلال استخدام أداة فحص التغذية المصدق عليها.
2. تقييم شامل لتحديد التشخيص وشدة سوء التغذية.

بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لمعايير التشخيص المحتملة لسوء التغذية، اختارت المجموعة المعايير التالية:

- فقدان الوزن غير المقصود.
- مؤشر كتلة جسم منخفض.
- انخفاض كتلة العضلات.
- انخفاض تناول الطعام أو الاستيعاب.
- عبء المرض / الالتهاب.

سوء التغذية:

عند تعريف سوء التغذية، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. قد يكون أي عنصر غذائي ناقصًا، وليس فقط الطاقة والبروتين، ويمكن أن يساهم في سوء التغذية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يفهم الأطباء أن استهلاك العناصر الغذائية لا يعني فقط تناولها عن طريق الفم، ولكن أيضًا التغذية التي يتم توفيرها عن طريق الوسائل المعوية والحقن. يجب أن يدرك الأطباء دور سوء الامتصاص، والخسائر المفرطة، والحالة الالتهابية، وزيادة متطلبات التمثيل الغذائي في خلق عجز التغذية. يجب أيضًا التعرف على النتائج السريرية لسوء التغذية. أخيرًا، يجب أن يدرك الأطباء أن الحاجة إلى العناصر الغذائية يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا للأفراد طوال حياتهم بناءً على الظروف الفيزيولوجية والبيئية المختلفة.

على الرغم من أن سوء التغذية يمثل مشكلة عالمية، إلا أنه لا يوجد إجماع حول كيفية تعريفه. كلمة سوء التغذية تعني التغذية "السيئة"، والتي يمكن أن تشير إلى كل من نقص التغذية والإفراط في التغذية. تم نشر العشرات من التعريفات لسوء التغذية بواسطة القواميس الطبية، بالإضافة إلى لجان الخبراء التي تمثل المنظمات الوطنية والدولية. وتركز بعض التعريفات فقط على اختلال توازن العناصر الغذائية التي يتم

استهلاكها في النظام الغذائي. أما التعريفات الأخرى أكثر تعقيداً وتتناول التأثيرات الفيزيولوجية التي تزيد من الطلب أو تقلل من استخدام المغذيات، أو العواقب السريرية التي تتبع سوء التغذية.

يعد سوء التغذية من العوامل الرئيسة التي لها علاقة بحالات الوفيات التي تحدث للمسنين، كما أنه شائع في المرضى المسنين المنومين في المستشفيات، وهذا يؤدي إلى طول فترة إقامة المسن في المستشفى مما يترتب عليه إهدار في النفقات الصحية، ومن المعروف أنه مع التقدم في العمر تحدث تغيرات فيزيولوجية ووظيفية وصحية وهذه التغيرات تختلف درجتها ووقت حدوثها من مسن إلى مسن آخر. هذه التغيرات التي تحدث في جسم المسن لها.

في البشر، يمكن أن يسبب النظام الغذائي غير الصحي:

- الأمراض المرتبطة بنقص العناصر الغذائية: مثل العمى، وفقر الدم، الاسقربوط، الولادة المبكرة، ولادة جنين ميت.
- الأمراض المرتبطة بزيادة العناصر الغذائية الزائدة: مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي؛ وأمراض جهازية مزمنة شائعة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري، وهشاشة العظام.
- من الفرضية الأساسية للمبادئ التوجيهية الغذائية أن الجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو عرقهم أو ظروفهم الاقتصادية أو حالتهم الصحية، يمكنهم الاستفادة من تغيير خيارات الأطعمة والمشروبات لدعم الأنماط الغذائية الصحية بشكل أفضل.
- التغذية مهمة لجميع الكائنات الحية. حيث تصف التغذية الأطعمة التي يحتاجها البشر والحيوانات الأخرى للنمو والتطور والتمتع بصحة جيدة. وتشمل المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الدقيقة.
- دور المغذيات الكبيرة المقدار والبروتينات والدهون والكربوهيدرات هو تطوير القلب والأوعية الدموية المرض والسمنة وكذلك في الوقاية منها. لقد وجدت أنظمة كيتو الغذائية، والأنظمة الغذائية منخفضة نسبة السكر في الدم، والأنظمة الغذائية قليلة الدسم جميعاً أبطالها.
- المغذيات الدقيقة في الغذاء هي عنصر مهم آخر في الحفاظ على صحة الغذاء.

إن أمراض التغذية تحدث بسبب الغذاء غير المناسب. ففي العديد من البلدان النامية، يرغم الفقر الناس بالاعتماد على غذاء غير متكامل. وتكثر بين هؤلاء الناس أمراض نقص التغذية والقصور الغذائي. وينشأ نقص التغذية عن النقص العمومي في الغذاء. ويتميز بتأخر النمو ونقص الطاقة وضعف المقاومة للأمراض المعدية. أما أمراض القصور الغذائي فتنشأ عندما يفتقر الغذاء إلى عنصر واحد أو أكثر من العناصر الغذائية الأساسية. فنقص البروتين يؤدي إلى مرض الكواشيوركور، وهو مرض خطير يصيب الأطفال عادة، وقد يؤدي إلى الوفاة. ويسبب نقص الفيتامينات أمراضاً مثل البري بري والبلاغرا والكساح والإسقربوط. وينتج مرض فقر الدم والدرق (تضخم الغدة الدرقية) عن نقص المعادن. ويمكن أن تؤدي العادات السيئة في التغذية إلى حدوث أمراض نقص غذائي في البلدان المتقدمة أيضاً. ولكن في هذه الأخيرة، تحدث معظم مشاكل التغذية بسبب الإفراط في الطعام. فالبدانة (السمنة الزائدة) تحدث عندما يأكل الشخص كمية من الطعام أكثر من التي يحرقها الجسم. وتتسبب البدانة على حدوث العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

العمل والإعفاء

مقدمة:

على المستوى البيولوجي الأساسي، فإن التعب هو في الأساس اختلال التوازن بين إمدادات الطاقة والطلب عليها. لديك مستويات طاقة منخفضة بشكل مزمن عندما لا تحصل خلاياك على إمدادات الطاقة التي تحتاجها، أو عندما يكون الطلب عليها مرتفعاً جداً - أو كلاهما. هذا يخلق نقصاً في الطاقة، مما يؤدي إلى أعراض التعب.

في حين أن هناك العديد من العوامل المساهمة في هذا النقص في الطاقة، فإن الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يجب فهمه هو أن قصة الإرهاق تتمحور حول الميتوكوندريا.

تعد الميتوكوندريا "قوة الخلية". داخل كل خلية من خلايا أجسامنا تقريباً، لدينا ما بين 500 إلى 2000 ميتوكوندريا وظيفتها حرقاً جعل الطاقة التي تحتاجها الخلايا للعمل. تأخذ الميتوكوندريا الأكسجين الذي يتم تنفسه والطعام الذي يتم تناوله (بشكل أساسي الكربوهيدرات والدهون) لإنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو الوقود المستخدم لتشغيل جميع العمليات الخلوية والتمثيل الغذائي.

بدون الميتوكوندريا، لن تتمتع الخلايا بالقدرة على إنتاج الطاقة التي تحتاجها لتعمل، مما يعني أنه لا يمكن أن تحدث أي عملية في الجسم بالطريقة التي تم تصميمها بها. وليس من المبالغة القول إنه بدون الميتوكوندريا لا حياة! ففي الأساس، مستويات الطاقة المنخفضة هي ببساطة نتيجة لعجز مزمن في الطاقة الخلوية.

يعد التعب هو العرض الذي ينتج عندما لا تنتج الميتوكوندريا الموجودة في تريليونات الخلايا التي يتكون منها جسمك - عضلاتك، وغددك المنتجة للهرمونات، وقلبك، وكبدك، ودماغك، وما إلى ذلك - طاقة كافية لتشغيل وظائفها على نحو فعال. وكما نعلم الآن من خلال عشرات الدراسات التي شملت أشخاصاً يعانون من الإرهاق المزمن أو حالات مرضية أخرى يكون التعب فيها شائعاً، فإن الارتباطات المتسقة بين متلازمات التعب وخلل الميتوكوندريا تشمل:

- النقص في الكارنيتين، المطلوب لنقل الدهون إلى الميتوكوندريا لاستخدامها كمصدر للطاقة.
- عجز في الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10)، وهو مطلوب لإنتاج الطاقة.
- تركيزات أقل من مضادات الأكسدة ومستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي.
- انخفاض معدلات ATP (الطاقة الخلوية).
- انخفاض التعبير الجيني في المسارات الوظيفية لإنتاج الطاقة، مثل تلك المتعلقة بالتمثيل الغذائي، ونقل البروتين، وتشكل الميتوكوندريا.

أعراض توقف الميتوكوندريا:

- تشتت الدماغ.
- الالتهاب المزمن.
- ضعف إزالة السموم.
- ضعف القدرة على التحمل.
- ضعف الأداء العقلي والجسدي.
- التعب المزمن.

الإرهاق الوظيفي (الاحتراق الوظيفي):

لأكثر من 40 عامًا، ظل العلماء والأكاديميون وخبراء مكان العمل عالقين في نقاش حول تعريف واضح وموحد لـ "الإرهاق". حتى أخيرًا، في عام 2019، حاولت منظمة الصحة العالمية (WHO) وضع حد للجدل من خلال تضمين الإرهاق في المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) كظاهرة مهنية، "متلازمة تم تصورها على أنها ناتجة من ضغوط العمل المزمنة التي لم تتم إدارتها بنجاح". وتعرفه ميريام وبستر بأنه: "حالة الشخص الذي أصبح شديد التعب جسديًا وعاطفيًا بعد القيام بعمل شاق لفترة طويلة".

هناك عرض أساسي لكل بُعد من أبعاد الإرهاق - الإرهاق العقلي والجسدي وحده بالنسبة إلى وظيفتك هو حالة من الإرهاق المفرط؛ السخرية وحدها هي حالة فك الارتباط. والعجز وحده هو حالة من عدم الفعالية. دعونا نلقي نظرة على كل من الأعراض الثلاثة على حدة.

أسباب الاحتراق الوظيفي:

يمكن أن ينتج الاحتراق الوظيفي عن عوامل مختلفة، بما في ذلك:

- عدم السيطرة: قد تؤدي عدم القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بوظيفتك مثل تحديد جدولك الزمني أو المهام أو شركاء العمل أو حتى الحصول على موارد العمل الناقصة إلى شعورك بالتوتر الدائم الذي يؤدي بدوره إلى الإرهاق الوظيفي في النهاية.
- توقعات وظيفية غير واضحة: إذا لم تكن لديك رؤية واضحة بشأن متطلبات درجتك الوظيفية أو ما يتوقعه مشرفك أو الآخرون منك، فقد تشعر بأنك غير كفؤ وتبدأ في فقدان الثقة بنفسك والاهتمام بعملك.
- بيئة العمل غير الصحية: لا يمكن أن تكون بيئة العمل في مكان ما صحية بشكل كامل، فقد يكون هناك من يضايقك من زملاء العمل، أو ربما يكون لديك بعض المشاكل مع أحد الزملاء أو أنك لا تستطيع الانسجام مع فريقك أو مديرك. مع استمرار العمل في تلك البيئة، يتولد لديك ضغوط عمل تؤدي إلى الإرهاق.
- بذل الجهد المستمر: عندما تكون الوظيفة رتيبة ذات روتين ثابت أو حتى ذات مهام مختلفة متعددة، فأنت في كلا الحالتين تحتاج إلى بذل الجهد باستمرار للحفاظ على تركيزك أثناء تأدية مهامك الوظيفية وهذا بالطبع يستنزف من طاقتك ويؤدي بك إلى الشعور بالإرهاق.
- نقص التواصل الاجتماعي: إذا كنت تشعر بالعزلة في العمل وفي حياتك الشخصية ولا تمتلك الكثير من الأصدقاء وتتواصل معهم أو لا تجيد التعامل والتقرب من الآخرين، فقد يُشعرك ذلك بمزيد من التوتر.
- اختلال التوازن بين العمل والحياة: إذا كان عملك يستهلك الكثير من الوقت والجهد فتكون منهكًا ولا تملك الطاقة لقضاء الوقت مع عائلتك وأصدقائك، فقد يؤدي ذلك إلى شعورك بالإرهاق سريعًا.

أعراض الاحتراق الوظيفي:

الإرهاق: هو العرض الرئيسي للاحتراق. فهو يتألف من إجهاد جسدي وإدراكي وعاطفي عميق يقوض قدرة الأشخاص على العمل بفعالية ويشعرون بالإيجابية تجاه ما يفعلونه. يمكن أن ينبع هذا من مطالب ثقافة تنظيمية تعمل دائمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو ضغوط زمنية شديدة، أو ببساطة لديك الكثير

لتفعله، خاصةً عندما تفتقر إلى التحكم في عملك، أو لا تعجبك المهام الموكلة بها، أو ليس لديك المهارات اللازمة لتجميعها. في حالة الإرهاق، تجد أنك غير قادر على التركيز؛ حتى المهام الروتينية والممتعة سابقاً تبدو شاقة، ويصبح من الصعب جر نفسك داخل وخارج المكتب.

التشاؤم: ويسمى أيضاً تبدد الشخصية، تمثل تآكلًا للانخراط. إنها في الأساس طريقة لإبعاد نفسك نفسياً عن عملك. فبدلاً من الشعور بالاستثمار في مهامك ومشاريعك وزملائك وعملائك والمتعاونين الآخرين، فإنك تشعر بأنك منفصل، وسلبى، وحتى قاسٍ. يمكن أن يكون التشاؤم نتيجة عبء العمل الزائد، ولكن من المحتمل أيضاً أن يحدث في وجود صراع كبير، وعدم الإنصاف، وقلة المشاركة في صنع القرار. والتشاؤم المستمر هي إشارة إلى أنك فقدت الاتصال بعملك والتمتع به والفخر به.

عدم الكفاءة: يشير إلى الشعور بعدم الكفاءة ونقص الإنجاز والإنتاجية. يشعر الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاحتراق الوظيفي بأن مهاراتهم تتدهور ويقلقون من أنهم لن يتمكنوا من النجاح في مواقف معينة أو إنجاز مهام معينة. غالباً ما يتطور جنباً إلى جنب مع الإرهاق والتشاؤم لأن الناس لا يستطيعون الأداء في أقصى طاقتهم عندما ينفد الوقود ويفقدوا اتصالهم بالعمل. ولكن يمكن أن يبدأ الاحتراق الوظيفي أيضاً بعدم الكفاءة إذا كنت تفتقر إلى الموارد والدعم للقيام بعملك بشكل جيد، بما في ذلك الوقت الكافي والمعلومات والتوقعات الواضحة والاستقلالية والعلاقات الجيدة مع أولئك الذين تحتاج إلى مشاركتهم لتحقيق النجاح. يمكن أيضاً أن يؤدي عدم وجود تعليقات وتقدير ذي مغزى، والذي يتركك تتساءل عن جودة عملك والشعور بأنه لا يحظى بالتقدير، بتنشيط هذا المكون.

مراحل الاحتراق الوظيفي:

لا يحدث الاحتراق الوظيفي فجأة أو دفعة واحدة، ورغم اختلاف الأعراض من شخص لآخر، هناك عدة مراحل يمر بها الشخص حتى يصل إلى الاحتراق في النهاية:

- الطموح المفرط: عندما تتولى عملاً أو وظيفة جديدة، فإنك تكون متحمساً لإنجاز كل شيء على أكمل وجه وتبدأ في النظر إلى زملائك الأعلى منك في الدرجة الوظيفية وتطمح لأن تصل إلى مكانهم سريعاً.
- دفع نفسك للعمل بجدية أكبر: يدفعك الطموح إلى العمل بجهد وبجدية أكبر من أجل الوصول إلى هدفك.
- إهمال احتياجاتك الخاصة: ترى أن العمل بجدية لا يحقق النتائج التي ترغب بها سريعاً فتحاول اقتطاع بعض الوقت من حياتك الشخصية فتبدأ بالتضحية ببعض من وقت النوم، وقت ممارسة الرياضة أو بعض أوقات تناول الطعام.
- إلقاء اللوم على الآخرين: تشعر بأن كل العمل الجاد الذي تتجوزه لا يجدي نفعاً، ويؤدي إهمال احتياجاتك إلى جعلك عصبياً ومتوتراً، وبدلاً من الاعتراف بأنك تدفع نفسك إلى أقصى الحدود، فإنك تلقي اللوم على غيرك.
- تجاهل الأنشطة الحياتية غير المتعلقة بالعمل: تبدأ في هذه المرحلة بالانسحاب من الاجتماعات العائلية ولقاءات الأصدقاء. تشترك الدعوات للحفلات والخروج للقاء الأصدقاء بالعبء بدلاً من أن تكون ممتعة.
- مرحلة الإنكار: يتصاعد نفاذ صبرك مع من حولك، فبدلاً من تحمل المسؤولية عن سلوكياتك وأفعالك، فإنك تلوم الآخرين وتراهم غير أكفاء أو كسالى ومتغطرسين. ولا ترى أبداً أن سبب المشكلة نابع منك.

- التغييرات السلوكية: في هذه المرحلة تكون قد اقتربت من نهاية المنحدر نحو الإرهاق. تصبح طباعك أكثر حدة وتتحول إلى شخصية عدوانية سريعة الغضب نافذة الصبر تهاجم أحبائك والمقربين إليك دون سبب.
- فقدان الهوية: في هذه المرحلة تشعر بفقدان قدرتك على السيطرة على زمام أمور حياتك وترى بأنه لا شيء يسير على ما يرام وتبدأ في التساؤل كيف ومتى وصلت لهذا الحال وتشعر بأنك غريب عن نفسك لا تعرف ماذا تفعل أو ما الذي تريده.
- الفراغ الداخلي: عقلك الآن مشوش وفي حالة من الفوضى من الأفكار المضطربة غير المفهومة، فجأة تسكن تلك الضوضاء ولا تشعر سوى بالفراغ بداخلك فتحاول البحث عن عادة تملأ هذا الفراغ أو تنسيك إياه فتتجه إلى إدمان شيء ضار كالإفراط في تناول الطعام، النوم أو ألعاب الفيديو وغيرها.
- الاكتئاب: تفقد الرغبة في الحياة معناها وتبدأ في الشعور باليأس.
- الانهيار العقلي أو الجسدي: لا يقتصر تأثير الاكتئاب على نفسك وحسب، بل إنه يمتد للتأثير على جسدك وعقلك وقد يشوش تفكيرك وطريقة حكمك على الأمور.

التخلص من الاحتراق الوظيفي:

- سواء كنت في بداية مراحل الاحتراق أو في المنتصف أو قد وصلت لمرحلة الإرهاق النهائية، فإن محاولة الاستمرار هكذا دون حل المشكلة لن تؤدي بك إلا بمزيد من الضرر. لذا، فقد حان الوقت الآن لإنهاء ذلك الأمر وتتعلم كيف يمكنك أن تتغلب على الإرهاق بمفردك. هناك 3 خطوات أساسية للتعامل مع الإرهاق:
- التعرف: تحتاج في هذه المرحلة إلى تعلم مراحل الاحتراق الوظيفي وذلك لتتمكن من التعرف والانتباه إلى أي علامة تدل على أنك في طريقك نحو الإرهاق.
 - اتخاذ إجراء: إذا كنت تسير نحو الإرهاق، فتدارك الموقف سريعاً وحاول إصلاح الأضرار التي أصابتك قبل أن تتفاقم. ولا بأس بطلب الدعم في حالة احتجت إلى ذلك.
 - الثبات: لكي تتمكن من مواجهة مسببات الإرهاق والصمود أمامها دون أن تدعها تؤثر عليك أو يكون تأثيرها ضئيل على الأقل فأنت بحاجة إلى الاهتمام بصحتك الجسدية والعقلية والنفسية.

الاستراحة والنوم:

النوم هو حالة سلوكية من الاعتقال النفسي الحركي مع زيادة عتبة الاستيقاظ، والتي يسهلها الانفصال الحسي عن البيئة. أشار كارسكادون وديمنت إلى النوم على أنه حالة سلوك عصبية متكررة وقابلة للانعكاس من الانسحاب الإدراكي النسبي من البيئة وعدم الاستجابة لها. عادة ما يكون النوم مصحوباً بهدوء سلوكي، ووضعية معينة، وعينين مغلقتين. إنه يشمل مجموعة من التفاعلات المعقدة، والتي لم يتم فهمها بالكامل حتى الآن،

في الجهاز العصبي المركزي وجميع أنظمة الجسم الأخرى. كبشر، نقضي ما يصل إلى ثلث حياتنا في هذه الحالة السلوكية العالمية، والتي لوحظت في جميع أنواع الحيوانات. ومع ذلك، فإن النوم ليس مجرد حالة سلبية يكون فيها الدماغ هادئاً، بل هو سلسلة ديناميكية شديدة التنظيم ومعقدة من حالات الدماغ التي تكرر نفسها بنمط مميز. يتم الحفاظ على الآليات الجزيئية التي تتحكم في إيقاعات النوم بشكل كبير من الناحية

التطورية. ومع ذلك، فإن التنظيم الدوري للنوم يختلف داخل الأنواع وفيما بينها. يبدو أن فترة مراحل النوم تزداد مع زيادة حجم الدماغ عبر الأنواع، ويزداد عمق ونسبة مراحل حركة العين غير السريعة (NREM) في كل دورة مع نضوج الدماغ داخل الأنواع.

مراحل النوم:

يتألف النوم الطبيعي للإنسان من حالتين رئيسيتين:

- حركة العين السريعة (REM).
- حركة العين غير السريعة NREM.

واللذان يتناوبان دوريًا خلال فترة النوم.

- يتضمن نوم حركة العين غير السريعة تباطؤًا وزيادة تزامن مخطط كهربية الدماغ (EEG)، المرتبط بتوتر العضلات المنخفض والحد الأدنى من النشاط الإدراكي. وينقسم نوم حركة العين غير السريعة إلى ثلاث مراحل، وفقًا لدرجة التزامن الواضحة على مخطط كهربية الدماغ والعلامات الأخرى:
 - ✓ المرحلة 1 (N1) - النعاس أو النوم الخفيف.
 - ✓ المرحلة 2 (N2) - النوم المتوسط.
 - ✓ المرحلة 3 (N3) - النوم العميق.
- يتميز نوم حركة العين السريعة بتخطيط كهربية الدماغ غير متزامن، وتكون عضلات الهيكل العظمي متوترة (بصرف النظر عن تلك التي تتحكم في حركات العين)، ويحدث معظم الأحلام خلال هذه المرحلة من النوم.
- يشتمل نمط النوم الليلي عادة على العديد من الخصائص الموثوقة:
 - ✓ يبدأ النوم في N1 NREM ويتقدم خلال مراحل NREM الأعمق (N2 و N3) قبل حدوث الحلقة الأولى من نوم حركة العين السريعة بعد 80-100 دقيقة تقريبًا.
 - ✓ بعد ذلك، نوم NREM ودورة نوم حركة العين السريعة مدتها 90 دقيقة تقريبًا.
 - ✓ تكون مراحل نوم N3 أكثر تركيزًا في دورات نوم حركة العين السريعة المبكرة، بينما تطول نوبات نوم حركة العين السريعة طوال الليل.
 - ✓ يسود نوم الموجة البطيئة (SWS) أثناء N3 في الثلث الأول من الليل وهو مرتبط ببدء النوم وطول مدة اليقظة.
 - ✓ يسود نوم حركة العين السريعة في الثلث الأخير من الليل، ويرتبط بإيقاع الساعة البيولوجية لدرجة حرارة الجسم.
 - ✓ يمثل اليقظة في النوم أقل من 5٪ من الليل.
 - ✓ عادة ما يكون نوم حركة العين غير السريعة 75-80٪ من النوم.
 - ✓ نوم حركة العين السريعة (20-25٪) تحدث في أربع إلى ست حلقات منفصلة..
 - ✓ النوم اللاحق بعد ليلة واحدة من الحرمان من النوم يفضل SWS أثناء التعافي.
 - ✓ يحدث انتعاش نوم حركة العين السريعة في ليالي التعافي الثانية أو اللاحقة بعد نوبة من قلة النوم.

نصائح إيجاد وقت للنوم:

1. لن تتجز كل شيء أبدًا:

أدرك أنك لن تتجز كل شيء أبدًا، بغض النظر عن مدى سرعتك في الجري. في الواقع، ربما تكون قد لاحظت أنه كلما ركضت بشكل أسرع وأكثر فاعلية في القيام بالأشياء، زادت مهامك وأعمالك. وإليك سرًا: إذا كنت تبطئ وتستغرق وقتًا للنوم، فستجد أن عددًا أقل من الأشياء تجد طريقها إلى قائمة مهامك، ويبدو أن الكثير من الأشياء والمشكلات تختفي ببساطة. في الغالب، أشياء لم تكن تريد فعلها على أي حال. بعد ذلك ستجد أن الحصول على ثماني ساعات من النوم كل ليلة سيجعلك أكثر كفاءة وفعالية، وستستمتع بالأشياء التي تفعلها أكثر.

2. احتفظ بما يبدو جيدًا وتخلص من الباقي:

ضع قائمة بمعظم الأشياء التي تقضي وقتًا في فعلها في الحياة، سواء في المنزل أو في العمل. وضعها في عمودين. يحتوي العمود 1 على الأشياء التي تشعر بالرضا عن القيام بها، أو على الأقل تشعر أن القيام بها أفضل من عدم القيام بها. في العمود 2، ضع الأشياء التي تعتقد أنه يجب عليك فعلها لكنها تشعر بالسوء. يتضمن ذلك أشياء مثل العديد من اجتماعات اللجان واجتماعات المدرسة والأشياء الأخرى التي لا تحبها حقًا ولكنك تعتقد أنك يجب أن تفعلها. وقد سمي هذا "يجب على نفسك"، والتفكير في "يجب أن أفعل هذا؛ يجب أن أقوم به".

وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

- عدم استهلاك الكافيين بعد الساعة 4:00 مساءً.
- عدم استخدام السرير لحل المشاكل أو القيام بالعمل. فإذا كنت معتادًا على استخدام سريرك في العمل، فمن الأفضل تغيير منطقة عملك إلى جزء آخر من المنزل. إذا كان يساعدك على النوم، يمكنك مشاهدة التلفزيون المريح (ربما على جهاز توقيت يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون إذا كنت تنام أثناء المشاهدة) أو قراءة كتاب مريح في السرير حتى لا يمكنك البقاء مستيقظًا.
- أخذ حمام ساخن قبل النوم إذا كان الجو باردًا بالخارج. يمكن أن تؤدي إضافة كوبين من أملاح إبسوم (المغنيسيوم) إلى استرخاء العضلات القوي وتسكين الآلام أيضًا.
- المحافظة على درجة حرارة الغرفة معتدلة.
- إذا كان الشريك يشخر، احصل على زوج جيد من سدادات الأذن أو سماعات إلغاء الضوضاء واستخدمها. غالبًا ما تكون سدادات الشمع التي تتشكل على شكل الأذن هي الأفضل. قد يكون من المفيد أيضًا أن يكون لديك إما مولد صوت يُصدر أصواتًا طبيعية أو، أفضل من ذلك، شريط يحفز مرحلة النوم العميق (REM). غالبًا ما يعاني أزواج الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير من اضطراب شديد في النوم. قد تحتاج إلى النوم في غرفة نوم منفصلة حتى تجد طريقة للنوم بهدوء خلال الشخير.
- إذا كنت تستيقظ كثيرًا للتبول أثناء الليل، فلا تشرب الكثير من السوائل بالقرب من موعد النوم.
- وضع ساعة غرفة النوم بعيدًا عن متناول اليد وتوجيهها بعيدًا حتى لا يتم رؤيتها. فكلما نظر إلى الساعة يؤدي إلى تفاقم مشاكل النوم والإحباط.
- تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين (1 إلى 2 أونصة) قبل النوم. حيث يتسبب الجوع في الأرق لدى جميع الحيوانات، ولا يستثنى من ذلك الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب انخفاض إفرازات الغدة الكظرية في انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الليل، مما سيوقظك بين الساعة 2:00 صباحًا و

4:00 صباحًا. يمكن أن تساعد وجبة خفيفة غنية بالبروتين مثل البيض المسلوق في وقت النوم. إذا كانت هذه هي المشكلة، فستعرف في الليلة الأولى أو الثانية أن لديك وجبة خفيفة عالية البروتين قبل النوم، حيث ستنام طوال الليل دون الاستيقاظ كثيرًا.

الاضطرابات المتعلقة بالنوم:

- الأرق:

هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يرتبط مع حالات طبية ونفسية وحالات النوم. يرتبط بأعباء شخصية واجتماعية اقتصادية كبيرة. تتم هنا مناقشة السمات السريرية والتقييم وعلم الأوبئة وعواقب الأرق والتشخيص التفريقي والعلاج.

خصائص الأرق:

- الصعوبة المستمرة في النوم لفترة كافية من الوقت أو عدم القدرة المستمرة على الحصول على نوم موحد الذي يحدث على الرغم من وجود فرصة كافية للنوم.
- يؤدي إلى اختلال وظيفي أثناء النهار.
- لا يمكن تفسيره بشكل أفضل من خلال اضطراب نوم آخر.

من المهم أن نلاحظ أن:

- قلة النوم في حالة عدم وجود اختلال وظيفي أثناء النهار أو ضيق لا يشكل أرقًا. هؤلاء الأشخاص ببساطة ينامون لمدة قصيرة ولا يتشكل اضطراب في النوم.
- النوم القصير بسبب عدم كفاية فرص النوم ليس أرقًا. هذا هو متلازمة النوم غير الكافية، والمعروفة أيضًا باسم تقييد النوم أو الحرمان من النوم. تختلف آثار هذا الاضطراب وعلاجه اختلافاً كبيراً عن الأرق.

- ملازمة توقف التنفس أثناء النوم:

هو حالة يتوقف فيها الشخص عن التنفس بشكل متكرر أثناء الليل. وهناك نوعان رئيسيان من انقطاع النفس النومي:

- انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA): وهو انسداد متقطع لمجرى الهواء العلوي. في OSA، ينهار البلعوم (الحلق) بشكل متكرر أثناء النوم. يحارب الشخص المصاب بانقطاع النفس الانسدادي النومي للتنفس ضد انسداد مجرى الهواء، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. في نهاية المطاف، يوقظ الإحساس بالاختناق الشخص، وتنقبض عضلات الحلق، ويفتح مجرى الهواء، ويدفع الهواء للداخل تحت ضغط مرتفع. عندما يتم فتح مجرى الهواء، يسمح الهواء المتسارع للمريض بالعودة مرة أخرى للنوم، ولكنه يصدر صوتاً عالياً يلهث. لا يدرك الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي بشكل عام حدوث ذلك، على الرغم من أن شركائهم في الفراش غالبًا ما يعانون من اضطراب شديد في النوم بسبب الشخير واللهاث. قد تكرر هذه الدورة نفسها

عدة مرات طوال الليل. هذا الاستيقاظ المستمر من النوم العميق، وكذلك فقدان الأكسجين في الدم، يمكن أن يسبب النعاس في اليوم التالي، وضباب الدماغ، وضعف التركيز، وتغيرات المزاج.

- انقطاع النفس النومي المركزي (CSA): وهو عندما تكون هناك مشكلة في الدماغ.

- متلازمة تلمل الساق (RLS):

هي اضطراب عصبي شائع يتميز بالحاجة إلى تحريك الجسم، عادةً ولكن ليس بشكل ثابت في الساقين، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بمجموعة من الأحاسيس غير السارة. بالإضافة إلى الأعراض الحسية، فهو سبب شائع وغير معروف في كثير من الأحيان للأرق، وخاصة صعوبات بدء النوم. يتم تعريف متلازمة تلمل الساق (RLS) من خلال عدد من معايير التشخيص الإلزامية:

- الرغبة في تحريك أجزاء الجسم، عادة الساقين، مصحوبة بأحاسيس غير مريحة أو مزعجة.
 - تبدأ الأعراض خلال فترات عدم الحركة أو النوم، وتزداد سوءًا مع عدم الحركة.
 - ينتج عن حركة الأطراف المصابة تخفيف جزئي أو عابر.
 - تفاقم الأعراض في المساء والليل.
 - لا يتم تفسير الأعراض المذكورة أعلاه فقط من خلال حالة طبية أخرى.
- من المهم التأكيد على أن غالبية المرضى (85%) المصابين بـ RLS و PLMD لا يحتاجون إلى علاج دوائي. وقبل الشروع في العلاج، يجب بذل الجهود لاستبعاد الأسباب الكامنة:
- تحديد السلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم متلازمة تلمل الساق (RLS) (مثل تقييد النوم، والكحول، والكافيين، والنيكوتين).
 - الانسحاب، إن أمكن، من الأدوية التي قد تحفز أو تتسبب في حدوث متلازمة تلمل الساقين.
 - الفحص العصبي.
 - الفحص الكلوي لاستبعاد اليوريا.
 - دراسة نسب الحديد، وخاصة الفيريتين.
- تشمل العلاجات غير الدوائية:

- تحسين نظافة النوم ومراعاة العلاج المعرفي السلوكي.
- العلاج بالاسترخاء.
- المشي أو التمدد قبل النوم.
- تدليك أجزاء الجسم المصابة.
- الاستحمام بماء دافئ قبل النوم.
- مكملات المغنيسيوم.

- متلازمة مقاومة مجرى الهواء العلوي (UARS):

عند النوم، يسقط التناغم العصبي العضلي للعضلات الموسعة للمجرى الهوائي ويضيق مجرى الهواء العلوي. وإذا ما أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في مقاومة تدفق الهواء، فقد يزداد جهد الشهيق حتى يستيقظ المريض مع حالة إثارة من النوم، ولكن بدون انقطاع النفس، أو نقص التنفس، أو عدم تشبع انقطاع النفس الانسدادي النومي. يؤدي ذلك إلى تقطع النوم ويمكن أن يترك المريض يشعر بالنعاس المفرط.

في UARS، يستمر المرضى في التنفس ولا يتشبعون. يتشابه علاج UARS مع علاج انقطاع النفس الانسدادي النومي.

يحدث النوم عندما يحدث إصلاح الأنسجة، وهذا هو السبب في أن قلة النوم تسبب الألم. هو أيضا أمر بالغ الأهمية لإنتاج هرمون النمو السليم. يُطلق على هرمون النمو أيضًا اسم "إينبوع هرمون الشباب" ويرتبط بمظهر الشباب بالإضافة إلى زيادة العضلات وتقليل الدهون. ثبت أنه مهم لوظيفة المناعة. ومهم لتنظيم الوزن لأن هرمونات قمع الشهية مثل اللبتين يتم إنتاجها أثناء النوم. أظهرت الدراسات أن قلة النوم كانت مرتبطة بزيادة الوزن بمعدل ستة أرطال. في دراسة أجريت على 68183 امرأة، تمت متابعتها على مدى ستة عشر عامًا، كان أولئك الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليلة أكثر عرضة بنسبة 32 في المائة لاكتساب ثلاثة وثلاثين رطلاً مقارنة بمن ينامون سبع ساعات في الليلة. لذلك، من المفيد تخصيص وقت لثمانى ساعات من النوم. ليس فقط عندما يكون لديك المزيد من الطاقة وألم أقل، ولكن ستفقد الوزن وتبدو أصغر سنًا أيضًا.

النظافة الفردية

يُعدّ الاهتمام بالنظافة الشخصية والعناية بها من أخطر المشاكل التي تواجه طلاب المرحلة الثانوية. حيث إنّ العناية الصحيحة بالجسم تقع على عاتق الفرد وحده.

أنت تعيش اليوم في عالم يعتمد على الصحة الجيدة. فالصحة السيئة تُقلّل من متعة الحياة وتُفسد متعة العيش. حيث سيتم التركيز على تنمية الفرد ككل. تم تناول كل مشكلة من مشاكل النظافة والعناية الشخصية في هذه المحاضرة.

كيفية الحفاظ على نظافة الجسم:

المزايا المكتسبة إذا كان لديك جسم نظيف:

- 1- شعبية أكبر: الجسم النظيف يفتح لك فرصاً أكثر.
- 2- رائحة جسم أقل: الاستحمام اليومي يزيل روائح الجسم، ولن ينزعج أصدقاؤك من وجودك معهم.
- 3- المزيد من الفخر: ستشعر بتحسّن إذا كنت تعلم أن جسمك نظيف.
- 4- المزيد من الحيوية: الاسترخاء من الاستحمام سيمنحك دفعة إضافية من القوة عند الحاجة.
- 5- المزيد من الألفة: النظافة تجذب الجنس الآخر إليك.
- 6- أمراض أقل: الجسم النظيف لديه فرصة أفضل للتخلص من الأمراض.

كيفية الاستحمام للجسم:

- الأدوات: كيفية اختيار أدوات استحمام جيدة:
 - 1- تجنب الصابون الرخيص ذو الرائحة العطرة، فقد يهيج البشرة.
 - 2- استخدم فرشاة يد ناعمة ولكن ثابتة لتنظيف الشقوق والزوايا والأماكن التي يصعب الوصول إليها في الجسم.
 - 3- استخدم صابوناً أبيض كاستلياً عالي الجودة.
 - 4- ضع سجادة في حوض الاستحمام وعلى الأرض لمنع الانزلاق.
 - 5- استخدم مزيل عرق جيد للإبط فوراً بعد الاستحمام.
 - 6- استخدم بودرة مزيل عرق آمنة للقدمين.
 - 7- استخدم قطعة قماش خشنة ومنشفة.
 - 8- استخدم غطاء استحمام بلاستيكيّاً أو مطاطيّاً لحماية الشعر من البلل.
 - 9- اختر مُنعم مياه جيد لحمامات الفقاعات لمنع تكوّن حلقة على حوض الاستحمام.

- الأنواع: كيفية اختيار مرافق الاستحمام المناسبة لك:

- 1- الاستحمام في حوض الاستحمام:
 - استخدم حوض الاستحمام كحمام نقع.
 - قد يكون للاستحمام في حوض الاستحمام بعض الفوائد العلاجية في تخفيف آلام العضلات.
 - يُعد الاستحمام في حوض الاستحمام خياراً جيداً للاستحمام الهادئ والمريح.
 - بعد الاستحمام، اشطف جسمك بماء بارد ونشط.
- 2- الاستحمام تحت المرش (الدش):
 - حمام الدش يوفر الوقت ويُنعش.

- إذا كنت تستخدم الدش بانتظام، فعليك التخطيط للاستحمام في حوض الاستحمام مرة واحدة أسبوعياً.
- حمام الدش أسلوب استحمام جيد بعد ممارسة التمارين الرياضية النشطة، وكذلك للفنات خلال فترة الحيض.

روتين الاستحمام:

1. استحم ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً.
2. استحم بماء دافئ.
3. افرك الوجه والأذنين والرقبة جيداً أثناء ملء حوض الاستحمام بالماء.
4. استخدم الفرشاة أو قطعة قماش للظهر والصدر.
5. ذلك المرفقين والركبتين واليدين والكعبين بحركات إضافية.
6. انتبه بشكل خاص لإبطي الإبطين والقدمين.
7. اغسل جميع مناطق الجسم جيداً بالصابون.
8. اغسل وافرك جميع الشقوق من الخصر إلى الركبتين.
9. افرك الساقين والقدمين مع اهتمام خاص بأصابع القدمين والمناطق الخشنة.
10. اشطف الجسم جيداً.
11. أغلق المسام بالماء البارد.
12. تجنب إتلاف الجلد.
13. انتقل من الحوض إلى سجادة نظيفة.
14. جفف جميع أجزاء الجسم تماماً مع التركيز على التجفيف بين أصابع القدمين.
15. جفف بمنشفتك الخاصة وجفف من الرأس إلى القدمين.
16. ضع مزيل عرق كريمي بين أصابع القدمين وتحت الإبطين.
17. استحم ليلاً إن أمكن.
18. لا تلمس أبداً مفاتيح الكهرباء وأنت مبلل.

كيفية العناية بالجلد:

المزايا المكتسبة إذا كان لديك عناية بالجلد:

- 1- جاذبية أكبر: ستتمتع بمظهر جذاب إذا كانت بشرتك صافية وناعمة.
- 2- لون بشرة أفضل: السمرة الجيدة ستجعلك محط حسد الآخرين.
- 3- وظيفة أفضل: المظهر الجميل يساعد في الحصول على وظيفة..
- 4- الشعبية: عندما تكون جذاباً، تتم دعوتك إلى جميع الأنشطة.
- 5- شفاه ياقوتية: ستكون شفثيك ناعمة أكثر ورطبة.

كيفية الحصول على بشرة جميلة:

- التعرق: كيفية مكافحة رائحة الجسم:

- 1- اختر مزيل عرق جيد لا يسد المسام، ولا يضر بالملابس، ويمتنع عرق الجسم.
- 2- استحم يومياً.

- 3- اغسل يديك ووجهك بكمية كبيرة من الصابون والماء.
- 4- اشطف الصابون جيداً بالماء الدافئ.
- 5- مارس تمارين رياضية جيدة لزيادة التعرق، ثم اتبعها بدش سريع.
- 6- ارتدِ ملابس داخلية نظيفة يومياً.

- العيوب: كيفية العناية بالزوائد الجلدية الخارجية:

1. اغسل وجهك ثلاث مرات يومياً على الأقل.
2. عرّض وجهك للبخار لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.
3. أغلق المسام بماء بارد.
4. استخدم مستحضرات التجميل باعتدال.
5. اتبع نظاماً غذائياً جيداً قليل الدهون والنشويات.
6. أزل الرؤوس السوداء بعناية فائقة.
7. افتح البثور فقط بإبرة معقمة.
8. تجنب عصر الجلد.
9. تجنب أشعة الشمس القوية.
10. تجنب مزيلات النمش لأنها لا تُجدي نفعاً.
11. استخدم عصير الليمون لتبييض النمش.
12. قلل من تناول الحلوى.
13. لا تنتف الشعر من الشامات أو الثآليل.
14. استشر طبيباً في حالة الدمامل.
15. تجنب ارتداء الملابس التي تحتك بالزوائد الجلدية الكبيرة.
16. لتخفيف الحكّة، رُش المنطقة بمسحوق حمض البوريك.
17. تجنب المصابين بالقوباء.
18. تجنب استخدام المناشف العادية وأدوات المرحاض.
19. ارتدِ بنطالاً طويلاً عند الخروج في الغابة لحماية بشرتك من الأعشاب السامة.
20. تناول الكثير من الفاكهة الطازجة.
21. اشرب ستة أكواب من الماء على الأقل يومياً للمساعدة في التخلص من فضلات الجسم.
22. تناول الطعام بانتظام وتخلص منه.
23. استشر طبيب أمراض جلدية إذا سادت حالة جلدية شديدة.

- البشرة: كيفية الحفاظ على نعومة بشرتك ونقاؤها:

- 1- اغسل جيداً بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد، فهو يُحسن الدورة الدموية.
- 2- استخدم منشفة شخصية نظيفة عند الغسل أو الاستحمام.
- 3- لا تستخدم مُقَوِّيات البشرة أو اللوشن لإزالة المسام الواسعة أو التجاعيد.
- 4- دلّكي بشرتك بقوة بعد الاستحمام.
- 5- اغسلي وجهك بكريم منظم في بعض الأحيان. للبشرة الجافة، ضعي كمية قليلة من الكريم.
- 6- قبل النوم ضعي القليل من زيت البندق على البشرة بعد الغسيل لإغلاق المسام.

7- اتباع نظام غذائي صحي، مع تقليل كمية النشويات.

- المكياج: كيفية استخدام مستحضرات التجميل:

1. ضعي مستحضرات التجميل بطريقة لا يلاحظها الآخرون.
2. استخدمي الكمية الكافية لإبراز جمالك.
3. اشترى فقط مستحضرات التجميل من ماركات معروفة.
4. تجنبى المستحضرات المزيفة التي تدعي أنها فعّالة.
5. استخدمى كريم أساس خفيف كقاعدة بوردرة.
6. إذا كان لون وجهك باهتًا، استخدمى القليل من أحمر الشفاه الكريمي.
7. استخدمى إسفنجة بوردرة نظيفة.
8. يجب وضع أحمر الشفاه على محيط الشفاه الأساسي.
9. اختاري لون أحمر شفاه يتناسب مع لون أحمر الشفاه ويمتزج جيدًا مع لون البشرة.
10. استخدمى فرشاة أحمر الشفاه لتحديد حواف الشفاه، ثم املئها بعناية.
11. بعد وضع أحمر الشفاه، ربتيه بمنديل تنظيف.
12. تأكدي من عدم وجود أي أثر لأحمر الشفاه على الأسنان.

- التسمير: كيفية تجنب حروق الشمس الضارة:

- 1- عرّضى جسمك فقط، لمدة 15 أو 20 دقيقة في اليوم الأول، ثم زيدي المدة تدريجيًا.
- 2- تجنبى الحروق الخطيرة باستخدام زيوت فلتر الشمس.
- 3- لا تنامي تحت أشعة الشمس.
- 4- احذري من الأيام الغائمة.
- 5- استخدم نظارات شمسية لحماية عينيك.
- 6- استخدم ضمادة من صودا الخبز لتخفيف الألم الناتج عن حروق الشمس.
- 7- احذر من الإعلانات المزيفة لزيوت حروق الشمس.
- 8- استشر طبيبًا في حالة حروق الشمس الشديدة.

كيفية العناية بالشعر:

المزايا المكتسبة إذا كان لديك شعر مُهندم:

- 1- توفير أكبر: إذا اعتنيت بشعرك وفروة رأسك الآن، فستوفر على العلاجات الباهظة الثمن، والأنظمة الغذائية، والأدوية الحاصلة على براءة اختراع، والشعر المستعار.
- 2- شعر أسهل في التصفيف: الشعر النظيف سهل التمشيط والعناية.
- 3- راحة: فروة رأس وشعر نظيفان، يمنعان التهيج المزعج.
- 4- أصدقاء أكثر: الشعر النظيف واللامع يعني صحة جيدة تجذب الأصدقاء.

كيفية الحصول على شعر نظيف والحفاظ عليه:

- العناية بالشعر: كيفية الحصول على شعر لامع وجميل:
1. حافظي على تمشيط الشعر.

2. دلكي فروة الرأس بأطراف الأصابع، بحركات دائرية سريعة.
3. ضعي رأسك في مستوى منخفض عن مستوى جسمك من حين لآخر لزيادة تدفق الدم إلى الرأس.
4. حافظي على دهنية شعرك الطبيعية، واستخدمي زيتاً إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الزيت.
5. استخدمي دائماً مشطك وفرشاة شعرك الخاصين، وحافظي على نظافتهما.
6. تجنب الإفراط في استخدام الزيوت والمقويات.
7. أزلي الشعر غير المرغوب فيه.
8. حافظي على نظافة شعرك وفروة رأسك.
9. اجعلي تمشيط الشعر عادة يومية.
10. اختر فرشاة شعر ذات شعيرات صلبة.
11. لا تخدشي فروة الرأس بأظفرك أو بأدوات حادة.
12. اسحبي الشعر بانتظام لتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.
13. يجب أن يتم قص وتصفيف الشعر بواسطة مصفف شعر محترف.
14. لا تبللي شعرك كثيراً عند التمشيط.

- القشرة: كيفية مكافحة قشرة الرأس:

- 1- اغسل الشعر بالشامبو عند الحاجة.
- 2- قبل غسل الشعر بالشامبو، دلك الزيت في فروة الرأس لترطيبها وتخفيف القشرة.
- 3- ضع لوشناً مطهراً ومنعشاً على فروة الرأس يومياً.
- 4- استخدم تدليكاً سريعاً بأطراف الأصابع يومياً.
- 5- ضع كمية صغيرة من زيت الشعر عندما تكون فروة رأسك جافة.
- 6- جفف شعرك تماماً بعد غسله.
- 7- لا تقلق بشأن قشرة الرأس. إنها تؤثر فقط على المظهر وليس على تساقط الشعر.
- 8- استشر طبيباً إذا خرجت قشرة الرأس عن السيطرة.

- مقويات الشعر: كيفية اختيار منتج جيد للشعر:

- 1- اختر مستحضراً يُساعد على تثبيت الشعر في مكانه.
- 2- لا تستخدم مُستحضراً دهنيّاً للشعر.
- 3- لا تستخدم مُنتجاً لا يُناسب مزاياه الإعلانية.
- 4- اختر مُستحضراً يُمكن الحصول عليه بسهولة.

- الغسيل: كيفية غسل الشعر بالشامبو:

- 1- بلّل الشعر بماء فاتر ناعم.
- 2- تجنّب استخدام صابون الكيك، ويُفضّل الصابون السائل.
- 3- تجنّب تيارات الهواء عند غسل الشعر.
- 4- مشط شعرك جيداً وذلكه بمُستحضر جيد للشعر.
- 5- وّرّع الشامبو جيداً على الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس.
- 6- اشطفي الرغوة الأولى برذاذ يدوي. أو تحت الدش. ثم كرري الدورة مرة أخرى.

7- جففي الشعر جيداً بمنشفة كبيرة ونظيفة.

- الشعر غير المرغوب فيه: كيفية إزالة الشعر:
 1. استخدمي شفرة حلاقة آمنة أو ملقطاً لشعر الساقين وتحت الإبطين.
 2. نتف الشعر من الشامات أو النتوءات.
 3. احلقي وجهك كلما دعت الحاجة عن طريق تمرير الشفرة على الشعر في اتجاه نموه.
 4. بيّضي الشعر غير المرغوب فيه على الوجه والذراعين والساقين باستخدام بيروكسيد الهيدروجين.
 5. حافظي على شفرة الحلاقة حادة.
 6. استخدم الماء الساخن لتليين الشعر.
 7. استخدم ماكينة حلاقة كهربائية للبشرة الحساسة.
 8. اسحب الشعر الذي ينمو تحت الجلد بحرص.
 9. تجنب مزيلات الشعر الكيميائية.
 10. لا تنتف حاجبيك.

- الصلع: كيفية الحفاظ على شعرك:
 1. تجنب تصفيف الشعر لأنه يجعل الشعر هشاً.
 2. علاج الصلع الناتج عن مرض ما عن طريق معالجة المرض.
 3. التغذية السليمة، وقضاء الحاجة، وممارسة الرياضة، والخروج في الهواء الطلق، والنوم، كلها عوامل تساعد على الوقاية من الصلع.
 4. الحفاظ على نظافة الشعر وفروة الرأس.
 5. تنشيط الشعر وتدليكه يوميًا.
 6. لا تحاول استخدام العلاجات المنزلية.
 7. لا تستخدم الصبغات أبدًا.
 8. استخدم زيوت الشعر والمقوياته باعتدال.
 9. لا تقلق بشأن الصلع، فلا يوجد علاج محدد له.
 10. أبلغ طبيب أمراض جلدية إذا تساقط شعرك فجأة.

كيفية الحفاظ على نظافة الفم:

المزايا المكتسبة من العناية الجيدة بالأسنان والفم:

- 1- ألم أقل: العناية الجيدة بالأسنان تمنع التسوس الذي يسبب الألم.
- 2- متعة أكبر: يمكنك تناول شرائح اللحم الشهية وشرب المشروبات الساخنة والباردة.
- 3- أسنان لؤلؤية: ستصبح أسنانك بيضاء وجميلة من خلال العناية المناسبة.
- 4- أصدقاء أكثر: الأسنان والفم الجيدان يعنيان رائحة فم طيبة تساعد على اكتساب الأصدقاء والحفاظ عليهم.
- 5- مال أكثر: يمكنك توفير المال من خلال تقليل فواتير معالجات الأسنان.

كيفية العناية بالأسنان والفم:

- الحماية: كيفية حماية الأسنان:
 - 1- تنظيف الأسنان واللثة بالفرشاة بعد كل وجبة.
 - 2- اختيار طبيب أسنان جيد التعامل معه.
 - 3- اختيار نظام غذائي جيد.
 - 4- تناول بعض الأطعمة التي تتطلب المضغ مع كل وجبة.
 - 5- زيارة طبيب الأسنان بانتظام وإجراء ما يلزم من أعمال.
 - 6- تجنب تناول الطعام قبل النوم.
 - 7- تجنب تناول الحلويات والسكريات بكثرة.
 - 8- قم بتصوير الفم بالكامل بالأشعة السينية بانتظام للبحث عن الأسنان المصابة.
 - 9- منع ازدحام الأسنان، واستشر أخصائياً، ولا تُهَيِّج أنسجة اللثة.

- الأدوات: كيفية اختيار فرشاة الأسنان المناسبة:

- 1- لا تستخدم فرشاة ذات شعيرات نايلون، (الشعيرات الطبيعية هي الأفضل).
- 2- اختر مقابض بألوان مختلفة لأفراد العائلة.
- 3- حافظ على فرشاة الأسنان معرضة للهواء.
- 4- خزّن الفرشاة في مكان جاف حيث لا يلامس أي شيء الشعيرات.
- 5- لا تستخدم فرشاة دافئة أبداً.
- 6- يجب أن تحتوي الفرشاة الجيدة على شعيرات متعددة.
- 7- اطلب من طبيب أسنانك أن يوصي بفرشاة جيدة.
- 8- اختر فرشاة صغيرة للوصول إلى الفتحات الصغيرة.
- 9- احتفظ بفرشائين بحيث يمكن تبديلهما.
- 10- يجب أن تكون جميع الشعيرات متساوية الطول.

- مواد تنظيف: كيفية اختيار معجون أسنان جيد:

- 1- استخدم فقط معجون الأسنان الموصى به.
- 2- لا تستخدم معجون أسنان يُهَيِّج اللثة.
- 3- لا تستخدم معجون أسنان يُخدش مينا الأسنان.
- 4- يجب أن يكون معجون الأسنان ذو نكهة نظيفة ومنعشة.

- التنظيف: كيفية تنظيف الأسنان:

1. بلل الفرشاة وضع كمية صغيرة من المعجون.
2. استخدم حركة دائرية لتنظيف الأسنان واللثة.
3. قسّم قوس الأسنان إلى ستة أقسام وهمية.
4. نظف كل قسم على حدة.
5. افرك جميع الأسطح الداخلية.

6. نظف الجزء الداخلي من القواطع بحركة لأعلى ولأسفل.
7. اشطف الفرشاة وكرر عملية التنظيف بالماء النظيف.
8. استخدم خيط الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان.
9. ذلك اللثة أثناء تنظيف الأسنان.
10. يجب استخدام أعواد الأسنان بحذر لتجنب إتلاف أنسجة اللثة.

- الأمراض: كيفية مكافحة عدوى الفم:

- 1- لا تستخدم الأسنان كملزمة.
- 2- لا تنظف الأسنان بأشياء صلبة.
- 3- الحصول على رعاية جيدة للأسنان.
- 4- إزالة الأسنان التي تسبب الضغط.
- 5- استخدام غسول فم جيد ومعقم.
- 6- لا تستخدم فرشاة أسنان أي شخص آخر.
- 7- تجنب استخدام أدوات أو أكواب الشرب الخاصة بشخص آخر.
- 8- لا تسبح في المسابح الملوثة.
- 9- استشر طبيب أسنانك في حالة حدوث أي عدوى في الفم.
- 10- لا تضع فمك على صنوبر مياه الشرب العامة.
- 11- لا تضع المفاتيح أو الأقلام أو أي أشياء أخرى في فمك.

- العناية بالأسنان: كيفية الحصول على الخدمات المهنية واستخدامها:

- 1- اختر طبيب أسنان خريج كلية طب أسنان معترف بها.
- 2- اطلب منه النصيحة.
- 3- لا تختار طبيب أسنان لا يؤمن بطب الأسنان الوقائي.
- 4- تأكد من أنه يلبي معاييرك.
- 5- اختر طبيب أسنان يُشعرك بالراحة أثناء علاج أسنانك.

صحة الأجهزة والحواس

1

صحة جهاز التنفس:

الجهاز التنفسي:

تأتي كلمة "الجهاز التنفسي" من كلمة لاتينية تعني "يتنفس". الجهاز التنفسي له علاقة بالتنفس. وهي تشمل أكثر من الرئتين. فهو يشمل جميع الأنابيب والأكياس الهوائية التي تمتلئ وتفرغ عندما يتنفس الشخص. تساعد العضلات على توسيع الرئتين وتحريك الهواء داخل وخارج الرئتين. وتعمل الأعصاب في الدماغ تلقائيًا على عمل العضلات.

يشمل الجهاز التنفسي الأنف والفم والقصبه الهوائية وصندوق الصوت والرئتين. معظم الناس لا يلاحظون متى تعمل هذه الأعضاء. لكن كل عضو يلعب دورًا كبيرًا في التنفس.

جهاز الصوت:

يوجد في الجزء العلوي من القصبه الهوائية هيكل يسمى صندوق الصوت أو الحنجرة. يتم استخدامه في التحدث والغناء وإصدار أصوات أخرى. يوجد داخل الحنجرة الحبال الصوتية. وهي طيات صغيرة من الأنسجة الرخوة. عندما يحدث التنفس، تتباعد هذه الطيات. ويسمح هذا للهواء بالتحرك بحرية عبر صندوق الصوت. فعادة ما يتم الاستنشاق قبل أن يتم التحدث وعندما تكون مستعدًا للتحدث، تتحرك ثنايا الحنجرة معًا. وأثناء الزفير، فإن الهواء من رئتيك يجعل الطيات تهتز. والاهتزاز يصدر صوتًا.

القصبات الهوائية:

البلعوم هو المنطقة الموجودة في الجزء العلوي من الحلق. ثم ينتقل الهواء عبر صندوق الصوت وأسفل القصبه الهوائية أو القصبه الهوائية. هو عبارة عن أنبوب يبلغ عرضه تقريبًا خرطوم الحديقة. ويبلغ طولها عند البالغين حوالي 4.5 بوصة (11 سم). ينقسم الجزء السفلي من القصبه الهوائية إلى فرعين. فرع واحد يؤدي إلى الرئة اليمنى. الآخر يؤدي إلى الرئة اليسرى. كل فرع يسمى القصبه الهوائية. ويطلق على الفرعين معًا اسم القصبات الهوائية. تنقسم كل قصبه إلى فروع أصغر وأصغر. تصبح الفروع صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالكاد. في نهايات أصغر الفروع توجد أكياس هوائية تسمى الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية لها جدران رطبة ورقيقة وحساسة. تلتف الأوعية الدموية الصغيرة حول الجزء الخارجي من كل كيس.

التنفس:

يعد التنفس مهم جدًا. ويحدث لسببين رئيسيين:

- يساعد الأنسجة في الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه الجسم.
- يساعد على التخلص من غازات العادم التي تسمى ثاني أكسيد الكربون.

يتكون الهواء من عدة غازات مختلفة. الغاز الرئيسي هو النيتروجين. يتكون ما يقرب من أربعة أخماس الهواء من هذا الغاز. يشكل الأكسجين حوالي خمس الهواء. يتكون الهواء المتبقي من العديد من الغازات

بكميات صغيرة جداً، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون. تحتاج جميع أنسجة وأعضاء الجسم إلى الأكسجين لتعمل بشكل صحيح.

لا يمكن للقلب أن ينبض بدون أكسجين. ولا يمكن للدماغ أن يفكر بدون. ولا تستطيع عضلات الذراع والساق الحركة إلا إذا حصلت على الأكسجين. عندما تقوم الأنسجة والأعضاء بعملها، فإنها تخلق مواد النفايات. واحد من هؤلاء هو ثاني أكسيد الكربون. ويجب إزالة هذا الغاز حتى تستمر الأنسجة في العمل. ووظيفة الجهاز التنفسي هي جلب الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

حماية جهاز التنفس:

من المهم عند مناقشة حماية الجهاز التنفسي فهم المصطلحات المستخدمة لوصف مخاطر الاستنشاق:

- الأبخرة الضبابية (Vapors): هي الشكل الغازي للمواد التي عادة ما تكون في الحالة الصلبة أو السائلة في درجة حرارة الغرفة وتتكون عن طريق التبخر. غالباً ما تنتج المذيبات أبخرة، على سبيل المثال، التولوين وكلوريد الميثيلين. توجد الغازات كجزيئات فردية في الهواء عند درجة حرارة الغرفة. وتشمل الأمثلة غازات اللحام وأول أكسيد الكربون والأكسجين والنيتروجين.
- الغبار الجوي (Aerosols): هو مصطلح يستخدم على نطاق واسع لتمثيل العديد من الأنظمة ذات المرحلتين المكونة من معلق للجسيمات السائلة أو الصلبة في الغاز، وعادة ما يكون الهواء، مع الإشارة إلى أي أجزاء من الجسيمات الصلبة باسم "الجسيمات".
- الغبار (Dusts): هي الجسيمات الصلبة التي تتشكل أو تتولد من المواد الصلبة من خلال عمليات ميكانيكية مثل التكسير أو الطحن أو الحفر أو الكشط أو التفجير. أمثلة: غبار الرصاص والسيليكا.
- الأبخرة (Fumes): الجسيمات الصلبة التي تتكون عندما يتبخر معدن أو مادة صلبة أخرى وتتكثف الجزيئات أو تتصلب في الهواء البارد. أمثلة: أبخرة المعادن من الصهر أو اللحام، والأبخرة من حقن البلاستيك أو عمليات القولبة بالحقن.
- الرذاذ (Mists): قطرات صغيرة من السائل معلقة في الهواء. غالباً ما يتولد عن طريق التكثيف أثناء التحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة أو عن طريق الرش أو الرغوة أو التفطيت. أمثلة: ضباب الزيت الناتج عن عمليات قطع المعادن، والضباب الحمضي من الطلاء الكهربائي، ورذاذ الطلاء.
- الدخان (Smoke): جزيئات الكربون أو السخام الناتجة عن الاحتراق غير الكامل للمواد القائمة على الكربون مثل الفحم أو الزيت. غالباً ما يحتوي على قطرات (سائلة)، جنباً إلى جنب مع جزيئات جافة.

جهاز التنفس الصناعي هو نوع من "معدات الحماية الشخصية" (PPE) المصممة لحماية الفرد من التعرض الاستنشاق الضار، مثل المواد الكيميائية والجسيمات. وفي ظل "التسلسل الهرمي للضوابط" التقليدية، فإن معدات الحماية الشخصية هي "الملاذ الأخير"، ولا يعتمد عليها إلا عند استنفاد خيارات استبدال المواد، والرقابة الهندسية، والرقابة الإدارية.

تعمل أجهزة التنفس إما عن طريق الإزالة المادية للملوثات من الهواء الذي يتم استنشاقه أو عن طريق توفير هواء نظيف قابل للتنفس.

فئة المرشح	مقاومة رذاذ الزيت	كفاءة المرشح
N95	مقاومة معدومة	يرشح 95% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء وخالية من رذاذ الزيت.
N99	مقاومة معدومة	يرشح 99% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء وخالية من رذاذ الزيت.
N100	مقاومة معدومة	يرشح 99.97% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء وخالية من رذاذ الزيت.
R95	مقاومة متوسطة	يرشح 95% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء، ولكن مقاومة بسيطة لرذاذ الزيت.
P95	مقاومة قوية	يرشح 95% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء، ومقاومة قوية لرذاذ الزيت.
P99	مقاومة قوية	يرشح 99% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء، ومقاومة قوية لرذاذ الزيت.
P100	مقاومة قوية	يرشح 99.97% من الجسيمات المحمولة في الهواء. لأي جسيمات صلبة أو سائلة محمولة في الهواء، ومقاومة قوية لرذاذ الزيت.

يختلف اختيار العبوات المتاحة بين الشركات المصنعة لأجهزة التنفس الصناعي. على غرار مرشحات الجسيمات، حيث يتبع مصنعو العبوات الكيميائية اتفاقية مشتركة، من خلال استخدام معايير مثل ANSI K-13-1973 أو ANSI / AIHA / ASSE Z88.7-2010، للترميز اللوني للملصقات المستخدمة للتمييز بين عبوات التنفس، على سبيل المثال، أسود = بخار عضوي، أبيض = غاز حمضي، أخضر = غاز أمونيا، إلخ.

استخدام معدات الوقاية الشخصية في الرعاية الصحية:

تشكل الأمراض المعدية الناشئة والعائدة للظهور تهديدًا مستمرًا على مستوى العالم. يتم استخدام العديد من تدابير مكافحة العدوى الصيدلانية وغير الصيدلانية في الرعاية الصحية والمجتمعية للسيطرة على الأمراض المعدية. حيث ركزت معظم الأبحاث على التدابير الصيدلانية مثل الأدوية واللقاحات، لكن معدات الحماية الشخصية (PPE) وغيرها من التدابير غير الصيدلانية غالبًا ما تكون أول حماية متاحة للمستجيبين في الخطوط الأمامية.

يتم تصنيف تدابير مكافحة العدوى بشكل عام وفقًا لثلاثة مستويات من التسلسل الهرمي:

1. تدابير الرقابة الإدارية.

تشمل التخلص من المخاطر والاستبدال والضوابط الهندسية. تتطلب هذه الضوابط تطوير السياسات والإجراءات، وإسناد المسؤوليات، وتقييم المخاطر، والتحكم في المصادر، والتعليم، والتدريب.

2. تدابير الرقابة البيئية.

تشمل تدابير تهدف إلى الحد من انتشار العدوى من خلال تصميم الغرفة، والعزل وتدابير تبادل الهواء مثل التهوية المناسبة، وإنشاء غرف عزل العدوى المنقولة بالهواء وأنظمة للتنظيف والتخلص من النفايات.

3. استخدام معدات الحماية الشخصية.

تشمل الملابس أو المعدات المستخدمة للحماية من المواد البيولوجية والكيميائية وغيرها من المواد الخطرة مثل القفازات والعباءات والمآزر والنظارات الواقية ودروع الوجه والقبعات الجراحية وأقنعة الوجه وأجهزة التنفس. وتعتبر معدات الحماية الشخصية هي خط الدفاع الأخير في التسلسل الهرمي لمكافحة العدوى ويوصى بها مع تدابير مكافحة العدوى الأخرى. ومع ذلك، في حالة تفشي المرض أو حدوث جائحة، قد تكون طبيعة العامل الممرض غير معروفة وقد لا تتوفر الأدوية واللقاحات في المرحلة المبكرة، مما يجعل معدات الوقاية الشخصية بالغة الأهمية.

أنواع معدات الحماية الشخصية:

تستخدم أنواع مختلفة من معدات الوقاية الشخصية في أماكن الرعاية الصحية والمجتمع للحماية من التهابات الجهاز التنفسي وغيرها. حيث يمكن تصنيفها إلى:

- حماية الجهاز التنفسي (أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي).
- حماية الجلد (بدلة أو رداء / مريلة للجسم بالكامل، غطاء / غطاء جراحي، قفازات وأحذية / غطاء حذاء).
- حماية العين (نظارات واقية أو واقي للوجه).

أمراض الجهاز التنفسي:

تؤثر السلامة والصحة المهنيان بشكل مباشر على صحة الجهاز التنفسي. يمكن أن يؤدي التعرض المهني إلى مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي، من أمراض الشعب الهوائية إلى أمراض الرئة الخلالية.

- الربو المهني:

هو أكثر أمراض الرئة المهنية شيوعًا على مستوى العالم ولا يتم تقديره بشكل عام. تشير التقديرات إلى أن 10-15٪ من حالات الربو عند البالغين مرتبطة بالتعرض المهني، ويبلغ حوالي 20٪ من المصابين بالربو عن تفاقم أعراض الربو بسبب التعرض في مكان العمل. يمكن تقسيم الربو المهني إلى ثلاث فئات رئيسية:

- الربو المهني.
- الربو المتفاقم في العمل.
- الربو الناجم عن التهيج (مرض مجرى الهواء التفاعلي الحاد).

- أمراض الرئة المرتبطة بالزراعة:

يعمل غالبية المزارعين ويعيشون في البيئة الزراعية مما يشكل تحديات كبيرة في الإدارة حيث يكون الحد من التعرض ضروريًا. تتعرض زوجات المزارعين، حتى عند العمل خارج المزرعة، للعديد من عوامل الخطر نفسها التي يتعرض لها المزارعون أنفسهم. حيث تخلق الزراعة عرضًا فريدًا للتعرض. وتؤدي مجموعة المستضدات المحتملة المرتبطة بالعمل الزراعي إلى مجموعة من أمراض الرئة المهنية، وذلك بسبب كل من العمليات المناعية التي تتم بوساطة مناعية وغير مناعية. ومن هذه الأمراض:

- داء الرشاشيات (رئة المزارع).
- متلازمة سمية الغبار العضوي.
- مرض سيلو فيلر.

- أمراض الرئة المرتبطة بتصنيع الغذاء:

يستخدم ثنائي الأسيتيل على نطاق واسع في معالجة الأغذية، مما يمنح الأطعمة نكهة زبدة صناعية. على الرغم من اعتباره آمنًا بشكل عام للاستهلاك البشري، إلا أن استنشاق ثنائي الأسيتيل يرتبط بتطور التهاب القصيبات الحاد الساد.

- أمراض الرئة المرتبطة بصناعة المنسوجات:

من الأمراض المرتبطة بهذه الصناعة:

- مرض الرئة البنية أو السحار القطني.
- مرض الرئة الخلالي.

- أمراض الرئة المرتبطة بالصناعات الثقيلة:

من الأمراض المرتبطة بهذه الصناعة:

- السحار السيليسي.
- مرض الرئة المصاحب لغبار الفحم.

حماية الجهاز التنفسي:

1. النظافة من أهم طرق الوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، ويجب الحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة للتخلص من الجراثيم والفطريات.

2. الابتعاد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، لمنع انتقال أمراض الجهاز التنفسي من الأشخاص المصابين بالأمراض.
3. الحرص على الابتعاد عن الأشخاص المدخنين لأن التدخين يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التنفسي ويتسبب في إصابته بالأمراض.
4. الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية مما يعمل على تقوية العضلات واستنشاق الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.
5. الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها الدخان والغازات التي تضر الجهاز التنفسي التي تعمل على الإصابة بالأمراض مثل الربو والالتهابات التي تصيب الرئة والقصبه الهوائية.
6. تناول كمية كبيرة من السوائل التي تعمل على الحفاظ على رطوبة الجسم كما تعمل على التخفيف من إفرازات الرئتين.
7. وجود النباتات المختلفة في المنزل يعمل على تنقية الجو وزيادة نسبة الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون والأسيتون والأمونيا.
8. الحرص على التطعيمات التي تساعد على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والتي تقوي مناعة الجسم.
9. من المهم تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن، خاصة التي تحتوي على فيتامين سي، كما يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين.
10. أحماض أوميغا 3 تعد من الأحماض الهامة التي تساعد في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.
11. الحرص على أخذ الراحة الكافية، حتى لا يزيد المرض مع الشخص المصاب. من المهم الاهتمام بالصحة النفسية والتخلص من التوتر لأن له الكثير من الأعراض الجانبية للجهاز التنفسي.
12. الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية والتي تضر بالجهاز التنفسي. في حالة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة يجب الذهاب إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب.

صحة جهاز الهضم – صحة الفم:

جهاز الهضم:

يبدأ الجهاز الهضمي، وغالبًا ما ننسى، مع **تجويف الفم**. تطحن الأسنان الطعام قبل أن تدفعه عضلات البلعوم المخططة إلى المريء.

المريء عبارة عن أنبوب يبلغ قطره التقريبي 2.5 سم، والذي يسمح بمرور الطعام من تجويف الفم عبر التجويف الصدري إلى المعدة. يبدأ المريء من العضلة الحلقية البلعومية (أو العضلة العاصرة للمريء العلوية)، وتستمر حتى العضلة العاصرة للمريء السفلية قبل دخولها في تجويف البطن والمعدة. ينقسم المريء بشكل كلاسيكي إلى ثلاثة أجزاء متطابقة نسبيًا يتم تحديدها على أنها الثلث العلوي والمتوسط والسفلي من المريء.

المعدة هي عبارة عن كيس كبير على شكل حرف J يقع في الجزء العلوي الأيسر من البطن يعمل كخزان لعبور ومعالجة الطعام المبتلع إلى المريء وفي طريقه إلى الأمعاء الدقيقة حيث سيتم امتصاصه. يوجد عند مفترق الصدر والبطن، العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهي صمام أحادي الاتجاه لدخول الطعام إلى المعدة.

الأمعاء الدقيقة هو عبارة عن أنبوب طويل (طوله 3-4 أمتار وقطره 2-4 سم) يبدأ عند البوابة وينتهي عند الصمام اللفائفي (أو صمام بوهين) ويقع بين المعدة والقولون. يتم التعرف على ثلاثة أجزاء: الاثني عشر، والصائم، والدقاق. يبدأ العفج مباشرة بعد البواب وينتهي بعد 25-30 سم.

القولون يبلغ عرضه ما يقرب من 5 إلى 8 سم ويبلغ طوله من 80 إلى 150 سم ويبدأ بعد الصمام اللفائفي وينتهي عند فتحة الشرج. يفصل الصمام اللفائفي (أو صمام بوهين) الأمعاء الدقيقة عن القولون. ويتألف القولون من ثلاثة أجزاء: القولون الصاعد، والقولون المعترض، والقولون النازل.

المستقيم هو الجزء الأبعد من الأمعاء الغليظة، ويمتد من القولون السيني. يتم تمييز التقاطع بين الاثني عشر من خلال الزاوية المستقيمة السينية. يبلغ طوله حوالي 15 سم عند البالغين، وينتهي بشكل بعيد في القناة الشرجية.

الكبد يقع خلف القفص الصدري السفلي الأيمن، تحت الحجاب الحاجز. لذلك، عادة ما يكون ملموسًا فقط أثناء الاستنشاق. تبدو حدودها حادة ولكنها مرنة في الحالة الطبيعية. لها شكل مثلث، وهو أكبر عضو في جسم الإنسان، حيث يتراوح وزنه بين 1 و2 كغ حسب وزن الجسم. لون الكبد بني محمر بسبب تركيزه العالي في أصباغ الحديد. يتكون سطحها الأملس من كبسولة صغيرة جدًا (أقل من 1 مم على أقسام نسيجية)، تسمى كبسولة جليسون.

البنكرياس هو عضو خلف الصفاق يمكن تقسيمه إلى أربع مناطق تشريحية: الرأس، والعنق، والجسم، والذيل. ويعد عضو صلب يحتوي على قنوات البنكرياس الرئيسية والملحقة، بالإضافة إلى القناة الصفراوية المشتركة.

الشجرة الصفراوية تشمل القنوات الصفراوية والمرارة. حيث تسمح القنوات الصفراوية للصفراء التي يفرزها الكبد بالوصول إلى الاثني عشر (حيث ستلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الدهون). تبدأ داخل الكبد لتصل إلى القناة الكبدية المشتركة والقناة الصفراوية المشتركة (CBD)، وذلك عبر القنوات الصفراوية خارج الكبدية اليمنى واليسرى. ثم تنضم المرارة إلى منطقة التدفق المركزية عن طريق القناة الكيسية، التي يحدد موضعها الترسيم بين القناة الكبدية المشتركة (المنبع) والقناة الصفراوية المشتركة (المصب).

أمراض الجهاز الهضمي:

- الإسهال (Diarrhea):

يشير الإسهال، بلغة الطب العلمي، إلى حالة يكون فيها وزن البراز أكبر من 200 جرام في اليوم. في الممارسة السريرية، يستخدم مصطلح "الإسهال" من قبل المرضى (والأطباء) لوصف البراز الغزير جدًا أو المتكرر جدًا (البراز الطبيعي، 1-3 مرات في اليوم)، أو اللين جدًا (أو السائل)، أو العاجل، أو صعب للاحتفاظ (سلس البول).

يمتص الجهاز الهضمي (أي المرور من تجويف الأمعاء إلى الجسم) العناصر الغذائية والركائز الأساسية للحياة، ولكنه أيضًا يفرز (أي المرور من الجسم إلى الجهاز الهضمي) المحاليل المستخدمة في عملية الهضم / الامتصاص الحيوية هذه (على سبيل المثال، 1 لتر من اللعاب، 2 لتر من إفرازات المعدة، 2 لتر من إفرازات البنكرياس، 1 لتر من الإفرازات الصفراوية، 1 لتر من إفرازات الأمعاء، إلخ).

البراز المطرود مصنوع من مواد لا تمتصها الأمعاء، وبالتالي فهي النتيجة الصافية للوظائف الإفرازية والامتصاصية في الجهاز الهضمي. قد تشمل الزيادة في البراز والإسهال الأمعاء الدقيقة و / أو القولون. بطريقة مبسطة، يمكننا فهم الفيزيولوجيا المرضية للإسهال باستخدام المفاهيم التكميلية للمفاهيم الأفقية والعمودية

- انتفاخ البطن (Abdominal Bloating):

قد يكون بسبب الهواء أو السوائل أو المواد الصلبة التي تتسبب في تمدد البطن. في الفحص البدني، سيساعد الإيقاع الرقمي في التمييز بين انتفاخ الهواء (الإيقاع مع أصوات الرنين) والأسباب الأخرى (الإيقاع مع الأصوات الباهتة). قد يكشف جس البطن عن كتل سائلة أو صلبة مقيدة أكثر أو أقل. في الفحوصات الإشعاعية، يمكن رؤية الهواء بسهولة في صورة أشعة سينية بسيطة للبطن؛ سيتم التعرف على المكونات السائلة أو الصلبة عن طريق الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية.

- الاستفراغ والغثيان (Nausea and Vomiting):

الغثيان هو إحساس غير سار بالشعور بالقيء. أما القيء فيشير إلى الطرد الفموي المفاجئ والقوي لمحتوى المعدة (وربما يشمل مادة من الاثني عشر أو الأمعاء البعيدة مع القيء الصفراوي أو البراز) بسبب حركات الجهاز الهضمي المضادة للالتهاب المصحوبة بانقباضات في عضلات البطن والحجاب الحاجز. يختلف القيء عن القلس، وهو ارتداد سهل لمحتويات المعدة إلى المريء (والتي يمكن أن تصل إلى الفم).

- الإمساك (Constipation):

غالبًا ما يتم تحديد الإمساك، في المجتمع الطبي، على أنه حالة يكون فيها عدد البراز اليومي منخفضًا (يتم تقدير التردد اليومي "الطبيعي" على أنه 1 ± 3 حركات أمعاء / يوم) و / أو الوزن (الوزن "الطبيعي" لـ البراز 200 جم / يوم تقريبًا). بالنسبة للمرضى، غالبًا ما يتعلق الإمساك بالشعور بعدم كفاية و / أو إخراج غير مرضٍ للبراز نادرًا (ليس بالقدر الذي يتوقعونه)، وعادة ما يكون صغير الحجم وقوامه صلبًا، ويصعب الإخراج (مع الإجهاد، إلخ).

يُدرج تصنيف روما الرابع لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية أن المريض يعاني من الإمساك إذا قدم على الأقل اثنين من العناصر التالية:

1. الإجهاد خلال أكثر من 4/1 من التغوط.
2. براز متكتل أو صلب أكثر من 4/1 من التغوط.
3. الإحساس بالإخراج غير الكامل لأكثر من 4/1 من التغوط.
4. الإحساس بانسداد / انسداد فتحة الشرج لأكثر من 4/1 من التغوط.
5. مناورات يدوية لتسهيل أكثر من 4/1 من التغوط.
6. أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع.

- السمنة (Obesity):

السمنة هي تراكم مفرط للدهون في الجسم. في البالغين، يعتمد تحديد الوزن الزائد والسمنة على مؤشر كتلة الجسم (BMI). مؤشر كتلة الجسم 25-29.9 كجم / م² يتوافق مع الوزن الزائد، < 30 كجم / م² للسمنة، و < 40 كجم / م² للسمنة المرضية. تزداد المضاعفات مع درجة زيادة الوزن. في الأطفال والمراهقين،

يتم تحديد الوزن الزائد بمؤشر كتلة الجسم < 85 بالمائة بالنسبة للعمر والجنس والسمنة بواسطة مؤشر كتلة الجسم < 95 بالمائة.

نوع توزيع الدهون في الجسم مهم. حيث يرتبط تراكم الدهون داخل البطن أو الحشوية بخطر أكبر للإصابة بأمراض التمثيل الغذائي والوفيات مقارنةً بتراكم الدهون المحيطة أو تحت الجلد أو الفخذ. محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الخصر يرتبطان بالسمنة داخل البطن وهما أفضل علامات خطر للأمراض المزمنة من مؤشر كتلة الجسم (وهو انعكاس للسمنة الكلية).

- اليرقان (Jaundice):

اليرقان يشير إلى اللون الأصفر للجلد الناجم عن تراكم البيليروبين بسبب زيادة البيليروبين في الدم (فرط بيليروبين الدم). يبدو لون الجلد مصفرًا، وفي حالة فرط بيليروبين الدم الحاد والمطول، قد يتخذ لونًا بنيًا أو أخضرًا. يُقترن البيليروبين في الكبد ويُفرز في البول. يسبب البيليروبين المترافق تلونًا داكنًا للبول (بول شبيه بالكوكاكولا في حالة اليرقان المصحوب بفرط بيليروبين البول). يؤدي عدم وجود إفراز البيليروبين من الكبد إلى الأمعاء إلى فقدان البراز للون البني ويصبح شاحبًا أو بلون الطين (براز أكولي).

حماية الجهاز الهضمي:

اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الطعام ببطء، وإدارة التوتر، وممارسة النشاط البدني بانتظام - هذه بعض التغييرات المهمة في نمط الحياة التي قد يكون لها تأثير كبير على صحة الجهاز الهضمي.

جسم الإنسان مصمم لهضم أنواع كثيرة من الأطعمة، لكن كل شخص مختلف. قد تؤدي بعض الأطعمة إلى ظهور علامات وأعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص ولكن ليس لدى آخرين. لهذا السبب لا توجد وصفة واحدة للحفاظ على أمعائك سعيدة. ولكن هناك بعض المبادئ الأساسية للهضم الجيد - الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب الحد منها - والتي تنطبق على معظم الناس.

تعتبر الأطعمة النباتية - الخضروات والفواكه والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة - مصادر ممتازة للألياف. مثل البازلاء والفاصوليا والتوت والخضر الورقية والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني. سيقبل الجهاز الهضمي تقريبًا أي طعام يتم إرساله في طريقه. ومع ذلك، تميل بعض الأطعمة إلى المرور بسهولة وسرعة عبره وتساعد على العمل بشكل صحيح. هذه الأطعمة غنية بالألياف الغذائية، وهي عنصر غذائي يعد جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي ومهم بشكل خاص لعملية الهضم. الألياف هي جزء من الغذاء النباتي غير قابل للهضم ولا يمتصه جسمك. حيث تأتي الألياف في شكلين:

- قابل للذوبان.

- غير قابل للذوبان.

وعادة ما تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على كلا الشكلين. تمتص الألياف القابلة للذوبان ما يصل إلى 15 ضعف وزنها في الماء أثناء تحركها عبر الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه براز أكثر ليونة. بينما الألياف غير القابلة للذوبان تعطي البراز حجمه.

بعض النصائح للمساعدة في تحسين عملية الهضم:

1. تناول كميات معتدلة.
2. تناول الطعام في الصباح.
3. تناول الطعام في أوقات منتظمة.
4. الاسترخاء أثناء الأكل.
5. الجلوس باعتدال عند تناول الطعام.

النشاطات البدنية:

النشاط البدني مهم جداً لعملية الهضم. يساعد النشاط البدني اليومي على تسريع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على وزن صحي. يشير النشاط البدني إلى أي حركة تقوم بحرق السعرات الحرارية، مثل البستنة وتنظيف المنزل أو أخذ استراحة ممتدة من مكتبك.

التمرين هو شكل منظم ومتكرر من النشاط البدني، مثل دورات السباحة وركوب الدراجات والمشي السريع ورفع الأثقال. تعتبر التمارين الهوائية - وهي التمارين التي تزيد من معدل التنفس وضربات القلب - مفيدة جداً لعملية الهضم الصحية. التمارين الهوائية تحفز نشاط عضلات المعدة والأمعاء، مما يساعد على نقل الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي. وتساعد التمارين الهوائية أيضاً على فقدان الوزن.

صحة الأجهزة والحواس

2

الهيكل العظمي:

يوجد أكثر من 200 عظمة منفصلة في الهيكل العظمي البشري البالغ. ويمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات حسب شكلها الأساسي. تم العثور على عظام طويلة في الأطراف وتأخذ شكل أنابيب مجوفة مغلقة من كلا الطرفين. وتأخذ العظام المسطحة شكل صفائح عظمية عريضة (على سبيل المثال العظام التي تشكل الجمجمة)، والعظام غير المنتظمة، كما يوحي اسمها، لا تتناسب مع أي من الفئات المذكورة أعلاه بسبب شكلها غير المنتظم. من أمثلة العظام غير المنتظمة الفقرات وعظام قاعدة الجمجمة.

مكونات العظام:

العظام مادة مركبة تتكون من جزء عضوي وغير عضوي (معدني). بالوزن، تتكون العظام الجافة من حوالي 64٪ من المعادن و26٪ من المواد العضوية و10٪ المتبقية عبارة عن ماء مرتبط داخل بنية العظام. الغالبية العظمى من المكون العضوي هو الكولاجين، وهو بروتين يشكل أليافاً طويلة. يتكون الجزء المعدني من بلورات صغيرة مدمجة في مصفوفة من ألياف الكولاجين. يتألف معدن العظام بشكل رئيسي من هيدروكسي أبات، وهو شكل من أشكال فوسفات الكالسيوم الذي يقارب تركيبه الصيغة الكيميائية $Ca_{10}(OH)_2(PO_4)_6$. يمنح المكون المعدني العظم صلابته، ويمنحه المكون العضوي مرونة مما يمنحه قوته. يتحلل الجزء العضوي بعد الموت، والذي يفسر بشكل أساسي الطبيعة الهشة إلى حد ما لمعظم العظام الأثرية.

من حيث التركيب الإجمالي، هناك نوعان مختلفان من أنسجة العظام، العظم القشري والتريبيقي:

❖ العظم القشري: هو الجزء الصلب والكثيف الذي يشكل الطبقة الخارجية من العظام. وهو الأثخن في أغشية العظام الطويلة. تشكل طبقة رقيقة حول نهايات العظام الطويلة وحول العظام المسطحة وغير المنتظمة.

❖ العظم التريبيقي: أقل كثافة من العظم القشري وله بنية قرص العسل. يقع العظم التريبيقي في نهايات العظام الطويلة وفي داخل العظام المسطحة وغير المنتظمة.

في العظام الحية، يُحاط معظم السطح الخارجي بغشاء رقيق، وهو السمحاق. تصطف الجدران الداخلية للتجاويف النخاعية للعظام الطويلة بغشاء آخر، وهو بطانة العظم، والذي يبطن أيضاً شبكة التجاويف الصغيرة في العظم التريبيقي.

الخلايا العظمية:

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من خلايا العظام:

❖ بانيات العظم: وهي المسؤولة عن تكوين عظام جديدة.

❖ الخلايا العظمية: الحفاظ على العظام كنسيج حي.

❖ ناقضات العظم: وهي المسؤولة عن ارتشاف (إزالة) العظم.

غالبًا ما تتركز بانيات العظم على أسطح العظام (على سبيل المثال، تحت السمحاق). فهم مسؤولون عن إنتاج المصفوفة العضوية والتي يتم تمعدنها بعد ذلك لتشكيل العظام. توجد الخلايا العظمية في فراغات

(ثغرات) داخل أنسجة العظام. يتلقون المغذيات عبر قنوات دقيقة (القنوات) التي تربط ثغرات الخلايا العظمية داخل نفس الصفائح أو تلك المجاورة. وتمتص ناقضات العظم النسيج العظمي عن طريق الانحلال الحمضي للمكون المعدني والتدهور الإنزيمي للمرحلة العضوية.

أمراض العظام:

كل مرض فريد من نوعه، ولكن من أجل توفير إطار للنقاش، من المفيد تصنيف تلك التي تؤثر على الهيكل العظمي بطريقة ما. يظهر التصنيف على أساس سبب المرض والتغيرات المرضية في العظام:

❖ **التشوهات الخلقية:** وهي موجودة منذ الولادة، إما نتيجة لعيوب جينية أو بسبب مشاكل أثناء الحمل. وهي تتراوح في شدتها من تلك التي لا تتوافق مع الحياة إلى تلك التي لا تسبب أي أعراض.

❖ **التشوهات المكتسبة:** وتنقسم إلى:

- التهابية.
- ورمية (الأورام والحالات ذات الصلة).
- الأمراض الناتجة عن الاختلالات أو النقص الأيضي والغذائي.
- اعتلال المفاصل (أمراض المفاصل).

- **ترقق العظام (Osteoporosis):**

يشكل ترقق العظام مشكلة صحية عامة رئيسية، من خلال ارتباطه بالكسور المرتبطة بالعمر، وخاصة في الورك والفقرات والساعد القاصي والعضد، مع عواقب وخيمة من حيث المراضة والوفيات. يتسبب مرض هشاشة العظام في جميع أنحاء العالم في حدوث أكثر من 8.9 مليون كسر سنوياً، مما يعني أنه في المتوسط، يحدث كسر هشاشة العظام كل 3 ثوانٍ.

- **الورم العظمي (Osteosarcoma):**

هو ورم عظمي نادر يصيب بشكل رئيسي المرضى الصغار. ونظراً لأنه لديه ميل كبير للانتشار، فقد تم تصنيفه ضمن أكثر مصادر الوفيات المرتبطة بالسرطان في أورام الطفولة. وعلى الرغم من تحسن معدل بقاء مرضى هذا الورم نتيجة للتقنيات الجراحية المحسنة والعلاج الكيميائي متعدد العوامل، فإن بقاء المرضى الذين يصابون بالنقائل لا يزال منخفضاً. لذلك، فإن الفهم الأكثر تفصيلاً للآليات الجزيئية والتعرف المحدد للعلامات الحيوية المشاركة في بدء الورم وتطوره وتشكيل النقائل له أهمية فورية لتطوير استراتيجيات علاج جديدة ومحسنة.

- **التهاب العظم (Osteitis):**

تحدث العدوى بسبب الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. قد تبدأ الآفات المعدية في الهيكل العظمي بسبب تعرض العظم للبيئة الخارجية، على سبيل المثال، عند كسر مفتوح (أي مركب)، أو قد يكون امتداداً مباشراً لعدوى الأنسجة الرخوة إلى العظم المجاور. على سبيل المثال، قد تحدث الآفات المعدية للأضلاع

بسبب ملامسة التهابات الرئة المجاورة مثل السل، أو قد تحدث التهابات الطنوب بسبب الآفات الجلدية العلوية. في كثير من الأحيان، لا يكون مرض الهيكل العظمي ناتجاً عن عدوى مباشرة في العظام ولكن بسبب الانتشار الثانوي للمرض، عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي، من العدوى الأولية في الأنسجة الرخوة.

- أمراض العظم نتيجة سوء التغذية:

أمراض العظام الأيضية هي تلك التي يحدث فيها خلل في التوازن الطبيعي بين تكوين العظام وارتشاف العظام بسبب بعض الاضطرابات الأيضية. قد تكون ناجمة عن نقص التغذية أو عدم التوازن، أو قد تنشأ لأسباب أخرى. تشمل الأمراض الأيضية الأخرى التي تم التعرف عليها في بقايا الهيكل العظمي الاسقربوط ومرض باجيت الذي يصيب العظام.

- الكساح (Rickets):

هو مرض استقلابي تم التعرف عليه في بقايا الهيكل العظمي، هو مرض يصيب الأطفال وهو فشل في التمعدن المناسب لنمو العظام بسبب عدم توفر فيتامين د بشكل كافٍ. معظم فيتامين د في الإنسان ليس غذائياً ولكنه يتم تصنيعه في الجسم عن طريق تأثير أشعة الشمس على مادة في الجلد. وبالتالي، فإن معظم الكساح لا ينتج عن اختلال التوازن الغذائي ولكن بسبب عدم تعرض الجلد لأشعة الشمس بشكل كافٍ. تصبح العظام ضعيفة التمعدن مثنية ومشوهة، خاصة تلك الموجودة في الساقين، وقد تستمر هذه التشوهات حتى سن البلوغ.

طرق الحفاظ على صحة الهيكل العظمي:

1. تناول نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالكالسيوم وفيتامين د.
2. ممارسة الكثير من النشاط البدني.
3. عيش حياة صحية.
4. التحدث إلى الطبيب حول صحة العظام.
5. منع السقوط.

جهاز الدوران والقلب:

يقوم جهاز الدوران بنقل الدم من وإلى كل جزء من أجزاء الجسم. يشمل هذا النظام الدم والقلب وجميع الأوعية الدموية. التدوير يعني التحرك في دائرة. الدم لا يصنع دائرة لأنه يتدفق عبر الجسم. ولكن مع تحرك الدم، فإنه يستمر في العودة من خلال القلب.

القلب هو العضو الذي يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. وله أربعة أقسام، أو غرف بداخله. غرفتان في الأعلى واثنان في الأسفل. تسمى كل غرفة علوية الأذين. كل غرفة سفلية تسمى البطين. يحتوي القلب على الأذين الأيمن والبطين الأيمن. على الجانب الآخر، يوجد به الأذين الأيسر والبطين الأيسر.

في كل مرة ينبض فيها القلب، يضغط ويخرج الدم. يتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية. هناك أنواع مختلفة من الأوعية الدموية. هم الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة. الدم المتدفق بعيداً عن القلب يتحرك عبر الشرايين. والشرايين لها جدران عضلية ومرنة. تنبض جدران الشرايين الرئيسية أو تنبض في كل مرة ينبض فيها القلب. عندما تشعر بنبض في معصمك أو رقبتك، فإنك تشعر بخفقان في الشريان. تضرب الشرايين بسبب تدفق الدم من خلالها. تنقسم الشرايين البعيدة عن القلب إلى أوعية أصغر. تصبح الأوعية صغيرة جداً بحيث لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر. تسمى هذه الأوعية الشعيرات الدموية.

بعد التدفق عبر الشعيرات الدموية، يبدأ الدم في العودة إلى القلب. تبدأ الشعيرات الدموية الصغيرة في التجمع. ينضمون لتشكيل أشعار أكبر. تسمى هذه الأوعية الأوردة. فهي تنقل الدم إلى القلب. جدران الأوردة ليست سميكة وعضلية مثل تلك الموجودة في الشرايين. والأوردة لا تنبض مع كل نبضة قلب. تحتوي الجدران الداخلية للعديد من الأوردة على لوحات صغيرة تسمى الصمامات. تجتمع الصمامات معاً لمنع الدم من التحرك للخلف. هذا يحافظ على تدفق الدم نحو القلب.

الدم عبارة عن سائل يحتوي على مواد مختلفة. إحدى المواد هي البلازما. تتكون البلازما بشكل أساسي من الماء ولها لون القش. تحمل البلازما العناصر الغذائية وخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية في جميع أنحاء الجسم. معظم خلايا الدم هي خلايا حمراء. تبدو خلايا الدم الحمراء مثل كعكة الدونات المسطحة. تحمل الخلايا الحمراء الأكسجين إلى الخلايا الأخرى في الجسم. يوجد عدد أقل من خلايا الدم البيضاء مقارنة بالخلايا الحمراء. لكن خلايا الدم البيضاء لها وظيفة مهمة للغاية. إنهم يدافعون عن الجسم ضد الجراثيم المسببة للعدوى. تجد الخلايا البيضاء جراثيم لا تنتمي إلى الجسم. في بعض الأحيان تلتصق الخلايا البيضاء بالجرثومة وتدمرها.

العوامل المؤثرة على الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية:

تعتبر العوامل التالية بشكل عام من العوامل الرئيسية التي يمكن السيطرة عليها من الأمراض القلبية الوعائية:

- ارتفاع ضغط الدم:

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجبار القلب على العمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى زيادة حجمه وضعفه بمرور الوقت. كما أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب الاحتقاني والفشل الكلوي. عندما يترافق ارتفاع ضغط الدم مع السمنة أو التدخين أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أو مرض السكري، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يزيد عدة مرات.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم:

تزداد فرصة الإصابة بأمراض القلب التاجية عندما ترتفع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. عندما يكون لدينا عوامل خطر أخرى (مثل ارتفاع ضغط الدم)، تزداد فرصة الإصابة به بشكل أكبر. على

الرغم من أن مستويات الدهون تتأثر بالعديد من العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل العمر والجنس والوراثة، يمكننا في كثير من الأحيان السيطرة عليها من خلال التدخل الغذائي وزيادة التمارين الرياضية. في الواقع، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد يؤدي انخفاض مستويات الكوليسترول بنسبة 10% فقط إلى انخفاض بنسبة 30% في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

- التدخين:

في الماضي، كان التدخين مرتبطًا عادة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة. ومع ذلك، فإنه يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية الطرفية (مرض في الأوعية التي تمد الذراعين والساقين بالدم).

- السمنة:

يزيد الوزن أكثر بقليل من المثالي بالنسبة للطول من خطر الإصابة بأمراض القلب. كلما زاد عدد الأرطال عن الوزن المثالي، زاد عامل الخطر. إن تجاوز الوزن المثالي بنسبة 30% يضع ضغطًا حقيقيًا على القلب ويرفع ضغط الدم.

- الخمول البدني:

الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 30% إلى 50% وخطر الإصابة بنوبة قلبية أكبر من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

- داء السكري:

تزيد الإصابة بمرض السكري من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون به من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ويعانون من زيادة الوزن.

- الضغط العصبي:

مصطلح "الإجهاد" في الحقيقة لا يحتاج إلى مقدمة. كلنا نعرف ما هو الضغط. نشعر به كل يوم. ببساطة، الإجهاد هو النتيجة النهائية للصراع بين متطلبات الحياة وقدرتنا على تلبية تلك المطالب. ما يسبب لنا التوتر، وكيف نتفاعل مع هذا الضغط، هو فردي مثلنا. الضغوطات الأكثر شيوعًا هي الأسرة والعمل والشؤون المالية.

من العوامل المساهمة أخرى:

- الإفراط في تناول الكحول.
- الهرمونات الجنسية.
- حبوب منع الحمل.

أمراض القلب والأوعية:

على الرغم من أن المرض المعني يشار إليه عادة باسم "أمراض القلب"، فإن المصطلح الرسمي والأكثر شمولاً هو أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD). وهذا يشمل أي اضطراب يصيب القلب أو الأوعية الدموية. في الواقع، يمكن أن تأخذ الأمراض القلبية الوعائية عدداً من الأشكال، كثير منها متداخل. يتيح لنا مصطلح "القلب والأوعية الدموية" أيضاً معرفة أنه على الرغم من أن القلب هو بالتأكيد اللاعب الأكثر قيمة في أجسامنا، إلا أنه يعتمد على الأوعية الدموية والرننتين في العمل.

يقوم نظام القلب والأوعية الدموية لدينا بالكثير من العمل:

- مع كل نبضة قلب، ينقل مجرى الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى ما يقرب من 300 تريليون خلية في الجسم.
- يضخ القلب "السائل" مليون برميل من الدم في متوسط العمر. هذا يكفي لملء 3.3 ناقلة عملاقة. (تخيل كمية الدم التي يضخها أثناء التمرين أو أوقات الإجهاد، عندما يعمل بجهد أكبر).
- في غضون 50 عامًا، تكفي الطاقة التي يبذلها القلب لرفع سفينة حربية من الماء.

على سبيل المثال، مرض القلب التاجي، والذي يبدأ عندما تتراكم اللويحات (التي تتكون من الكوليسترول والدهون أو الدهون الأخرى، والكالسيوم، ومادة تخثر الدم تسمى الفيبرين)، وفي النهاية تضيق أو تسد الشرايين التاجية. تحدث هذه الحالة، المعروفة باسم تصلب الشرايين، بشكل تدريجي على مدار فترة زمنية.

- ارتفاع ضغط الدم:

يضخ القلب الدم عبر الأوعية الدموية، ويتم دفع الدم على جدران الأوعية الدموية. هذا يخلق ضغطاً يسمى ضغط الدم. يتطلب الجسم هذا الضغط لتحريك الدم في جميع أنحاء نفسه. حتى يتمكن كل جزء من الجسم من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه. الشرايين السليمة مرنة وتتمدد للسماح بدخول المزيد من الدم من خلالها. يعتمد تمددها على مدى شدة ضغط الدم على جدران الشرايين. من المهم أن يكون ضغط الدم ضمن النطاق الصحي للبقاء بصحة جيدة. يستخدم جهاز يسمى مقياس ضغط الدم لقياس ضغط الدم. يتم تسجيل ضغط الدم كرقمين:

- ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى): يشير إلى الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين أثناء ضخ القلب للدم.
- ضغط الدم الانبساطي (الرقم الأدنى): يشير إلى الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين أثناء استراحة القلب بين الضربات.

العوامل التي تؤثر على ضغط الدم:

1. قلة النشاط البدني.
2. الضغط العصبي.
3. ساعات العمل الطويلة.
4. تناول الملح.

- تصلب الشرايين:

هو تصلب الشريان الذي يسبب فقدان القدرة على التمدد. من ناحية أخرى، يؤدي تصلب الشرايين إلى تكوين طبقة من الدهون في البطانة الداخلية لجدار الأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص الشرايين. تصلب الشرايين هو مرض التهابي ينشأ داخل البطانة الوعائية ويتطور ليصبح لويحة ليفية. بمرور الوقت، يصلب محتوى اللويحة الدهنية ويجعل الوعاء أكثر صلابة ويضيق حجم التجويف، مما يتداخل مع إمداد الدم الطبيعي للأنسجة. يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

- مرض القلب التاجي:

هو اضطراب في الأوعية الدموية يشمل الشرايين التاجية التي تصحح مسدودة بسبب تراكم الكوليسترول والمواد الأخرى التي يشار إليها باسم اللويحات على جدرانها الداخلية.

يؤدي الانسداد الجزئي إلى إبطاء تدفق الدم، مما يؤدي بدوره إلى تقليل وصول الأكسجين إلى القلب. يُطلق على نقص الدم الغني بالأكسجين نقص التروية، وعلى الرغم من أن العديد (20٪ إلى 30٪) ممن يعانون من هذا ليس لديهم أعراض على الإطلاق (حالة تسمى نقص التروية الصامت).

بالنسبة للبعض، قد يحدث أيضاً عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) - وهذا أيضاً يمكن أن يكون صامتاً. سواء صامت أم لا، فهو يعتبر مقدمة لتشخيص حالي أو مستقبلي لأمراض القلب. تعتبر النوبة القلبية (مرة أخرى، صامتة أحياناً وأحياناً لا) أحد أكثر أعراض أمراض الشرايين التاجية شيوعاً. يمكن أن تؤدي النوبة الطويلة من الإقفار أيضاً إلى توقف القلب، مما يعني توقف القلب فجأة عن النبض أو فشل القلب الاحتقاني.

اعتماداً على من يقوم بالتصنيف، تعتبر ثلاثة مما سبق "أعراضاً" لمرض القلب التاجي: عدم انتظام ضربات القلب، والذبحة الصدرية، والنوبة القلبية.

الحفاظ على صحة جهاز الدوران:

1. يجب الالتزام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم، لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، والمشي من أفضل هذه التمارين، فالتمارين الرياضية مهمة في تخليص الجسم من الدهون والسموم، التي تشكل العدو الخطير بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.
2. تناول كمية معتدلة من الملح في اليوم، بحيث لا تتجاوز الست غرامات، فالملح من العوامل التي تساعد على رفع ضغط الدم، وبالتالي تزداد نسبة الإصابة بأمراض القلب.
3. الإقلاع عن التدخين، حيث يعتبر الدخان غني بمادة النيكوتين، والتي تسبب عدداً كبيراً من الأمراض للقلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، كما أن الدخان يحتوي على نسبة عالية من أول أكسيد الكربون، الذي يحفز الكوليسترول على الترسيب على جدران الأوعية الدموية.
4. تجنب المشروبات الكحولية، حيث تؤثر الكحول في مستوى معدل ضربات القلب، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا من الأفضل تجنب تناول الكحول، لحماية القلب من هذه الأمراض.

5. الزيادة الكبيرة في الوزن، تؤدي إلى تراكم الكوليسترول بكميات كبيرة، على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي ترفع نسبة الإصابة بالسكتات القلبية، وتسبب أيضاً أمراض الشرايين، وخاصة تلك التي تصيب الشريان التاجي، لذا من الأفضل أن يكون الجسم ذا وزن طبيعي ومناسب.
6. يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة، لأن هذه الوجبات غنية بكميات كبيرة من الدهون، كما أنها غنية بالكوليسترول، والكمية الفائضة من الكوليسترول تتراكم على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي تنسد هذه الأوعية.
7. يجب النوم كل يوم لمدة ثماني ساعات، ويجب أن يكون النوم مريحاً، لأن النوم هو طريق الجسم في تصليح نفسه.
8. تجنب التوتر والتخلص منه، فالتوتر له تأثير سلبي بشكل كبير على صحة القلب، ومن الممكن التخلص من التوتر عن طريق ممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية، أو حتى ممارسة تمرين اليوغا.

صحة الأجهزة والحواس

3

الجهاز البولي:

وظيفة الجهاز البولي هي تصفية الدم وتكوين البول كمخلفات ثانوية. تشمل أعضاء الجهاز البولي الكليتين، والحوض الكلوي، والحالبين، والمثانة، والإحليل.

الكلى:

- هي عبارة عن أعضاء صلبة تشبه حبة الفول.
- تقع تحت الأضلاع باتجاه منتصف الظهر.
- توجد الكلية اليمنى أدنى قليلاً من اليسار.
- يبلغ طول كل منها حوالي 11 سم وعرضها 6 سم وسمكها 3 سم.
- متوسط الوزن 150 غ للذكور و135 غ للإناث.
- كل كلية لها حدود جانبية محدبة ووسطية مقعرة.
- كل كلية لها كبسولة ليفية.
- تزيل الكلى اليوريا من الدم من خلال وحدات ترشيح صغيرة تسمى النيفرون. يتكون كل نيفرون من كرة مكونة من شعيرات دموية صغيرة تسمى الكبيبة وأنبوب صغير يسمى النبيبات الكلوية.

الغدة الكظرية:

عبارة عن غدة صغيرة تقع فوق كل كلية. تنتج الهرمونات الأساسية، بما في ذلك الهرمونات الجنسية والكورتيزول.

الحالب:

تنقل الأنابيب الضيقة النحيلة البول من الكلى إلى المثانة. الحالب عبارة عن أنابيب تتقلص عضلات جداره وتسترخي باستمرار، مما يدفع البول إلى النزول بعيداً عن الكلى. إذا كان البول يتراجع أو يُسمح له بالوقوف، يمكن أن تتطور عدوى الكلى. كل 10 إلى 15 ثانية تقريباً، يتم إفراغ كميات صغيرة من البول في المثانة من الحالب. الوظائف: ينقل الحالبان البول من الكلى إلى المثانة.

المثانة:

كيس عضلي ناعم وقابل للطي يخزن البول مؤقتاً. تظهر ثلاث فتحات في المثانة - فتحتان للحالب وفتحة واحدة لمجرى البول.

في الذكور، تحيط غدة البروستاتا برقبة المثانة، حيث تفرغ في مجرى البول.

- يبلغ طول المثانة الفارغة 5-7.5 سم، بينما يبلغ طول المثانة الممتلئة حوالي 12.5 سم وتتسع لحوالي 500 مل من البول، لكنها قادرة على حمل أكثر من ضعف هذه الكمية (1500 مل).
- هو خزان البول الذي يستقبله الكلى.
- عضلتان عاصرة. تساعد هذه العضلات الدائرية على منع تسرب البول عن طريق الإغلاق بإحكام مثل الشريط المطاطي حول فتحة المثانة.
- أعصاب في المثانة. تنبه الأعصاب الشخص عندما يحين وقت التبول أو إفراغ المثانة.

الإحليل:

هو قناة انتقال البول من المثانة إلى الخارج. يختلف بين الجنسين. يبلغ طول مجرى البول الأنثوي 4 سم، بينما يبلغ طوله في الذكور حوالي 15-25 سم عند البالغين. تحيط به العضلة العاصرة الخارجية أو الإحليل.

أمراض الجهاز البولي:

التهاب المسالك البولية (UTIs):

تعد من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعاً، حيث تصيب 150 مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم. سريريًا، يتم تصنيف التهابات المسالك البولية على أنها غير معقدة أو معقدة. عادةً ما تصيب عدوى المسالك البولية غير المعقدة الأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم تشوهات هيكلية أو عصبية في المسالك البولية.

يتم تقرييق هذه الالتهابات إلى عدوى المسالك البولية السفلية (التهاب المثانة) والتهابات المسالك البولية العلوية (التهاب الحويضة والكلية). ترتبط العديد من عوامل الخطر بالتهاب المثانة، بما في ذلك جنس الإناث، والتهاب المسالك البولية السابقة، والنشاط الجنسي، والعدوى المهبليّة، والسكري، والسمنة، والحساسية الوراثية.

عادة ما يتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض التهاب المسالك البولية بالمضادات الحيوية. يمكن أن تؤدي هذه العلاجات إلى تغيير طويل الأمد في الجراثيم الطبيعية للمهبل والجهاز الهضمي وفي تطوير كائنات دقيقة مقاومة للأدوية المتعددة. يمكن أن يؤدي توفر المنافذ التي لم تعد مليئة بالميكروبات المعدلة إلى زيادة خطر الاستعمار بمسببات الأمراض البولية المقاومة للأدوية المتعددة.

حصاة الكلى:

وهي عبارة عن مادة صلبة تشبه الحصاة يمكن أن تتكون في إحدى كليتيك أو كليهما عند وجود مستويات عالية من بعض المعادن في البول. نادرًا ما تسبب حصوات الكلى ضررًا دائمًا إذا تم علاجها من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

قد تكون الحصى موجودة في الكلى إذا تم الشعور بالألم حاد في الظهر أو الجانب أو أسفل البطن أو الفخذ. أو يوجد دم في البول. إذا كانت الحصوة صغيرة تمر بسهولة عبر المسالك البولية، فقد لا تظهر أعراض على الإطلاق.

احتباس البول:

هو حالة لا يمكن فيها إفراغ كل البول من المثانة. ويمكن أن يكون احتباس البول حادًا - عجزًا مفاجئًا عن التبول، أو مزمنًا - عدم قدرة تدريجية على إفراغ المثانة من البول تمامًا.

يمكن أن تتراوح أعراض احتباس البول من ألم شديد في البطن وعدم القدرة على التبول، إلى أعراض قليلة أو معدومة على الإطلاق. وينتج احتباس البول إما عن انسداد يمنع جزئيًا أو كليًا تدفق البول، أو عدم قدرة المثانة على الاحتفاظ بقوة كافية لطرد البول بالكامل.

تضخم البروستات الحميد:

هو حالة تصيب الرجال تكون فيها غدة البروستاتا متضخمة وليست سرطانية. يسمى تضخم البروستاتا الحميد أيضًا انسداد البروستاتا الحميد. تمر البروستاتا بفترتين رئيسيتين للنمو مع تقدم الرجل في العمر. يحدث الأول في وقت مبكر من سن البلوغ، عندما يتضاعف حجم البروستاتا. تبدأ المرحلة الثانية من النمو في حوالي سن 25 وتستمر خلال معظم حياة الرجل. غالبًا ما يحدث تضخم البروستاتا الحميد مع مرحلة النمو الثانية.

سبب تضخم البروستاتا الحميد ليس مفهوما جيدا. ومع ذلك، فإنه يحدث بشكل رئيسي عند كبار السن من الرجال. لا يحدث تضخم البروستاتا الحميد عند الرجال الذين تمت إزالة خصيتيهم قبل سن البلوغ. لهذا السبب، يعتقد بعض الباحثين أن العوامل المتعلقة بالشيخوخة والخصيتين قد تسبب تضخم البروستاتا الحميد. طوال حياتهم، ينتج الرجال هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري، وكميات صغيرة من هرمون الاستروجين، وهو هرمون أنثوي. مع تقدم الرجال في العمر، تقل كمية هرمون التستوستيرون النشط في دمائهم، مما يترك نسبة أعلى من الأستروجين. اقترحت الدراسات العلمية أن تضخم البروستاتا الحميد قد يحدث لأن ارتفاع نسبة هرمون الأستروجين داخل البروستاتا يزيد من نشاط المواد التي تعزز نمو خلايا البروستاتا.

مشاكل التحكم في المثانة والتبول اللاإرادي عند الأطفال:

قد يعاني الأطفال الذين لا يتحكمون في التخلص من البول من مشكلة في التحكم في المثانة. يعد كل من التبول اللاإرادي أثناء النهار والتبول الليلي أمر شائع - ويميل إلى التلاشي مع نضوج الأطفال. في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الظروف الصحية إلى التبول.

تشمل علامات مشكلة التحكم في المثانة تسرب البول أو الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر أو عاجل أو السرير المبلل. غالبًا ما يؤدي النمو البدني البطيء إلى التبول اللاإرادي. يمكن أن تؤدي عادات الحمام أحيانًا إلى التبول أو تقاوم الأمر.

الحفاظ على صحة الجهاز البولي:

تشير صحة المسالك البولية إلى مدى جودة عمل الجهاز في إزالة النفايات وإنتاج البول والتحكم فيه، بالإضافة إلى أي اضطرابات أو مشاكل قد تحدث داخل الجهاز. يمكن أن تؤثر هذه المشاكل على الجهاز بأكمله، أو على أجزاء معينة فقط من المسالك البولية، مثل المثانة.

لأن الجهاز البولي كغيره من أجهزة وأعضاء الجسم الأخرى فقد يتعرض للعديد من المشاكل مثل سلس البول، التهابات المسالك البولية، وتضرر المثانة، حيث يمكن تجنب الإصابة بهذه المضاعفات والأمراض للحفاظ على صحة الجهاز البولي عن طريق عدة خطوات منها ما يأتي:

شرب كميات كافية من الماء	الوقاية من الإمساك
الحفاظ على وزن صحي	عدم التأخر في تفريغ المثانة
الحد من استخدام بعض الأدوية	ممارسة الأنشطة البدنية
الفحص الدوري للبروستاتا	الفحص الدوري لوظائف الكلى
ارتداء ملابس داخلية قطنية وفضفاضة	إفراغ البول بشكل كامل عند التبول

صحة الحواس (العين والأذن):

العين:

وفرت الطبيعة للعين الناعمة والضعيفة حماية ممتازة - مهد ذو طبقات أو تجويف من العظام يسمى المدار. يحتوي المدار على عظم ثقيل على حوافه الخارجية، وعظام أرق على الأسطح الداخلية (الأنفية)، وأيضًا وسادة من الدهون، مما يسد العين.

يحتوي هذا التجويف أيضًا على العضلات والأعصاب التي تسمح بحركة العينين والجفون؛ والأوعية الدموية التي تغذي أنسجة العين وتحافظ عليها؛ والغدة الدمعية التي تفرز الدموع التي تعمل على تليين العين. (تخيل مدى صعوبة وألم تحريك عينيك للأمام والخلف، أو فتح وإغلاق جفونك بدون هذه الرطوبة).

تعد الغدة الدمعية أيضًا جزءًا من نظام دفاع العين: استجابة للدغة المواد الكيميائية أو البصل، أو لمهيجات مثل الغبار أو حبوب اللقاح، يتم تشغيل الصنبور لتخفيف وغسل أي شيء قد يؤدي العين. (لأسباب أخرى غير مفهومة تمامًا، تستجيب هذه الغدة الدمعية أيضًا للحزن والفرح الكبير والمشاعر القوية الأخرى).

الحفاظ على صحة العين:

1. الحصول على فحص للعينين.
2. حماية العينين.
3. اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل.
4. زيارة الطبيب بشكل دوري.
5. عدم تناول المكملات والأدوية بشكل مبالغ به.
6. التقليل من العادات السيئة.
7. الأخذ بالاعتبار تاريخ العائلة الطبي والجينات.

الأذن:

تعد الأذن من أكثر أجزاء الجسم تعقيدًا وانضغاطًا. تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء أساسية: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية.

- تمرر الأذن الخارجية الموجات الصوتية إلى الأذن الوسطى.
- تضخم الأذن الوسطى الموجات الصوتية وتوصلها إلى الأذن الداخلية.
- تحوّل الأذن الداخلية الموجات الصوتية إلى إشارات عصبية وترسلها إلى الدماغ حيث "تسمع".
- الأذن الداخلية مسؤولة أيضًا عن التوازن. يكتشف حركة الرأس والجاذبية ويرسل إشارات إلى الدماغ لتوفير الإحساس بالتوازن.

يمكن أن تسبب اضطرابات الأذن أعراضًا مختلفة. يمكن أن يشير كل عرض بمفرده إلى مشاكل معينة، ولكن عندما يتم النظر إلى المؤشرات معًا، تظهر صورة أوضح. فهم الأعراض هو المفتاح لمعرفة ما الذي يسبب اضطرابات الأذن.

الوقاية من فقدان السمع:

تتضمن بعض الاستراتيجيات البسيطة للوقاية من فقدان السمع ما يلي:

- تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة، بما في ذلك الحصبة والتهاب السحايا والحصبة الألمانية والنكاف.
- تحصين المراهقات والنساء في سن الإنجاب ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل.
- الوقاية من عدوى الفيروس المضخم للخلايا للأمهات الحوامل من خلال النظافة الجيدة.
- فحص وعلاج مرض الزهري والأمراض المعدية الأخرى عند النساء الحوامل.
- تعزيز برامج صحة الأم والطفل، بما في ذلك تعزيز الولادة الآمنة.
- اتباع ممارسات العناية الصحية بالأذن.
- فحص الأطفال للكشف عن التهاب الأذن الوسطى، متبوعًا بتدخلات طبية أو جراحية مناسبة.
- تجنب استخدام عقاقير معينة قد تكون ضارة بالسمع، ما لم يتم وصفها ومراقبتها من قبل طبيب مؤهل.
- إحالة الأطفال المعرضين لخطر كبير، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الصمم أو المولودين
- تقليل التعرض (المهني والترويحي) للأصوات الصاخبة من خلال زيادة الوعي بالمخاطر.
- تطوير وإنفاذ التشريعات ذات الصلة.

الصحة العقلية

الصحة العقلية وعلاقتها بالصحة العامة:

الصحة العقلية، كما حددتها وكالة الصحة العامة الكندية، "هي قدرة الفرد على الشعور والتفكير والتصرف بطرق لتحقيق نوعية حياة أفضل مع احترام الحدود الشخصية والاجتماعية والثقافية". وضعف أي من هذه الحدود يشكل عوامل خطر للاضطرابات النفسية، أو المرض العقلي الذي هو أحد مكونات الصحة العقلية.

تُعرّف الاضطرابات النفسية بأنها "الحالات الصحية التي تؤثر على الوظائف المعرفية والاستجابات العاطفية والسلوك المرتبط بالضيق و / أو ضعف الأداء وتغيرها". ICD-11 هو المعيار العالمي المستخدم لتشخيص الاضطرابات النفسية المختلفة وعلاجها والبحث والإبلاغ عنها.

عرفت منظمة الصحة العالمية نوعية الحياة بأنها "تصور الفرد لمكانه في الوجود، في سياق الثقافة ونظام القيم الذي يعيش فيه، فيما يتعلق بأهدافه وتوقعاته ومعاييرها واهتماماته". إنه مفهوم واسع للغاية يتأثر بطريقة معقدة بالصحة الجسدية للفرد، وحالته النفسية، ومستوى استقلاليتها، وعلاقاتها الاجتماعية، فضلاً عن علاقته بالعناصر الأساسية لبيئته.

ترتبط الصحة العقلية بعدد من عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية والإجهاد وتعاطي المخدرات والصلات الاجتماعية والتفاعلات. يمكن للمعالجين والأطباء النفسيين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والممرضات الممارسين أو أطباء الأسرة المساعدة في إدارة المرض العقلي بعلاجات مثل العلاج أو الاستشارة أو الأدوية.

الأمراض العقلية أكثر شيوعاً من السرطان أو السكري أو أمراض القلب. تشير الدلائل إلى أن 450 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من بعض الأمراض العقلية. يحتل الاكتئاب الشديد المرتبة الرابعة بين الأسباب العشرة الأولى للأمراض في جميع أنحاء العالم. بحلول عام 2029، من المتوقع أن يصبح المرض العقلي السبب الرئيسي للمرض في جميع أنحاء العالم. تشير الدلائل المستمدة من منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم يتأثرون بمرض عقلي يؤثر على احترامهم لذاتهم وعلاقاتهم وقدرتهم على العمل في الحياة اليومية.

يمكن أن تؤثر الصحة العاطفية للفرد على صحته الجسدية. يمكن أن تؤدي الصحة العقلية السيئة إلى مشاكل مثل عدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة واضطرابات تعاطي المخدرات. يمكن للصحة العقلية الجيدة أن تحسن نوعية الحياة بينما يمكن أن تؤدي الصحة العقلية السيئة إلى تفاقمها. وفقاً لـ Richards و Muse-Burke و Campania، "هناك أدلة متزايدة على أن القدرات العاطفية مرتبطة بالسلوكيات الاجتماعية مثل إدارة الإجهاد والصحة البدنية". حيث يميلون إلى السلوكيات المعادية للمجتمع (على سبيل المثال، اضطراب تعاطي المخدرات واضطراب تعاطي الكحول، والمعارك الجسدية، والتخريب)، مما يعكس الصحة العقلية للشخص والمشاعر المكبوتة. قد يعاني البالغون والأطفال الذين يعانون من مرض عقلي من وصمة العار الاجتماعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

حتى وقت قريب جداً، ركزت الصحة العامة على الأمراض الجسدية، والأمراض المعدية في البداية، ومؤخراً على أمراض "نمط الحياة" لأمراض القلب التاجية والسرطان. كانت هناك مبادرات عرضية تهدف إلى الحد من الانتحار، مثل التغييرات في إمدادات الغاز المنزلي والأجهزة، والتغييرات في وصف الأدوية وتعبئتها، لكن ممارسة الصحة النفسية العامة جديدة جداً. ينبع أحد أسباب ذلك من الإحصائيات الروتينية التي تركز عليها ممارسة الصحة العامة. حتى وقت قريب، كانت الإحصائيات التي كانت متاحة

بسهولة هي إحصاءات الوفيات، والتي قللت بشكل منهجي من أهمية الأمراض التي تعطل ولكنها نادرًا ما تقتل. تضافرت عدة أمور لإبراز الصحة النفسية العامة في القرن الحادي والعشرين؛ وتشمل هذه:

- من منظور علمي، فإن تقدير سنوات الحياة المصححة بالجودة قد أتاح تسليط الضوء على الأهمية النسبية للمرض العقلي.
- من منظور مجتمعي، فإن المحرمات المرتبطة بالأمراض العقلية بدأ تحديها حيث الآن أصبحت شخصيات عامة محترمة يتحدثون عن أمراضهم وتأثيرها على حياتهم، وأصبح من الصعب غض الطرف عن الأمراض العقلية.
- أخيرًا، بدأ الاعتراف في الصحة العامة بأن العديد من محددات المرض الجسدي ترجع أصولها إلى الدوافع العقلية أو النفسية للسلوكيات الخطرة على الصحة، وبالتالي فإن المزيد من التقدم في القضاء على بعض الأمراض الجسدية، على سبيل المثال أمراض القلب أو السرطان، سيعتمد على تحديد الصحة العقلية.

عند العمل مع مريض، يستخدم طبيب الصحة العقلية إطاره النظري وخبرته لوضع تصور للمريض، وتجاربهم السابقة، وتجاربهم الحالية، ورؤيتهم للعالم (كيف يرون العالم وأنفسهم فيه)، ومهارات العلاقة، والأساليب، والنهج، ومهارات التفاعل والمهارات الاستراتيجية والاحتياجات والرغبات والآمال والأهداف وغير ذلك الكثير.

يعمل الأطباء على إيجاد طرق للحفاظ على سلامة عملائهم وعائلاتهم وأنفسهم. يزيد يوميًا قطع الاتصال بين البشر والانتقال معظم جلسات الصحة العقلية إلى منصات الإنترنت بشكل أساسي. وتم دفع العديد من الأطباء إلى إجراء تعديلات فيما يتعلق بالطريقة التي يقدمون بها الخدمات. تضمن هذا التحول عملية ضرورية لإجراء جرد للمكونات المشاركة في الخدمات التي قدموها تاريخيًا في محاولة لترجمة المكونات إلى منصة صحية عبر الإنترنت.

تصنيف الاضطرابات العقلية:

يعتبر تصنيف الاضطرابات النفسية، المعروف أيضًا باسم علم تصنيف الأمراض النفسي أو التصنيف، جانبًا رئيسيًا من مهن الطب النفسي ومهن الصحة العقلية الأخرى ومسألة مهمة للمستهلكين ومقدمي خدمات الصحة العقلية. يوجد حاليًا نظامان راسخان على نطاق واسع لتصنيف الاضطرابات النفسية - الفصل الخامس من التصنيف الدولي للأمراض (ICD-10) الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية (WHO) والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-IV) الذي أنتجته الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA).

يُعتقد أن كلتا فئتي الاضطرابات قائمة على أنها أنواع مميزة، وقد قامت عن عمد بتقريب رموزها في المراجعات الأخيرة بحيث تكون الكتيبات في الغالب قابلة للمقارنة على نطاق واسع، على الرغم من استمرار وجود اختلافات كبيرة. قد تكون مخططات التصنيف الأخرى قيد الاستخدام محليًا، على سبيل المثال التصنيف الصيني للاضطرابات العقلية. الكتيبات الأخرى لها بعض الاستخدام المحدود من قبل أولئك الذين لديهم قناعات نظرية بديلة، مثل دليل التشخيص الديناميكي النفسي.

تستخدم تصنيفات DSM و ICD المستخدمة على نطاق واسع تعريفات تشغيلية. وهناك جدل علمي كبير حول الصلاحية النسبية لنظام تصنيف "فئوي" مقابل نظام "الأبعاد"، بالإضافة إلى الجدل الكبير حول دور العلم والقيم في مخططات التصنيف والاستخدامات المهنية والقانونية والاجتماعية التي يستخدمونها.

تشير منظمة الصحة العالمية والدراسات الاستقصائية الوطنية إلى أنه لا يوجد إجماع واحد على تعريف الاضطراب / المرض النفسي، وأن الصياغة المستخدمة تعتمد على السياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والقانوني في سياقات مختلفة وفي مجتمعات مختلفة. ويمكن أن يشمل التعريف الواسع المرض العقلي والتخلف العقلي واضطراب الشخصية والاعتماد على المواد، لكن الشمول يختلف باختلاف البلد ويُقال إنه قضية معقدة.

تُصنف الاضطرابات العقلية عمومًا بشكل منفصل إلى:

- الاضطرابات العصبية.
- صعوبات التعلم.
- التخلف العقلي.

أنواع مخططات التصنيف:

- المخططات الفنية:

حققت مخططات التصنيف هذه بعض القبول الواسع النطاق في الطب النفسي ومجالات أخرى، ووجد بشكل عام أنها حسنت الموثوقية بين المقيمين، على الرغم من أن الاستخدام السريري الروتيني أقل وضوحًا.

- المخططات غير الفنية:

لا تستخدم بعض مناهج التصنيف الفئات ذات الفواصل الفردية التي تفصل بين المريض والصحي أو غير الطبيعي عن الطبيعي (يطلق على هذه الممارسة أحيانًا اسم "الطب النفسي العتوي" أو "التصنيف ثنائي التفرع"). وبدلاً من ذلك، قد يعتمد التصنيف على "أطيف" أساسية أوسع، حيث يربط كل طيف معًا نطاقًا من التشخيصات الفنية ذات الصلة وأنماط الأعراض غير الحدية.

ICD-10:

التصنيف الدولي للأمراض (ICD) هو تصنيف تشخيصي قياسي دولي لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية. يركز الفصل الخامس منه على "الاضطرابات العقلية والسلوكية" ويتكون من 10 مجموعات رئيسية بالإضافة إلى مجموعة من "الاضطرابات النفسية غير المحددة":

F0	عضوي، بما في ذلك الاضطرابات النفسية العرضية.
F1	الاضطرابات العقلية والسلوكية بسبب استخدام المواد ذات التأثير النفساني.
F2	الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية.
F3	الحالة المزاجية [الاضطرابات العاطفية].
F4	الاضطرابات العصبية والمتعلقة بالإجهاد والاضطرابات الجسدية.

F5	المتلازمات السلوكية المرتبطة بالاضطرابات الفيزيولوجية والعوامل الجسدية.
F6	اضطرابات الشخصية والسلوك لدى الأشخاص البالغين.
F7	التخلف العقلي.
F8	اضطرابات النمو النفسي.
F9	الاضطرابات السلوكية والعاطفية يبدأ ظهوره عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

يوجد داخل كل مجموعة فئات فرعية أكثر تحديداً. يتضمن التصنيف الدولي للأمراض (ICD) اضطرابات الشخصية في نفس المجال مثل الاضطرابات العقلية الأخرى، على عكس الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM).

DSM-IV:

يصف DSM-IV، الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للطب النفسي، الاضطراب العقلي بأنه "متلازمة أو نمط سلوكي أو نفسي مهم سريريًا يحدث في الفرد، ... مرتبط بالضيق الحالي ... أو الإعاقة ... أو مع زيادة كبيرة في خطر المعاناة"، وينص الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية أيضًا على أنه "لا يوجد افتراض بأن كل فئة من فئات الاضطراب العقلي هي كيان منفصل تمامًا بحدود مطلقة تفصله عن الاضطرابات العقلية الأخرى أو من عدم وجود اضطراب عقلي." يتكون DSM-IV من خمسة محاور (مجالات) يمكن من خلالها تقييم الاضطراب. والمحاور الخمسة هي:

- المحور الأول: الاضطرابات السريرية (جميع الاضطرابات النفسية باستثناء اضطرابات الشخصية والتخلف العقلي).
- المحور الثاني: اضطرابات الشخصية والتخلف العقلي.
- المحور الثالث: الحالات الطبية العامة (يجب أن تكون مرتبطة باضطراب عقلي).
- المحور الرابع: النفسية والاجتماعية والبيئية المشكلات (على سبيل المثال شبكة الدعم الاجتماعي المحدودة).
- المحور الخامس: التقييم العالمي للأداء (يتم تقييم الوظائف النفسية والاجتماعية والمتعلقة بالوظيفة على أساس سلسلة متصلة بين الصحة العقلية والاضطراب النفسي الشديد).

ويمكن اعتبار الفئات الرئيسية للاضطراب في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية هي:

الفئة	مثال
اضطرابات النمو أو إعاقات النمو. تظهر عادة عند الأطفال والمراهقين.	التخلف العقلي. اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
الهذيان والخرف وفقدان الذاكرة والاضطرابات المعرفية الأخرى.	مرض الزهايمر.
الاضطرابات النفسية بسبب حالة طبية عامة.	الذهان المرتبط بالإيدز.
الاضطرابات المتعلقة بالمواد.	إدمان كحول.
الفصام والاضطرابات الذهنية الأخرى.	اضطراب الوهمية.
اضطرابات المزاج.	اضطراب اكتئاب حاد.

اضطراب ثنائي القطب.	
اضطراب القلق العام.	اضطرابات القلق.
اضطراب الجسد نتيجة اضطرابات عقلية أو نفسية.	الاضطرابات الجسدية نتيجة اضطرابات عقلية أو نفسية.
متلازمة مانتشاوزن.	اضطرابات التمارض.
اضطراب الهوية.	اضطرابات انفصامية.
اضطراب الهوية الجنسية.	اضطرابات الهوية الجنسية.
فقدان الشهية العصبي. الشراهة المرضي العصبي.	اضطرابات الأكل.
الأرق.	اضطرابات النوم.
هوس السرقة.	اضطرابات السيطرة على الانفعالات غير المصنفة.
اضطراب التكيف.	اضطرابات التكيف.
اضطراب الشخصية النرجسية.	تقلبات الشخصية.
خلل الحركة المتأخر. الإساءة للأطفال.	الحالات الأخرى التي قد تكون محور الاهتمام السريري.

تصنيفات أخرى:

- التصنيف الصيني للجمعية الصينية للطب النفسي للاضطرابات العقلية (حاليًا 3-CCMD).
- دليل أمريكا اللاتينية للتشخيص النفسي (GLDP).

الاضطرابات العقلية:

- اضطراب القلق المعمم:

يُنظر إليه على أنه اضطراب القلق الرئيسي. ويمكن تتبع كيفية حصوله على هذا التصنيف، إلى حد ما، إلى التغييرات التي حدثت بمرور الوقت في تطوير الدليل التشخيصي والإحصائي (DSM) للجمعية الأمريكية للطب النفسي وهو الأداة الرئيسية المستخدمة في التشخيص. هذا النظام، الذي يستمر تطويره من قبل اللجنة، قد مر بتغييرات كبيرة في سياق الإصدارات المتتالية.

الأعراض الرئيسية لاضطراب القلق العام المحددة في الإصدار الحالي من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية هي: القلق المفرط والقلق الذي يصعب السيطرة عليه ويظل موجودًا في معظم الأيام لمدة 6 أشهر أو أكثر. ومع ذلك، فإن الشكاوى الأولية التي تدفع المرضى إلى التماس العناية الطبية تتعارض في كثير من الأحيان مع هذه الصورة. أعراض القلق، على الرغم من وجودها، في كثير من الأحيان ليست الشكاوى الأساسية في المرضى الذين يعانون من اضطراب القلق العام. نظرًا لأن المصابين باضطراب القلق العام يشكون في الغالب من الأعراض الجسدية والألم، فمن المؤسف أن هذه ليست مدرجة كميزات تشخيصية مهمة.

- الاكتئاب الشديد:

اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) هو مرض نفسي واسع الانتشار يتميز بارتفاع مخاطر المراضة والوفيات ومستوى عالٍ من الاعتلال المشترك مع العديد من الاضطرابات النفسية وغير النفسية. كما أنه مرتبط بشكل متكرر مع الوسواس القوي في الممارسة السريرية اليومية. حيث يولد ضائقة عاطفية شديدة وضعف ملحوظ في الأداء العام. ويتميز بمسار مزمن و / أو متكرر، مما يؤدي إلى تدهور عميق في نوعية الحياة.

على الرغم من التقدم الكبير في العلاجات الدوائية والنفسية، لا يزال 20-30٪ من المرضى يستجيبون دون جدوى لاستراتيجيات العلاج الطبي القياسية لهذه الاضطرابات.

أعراض الاكتئاب الشديد هي:

- فقدان الشهية.
- الشعور بالحزن المستمر أو التعاسة دون راحة.
- الشعور بالفراغ أو استنزاف كل شيء.
- عدم القدرة على الشعور بأي شيء غير الحزن.
- شعور باليأس والعجز. المستقبل يبدو قاتماً ومظلماً. لا توجد ذرة من السطوع في الأفق.
- الأنشطة التي كانت تجلب لك السعادة أو السعادة الهائلة تقابل الآن بعدم الاهتمام وفقدان الطاقة.
- الشعور بالتعب أو الخمول طوال الوقت. قد تستيقظ متعباً حتى بعد نوم ليلة سعيدة.
- الرغبة في النوم طوال الوقت أو زوال الرغبة كاملة.
- فقد الوزن أو زيادته.
- شعور منخفض باحترام للذات. شعور عام بأنك بلا قيمة.
- أفكار انتحارية.

- انفصام الشخصية:

هو اضطراب نفسي تطوري عصبي معقد وغير متجانس يتميز بمجموعة متنوعة من الأعراض. يمكن تجميع الأعراض بشكل كلاسيكي في ثلاثة مجالات رئيسية:

- إيجابية (الهوسة، والأوهام، واضطراب الفكر).
- السلبية (الانسحاب الاجتماعي، وقلة التأثير).
- الخلل المعرفي (الانتباه والعمل ووظائف الذاكرة العرضية وسرعة المعالجة).

إن سبب الإصابة بالفصام غير معروف، ولكن يعتقد الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية وعوامل أخرى خاصة بكيمياء المخ تساهم في الإصابة بهذا الاضطراب. قد تساهم مشاكل بعض المواد الكيميائية بالمخ التي تحدث بشكل طبيعي، بما في ذلك الناقلات العصبية التي يُطلق عليها دوبامين وغلوتامات، في انفصام في الشخصية.

وبائيات الأمراض العقلية:

تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إلى تزايد هائل في انتشار الاضطرابات النفسية والعقلية في العالم، وذلك نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة، نفسية، بيولوجية، اجتماعي. ويمكن من خلال هذه الأرقام الاستدلال على حجم المشكلة. حيث أن الاضطرابات العقلية تصيب أعدادا كبيرة من الناس في مختلف مراحل العمر، ومن مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتسبب في تدهور ومعااناة يمتد أثرها إلى الأسرة والمجتمع.

تنتشر الاضطرابات العقلية بدرجات متفاوتة ومختلفة من الشدة والكثافة، لدرجة يندر أن يوجد من بيننا من هو خال تماما من كافة هذه الاضطرابات. ومع تقدم أدوات ووسائل القياس النفسي، وكذلك الطب النفسي وأدوات التشخيص العلمية الدقيقة، أصبح من الممكن التمييز بين الشخص السوي المعافى والشخص المريض عقليا، بعدما نجح علماء النفس في وضع معايير ثابتة، تميز بين المرض والسواء، كما تحدد الاضطراب الذي يعاني منه الشخص. وبناءا على ما سبق، تتضح أهمية معالجة تأثير الاضطرابات العقلية على السلوك الإجرامي.

1 من كل 8 أشخاص أو 970 مليون شخص حول العالم مصاب باضطراب عقلي، وكان القلق والاكتئاب الأكثر شيوعاً. تتضمن الاضطرابات العقلية اضطرابات كبيرة في التفكير أو التنظيم العاطفي أو السلوك. وهناك العديد من الأنواع المختلفة من الاضطرابات النفسية. في عام 2020، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات الاكتئاب بشكل كبير بسبب جائحة COVID-19. وتظهر التقديرات الأولية زيادة بنسبة 26% و 28% على التوالي للقلق واضطرابات الاكتئاب الكبرى في عام واحد فقط. في حين أن خيارات الوقاية والعلاج الفعالة موجودة، فإن معظم المصابين باضطرابات نفسية لا يحصلون على رعاية فعالة. يعاني العديد من الأشخاص أيضاً من وصمة العار والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان.

الحفاظ على الصحة العقلية:

لا تقل الصحة العقلية والرفاهية أهمية عن الصحة الجسدية. حيث تمكّن الصحة العقلية الإيجابية والرفاهية من العمل بشكل جيد، والروابط الاجتماعية ذات المغزى، وتقدير إيجابي للذات، ويكون المرء أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الحياة.

يعد الحفاظ على صحة أذهاننا جزءاً مهماً من صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام. ومن بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة العقلية والرفاهية:

1. قضاء الوقت مع الأصدقاء والأحباء والأشخاص الذين نثق بهم.
2. التحدث عن مشاعرك أو التعبير عن مشاعرك بانتظام.
3. التقليل من استهلاك الكحول.
4. تجنب تعاطي المخدرات غير المشروعة.
5. الحفاظ على النشاط وتناول الطعام جيداً.
6. تطوير مهارات جديدة وتحدي القدرات.
7. الاسترخاء والاستمتاع بالهوايات.
8. تحديد أهداف واقعية.
9. الحصول على قسط كافٍ من النوم.

التربية الصحية

مقدمة:

اعتقادات الإنسان الأولية عن الصحة والمرض:

تعد الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان حيث يتم تعريفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه "حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل وليس مجرد غياب المرض أو العجز". ومع ذلك، ترتبط صحة الأفراد أيضًا بالبيئة التي يعيشون فيها وخاصة بقدرتهم على التكيف والاندماج في سياق حياتهم.

تعد العلاقة مع البيئة مهمة للغاية لأن هذا التفاعل هو الذي يحدد مفهوم الحالة الطبيعية مقارنة بعلم الأمراض. وهذه الحالة الطبيعية يجب أن يتم وضعها في سياقها حسب الجنس والأصل الجغرافي وظروف معيشة الأفراد.

في الواقع، ما هو طبيعي بالنسبة للشباب قد يختلف عما هو طبيعي بالنسبة لكبار السن. وهذا يعني أن مفهوم الصحة نسبي بالفعل وهو نتيجة تطور مثير للاهتمام لمفهوم المرض من المناهج الأولى "التعامل مع مجرد علاج الأعراض" إلى الوعد بمجتمع خالٍ من الألم، حيث لعب العلم والاقتصاد دورًا مهمًا في إعادة تعريف ثنائية الصحة / المرض.

تطور مفهوم المرض مع الزمن حيث كان في الماضي مرتبطًا بوجود الميكروبات. وفي وقت لاحق، تم التركيز على الدستور والبيئة. وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى المرض على أنه نظام يضعه الجسم في مكانه ليجد مرة أخرى توازنه المفقود.

في العصور القديمة، كان الشعور بالمرض يهتم بالفرد فقط؛ أما اليوم، يمكن للطبيب تشخيص حالة المرض بمعايير موضوعية. لذلك يمكن رؤية مفهوم المرض من عدة زوايا مختلفة.

وفقًا لفولتير، فإن فن الطبيب كان عبارة عن تسلية المريض حتى تشفيه الطبيعة. أما اليوم، بدلاً من ذلك، نشهد ظاهرة معاكسة، حيث يمكن اعتبار العديد من الحالات، التي كانت تُعتبر ذات يوم فيزيولوجية، خاضعة للتدخل العلاجي. تعتبر الظواهر الطبيعية مثل الخجل والصلع واللامبالاة والشيخوخة والتعب والتعاسة من الحالات التي يمكن علاجها: أمراض جديدة يجب معالجتها، غالبًا بطريقة مكلفة.

يعتبر الطبيب اليوناني أبقرات أبو الطب في العالم الغربي ومؤسس مدرسة تم بموجبها اعتبار جسم الإنسان حافظة لأربعة سوائل، والتي تسمى الأخلاط. حيث أن هذه الأخلاط هي الدم والبلغم والعصارة الصفراوية السوداء والعصارة الصفراوية الصفراء. تتكون الصحة من حالة توازن هذه المواد. وفي المقابل، يعد المرض هو حالة عدم توازن هذه الأخلاط.

التراث الاجتماعي والقيم الاجتماعية وعلاقتها بمفهوم الصحة والمرض:

لقد طورت كل ثقافة على كوكبنا نظامًا لفهم أسباب المرض والمرض وابتكرت طرقًا للوقاية منها وللمساعدة في شفاء أجساد وعقول المصابين. حيث تتنوع هذه الأنظمة الطبية العرقية بشكل كبير وكل منها جزء لا يتجزأ من الثقافة التي تطورت فيها والتي توجد حاليًا وتتطور بمرور الوقت.

النظم الطبية العرقية هي أنظمة ثقافية تعكس الموضوعات الثقافية السائدة للمجتمعات التي تطورت فيها. على سبيل المثال، النظام الطبي العرقي الأساسي في الولايات المتحدة هو الطب الحيوي، الذي يقوم على نهج علمي وعقلاني للعالم. إنه أيضًا نظام هرمي هادف للربح موجه في المقام الأول نحو المريض الفردي.

بدلاً من السياق الاجتماعي الأوسع لاعتلال الصحة (على سبيل المثال، الأسرة، البيئة المادية، الفقر، التمييز على أساس الجنس، العنصرية، إلخ) والتي سميت المحددات الاجتماعية للصحة.

وبالتالي، فإن الطب الحيوي يعكس في المقام الأول الموضوعات الثقافية الأساسية للأمريكيين مثل الاستقلال والفردية والوضعية العلمية والرأسمالية. فعلى الرغم من تطور الطب الحيوي في أوروبا والولايات المتحدة، فإن القيم الثقافية المحلية لمختلف البلدان في أوروبا وفي مناطق مختلفة من الولايات المتحدة تؤثر على كيفية ممارسته في الموقع. على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي وكندا، فإن الرعاية الطبية الحيوية هي إلى حد كبير نظام مؤمم وغير هادف للربح تموله حكومة كل من الدول الأعضاء وهذا يعكس أنظمة القيم الأكثر تقدماً والليبرالية اجتماعياً.

على الرغم من أن الطب الحيوي أصبح معولماً، إلا أن الثقافات المحلية تشكله وتعيد تشكيله ليتناسب مع قيمهم الثقافية الخاصة. تستند النظم الطبية العرقية بخلاف الطب الحيوي أيضاً إلى الموضوعات الثقافية الأساسية للثقافات التي تطورت فيها ولا يمكن فهمها تماماً دون بعض المعرفة بالقيم الثقافية التي توجه التنظيم الاجتماعي والديني والاقتصادي والسياسي للمجتمعات التي هم فيها.

تعريف التربية الصحية وأهدافها:

يشمل التنقيف الصحي فرصاً مبنية بوعي للتعلم تتضمن شكلاً من أشكال الاتصال المصممة لتحسين محو الأمية الصحية، بما في ذلك تحسين المعرفة وتطوير المهارات الحياتية التي تؤدي إلى صحة الفرد والمجتمع. ويمكن تعريفه بأنه "العملية المخططة والمنظمة للاستثمار في التعليم من أجل تحسين صحة السكان."

لا يهتم التنقيف الصحي فقط بتوصيل المعلومات، ولكن أيضاً بتعزيز الحافز والمهارات والثقة (الكفاءة الذاتية) اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الصحة. ويشمل التنقيف الصحي نقل المعلومات المتعلقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية التي تؤثر على الصحة، فضلاً عن عوامل الخطر الفردية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، واستخدام نظام الرعاية الصحية.

وبالتالي، قد يشمل التنقيف الصحي نقل المعلومات، وتطوير المهارات التي توضح الجدوى السياسية والإمكانيات التنظيمية لمختلف أشكال العمل لمعالجة المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للصحة. ففي الماضي، تم استخدام التنقيف الصحي كمصطلح يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات بما في ذلك التعبئة الاجتماعية والدعوة. أما الآن يتم تضمين هذه الأساليب في مصطلح تعزيز الصحة، ويقترح هنا تعريف أكثر ضيقاً للتنقيف الصحي للتأكيد على التمييز.

يعد التنقيف الصحي أحد جوانب تعزيز الصحة. يمكن العثور عليها في المدارس وأماكن العمل وفي مباني الرعاية الصحية وكجزء من خدمات صحة المجتمع. وهو ينطوي على استخدام وسائل الإعلام وقد يشمل استخدام الأساليب التعليمية لتغيير المعرفة والتأثير على مواقف المهنيين وصانعي السياسات.

نظراً لأن الكثير من التعلم يحدث في أماكن غير رسمية، يمكن العثور على الأشخاص العاملين في مجال التنقيف الصحي يعملون مع مجموعات الشباب والمنظمات المجتمعية والصحفيين في التلفزيون والراديو والصحافة. قد تتضمن الأساليب مواد تعليمية مكتوبة أو مناهج تشاركية تشمل المسرح والأغنية والرقص.

يعد التثقيف الصحي والمجال الأوسع لتعزيز الصحة الآن جزءاً معيارياً وهاماً من أي نظام للخدمات الصحية ويخضعان بشكل متزايد لتقييم قيمة استثماراتها.

أهداف التثقيف الصحي:

- نشر مفاهيم المعرفة الصحية السليمة في المجتمع.
- تمكين الناس من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم.
- مساعدة الناس في حل مشاكلهم الصحية باستخدام إمكانياتهم.
- بناء اتجاهات صحية طبيعية.
- ترسيخ السلوك الصحي السليم والتغيير الخاطئ للسلوك الصحي الحقيقي.

الهدف النهائي للتثقيف الصحي هو:

- تحسين صحة الفرد والمجتمع.
- تقليل نسبة الإصابة بالأمراض.
- الحد من الإعاقات والوفيات.
- تحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع.

تعريف الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية:

يمكن تعريف الصحة بشكل عام على أنها حالة من المعافاة الكاملة بدنيا ونفسيا واجتماعيا وروحيا. فقد أجمع الأطباء على أن الطب نوعان:

- حفظ الصحة على الأصحاء.
- ورد الصحة على المرضى بالمداواة وبالتأهيل.

وقد صاغت منظمة الصحة العالمية تعريفها للصحة على أنها: "المعافاة الكاملة، جسدياً ونفسياً واجتماعياً، لا مجرد انتفاء المرض أو العجز" وللصحة ثلاث أنواع:

1. الصحة الجسمية (Physical Health): وهي التي تتعلق بالجانب الجسماني، ولتحقيقها يجب عدم تناول ما يلحق ضرراً بالجسم، كما ينبغي الابتعاد عن العادات التي تسبب ضعفه ومرضه.
2. الصحة العقلية (Mental Health): وهي ما يتعلق بالجانب العقلي والفكري للإنسان، ويجب الحفاظ عليه، وذلك باجتناّب كل ما يؤدي إلى إتلافه أو تعطيله؛ كالخمر والمخدرات. والصحة العقلية السليمة ليست شيئاً تحوزه، ولكنها شيء تقوم به، فلكي تكون صحيحاً عقلياً فعليك أن تقيّم نفسك وتقبل بها، وهذا يعني:

- أن تشعر بأهمية نفسك وأن تقوم على رعايتها، وأن تحب نفسك ولا تكرهها، وأن تهتم بصحتك الجسدية.
- أن تأكل جيداً، وتنام جيدة، وأن تحافظ على لياقتك، وتمتع نفسك بما أحل الله لك.
- أن ترى نفسك شخصاً ذا قيمة بحد ذاتك؛ فلا ينبغي أن تكون نسخة من أحد، بل تنشئ نفسك مستعينا بالله، ثم بعمل مخلص دؤوب.
- أن تحكم على نفسك بناءً على مقاييس معتدلة، وألا تضع لنفسك أهدافاً مستحيلة؛ مثل: «يجب أن أكون ممتازة في كل ما أفعل».. ومن ثم تعاقب نفسك عندما لا تحقق هذه الأهداف.

3. الصحة النفسية (Psychological Health): تتعلق بالجانب الروحي في الإنسان. عن طريق الإيمان بالله وتقواه، وأداء العبادات المختلفة، والتحلي بالأخلاق الفاضلة؛ فالمؤمن الصادق لا تعرف الأمراض النفسية طريقاً إليه، لأنه لا يخاف من المرض والفقر أو المصائب لعلمه أن الرازق هو الله، وأنه لن يصيبه إلا ما هو مقدر له.

ولا يمكن للصحة النفسية أو الصحة الجسدية أن توجدا بمعزل عن بعضهما (العقل السليم في الجسم السليم، والعكس صحيح)، بل لا بد من أن تعتمد الوظائف الجسدية والنفسية بعضهما على بعض.

صحة الإنسان:

النمو الجسدي والعقلي والاجتماعي:

يتميز النمو البشري وتطوره بالطريقة التي يتغير فيها الحجم والشكل والنضج بالنسبة لمرور الوقت. لقد كان أكثر شيوعاً أن يتم تقييم حجم الأطفال لأسباب التصنيف والتنظيم التي تتطلب التقييم في أعمار معينة لأسباب محددة. ومع ذلك، فإن أول سجل طولي لدينا لنمو الطفل كان نتيجة الرغبة في تطبيق المنهج العلمي على العالم الطبيعي.

هناك مؤلفات أنثروبولوجيا واسعة النطاق، والتي تقدم وصفاً شاملاً لظاهرة أن حجم جسم الإنسان، ولا سيما القامة، التي تحققت في عمر معين، وكذلك وتيرة النضج الجنسي تكشف عن تباين داخل وبين السكان. باعتبارها سمات بيولوجية، يتم تحديدها جزئياً بواسطة العوامل الوراثية وجزئياً بواسطة العوامل البيئية، فضلاً عن التفاعل المتبادل بينهما. من بين العوامل البيئية، التي تساهم بشكل خاص في هذا الاختلاف، هناك عاملان في المقام الأول:

- جودة التغذية.
- المرض على مستوى السكان.

يشكل هذان المكونان البيئيان ما يسمى "الظروف المعيشية". لذلك، منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، في أوروبا الغربية، تم الاعتراف بالبيانات المتعلقة بمكانة الأطفال والمجندين العسكريين والعمر الرجولي كمؤشر جيد على درجة العجز الاجتماعي والاقتصادي والموارد.

علاوة على ذلك، فإنها توفر مؤشراً لدرجة عدم المساواة الاجتماعية بين السكان، وتبلغ عن التغيرات الزمنية في الحالة الاقتصادية للمجتمع بأكمله أو لمجموعات فرعية معينة، وهي شرائح محددة بدقة من المجتمع.

منذ عام 1976، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام بيانات نمو الأطفال كأفضل مؤشر على الحالة الصحية والتغذية للسكان، ولا يزال استخدامها شائعاً في الوقت الحاضر من قبل علماء الأنثروبولوجي والأكسولوجي.

لقد تطور الاهتمام والتقبل المتزايد للاعتراف بأهمية الديناميكيات الروحية والدينية في علاج الصحة العقلية والعلاج النفسي خلال العقود القليلة الماضية. في حين أنه لا يزال من السهل العثور على بعض الشكوك أو العداء تجاه الروحانية والدين بين مقدمي خدمات الصحة العقلية، فقد دعت جميع مجالات الصحة العقلية الرئيسية إلى الحساسية الروحية والدينية والكفاءة بين الممارسين.

أظهرت الأبحاث التجريبية أن العوامل الروحية والدينية يمكن أن ترتبط في كثير من الأحيان بشكل إيجابي بالصحة العقلية، وهناك أيضًا دليل تجريبي على أن غالبية عملاء العلاج النفسي لديهم معتقدات دينية وروحية هامة ويفضلون اعتبارها على أنها جزء من علاجهم النفسي.

من المعترف به الآن على نطاق واسع أن الخدمة السريرية الأخلاقية تتضمن معالجة الممارسات الدينية والروحية ومعتقدات العملاء باحترام وحساسية ثقافية وانفتاح (على سبيل المثال، الجمعية الأمريكية لعلم النفس).

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا للممارسة الأخلاقية أن يكون اختصاصيو الصحة العقلية على دراية بالتحيزات الشخصية المحتملة التي قد تكون لديهم فيما يتعلق بالدين والروحانية من أجل تقليل أي تأثير سلبي قد يكون لتحيزهم في علاج عملائهم.

TABLE 5.1. Ainsworth's Attachment Classifications With Associated Infant and Maternal Behaviors

Attachment classification	Infant behavior in the strange situation	Maternal behavior during home observations
Secure	Infants actively explored and played. Infants became upset and protested when mother left. Infants sought consolation and were comforted by mother when she returned. Infants resumed exploration and play after reunion.	Mothers were generally sensitive and attuned in responding to their infant, and made adjustments when misattuned.
Avoidant	Infants explored continually. Infants seemed indifferent to mother initially, during her absence, and when she returned. (Later research confirmed that despite appearing detached, these infants have high physiological distress.)	Mothers tended to reject infant's bids for attention and were often preoccupied with their own concerns.
Ambivalent	Infants appeared preoccupied with mother and do not explore/play much. Infants were upset when mother left. Infants were not receptive to soothing upon mother's return: some appeared angry and rejecting, others appeared helpless.	Mothers tended to be inconsistent in responding to infants and were often misattuned in their response.

أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان: 1. الأمراض السارية أو المعدية:

تعد الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسل والملاريا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وأمراض المناطق المدارية المهملة، من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في البلدان منخفضة الدخل والسكان المهمشين.

يعمل COVID-19 على عكس العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة هذه الأمراض. بالإضافة إلى النسبة العالية من الوفيات والمعاناة التي تسببها، فإن الأمراض المعدية تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن تشكل تهديدات كبيرة للأمن الصحي الدولي، كما يتضح من جائحة COVID-19.

المستمر. اعترافاً بالعبء الثقيل للأمراض المعدية، تتضمن أهداف التنمية المستدامة هدفًا محددًا لإنهاء أوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المزمنة، ومكافحة التهاب الكبد والأمراض المعدية الأخرى.

2. التدخين:

التدخين مضر جداً بصحة الإنسان، وهو يحتوي على العديد من المكونات مثل النيكوتين، والتبغ، وهذه المكونات تشكل خطراً على الصحة وتؤثر عليها سلباً، حيث تحتوي السجارة الواحدة على ستمائة مكون مختلف، وعند احتراق هذه المكونات يحدث تفاعل ينتج أكثر من 7000 مادة كيميائية بشكل عام منها 69 مادة مسرطنة، ولا تختلف السجائر عن الشيشة، فكلاهما لديه مستويات عالية من مسببات السرطان والسموم.

الانسحاب من التدخين يؤثر على:

- الشعور والنفسية فهو يسبب القلق، الغضب، والاكتئاب، وقد يسبب الصداع ومشاكل النوم.
- التدخين يؤثر على الأشخاص الموجودين في المكان نفسه، بسبب ظاهرة التدخين السلبي.
- جلطات الدم الناتجة عن التدخين يمكن أن تسبب السكتة الدماغية.
- التدخين من الممكن أن يكون له أعراض سلبية على الجلد، فهو قادر على التسبب بتلون الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.
- من الأعراض الجانبية للانسحاب من التدخين الغثيان والتقيؤ في بعض الأحيان والعصبية، وزيادة الوزن

3. الإدمان على المشروبات الكحولية:

يعتبر الكحول مادة نفسانية التأثير وذات خصائص مسببة للإدمان، ولطالما تم تعاطيه على نطاق واسع في العديد من الثقافات على مدى قرون. ويتسبب تعاطي الكحول على نحو ضار في عبء ثقيل من المرض وله عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة. وقد يتسبب تعاطي الكحول على نحو ضار كذلك في الإضرار بالآخرين من قبيل أفراد الأسرة، والأصدقاء، وزملاء العمل والغرباء. ويمثل تعاطي الكحول عاملاً مسبباً لأكثر من 200 مرض وإصابة واعتلالات صحية أخرى. ويرتبط شرب الكحول بمخاطر الإصابة بمشاكل صحية مثل الاضطرابات النفسية والسلوكية، بما فيها إدمان الكحول، والأمراض غير السارية الرئيسية مثل تشمع الكبد وبعض أنواع السرطان والأمراض القلبية الوعائية.

تنشأ نسبة كبيرة من عبء المرض الذي يمكن أن يعزى إلى استهلاك الكحول من الإصابات المتعمدة وغير المتعمدة، بما في ذلك تلك الناجمة عن حوادث المرور والعنف والانتحار. وعادةً ما تحدث الإصابات المميتة التي يمكن أن تعزى إلى استهلاك الكحول بين الفئات العمرية الصغيرة السن نسبياً. وقد ثبت وجود علاقة سببية بين شرب الكحول على نحو ضار والإصابة بالأمراض المعدية من قبيل السل وفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز أو حصائلها. إن تعاطي الأم الحامل للكحول قد يسبب متلازمة الكحول الجنينية ومضاعفات الولادة المبكرة.

4. الإدمان على المخدرات:

يعد إدمان المخدرات من أخطر المشكلات التي يتعرض لها الفرد أو المجتمع، حيث أن أضرار تعاطي المخدرات لا تمس مدمن المخدرات فقط، بل تمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية.

أضرار المخدرات الصحية من أشد الأضرار التي يتعرض لها مدمن المخدرات هو التأثير السلبي للمخدرات على صحة وجسم المدمن. ومن أبرز أضرار تعاطي المخدرات التي يمكن من خلالها التعرف على مدمن المخدرات:

- حدوث اضطرابات في القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين.
- التعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة.
- حدوث التهابات في المخ والتي تؤدي إلى الشعور بالهلوسة وأحيانًا فقدان الذاكرة.
- تليف الكبد وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم.
- اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الشهية مما يؤدي إلى الهزال والشعور بعد الاتزان.
- التأثير السلبي على النشاط الجنسي.

من أضرار المخدرات الصحية أيضًا ضعف الجهاز المناعي والصداع المزمن، وفي حالة الحمل قد تتعرض المرأة الحامل لحدوث فقر الدم وإجهاض الجنين وقد يمتد الأمر لحدوث عيوبًا خلقية للأجنة. وحدث الضرر النفسي والعقلي لمتعاطي المخدرات، وقد يؤدي الإفراط في تعاطي المخدرات إلى حدوث أمراضًا نفسية مزمنة واضطرابات عقلية إذا لم يتم تدارك الأمر. من أمثلة الأضرار النفسية والعقلية للمخدرات: حدوث تغيير في تركيبة المخ بالإضافة إلى حدوث خلل في الطريقة التي يعمل بها.

5. الأمراض القلبية والوعائية والداء السكري:

أهم عوامل الخطر السلوكية والتي تؤدي إلى حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية هي اتباع نظام غذائي غير صحي وعدم ممارسة النشاط البدني وتعاطي التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار. قد تظهر آثار عوامل الخطر السلوكية لدى الأفراد على شكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، وارتفاع مستوى الشحوم في الدم والزيادة المفرطة في الوزن والسمنة. ويمكن أن تُقاس "عوامل الخطر المتوسطة" هذه في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وأن تدل إلى مخاطر متزايدة لحدوث نوبة قلبية وسكتة دماغية وقصور القلب ومضاعفات أخرى.

إن الامتناع عن تعاطي التبغ، وتلافي الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، واختيار نظام غذائي غني بالخضر والفواكه، والشروع في ممارسة نشاط بدني بانتظام، وتجنب تعاطي الكحول على نحو ضار أثبت أنه من الممكن التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية. وإضافة إلى ذلك قد يكون علاج داء السكري والارتفاع المفرط في ضغط الدم وارتفاع مستوى الشحوم في الدم بواسطة الأدوية ضروريًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وللوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تُعتبر السياسات الصحية التي تهئ بيئات مواتية لاتخاذ خيارات صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع عنصراً أساسياً لتحفيز الناس على اتباع سلوك صحي والمحافظة عليه. وتشمل أمثلة التدخلات التي تنفذ على النطاق السكاني التي يمكن تنفيذها للحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:

- سياسات شاملة لمكافحة تعاطي التبغ.
- فرض الضرائب للتقليل من مدخول الأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح.
- بناء مسارات المشي وركوب الدراجات لزيادة النشاط البدني.
- استراتيجيات للتقليل من تعاطي الكحول على نحو ضار.
- تقديم الوجبات الصحية للأطفال في المدارس.

6. الأمراض الجنسية والإجراءات الوقائية:

هناك أكثر من 30 نوعاً مختلفاً من البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي يُعرف بأنها تنتقل عبر الاتصال الجنسي. وترتبط ثمانية من مسببات المرض هذه بأقصى معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً. ومن بين هذه المسببات، يمكن شفاء 4 حالات في الوقت الراهن وهي: الزهري والسيلان والمتدثرة وداء المشعرات. وأما الحالات الأربع الأخرى، فهي حالات عدوى فيروسية لا يمكن شفاؤها، وهي فيروس التهاب الكبد B، وفيروس الحلا البسيط (أو الهربس)، وفيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس الورم الحليمي البشري.

والطريقة السائدة لانتشار أنواع العدوى المنقولة جنسياً هي عن طريق الاتصال الجنسي. وقد تنتقل بعض أنواع العدوى المنقولة جنسياً من الأم إلى الطفل أثناء الحمل والوضع والإرضاع. وقد يصاب الشخص بعدوى منقولة جنسياً دون أن تظهر عليه أعراض مرضية واضحة. وتشمل الأعراض الشائعة للأمراض المنقولة جنسياً الإفرازات المهبليّة، والإفرازات الإحليلية أو الحرقان عند الرجال، وفُرح الأعضاء التناسلية، وألم البطن.

تتيح الواقيات الذكرية، عند استخدامها على النحو السليم وبشكل مستمر، واحدة من أنجح وسائل الوقاية من أنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. وتحمي الواقيات الذكرية كذلك من الحمل غير المقصود في العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي المتبادل. وعلى الرغم من فعالية الواقي الذكري، فإنه لا يوفر الحماية من العدوى المنقولة جنسياً التي تسبب قرحة خارج الأعضاء التناسلية (أي الزهري أو الهربس التناسلي). وتتوفر لقاحات آمنة وعالية الفعالية من أجل نوعين من أنواع العدوى المنقولة جنسياً، وهما التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري. وتمثل هذه اللقاحات تقدماً بارزاً في الوقاية من أنواع العدوى المنقولة جنسياً.

رغم الجهود الهائلة المبذولة لتحديد تدخلات بسيطة يمكنها الحد من السلوكيات الجنسية الخطرة، يظل تغيير السلوك أحد التحديات المعقدة. وقد أظهرت البحوث ضرورة التركيز على فئات سكانية محدّدة بعناية، والتشاور المكثّف مع الفئات السكانية المستهدفة على وجه التحديد، وإشراكها في عمليات التصميم والتنفيذ والتقييم. ويمكن للتعليم والمشورة أن يحسّنا قدرة الناس على التعرف على أعراض أنواع العدوى المنقولة جنسياً وأن يزيدا من احتمال التماسهم الرعاية وتشجيع الشريك الجنسي على القيام بذلك. وللأسف، فإن

نقص الوعي العام، ونقص التدريب بين العاملين الصحيين، ووصمة العار التي طال أمدها على نطاق واسع بشأن الأمراض المنقولة جنسياً، لا تزال تشكل حواجز أمام استخدام هذه التدخلات بشكل أكبر وأكثر فعالية.

يواجه الأشخاص الذين يلتمسون الفحص والعلاج من أنواع العدوى المنقولة جنسياً مشاكل متعددة. وتشمل هذه المشاكل محدودية الموارد، والوصم، ورداءة جودة الخدمات، ونفقات من الأموال الخاصة في كثير من الأحيان. وفي غالب الأحيان لا تتاح إمكانية الحصول على خدمات ملائمة في مجال الصحة الجنسية أمام الفئات السكانية المهمشة صاحبة أعلى معدلات الإصابة بأنواع العدوى المنقولة جنسياً مثل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، ونزلاء السجون، والفئات السكانية المتنقلة، والمراهقين.

وفي كثير من الظروف، غالباً ما تكون خدمات العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل مهمة وتعاني من نقص التمويل. وتؤدي هذه المشاكل إلى صعوبات في توفير الفحص للكشف عن حالات العدوى عديمة الأعراض، وعدم كفاية عدد الموظفين المدربين، ومحدودية القدرة المختبرية، وعدم كفاية إمدادات الأدوية المناسبة.

7. الأمراض الورمية (السرطانية) والإجراءات الوقائية:

ينشأ السرطان عن تحول خلايا عادية إلى أخرى ورمية في عملية متعددة المراحل تتطور عموماً من آفة سابقة للسرطان إلى ورم خبيث. وهذه التغيرات ناجمة عن التفاعل بين العوامل الوراثية للشخص وثلاث فئات من العوامل الخارجية، منها ما يلي:

- العوامل المادية المسرطنة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤينة.
- العوامل الكيميائية المسرطنة، مثل الأسبستوس ومكونات دخان التبغ والكحول والأفلاتوكسين (أحد الملوثات الغذائية) والزرنيخ (أحد ملوثات مياه الشرب).
- العوامل البيولوجية المسرطنة، مثل الالتهابات الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

يمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق ما يلي:

- الإقلاع عن تعاطي التبغ.
- الحفاظ على وزن صحي للجسم.
- اتباع نظام غذائي صحي يشمل تناول الفواكه والخضروات.
- ممارسة النشاط البدني بانتظام.
- تجنب تعاطي الكحول أو تقليل تعاطيه.
- الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B إذا كنت منتمياً إلى فئة يُوصى بتطعيمها.
- تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية (الناجمة في المقام الأول عن التعرض لأشعة الشمس و/ أو أجهزة التسمير الاصطناعية) و/ أو تطبيق تدابير الحماية من أشعة الشمس.
- الحد من التعرض (قدر المستطاع) للإشعاع المؤين (من خلال التصوير التشخيصي المهني أو الطبي).

- الحد من التعرّض لتلوث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة، بما فيه غاز الرادون (وهو غاز مشع ينتج عن الاضمحلال الطبيعي لليورانيوم، ويمكن التعرّض له في المنازل والمباني).

المحافظة على صحة الإنسان:

1. أهمية النظافة الفردية:

تعتبر النظافة الجيدة أمراً حيوياً لأنها تساعد على منعك أنت وأطفالك من الإصابة بالجراثيم والأمراض المعدية أو نشرها. يمكن أن تنتقل الجراثيم التي تسبب العديد من الأمراض من خلال ملامسة أشخاص آخرين، أو ملامسة يديك بالبراز، أو التعامل مع الطعام الملوث، أو ملامسة الأسطح أو الأشياء المتسخة.

محاولة الاستحمام كل يوم. الغسل جيداً، خاصةً تحت الإبطين وحول الأعضاء التناسلية والشرج. الحفاظ على النظافة سيمنع تهيج الجلد ويزيل البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم. غسل الجسم بالصابون أو سائل الاستحمام أو غسل الجسم المضاد للحساسية. يزيل الصابون المزيد من الجراثيم، ولكن قد تحتاج إلى غسل أجزاء الجسم الحساسة بالماء العادي أو الماء المالح. إذا لم يكن هناك ماء من الصنبور أو كان نادراً، فيمكن التنظيف بقطعة قماش مبللة أو إسفنج نظيفة.

لتجنب الإصابة بالمرض، يجب غسل اليدين جيداً لمدة 20 ثانية على الأقل.

2. مكافحة الأمراض والوقاية منها:

تتطلب الوقاية من انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو الحد منها تطبيق الإجراءات والبروتوكولات التي يشار إليها بمسمى "الضوابط". وقد نظمت هذه الضوابط في تسلسل هرمي وفقاً لفعاليتها في الوقاية من العدوى ومكافحتها، وهي تشمل ما يلي: الضوابط الإدارية، والضوابط البيئية والهندسية، ومعدات الحماية الشخصية.

- **الضوابط الإدارية:** تعطي هذه الضوابط الأولوية الأولى في استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها. وهي توفر البنية التحتية للسياسات والإجراءات الرامية إلى الوقاية من انتقال العدوى أثناء الرعاية الصحية والكشف المبكر عنها ومكافحتها. ولكي تكون تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها فعالة، يجب التنبؤ بمدى تدفق المرضى (والتنبؤ بالتالي بالمخاطر المحتملة) بدءاً من اللقاء الأول وحتى الخروج من المرفق.

- **الضوابط البيئية والهندسية:** تتضمن هذه الضوابط البنى التحتية الأساسية لمرافق الرعاية الصحية. وتعنى هذه الضوابط بضمان التهوية الكافية في جميع الأماكن داخل مرافق الرعاية الصحية، والتنظيف الكافي لهذه الأماكن. وينبغي الفصل بمسافة متر واحد على الأقل بين الأماكن المخصصة للمريض المصاب بأحد أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأشخاص الآخرين، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية (عندما يكونون غير مستخدمين لمعدات الحماية الشخصية). ومن شأن هذين الضابطتين أن يحدا من انتشار العديد من الممرضات أثناء الرعاية الصحية.

- **معدات الحماية الشخصية:** يساعد الاستخدام الرشيد والمستمر لمعدات الحماية الشخصية المتاحة وتنظيف اليدين على النحو الملائم أيضاً على الحد من انتشار العدوى. ويعد استخدام معدات الحماية الشخصية الضابط الأكثر وضوحاً للعيان من بين الضوابط المستخدمة في الوقاية من العدوى، ومع ذلك فهو آخر الضوابط وأضعفها في التسلسل الهرمي لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وينبغي

ألا يعتمد عليه كاستراتيجية أولية للوقاية. وفي غياب الضوابط الإدارية والهندسية الفعالة، لا تعود معدات الحماية الشخصية إلا بفائدة محدودة.

وسائل التربية الصحية:

التثقيف الصحي هو مزيج من الاستراتيجيات التعليمية التي تعزز التبني الطوعي لخيارات وسلوك أنماط الحياة الصحية. ويمكن تعريف نمط الحياة الصحي كما حددته منظمة الصحة العالمية على أنه "أسلوب حياة يتضمن تناول الكثير من الفواكه والخضروات وتقليل تناول الدهون والسكر والملح وممارسة الرياضة".

تعد الكتيبات، والمبادئ التوجيهية، ومنشورات المعلومات هي بعض الأدوات التقليدية التي توفر التثقيف الصحي للجماهير. وتعد مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية والمدونات هي أمثلة على الأساليب الحديثة التي تحظى بشعبية في زيادة الوعي الصحي بين الشباب. فهذه الأدوات مفيدة في تحسين المعرفة العامة للمرضى وعائلاتهم حول نمط الحياة الصحي والتزامهم بالعلاج.

في الإعداد السريري، يمكن استخدام هذه الأدوات كتعزيز من قبل الأطباء وأخصائي التغذية وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية المساعدة أثناء التواصل اللفظي مع المرضى. لا تساعد أدوات التثقيف الصحي في معالجة شكوك وتخوفات المرضى فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل كبير في التدريس والبحث.

دور المؤسسات العامة والخاصة في التثقيف الصحي:

دور الإعلام في التثقيف الصحي:

يلعب الإعلام دور كبير في المجال الصحي، كما أنه ليس محصوراً في نشر كافة الحالات المرضية وإنما يساهم في نشر كافة الأمور المتعلقة بالصحة.

- يساهم الإعلام بنشر كافة المعلومات والأخبار المتعلقة بالصحة، كما يقوم بنشر الإنجازات والندوات بالإضافة إلى نشر ورش العمل والقضايا التي تكون متعلقة بشكل كبير بالصحة والتجارب الصحية.
- يساهم الإعلام الصحي في تقديم كافة الإحصائيات والبيانات ذات علاقة بالصحة، مع أهمية التركيز على تحليلها وتقديمها لكافة الفئات الجماهيرية المتخصصة.
- يهدف الإعلام من خلال استخدام الأنشطة في رفع الوعي الصحي لدى الأفراد والمجتمعات المستهدفة، بالإضافة إلى أنه يساهم في غرس السلوكيات الصحية السليمة والإيجابية.
- يساهم الإعلام في تعزيز العلاقات والشراسة ما بينه وما بين القطاع الصحي، حيث يكون ذلك من خلال تقديم المعلومات الصحيحة، وأهمية التركيز على العواقب التي تحدثها الشائعات والمعلومات الخاطئة.
- يلعب الإعلام دور في تشجيع مؤسسات المجتمع للتكاتف مع بعضها البعض؛ وذلك من أجل خدمة المجال الصحي، بالإضافة إلى تشجيع الجهود التي تكون ذات هدف وإلى تنمية وتطوير كافة البرامج التوعوية الصحية. يساهم الإعلام في إبراز الجهود الناتجة عن المبادرات الصحية لدى المؤسسات العاملة والأفراد.

دور المشافي في التنقيف الصحي:

- زيادة وعي المرضى وأسرهم بأمراض العيون وغيرها من الاضطرابات الصحية ذات الصلة من خلال أنواع طرق التعليم المباشرة وغير المباشرة.
- تقديم الخدمات التعليمية لمرضى العيادات الخارجية من خلال الإحالة إلى قسم التوعية الصحية أو العيادة التعليمية في العيادات الخارجية.
- زيادة وعي المجتمع والعامّة وتعزيزه بشأن أمراض العيون وغيرها من الاضطرابات الصحية المتعلقة بذلك من خلال البرامج، والحملات، ووسائل الإعلام.
- تعزيز حقوق المرضى/أسرهم ومسؤولياتهم في جميع أنحاء المستشفى.
- تعزيز مفهوم تعزيز الصحة من خلال مواصلة أنشطتها لمرضى وموظفي المستشفى وللمجتمع من خلال هوية المؤسسة وممارسة الأعمال الروتينية.
- تعزيز القنوات التعليمية في المستشفى عن طريق بث فيديوهات تعليمية.
- توفير الفرص التدريبية لطلاب وطالبات التوعية الصحية كجزء من تطوير معارفهم ومهاراتهم وتحسينها.
- مساعدة فرق الرعاية الصحية الأخرى؛ لتحسين رضا المريض عن الرعاية الصحية المقدمة له.
- توفير التعليم المستمر لأخصائيي التوعية الصحية من خلال تنظيم ورش عمل وندوات في المستشفى وخارجه إذا لزم الأمر.

دور المثقف الصحي ومواصفاته:

يقوم أخصائيو التنقيف الصحي بتطوير برامج لتعليم الناس الظروف التي تؤثر على الرفاهية. يعمل العاملون في مجال الصحة المجتمعية على تعزيز العافية من خلال مساعدة الناس على تبني سلوكيات صحية.

مُعد مهنيًا ويمتلك المعرفة والمهارات القائمة على النظريات والأبحاث لتعزيز تغيير سلوك التنقيف الصحي لدى الأفراد والسكان. يستمد التنقيف الصحي من علوم مختلفة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والعجز والوفاة المبكرة. يقدم اختصاصيو التوعية الصحية معلومات عن القضايا المتعلقة بالصحة. يمكنهم تقييم احتياجات التدريب الصحي والتخطيط لبرامج التنقيف الصحي. قد يتخصصون وفقًا لمخاوف صحية محددة أو أمراض أو بيئة عمل أو تدريب. قد يعمل اختصاصيو التوعية الصحية كمستشارين مستقلين أو في الإدارات الصحية أو المنظمات المجتمعية أو الشركات أو المستشفيات أو المدارس أو الوكالات الحكومية. غالبًا ما يقوم اختصاصيو التوعية الصحية بما يلي:

- القيام بإجراء تقييمات لاحتياجات التدريب الصحي.
- تصميم وتطوير برامج التنقيف الصحي.
- نشر مواد التنقيف الصحي وأوراق المعلومات ومقترحات المنح.
- تطوير مناهج التنقيف الصحي.
- تعليم الصحة في المدارس الحكومية والخاصة.

تلقى معلم الصحة تدريبًا في مجال الصحة العامة أو تعزيز الصحة أو صحة المجتمع على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. للحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة في القوى العاملة في مجال التنقيف الصحي، ويمكن للمعلمين الصحيين الحصول على شهادات إضافية مثل أخصائي التنقيف الصحي

المعتمد (CHES) وأخصائي التثقيف الصحي المعتمد (MCHES)، وكلاهما مُنح من خلال اللجنة الوطنية لاعتماد التثقيف الصحي إلى الأشخاص الذين استوفوا مؤهلات الإعداد والامتحان الأكاديمي، والتي تتطلب أن يظل الشخص على اطلاع دائم بمتطلبات التعليم، وأن يحصل على 75 ساعة اتصال للتعليم المستمر على الأقل كل 5 سنوات.

يجب أن تستمر مهنة اختصاصي التوعية الصحية في دمج المهارات واسعة النطاق التي تتوافق مع احتياجات الصحة العامة الحالية في الإعداد المهني والتعليم المستمر. لمواجهة تحديات الصحة العامة الناشئة، ويحتاج العاملون في مجال الصحة العامة الحكوميون، بما في ذلك المثقفون الصحيون، بشكل متزايد إلى المزيد من المهارات الاستراتيجية التي تعالج المحددات الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية للصحة. تشمل احتياجات التدريب فهم التفكير في النظم وتحديد التدخلات عالية التأثير، وتغيير نهج الإدارة لتوسيع نطاق البرامج استجابة للبيئات المتطورة، واستخدام البيانات لصنع القرار، وتحديد المشكلات وحلها وتقييم النتائج، وإشراك السكان غير الممثلة تمثيلاً ناقصاً، واكتساب المعرفة بإدارة الموارد البشرية والمالية، ومعالجة مخاوف الصحة العامة أثناء إشراك جمهور أوسع من صانعي السياسات والقرارات.

صحة البيئة

مقدمة:

يعمل الإنسان دائماً وأبداً على استغلال مواد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته، إلا أن استغلاله لهذه الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدى إلى اختلال توازن جودة حياته، وأضر البيئة بشكل عام فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته. وأصبح هناك اعتقاد خاطئ بأن القضاء على مصادر التلوث هو الأساس في النهوض بالبيئة من جديد وليس العمل على تنمية مواردها وتحسين استخدام مثل هذه الموارد .

أما الاهتمام بالبيئة وقضاياها عبر السياسات البيئية فحديث نسبياً، وقد ظهر اصطلاح "علم البيئة" ecology عام 1866 على يد عالم الحيوان الألماني إرنست هاكيل. ويشق اصطلاح "علم البيئة" ecology من الكلمة اليونانية oikos والتي تعني الموطن، وقد استخدمه هاكيل للإشارة إلى "البحث في مجموع علاقات الحيوان ببيئته العضوية وغير العضوية". ومنذ أوائل القرن العشرين عُرف "علم البيئة" بكونه فرعاً من فروع البيولوجي (الأحياء) يبحث في علاقة الكائنات الحية ببيئتها.

في بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت القضية ذات الأهمية الأكبر التي يواجهها العالم اليوم هي قضية البيئة. وقد برزت المشاكل البيئية بوضوح في التحذيرات العلمية ومخاوف الجمهور واهتمام وسائل الاعلام، كما بدأت تأخذ طريقها إلى البرامج السياسية، والعالم العربي ليس معزولاً عن بقية العالم فيما يتعلق بهذا الموضوع.

البيئة وأنواعها:

- تعريفها:

هي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية علي سطح الأرض متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم ،كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابهة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري .

- أنواع البيئات:

- 1- بيئة مادية: الهواء - الماء - الأرض.
- 2- بيئة بيولوجية: النباتات - الحيوانات - الإنسان. وفي ظل التقدم والمدنية التي يلحظها العالم ويمر بها يوماً بعد يوم فيمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أنواع أخرى مرتبطة بالتقدم الذي أحدثه الإنسان:

- بيئة طبيعية: والتي تتمثل أيضاً في: الهواء - الماء - الأرض.
- بيئة اجتماعية: وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلاقات الداخلية للأفراد إلى جانب المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية.
- بيئة صناعية: أي التي صنعها الإنسان من: قرى - مدن - مزارع - مصانع - شبكات.

الأسباب التي أدت إلى وجود التحديات البيئية:

يعتبر الإنسان واستغلاله للموارد والذي يتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدى إلى اختلال توازن جودة حياته، والإضرار بالبيئة بشكل عام هو السبب الرئيسي الذي أدى لوجود المشاكل البيئية التي لا نعرف عواقبها حتى الآن. إن موضوع البيئة هو موضوع الحياة على هذا الكوكب في صورتها الطبيعية والبشرية. وهي مسؤولية كل من يعيش على الأرض بهدف إعمارها وليس التسبب في تدمير عناصر الحياة فيها، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بيد الإنسان، لكن يبدو أنه في طريقه إلى الرفاهية قد تعدى حدوده حتى غدت تصرفاته هي مصدر تلوث البيئة والإضرار بها. وإذا استثنينا بعض الظواهر التي تتم في إطار الطبيعة نفسها وفقا لقوانينها إلا أن قضايا البيئة تدور كلها حول الإنسان فهي من صنعه.

التلوث وأنواعه:

يعد التلوث مسؤولية الإنسان وهو الذي يسبب لنفسه الخطر، ولهذا فإن البيئة تحتاج إلى أناس يحبونها ويعرفون العناية بها جيدا فكل مكان توجد فيه النفايات والفضلات فهو نوع من التلوث. وكل دخان منتشر في الهواء فهو نوع آخر من التلوث. وكل ماء ملوث متجه نحو النهر فهو نوع جديد من التلوث، وكل مبيد يرش فهو ملوث للهواء .

يعرف التلوث بأنه أي تغير كيميائي أو نوعي في المكونات البيئية على ان يكون هذا التغير خارج مجال التذبذبات لأي من هذه المكونات بحيث يؤدي إلى اختلال في اتزان الطبيعة، كما وتعرف الملوثات بأنها أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أية ميكروبات أو جزيئات تؤدي لزيادة أو نقصان في المجال الطبيعي لأي من المكونات البيئية.

أنواع التلوث:

التلوث الهوائي Air Pollution	تلوث التربة Soil Contamination
التلوث المائي Water Pollution	التلوث الضوئي Light Pollution
التلوث الإشعاعي Radioactive Pollution	التلوث البصري Visual pollution

طرق التخلص والوقاية من التلوث الهوائي:

1. إلزام كافة المصانع في القطاع الخاص والعام على إقامة وحدات فلترة ومعالجة لمخلفاتها الغازية أو الغبارية والسائلة.
2. استخدام البنزين الخالي من الرصاص والمازوت الخالي من الكبريت.
3. مراقبة كافة وسائل النقل الخاصة والعامة والتأكد من سلامة محركاتها واحتراق الوقود بشكل سليم.
4. إبعاد المصانع عن المدن وأماكن السكن.
5. معالجة مياه الصرف الصحي بالطرق العلمية الحديثة.
6. استخدام الطاقة النظيفة بديلا عن الوقود الأحفوري (الفحم والمازوت).
7. استخدام المبيدات والأسمدة ذات المصدر العضوي وليس الكيميائي.
8. مراقبة المصانع والفعاليات الإنتاجية ذات التقنيات القديمة والملوثة وتطويرها.

9. زيادة المساحات المشجرة داخل المدن والتي يجب ألا تقل عن 44% من مساحة المدينة، بالإضافة إلى زراعة أحزمة خضراء تحيط بها.
10. عدم إعطاء أي ترخيص صناعي جديد لا يتقيد بشروط الحفاظ على سلامة صحة الإنسان والبيئة.

طرق مواجهة نقص المياه:

هنالك عدة طرق لزيادة كمية المياه العذبة منها:

- 1- المطر الاصطناعي: عادة يسقط المطر بواسطة تكتل بخار الماء على الذرات الصلبة الموجودة في الهواء مثل ذرات الغبار فتثقل هذه الذرات وتسقط على شكل أمطار، بالطبع بوجود عوامل أخرى مناسبة. العديد من الخبراء حاولوا تقليد هذه الطريقة بواسطة رش ملح يدعى يوديد الفضة AgI حيث يوجد لهذا الملح مقدرة لتجميع بخار الماء وتكوين قطرات ثقيلة تسقط على شكل أمطار. إحدى سيئات هذه الطريقة أنه يجب أن تتوفر الغيوم لحدوثها وأيضاً ممكن أن تسقط في أماكن غير مرغوب فيها بسبب الرياح الشديدة. التكاليف الاقتصادية لهذه الطريقة منخفضة نسبياً ولكنها تزودنا بكمية قليلة من الماء.
- 2- تحلية المياه المالحة: تحلية المياه المالحة معناه الحصول على مياه تركيز الأملاح فيها قليل بواسطة طرق مختلفة تقوم بفصل الأملاح عن الماء أو بفصل الماء عن الأملاح. هنالك عدة طرق لعملية التحلية منها طريقة الأسموزة العكسية وطريقة التبخر المضغوط.
- 3- تنقية مياه المجاري: تحتوي مياه المجاري 6.66% مياه فقط 6.4% مواد صلبة منها المواد العضوية. لهذا السبب مهم جداً أن نقوم باسترجاع هذه المياه، خاصةً بسبب قلة كمية المياه.
- 4- استعمال مياه المجاري: إن استعمال مياه المجاري المكررة يوفر كميات كبيرة من المياه الصالحة للاستعمال. ويمكن توفير حوالي 44% من المياه الصالحة للاستعمال المستعملة بالزراعة بواسطة استبدالها بمياه مجاري مكررة. إن الخطر الأساسي باستعمال مياه المجاري المكررة يكمن في إمكانية التعرض للأمراض نتيجة استعمال المنتجات الزراعية ولكي نمنع ذلك يجب أن تكون المياه المكررة ذات جودة عالية.
- 5- تجميع مياه الأمطار: كميات كبيرة من الأمطار تذهب سدى في كل سنة لأنها تجري كمياه علوية إلى البحر. ومن الممكن تجميع هذه المياه في مجمعات خاصة واستغلالها فيما بعد. لهذا الهدف يجب بناء السدود في مجرى الأنهار، ولكن توجد صعوبة في إيجاد مساحات تستعمل كمجمعات مائية وكذلك تكلفة إقامة هذه المجمعات تعتبر باهظة.
- 6- توفير في استهلاك الماء: توفير المياه هو مصدر المياه الصالحة الأكبر وهو الأرخص.

صحة الغذاء:

علم التغذية nutrition هو العلم الذي يبحث في العلاقة ما بين الغذاء food والجسم الحي، ويشمل ذلك تناول الطعام وهضمه digestion وامتصاصه absorption واستقلابه metabolism في الجسم، وما ينتج عن ذلك من تحرير الطاقة اللازمة للحياة والتكاثر وصيانة الأنسجة والإنتاج، وكذلك التخلص من

الفضلات. أي أن علم التغذية يعنى بجميع عمليات التقويض catabolism والابتناء anabolism التي تجري في الجسم مع ربطها بالغذاء المتناول وما يحتويه من العناصر الغذائية.

إرشادات غذائية للتقليل والسيطرة على الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية:

ازداد انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية بشكل كبير في معظم الدول العربية، وتشمل هذه الأمراض أمراض القلب والسمنة والسكري والسرطان وتسوس الأسنان. وفي عام 1994 عقدت الندوة الأولى حول التغذية والأمراض المزمنة في الدول العربية، ووضعت الندوة في ختام أعمالها إرشادات للتقليل من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها، نلخصها كالتالي:

1. قلل من تناول الأغذية الغنية بالدهون والكوليسترول.
2. حافظ على الوزن المثالي.
3. حاول الإكثار من الكربوهيدرات المركبة والألياف الغذائية.
4. قلل من تناول الصوديوم.
5. أكثر من تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم.
6. احرص على تناول الأغذية الغنية بالحديد.
7. قلل من تناول السكر.
8. احرص على أن يحتوي ماء الشرب على مادة الفلور.
9. قلل من تناول الأغذية المدخنة والمخللة والمملحة.
10. لا تدخن وابتعد عن مخالطة المدخنين.
11. لا تتناول المشروبات الكحولية.

صحة السكن:

تؤثر السكنات غير اللائقة بطريقة مباشرة على نوعية وجودة السلامة الصحية للأفراد، ومن أوجه هذا التأثير السلبي أن معظم السكنات غير اللائقة تتصف بقلة الوسائل الفعالة للتخلص من النفايات مما ينجر عنه التأثير السلبي على الجانب الوقائي الصحي وانتشار العديد من الأمراض المعدية، أو إذا كان السكن في حد ذاته مصدر للضجيج المستمر أو لم تكن له القدرة التقنية على التقليل من مصادر الضجيج الخارجية، إضافة إلى واقع احتواء السكنات الجاهزة على مادة الأميونت المسرطنة، ففي هذه الحالة يتحول السكن من ملاذ للراحة والطمأنينة إلى مصدر للخطر الصحي.

يعتبر المظهر الجمالي والمساحات الخضراء كذلك عنصر من عناصر السلامة الصحية النفسية للفرد، وبالتالي نتج عن ذلك إهمال للنوعية مقابل الاهتمام المتزايد بالكم فقط لمواجهة الطلب المتزايد على السكن بغض النظر عن كونه لائقاً أم لا.

يعتبر الحق في سكن لائق من الحقوق المسلم بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان الحصول على مستوى معيشي مناسب لكل فرد، ورغم ذلك وحسب احصائيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2010 فإن أزيد من مليار شخص على مستوى العالم لا يتمتعون بسكن لائق، ويعيش الملايين منهم في ظروف

تهدد حياتهم أو صحتهم، في أحياء فقيرة، عشوائية، أو في ظروف أخرى لا تراعي حقوق الإنسانية وكرامتهم.

في حين أن الاعتراف الرسمي دولياً بحق كل فرد في سكن لائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب تم بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة 25 البند 01 منه، ثم تم تأكيده صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966 في المادة 2 البند 01 منه. وبداية من هذا التاريخ اعترفت عدة معاهدات دولية متعلقة بحقوق الإنسان سواء صراحةً أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو إلى بعض عناصره، مثل حماية مسكن الفرد وخصوصيته. والملاحظ أن الالتزام باحترام الحق في السكن اللائق يطبق في كل الدول، باعتبار أن كل دولة لابد أن تكون قد صادقت على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات الدولية التي تشير إلى الحق في السكن اللائق والتزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية.

مفهوم السكن غير اللائق:

نعني بمصطلح "سكن"، لغة سَكَنَ، يسكن، فهو ساكن، فكل كلمة سكن مأخوذة من السكنية أي السلام بمعنى المكان الذي يوفر السكنية والسلام لشاغليه. ومن هنا أخذ المسكن معناه بأنه: إقامة مهيأة للناس في مجتمع معين، وهو الذي يؤمن استقرار الحياة للناس بحثاً عن السكنية والطمأنينة.

والسكن غير اللائق بهذا المعنى، يقصد به السكن الذي لم/ ولا يحترم الشروط والمقاييس القانونية والتقنية للتعمير، مهما تغيرت تسميات وأشكال هذا النوع من السكن كالسكن الفوضوي، السكن القصديري، سكن عشوائي، سكن هش، سكن عتيق أو آيل للسقوط.....

معايير السكن اللائق:

إن تحديد مفهوم "لائق" في هذه الحالة يتوقف على تبيان مجموعة من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، وكذا المناخية المشتركة بين الدول والواجب توافرها، وإن كان مستوى وحدة توافرها يختلفان من دولة إلى أخرى، غير أن السكن يجب أن يستوفي على الأقل أدنى المعايير التي سيأتي ذكرها وإلا اعتبر سكناً غير لائق.

ويقصد بهذه المعايير مجموع المقاييس والاعتبارات التي تم صياغتها وإنجاز وحداتها طرف المهتمين بشؤون العمارة والسكن، والتي يستوجب مراعاتها أثناء عمليتي تصميم السكنات، وذلك بغرض ضمان الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع، وتوفير فضاء سكني لائق لحياة إنسانية كريمة من أجل الوصول إلى أقصى درجات الإشباع السكني اللائق. تتمثل أهم هذه العوامل حسب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في:

- 1- أمن الحيازة: ويقصد به الضمان القانوني لامتلاك المسكن.
- 2- الصلاحية للسكن: بمعنى أن توفر مساحة السكن الحيز المناسب لساكنيه. إضافة إلى القدرة على الحماية من مختلف العوامل الطبيعية الخارجية.
- 3- توفر الخدمات الضرورية والمرافق الأساسية: ويقصد بالخدمات والمرافق الأساسية توفير خدمات متعلقة بالصحة، الأمن، الراحة، والبيئة النظيفة.

4- الملاءمة من الناحية الثقافية: يجب أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة.

5- المعايير النفسية والصحية للسكن اللائق: تمثلت في مجموعة من الاحتياجات والمتطلبات النفسية والصحية الواجب توافرها في أي سكن حتى يرقى إلى مستوى سكن لائق، وتتمثل في:

- الاحتياجات الجسدية: وتتمثل في قدرة السكن على المحافظة على درجة حرارة مناسبة لجسد الإنسان، وعلى نظافة وإضاءة كافية، والوقاية من الضوضاء، وكذا توفير أماكن لعب للأطفال.
- الاحتياجات النفسية: من خلال توفير جو من الخصوصية الأسرية، والمناظر الجمالية للسكن وللحي.
- الوقاية من الأمراض: عبر توفير قنوات مياه صحية، والحماية من تلوث المحيط ومن الحشرات.
- الوقاية من الحوادث: وذلك من خلال اتخاذ تدابير احتياطية حتى لا يتعرض شاغلي السكن للحوادث كالحرائق والتسمم بالغاز والسقوط ...

تأثير السكن غير اللائق على الصحة العامة:

ترتبط فرص الأفراد في التمتع بصحة جيدة ارتباطاً وثيقاً بالظروف التي ينشؤون فيها ويتعلمون ويعيشون ويعملون فيها، فإذا كانت مجموعة من الأفراد تعيش في مساكن غير لائقة لا تتوفر فيها أدنى معايير السكن اللائق، بالتبعية سيكون لديها أقل فرص للوصول إلى التعليم أو العمل، والخدمات الأساسية الأخرى، وكذا فرص محدودة أو منعدمة لأدنى شروط للرعاية الصحية.

يعتبر الاعتراف بعلاقة السكن بصحة الأفراد موضوعاً مهماً لم يتم التسليم به حديثاً، بدليل أنه قد تم معالجته إلى جانب عوامل أخرى مؤثرة على الصحة العمومية خلال المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الصحة العامة سنة 1986 في أوتوا، إضافةً إلى معالجته ضمن إعلان ريو السياسي سنة 2011 بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، وهو ما يعكس الاعتراف والالتزام العالمي بالحد من تأثير آثار العيش في سكنات غير لائقة على صحة شاغليها.

كما نشرت منظمة الصحة العالمية سنة 2018 بعض المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسكن والصحة، تضمنت بعض العواقب الصحية التي يمكن أن تحدث نتيجةً لظروف السكن السيئة كالانزلاقات، السقوط، الصدمات النفسية، الإجهاد، العزلة، مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مخاطر القلب والأوعية الدموية والتعرض للأمراض المعدية، وهي كلها عواقب ونتائج مرتبطة بشكل مباشر بظروف السكن غير اللائقة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل خاص على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة. وهو ما يعني أن جودة السكن ومدى ملاءمتها مع المستوى المعيشي المناسب تؤثر لا محالة وبشكل مباشر على الصحة العامة.

التخلص من الفضلات والنفايات والقمامة:

لقد كان للثورة الصناعية المتفجرة وهذا التقدم التكنولوجي المتسارع الذي نعيشه اليوم أكبر الأثر نحو زيادة حجم التلوث البيئي على مستوى العالم أجمع، وخلق الكثير من المشاكل التي قد تصل إلي حد الكوارث البيئية، فبصورة عامة تصنف الملوثات البيئية إلى ثلاث مجموعات، فهناك الملوثات الصلبة، والملوثات السائلة، والملوثات الغازية، وتحت هذا التصنيف تندرج المخلفات ذات الطبيعة المختلفة عن النفايات التي تندرج أيضا تحت هذا التصنيف، إذا هناك ما يطلق عليه المخلفات التي تأخذ الشكل الصلب أو السائل أو الغازي وهناك أيضا ما يطلق عليه النفايات التي تأخذ نفس الاشكال .

المخلفات:

يمكن تعريفها بأنها كل ما يتخلف عن المادة الأصل التي تم استهلاكها، وهذه المخلفات يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها للحصول على منتجات مماثلة للأصل أو منتجات جديدة، ولكن ذات جودة منخفضة، وبصورة عامة تنقسم المخلفات إلى قسمين رئيسيين هما المخلفات الصلبة والمخلفات الغير صلبة ويتم تحت هذين البندين إدراج أنواع المخلفات المختلفة:

- المخلفات الرطبة: يندرج تحتها كافة المخلفات العضوية وهي تشكل ما نسبته تقريبا من 50% الى 60% من مجمل مخلفات المدن مثل بقايا الأطعمة والمشروبات وبقايا الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان وبقايا الأغذية المتبقية من استهلاك المنازل والمطاعم والفنادق والمعسكرات، وغيرها من بقايا معامل المصنوعات الغذائية وبقايا الأفران من المخبوزات، ومخلفات الحقول والمزارع، مما يعد كمادة أولية لتصنيع السماد العضوي الذي يطلق عليه اسم "الكومبوست" الضروري للتربة الزراعية وخصوصا المستصلحة منها حديثا.
- المخلفات السائلة: هي كافة المواد الناتجة عن الاستهلاك أو عمليات الإنتاج المختلفة التي تجمعها خاصية السيولة أو شبه السيولة (المخلوطة) مثل الزيوت المستهلكة للمحركات وسوائل تبريد المحركات والمخلفات الكيماوية للمصانع و المعامل وهي تعتبر مخلفات شديدة السمية وتأثيرها بالغ الضرر على البيئة وخصوصا حين تسربها إلى المياه الجوفية واختلاطها.
- المخلفات الجافة: وهي تتضمن كافة المخلفات الصلبة المتنوعة حيث تشكل ما نسبته تقريبا من 30% الى 40% من مجمل مخلفات المدن مثل القوارير الزجاجية أو المعدنية أو البلاستيكية والمخلفات البلاستيكية المختلفة والورق بمختلف أنواعه والقطع و الأجزاء المعدنية المختلفة عن ورش أو مصانع السيارات او المعدات والأجهزة الأخرى وإطارات السيارات المستعملة وبقايا الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الصناعية وأيضا الأجهزة الالكترونية ومخلفات الطباعة والأحبار وقطع الأخشاب وبقايا الألواح الخشبية والقش والحطب والمخلفات المعدنية وبقايا المنسوجات والأقمشة.... الخ.
- المخلفات ذات الطبيعة الخاصة:

A. مخلفات المستشفيات والمراكز العلاجية والمعامل الطبية: هي تلك المخلفات التي تنتج من المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات وشركات إنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات ومراكز العلاج البيطري والمؤسسات البحثية وتلك التي تنتج من العلاج والتمريض في المنازل، وهي تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

1. مخلفات خطيرة.
2. مخلفات غير خطيرة.

بالحديث عن المخلفات الخطرة، فهي تلك المخلفات التي تنتج من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيماوية أو المشعة، وهي تشكل النسبة الأقل من إجمالي مخلفات الرعاية الصحية، إذ أنها تشكل خطرا على الافراد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها، وقد تم تصنيف هذه المخلفات الخطرة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية إلى:

- مخلفات الأجزاء وبقايا الأعضاء البشرية والحيوانية.
- المخلفات المعدية.
- المخلفات الكيماوية.
- المخلفات ذات الطبيعة الحادة.
- المخلفات الصيدلانية.
- المخلفات الملوثة بالمواد المشعة.
- مخلفات عبوات الغازات المضغوطة.
- مخلفات المواد السامة للجينات والخلايا.

أما المخلفات الغير خطيرة، هي جميع المخلفات التي تنتج من الأقسام الإدارية في المستشفيات، والمراكز العلاجية، ومراكز تقديم الرعاية الصحية، وتشمل أعمال النظافة العامة للمكاتب والإدارات المختلفة بعيدا عن العيادات وغرف الكشف على الامراض، وتلك المخلفات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي مخلفات الرعاية الصحية، و تعامل هذه النوعية من المخلفات معاملة مخلفات المكاتب والشركات والمنازل.

B. المخلفات الالكترونية - الأجهزة والادوات: تشمل كافة الأجهزة والمعدات والأدوات التي تكون الالكترونيات هي المشغل الرئيس لها، أو التي تعاني خلا، أو كسرا، أو التي لم تعد متوافقة مع التكنولوجيات الحديثة، أو تلك التي تم اتلافها، وهذه المخلفات تضم مجموعة كبيرة من المنتجات الكهربائية والالكترونية مما نستخدمه في المنازل والمكاتب والشركات والطرق... الخ، ومصدر خطورة هذه المخلفات أو النفايات هو احتوائها على مواد مشعة، وأخرى شديدة السمية؛ كالرصاص، والباريوم، والكاديوم، والزنك، والكروم ... الخ .

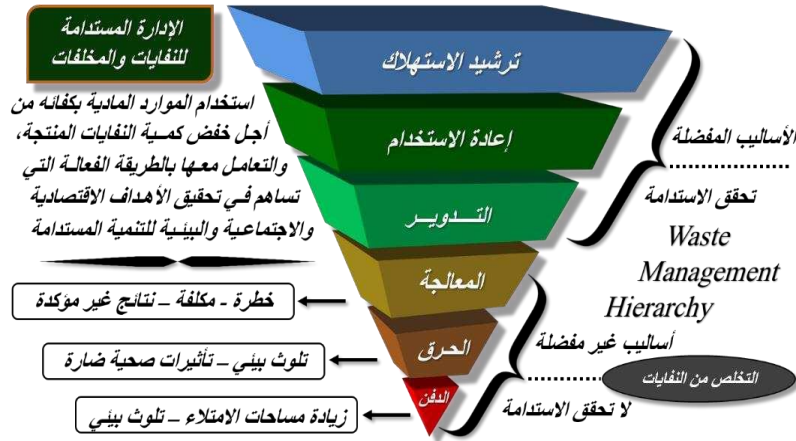
النفايات:

هي تلك المخلفات والبقايا التي تنتج من تحلل المواد العضوية أو الكيماوية أو بقايا المخلفات الصناعية الناتجة عن عمليات الغسيل أو التطهير للمواد الغذائية نتيجة معاملتها كيميائيا، أو بالطريقة الجافة للتخلص من الفضلات أو نتيجة حرقها داخل أفران خاصة مبنية بالطوب الحراري عند درجة انصهار عالية، أو تلك المواد التي تحتوي على مواد مشعة نتيجة تعرضها للإشعاعات النووية أو المفاعلات الذرية.

الإدارة المستدامة للمخلفات والنفايات:

كما ذكرنا في السابق، فإن عدد السكان في جميع أنحاء العالم آخذ في الزيادة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخلفات والنفايات، والذي يؤثر بالطبع على الصحة العامة والبيئة، مما قد يشكل مشاكل حرجية تحتاج إلى حلول سريعة ومكلفة، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تصبح هذه المخلفات والنفايات مصدرا مهما لكسب المال وقيمة اقتصادية مضافة للدولة، أو على الأقل تصبح عاملا مساعدا لتقليل التكلفة العالية للمعالجة بواسطة نظام متكامل لإدارة المخلفات والنفايات.

الهدف الاسمى لهذا النظام المتكامل المشار اليه هو العمل على بذل كل الجهود نحو الحد من تولد الكثير من المخلفات والنفايات من خلال تبني آليات معينة والعمل على تطويرها دائما، مثل إعادة الاستخدام أو التدوير، وحينما نتحدث عن الحد من تولد المخلفات والنفايات، فنحن نعني الحد من المصدر، أي ما يمكننا أن نطلق عليه منع المخلفات أو النفايات، يعني استهلاك أقل يؤدي إلى مخلفات ونفايات أقل، وهذا الامر يجب أن يبدأ من خلال طلب مواد أقل وإنتاج كميات أقل من المخلفات والنفايات أثناء عمليات التصنيع، وهذا يمكن أن يأتي من خلال استخدام منتجات طويلة الأمد كالمسحوق المتينة التي تدوم لفترة طويلة، وتطوير منتجات التعبئة الخالية من المواد السامة.



الوقاية من الأمراض

الوقاية من الأمراض الإنتانية:

في السنوات الأخيرة، أثارت فاشيات إنفلونزا الطيور، وفيرس إيبولا، وفيرس زيكا، والكوليرا قلقًا متزايدًا بشأن الأمن الصحي العالمي. فهي لا تُشكل عبئًا على اقتصاد ومجتمع جميع البلدان فحسب، بل تُشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، مما يؤثر على التنمية الاقتصادية العالمية والاستقرار الاجتماعي. في الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي عُقدت مؤخرًا، دعا قادة العالم إلى الوحدة والتعاون في مكافحة جائحة كوفيد-19، مؤكدين على أهمية التشارك العالمي في اللقاحات والأساليب الطبية. من الواضح أن حماية الأمن الصحي العالمي أصبحت القضية الأهم في الحوكمة العالمية، وضمانة مهمة للدول لتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الكوليرا:

مرض معدي معوي حاد، تسببه بكتيريا ضمة الكوليرا O1 وO139. ينتقل المرض بشكل رئيسي عن طريق المياه والأغذية الملوثة بضمة الكوليرا. يُعدّ سم الكوليرا الذي تنتجه ضمة الكوليرا العامل الممرض الرئيسي. تتراوح فترة حضانة الكوليرا عادةً بين عدة ساعات وحوالي 5 أيام. الأعراض السريرية الرئيسية هي الإسهال الشديد والبراز المائي. أما الحالات الشديدة فتعاني من مضاعفات الجفاف الشديد واضطرابات الإلكتروليت.

المبادئ العامة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها:

تتمثل المبادئ العامة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها في توفير مياه شرب آمنة، وتحسين مرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية، وتوفير العلاج في الوقت المناسب، وإجراء التنقيف الصحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوسيع نطاق التطعيم ضد الكوليرا.

يُعد لقاح الكوليرا إجراءً فعالاً للوقاية والسيطرة على تفشي الكوليرا ووباءها. توصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون لقاح الكوليرا الخيار الأمثل في المناطق المعرضة لخطر كبير من توطن الكوليرا، وكذلك في الأزمات الإنسانية المعرضة لخطر كبير من الإصابة بالكوليرا. يجب أن يقترن استخدام اللقاح بتدابير أخرى للوقاية من الكوليرا ومكافحتها، ويجب ألا يعيق اعتماد التدخلات الصحية الأخرى.

شلل الأطفال:

مرض معوي شديد العدوى يسببه فيروس شلل الأطفال. ينتقل فيروس شلل الأطفال من شخص لآخر، وينتشر بشكل رئيسي عن طريق البراز والفم، أو في حالات أقل شيوعًا، عن طريق المياه أو الأغذية الملوثة. يُعد البشر المستودع الوحيد المعروف لفيروس شلل الأطفال، والذي ينتقل في أغلب الأحيان عن طريق الأشخاص المصابين بعدوى غير ظاهرة.

تشمل الأعراض الأولية لشلل الأطفال الحمى والتعب والصداع والقيء وتيبس الرقبة وألم الأطراف. في نسبة ضئيلة من الحالات (حالة واحدة من كل 200 إصابة)، يُسبب فيروس شلل الأطفال الشلل، والذي غالبًا ما يكون دائمًا. يمكن الوقاية منه من خلال اللقاحات التي تُعطى عدة مرات.

مبادئ الوقاية والسيطرة على شلل الأطفال:

يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) بلقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي (bOPV) ولقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) وفقاً لبرنامج التحصين أو تعليمات التطعيم. في حال الرغبة في السفر إلى بلدان موبوءة بشلل الأطفال أو العمل فيها، يُنصح بجرعة واحدة من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي (bOPV) أو لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV).

اتباع النصائح لتجنب التعرض للأطعمة أو المشروبات التي قد تكون ملوثة ببراز شخص مصاب بشلل الأطفال:

- 1- تناول الطعام المطبوخ والساخن، والطعام من عبوات مغلقة، والبيض المسلوق جيداً، والفواكه والخضراوات المغسولة بماء نظيف أو مقشرة، ومنتجات الألبان المبسترة.
- 2- تجنب تناول الأطباق الباردة، والطعام الذي يقدمه الباعة الجائلين، والبيض النيء أو المطبوخ قليلاً، واللحوم أو الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، والخضراوات والفواكه النيئة غير المقشرة أو غير المغسولة، والتوابل المصنوعة من مكونات طازجة.
- 3- اشرب فقط المياه المعبأة والمختومة، والمشروبات الرياضية، أو المشروبات الغازية، والمياه المعقمة (المغلية، والمفلترة).

الحصبة:

مرض تنفسي حاد، شديد العدوى، وموسمي، يسببه فيروس الحصبة. المضيف الطبيعي الوحيد هو الإنسان الذي يمكنه نقل فيروس الحصبة. ينتقل الفيروس من شخص لآخر بشكل رئيسي عن طريق الهواء. تظهر أعراض الحصبة بعد 7-14 يوماً من التعرض، وتشمل عادةً حمى مبكرة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، والتهاب الملتحمة، وزكام، وسعال، وبقع صغيرة ذات مراكز بيضاء أو بيضاء مائلة للزرقة على قاعدة حمراء على الغشاء المخاطي للفم (بقع كوبليك). يظهر طفح جلدي أحمر مميز (بقع حطاطية) في اليوم الثالث إلى السابع بعد ظهور الأعراض المبكرة.

مبادئ الوقاية والسيطرة على الحصبة:

تتمثل الاستراتيجية الأساسية للسيطرة على الحصبة والقضاء عليها في تحقيق تغطية عالية المستوى بلقاح الحصبة بجرعتين والحفاظ عليها. يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) بلقاحات الحصبة. يُنصح بجرعة واحدة من لقاح الحصبة للمسافرين والعمال، غير المصابين أو الملقحين، في البلدان التي ينتشر فيها وباء الحصبة. حافظ على النظافة والصرف الصحي. اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون. إذا لم يتوفر ذلك، فنظف يديك بمعقم لليدين (يحتوي على 60% كحول على الأقل). تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك. إذا كنت بحاجة إلى لمس وجهك، فنظف يديك. غط فمك وأنفك بمنديل ورقي أو بكمك عند السعال أو العطس. حافظ على تهوية داخلية جيدة.

مرض المكورات السحائية:

يُشير مرض المكورات السحائية إلى أي مرض تُسببه بكتيريا تُسمى النيسيرية السحائية، والمعروفة أيضًا باسم المكورات السحائية. غالبًا ما تكون هذه الأمراض شديدة أو مميتة. وتشمل التهابات بطانة الدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا) والتهابات مجرى الدم (تجرثم الدم أو تسمم الدم). تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا بالمكورات السحائية الحمى والصداع وتيبس الرقبة. كما تُعتبر الغثيان والقيء ورهاب الضوء والارتباك من الأعراض الشائعة. قد يكون الأطفال حديثو الولادة والرضع بطيئين أو خاملين، أو سريعى الانفعال، أو يتقيؤون، أو لا يتغذون جيدًا، أو لديهم انتفاخ في المنطقة الرخوة من الجمجمة. قد تشمل أعراض تسمم الدم السحائي بالمكورات السحائية الحمى والقشعريرة، والتعب، والتقيؤ، وبرودة اليدين والقدمين، وآلامًا شديدة في العضلات والمفاصل والصدر أو البطن، وسرعة التنفس، والإسهال، وما إلى ذلك. تُصيب النيسيرية السحائية البشر فقط؛ ولا يوجد مستودع حيواني لها.

مبادئ الوقاية والسيطرة على التهاب السحايا:

يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) وفقًا لجدول برامج التحصين أو تعليمات التطعيم. الحفاظ على معايير النظافة والصرف الصحي. اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. إذا لم يتوفر ذلك، فنظف يديك بمعقم لليدين (يحتوي على 60% كحول على الأقل). لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك. غط فمك وأنفك بمنديل ورقي أو بكحك عند السعال أو العطس. حافظ على تهوية داخلية جيدة. مارس التمارين الرياضية والأنشطة الخارجية بانتظام ومناسبة. اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا. احصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم. أبعد الأطفال عن مرضى المكورات السحائية. ارتد الكمامات في الأماكن المزدحمة خلال موسم الأوبئة. في حال ظهور حمى وصداع وقيء، يُرجى زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن. التطعيم بلقاحات المكورات السحائية.

التهاب الدماغ الياباني:

يُعد فيروس التهاب الدماغ الياباني (JE) السبب الرئيسي لالتهاب الدماغ الذي يمكن الوقاية منه بلقاحات في آسيا وغرب المحيط الهادئ. ينتقل فيروس التهاب الدماغ الياباني عبر دورة انتقالية بين البعوض والخنازير و/أو الطيور المائية. يمكن أن يُصاب به البشر الذين يلدغهم بعوض مصاب، مثل بعوض الكيولكس، وبعوض الزاعجة، وبعوضة الأنوفيلة. ينتشر التهاب الدماغ الياباني بشكل رئيسي في المناطق الريفية وشبه الحضرية. معظم حالات عدوى فيروس التهاب الدماغ الياباني خفيفة (حمى وصداع) أو غير ظاهرة، ولكن حوالي 0.5% من حالات العدوى تؤدي إلى مرض شديد مع ظهور سريع للحمى الشديدة، والصداع، وتيبس الرقبة، والارتباك، والغيبوبة، والنوبات، والشلل التشنجي، والوفاة.

مبادئ الوقاية والسيطرة على التهاب الدماغ الياباني:

يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) بلقاح التهاب الدماغ الياباني الحي المُضعَّف أو المُعطَّل. تجنب لدغات البعوض. غطّ الجلد المكشوف بارتداء قمصان بأكمام طويلة وسراويل طويلة وقبعات. استخدم طاردًا مناسبًا للحشرات وفقًا للتعليمات. يمكن توفير حماية أطول باستخدام نسب أعلى من المكونات الفعالة. استخدم ملابس ومعدات معالجة بالبيريثيرين (مثل الأحذية والسراويل والجوارب والخيام). ابقَ ونم في غرف مُغطاة بشبك أو مُكيّفة. استخدم ناموسية إذا كانت منطقة نومك مُعرّضة للهواء الطلق.

الخنق (الدفتيريا):

الدفتيريا عدوى تنفسية حادة تُسببها بكتيريا الوتدية الخناقية، وهي تشكل خطرًا داهمًا على حياة الإنسان عبر التاريخ، وتُصيب بشكل رئيسي الحلق والمجاري الهوائية العلوية، وتنتج سمًا يؤثر على أعضاء أخرى. يُعد البشر مستودعًا لانتقال العدوى. معظم حاملي العدوى البالغين لا تظهر عليهم أعراض. ينتقل المرض من شخص لآخر عبر الرذاذ التنفسي، والتلامس الجسدي الوثيق، وعن طريق الأدوات الملوثة. نادرًا ما ينتقل الخناق الجلدي عن طريق ملامسة آفات الجلد. يشمل الخناق التنفسي التهاب البلعوم والوزتين.

مبادئ الوقاية والسيطرة على الخناق:

يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) بلقاحات الدفتيريا، وفقًا لجدول برنامج التحصين ومواصفات اللقاحات في بلدان الإقامة. الحفاظ على معايير النظافة والصرف الصحي. اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. إذا لم يتوفر ذلك، فتنظف يديك بمعقم لليدين (تحتوي على 60% كحول على الأقل). تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك. غط فمك وأنفك بمنديل ورقي أو بكحك عند السعال أو العطس. حافظ على تهوية داخلية جيدة.

التهاب الكبد الوبائي أ:

هو مرض معدٍ يصيب الكبد، ويمكن الوقاية منه باللقاح، ويسببه فيروس التهاب الكبد الوبائي أ. عادةً ما تظهر أعراضه فجأة، وتشمل الحمى، والتعب، وفقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، والبول الداكن، والإسهال، وبرازًا بلون الطين، وآلام المفاصل، واليرقان (اصفرار الصلبة والجلد والبول). لا تظهر أعراض على معظم المرضى أو يعانون من عدوى غير معروفة. ينتقل التهاب الكبد الوبائي أ بشكل أساسي عن طريق البراز والفم، أي عن طريق تناول الطعام والماء الملوثين، أو عن طريق الاتصال المباشر بشخص مصاب. المصدر الرئيسي للعدوى هو مرضى التهاب الكبد الوبائي أ والعدوى المتنتحية. البشر أكثر عرضة للإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ. يتعافى كل شخص تقريبًا تمامًا من التهاب الكبد الوبائي أ ويكتسب مناعة مدى الحياة. يرتبط خطر تفشي التهاب الكبد الوبائي أ بسوء الصرف الصحي والنظافة العامة وانخفاض المستوى الاقتصادي.

مبادئ الوقاية والسيطرة على التهاب الكبد أ:

يجب تطعيم الأطفال (المسافرين) وفقًا لجدول برامج التحصين وتعليمات لقاح التهاب الكبد الوبائي أ. الحفاظ على النظافة الشخصية والصرف الصحي الجيد. اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون. إذا لم يتوفر، فتنظفهما بمعقم لليدين (يحتوي على 60% كحول على الأقل). تجنب التلامس الوثيق، مثل مشاركة أدوات الطعام أو الأكواب مع المرضى. سلامة الغذاء. تناول طعامًا آمنًا واشرب مياهًا نظيفة عند السفر في المناطق النائية. يجب غلي الطعام (وخاصةً المحار) لأكثر من 90 ثانية أو تسخينه إلى 85 درجة مئوية لمدة 4 دقائق قبل تناوله. يجب تطهير الملوّثات بمحلول مبيض منزلي بتركيز 1:100. تجنب ملامسة الأطعمة غير المطبوخة أثناء التواجد في المنطقة الموبوءة.

الوقاية من الأمراض الغير إنتانية:

على الرغم من كل هذا الاهتمام، لا يعرف معظم الناس، وكثير من صانعي السياسات، وحتى بعض المتخصصين في مجال الصحة، ما يعنيه مصطلح "الأمراض غير المعدية" وما يشمله. ظهر هذا الوصف في البداية للإشارة إلى الأمراض التي كانت تُعتبر غير معدية من حيث المنشأ والانتشار، في وقت كانت فيه الصحة العالمية معنية بشكل رئيسي بالأمراض المعدية. ولغرض اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، اقترحت منظمة الصحة العالمية (WHO) حصر المصطلح في أربع مجموعات رئيسية من الأمراض: أمراض القلب والأوعية الدموية (التي تشمل السكتة الدماغية)، وداء السكري، والسرطانات، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة (مثل الربو، وانتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية المزمن).

ترتبط هذه المجموعات الأربع من الاضطرابات، على الرغم من اختلافها الكبير في ملفها السريري، بأربعة عوامل خطر مشتركة: التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، والكحول. يجد الكثيرون مصطلح "الأمراض غير المعدية" غير مُرضٍ لعدة أسباب:

- 1- ترتبط بعض أنواع السرطان (مثل سرطان عنق الرحم والكبد والمعدة) وبعض أشكال أمراض القلب (مثل أمراض القلب الروماتيزمية) بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية.
- 2- في الفهم الاجتماعي والوبائي لأسباب الأمراض، تُسَوَّق العوامل المسببة للأمراض، مثل التبغ والكحول والأطعمة غير الصحية، بشكل مكثف في جميع البلدان، ويمكن اعتبارها "معدية". كما أن السلوكيات معرضة للتغيير تحت تأثير الرسائل الثقافية والتجارية التي تُنقل إلى الناس.
- 3- أين تقع الأمراض العقلية، واضطرابات الرؤية والسمع، وأمراض الهيموغلوبين مثل الثلاسيميا، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي وأمراض النساء، وبعض أمراض الكلى، إذا اقتصر المصطلح على أربع مجموعات من الأمراض؟.

من المصطلحات الأخرى التي استُخدمت لوصف الأمراض غير المعدية "الأمراض المزمنة" و "الأمراض المرتبطة بنمط الحياة". وهذه المصطلحات أيضاً غير مُرضية. لا يوجد ما يُسمى "مزمناً" في الصورة السريرية لاحتشاء عضلة القلب الحاد (النوبة القلبية)، أو السكتة الدماغية (النوبة الدماغية)، أو الموت القلبي المفاجئ، حتى لو كان المرض الكامن قد تطور بشكل خفي.

عوامل الخطر ومحدداته

من بين عوامل الخطر العديدة المرتبطة بالأمراض غير المعدية، يمكن تحديد ثلاث فئات: بيولوجية، وسلوكية، واجتماعية اقتصادية. من بين هذه العوامل، تحتل عوامل الخطر السلوكية الأربعة التي حددتها منظمة الصحة العالمية (النظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، واستهلاك التبغ، والتعاطي الضار للكحول) موقعاً مركزياً.

تتأثر هذه العوامل من أعلى بعوامل اجتماعية واقتصادية مثل التعليم والدخل التي تؤثر على المستوى الفردي، وعوامل مجتمعية مثل سياسات التجارة، وتصميم المدن والنقل، ووسائل الإعلام والتأثيرات الثقافية التي تؤثر على مستوى السكان. بدورها، تؤثر السلوكيات بشكل كبير على عوامل الخطر البيولوجية مثل ضغط الدم، ووزن الجسم، وشكل الجسم (السمنة المركزية)، ودهون الدم، وسكر الدم، والتي تُعد العوامل الوسيطة التالية للإصابة.

في حين أن عوامل الخطر السلوكية الأربعة هي بالفعل العوامل الرئيسية المسببة للأمراض غير المعدية، حيث تُشكل حلقة الوصل الحاسمة بين المحددات الاجتماعية والأسباب البيولوجية، إلا أن هناك عوامل

خطر أخرى تُسهم في الإصابة بالأمراض غير المعدية. تتنوع هذه العوامل من الفيروسات المسببة للسرطان، إلى تلوث الهواء الداخلي والخارجي المسبب لأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويلعب التاريخ العائلي دورًا أيضًا، ولكن يجب أن ينصب تركيز استراتيجية الصحة العامة على عوامل الخطر القابلة للتعديل. لم يُحدد دور العوامل الوراثية بشكل كافٍ للتنبؤ بالمخاطر في العديد من الأمراض غير المعدية.

تكشف الاتجاهات العالمية أنه في حين أن استهلاك التبغ أخذ في الانخفاض في البلدان مرتفعة الدخل، فإنه يرتفع في البلدان منخفضة الدخل. وبالمثل، انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى السكان أو استقر في البلدان مرتفعة الدخل، ولكنه ارتفع ليصبح الآن الأعلى في البلدان منخفضة الدخل. ويستمر ارتفاع معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة في جميع مناطق العالم. ويتفاقم داء السكري أيضًا كوباء عالمي، حيث تُهيمن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من المصابين بداء السكري.

في المراحل المبكرة من أوبئة الأمراض غير المعدية، غالبًا ما ترتبط السلوكيات الضارة بارتفاع الدخل المتاح للأثرياء، مما يضعهم في فئة المعرضين للخطر. ومع ذلك، مع تفاقم الأوبئة، تُنتج عوامل الخطر بكميات كبيرة للاستهلاك الجماعي، ويُمدد انتشار التبغ والكحول والأطعمة المصنعة ووسائل توفير العمالة وأنظمة النقل الآلية الطريق لانتشار الأوبئة الجماعية. في مرحلة لاحقة، تستفيد الشرائح الثرية والمتعلمة من زيادة وصولها إلى المعلومات والخدمات الصحية والأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية في أوقات الفراغ لتجنب أو تقليل خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية. من ناحية أخرى، تفتقر الشرائح الفقيرة والأقل تعليمًا إلى المعرفة الكافية بالأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها، ولا تستطيع تحمل تكاليف الشراء والاستهلاك المنتظم للفواكه والخضراوات والزيوت الصحية والألياف، والتي غالبًا ما تكون أكثر تكلفة من الأطعمة المصنعة غير الصحية، وعادةً ما تعيش حياة أكثر إرهاقًا.

خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية:

حدد اجتماع الأمم المتحدة عام 2011 هدفًا يتمثل في خفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة 25%، بين سن 30 و70 عامًا، على أن يتم تحقيقه عالميًا بحلول عام 2030. وفي مايو 2013، وافقت جمعية الصحة العالمية على خطة عمل عالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، إلى جانب مجموعة من الأهداف والمؤشرات الطوعية المرتبطة بالإجراءات التي ستمكن من تحقيق هذا الهدف. وتسرد هذه الخطة تسعة أهداف طوعية مرتبطة بـ 25 مؤشرًا. ولتحقيق هذه الأهداف، توصي منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التالية:

- تعاطي التبغ:

- 1- تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC).
- 2- تقليل تكلفة منتجات التبغ من خلال زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.
- 3- إنشاء بيئات خالية تمامًا من التدخين، بموجب القانون، في جميع أماكن العمل الداخلية والأماكن العامة ووسائل النقل العام.
- 4- تحذير الناس من مخاطر التبغ من خلال تحذيرات صحية فعّالة وحملات إعلامية جماهيرية.
- 5- حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.

- الاستخدام الضار للكحول:

- 1- زيادة الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.

- 2- فرض قيود وحظر شامل على الإعلان عن الكحول والترويج له.
- 3- فرض قيود على توافر الكحول المباع بالتجزئة.
- 4- تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للحد من الاستخدام الضار للكحول.

- النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني:

- 1- تقليل الملح من خلال حملات إعلامية/تقليل محتوى الملح في الأطعمة المصنعة.
- 2- استبدال الدهون المتحولة بالدهون المتعددة غير المشبعة.
- 3- برنامج توعية عامة حول النظام الغذائي والنشاط البدني.

- النظام الصحي:

- 1- دمج تدخلات فعالة من حيث التكلفة لمكافحة الأمراض غير المعدية ضمن حزمة الرعاية الصحية الأولية الأساسية للنهوض بأجندة التغطية الصحية الشاملة.
- 2- استكشاف آليات تمويل صحي فعالة وأساليب تمويل مبتكرة، مثل فرض الضرائب على التبغ والكحول، لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق التغطية الصحية.
- 3- تحسين توافر التقنيات الأساسية بأسعار معقولة والأدوية الأساسية.
- 4- توسيع نطاق الكشف المبكر والتغطية، بدءًا بتدخلات فعالة من حيث التكلفة وعالية التأثير.
- 5- تعزيز وإعادة توجيه النظم الصحية لمعالجة الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر من خلال الرعاية الصحية الأولية التي تركز على الإنسان والتغطية الصحية الشاملة.

- أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري:

- 1- العلاج متعدد الأدوية (بما في ذلك ضبط نسبة السكر في الدم لمرض السكري والتحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال نهج شامل لإدارة المخاطر) خلال السنوات العشر القادمة.
- 2- حمض أسيتيل الساليسيليك لعلاج احتشاء عضلة القلب الحاد.
- 3- علاج قصور القلب الاحتقاني باستخدام مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات بيتا، ومدرات البول.
- 4- إعادة تأهيل القلب بعد احتشاء عضلة القلب.
- 5- الوقاية الثانوية من الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية.
- 6- مضادات التخثر لعلاج الرجفان الأذيني غير الصمامي متوسط وعالي الخطورة، ولعلاج تضيق الصمام التاجي والرجفان الأذيني.
- 7- حمض أسيتيل الساليسيليك بجرعة منخفضة لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية.
- 8- تدخلات للعناية بالقدم؛ برامج تثقيفية، وتوفير أحذية مناسبة؛ وعيادات متعددة التخصصات.

- داء السكري:

- 1- تدخلات نمط الحياة للوقاية من داء السكري من النوع الثاني.
- 2- رعاية ما قبل الحمل للنساء في سن الإنجاب (تشمل تثقيف المريضات وإدارة الجلوكوز المكثفة لسكري الحمل).

- 3- الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري عن طريق فحص العين المتوسع بانتظام، يليه علاج مناسب بالتخثير الضوئي بالليزر للوقاية من العمى.
- 4- إينالابريل للوقاية من تطور أمراض الكلى.

- السرطان:

- 1- الوقاية من سرطان الكبد من خلال التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي ب.
- 2- الوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال الفحص (الفحص البصري بحمض الأسيتيك) المرتبط بالعلاج في الوقت المناسب للآفات ما قبل السرطانية.
- 3- التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، حسب الاقتضاء، إذا كان فعالاً من حيث التكلفة ومعقول التكلفة، وفقاً للبرامج والسياسات الوطنية.
- 4- فحص سرطان عنق الرحم على مستوى السكان مرتبط بالعلاج في الوقت المناسب.
- 5- فحص سرطان الثدي بالأشعة السينية على مستوى السكان (50-70 عامًا) مرتبط بالعلاج في الوقت المناسب.
- 6- فحص سرطان القولون والمستقيم على مستوى السكان لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، مع مراعاة العلاج في الوقت المناسب.
- 7- فحص سرطان الفم لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر (مثل متعاطي التبغ) مع مراعاة العلاج في الوقت المناسب.
- 8- الرعاية التلطيفية؛ باستخدام وسائل علاجية فعالة من حيث التكلفة، بما في ذلك المسكنات الأفيونية لتخفيف الألم.

- أمراض الجهاز التنفسي المزمنة:

- 1- توفير مواقع مُحسّنة ووقود أنظف للحد من تلوث الهواء الداخلي.
- 2- تدخلات فعالة من حيث التكلفة للوقاية من أمراض الرئة المهنية، مثل التعرض للسيليكا والأسبستوس.
- 3- علاج الربو بناءً على إرشادات منظمة الصحة العالمية.
- 4- تطعيم إن يوينزا للمرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

- البحث والمراقبة:

- 1- وضع وتنفيذ أجندة بحثية وطنية ذات أولوية للأمراض غير المعدية.
- 2- تعزيز القدرات البحثية من خلال التعاون مع معاهد البحوث.
- 3- تنفيذ خيارات سياساتية أخرى لتعزيز ودعم القدرات الوطنية لإجراء بحوث وتطوير عالية الجودة.
- 4- وضع أهداف ومؤشرات وطنية بناءً على إطار الرصد العالمي.
- 5- إنشاء/تعزيز نظام شامل لمراقبة الأمراض غير المعدية، بما في ذلك التسجيل الموثوق للوفيات حسب السبب، وتسجيل حالات السرطان، وجمع البيانات الدورية حول عوامل الخطر، ومراقبة الاستجابة الوطنية.
- 6- دمج مراقبة/رصد الأمراض غير المعدية في نظم المعلومات الصحية الوطنية.

الرعاية الصحية الأولية

مفهوم الرعاية الصحية الأولية:

تقسم الرعاية الصحية إلى ثلاثة مستويات:

- الرعاية الصحية الأولية: تعد المستوى الأول من الاتصال بين الفرد والنظام الصحي، ويمكن التعامل مع غالبية الشكاوى والمشاكل الصحية السائدة بشكل مرض.
- الرعاية الصحية الثانوية: الخدمات العلاجية بشكل أساسي، وهو مستوى الإحالة الأول.
- الرعاية الصحية الثالثة: رعاية فائقة الاختصاص، مهارات التخطيط والإدارة، التدريس للموظفين المتخصصين.

قدمت منظمة الصحة العالمية واليونسف مصطلح "الرعاية الصحية الأولية" (PHC) وأصدرتا إعلاناً بأن هذا هو النهج الذي يجب أن تتبناه دول العالم من أجل الوصول إلى الهدف المعلن لتحقيق "الصحة للجميع بحلول عام 2000". حيث يجب أن تكون الرعاية الصحية الأولية شاملة حقاً. كان يجب أن يتألف من الرعاية الصحية الأساسية التي يتم توفيرها عالمياً للأفراد والعائلات بوسائل مقبولة لهم، وبمشاركتهم الكاملة، وبتكلفة يمكنهم تحملها هم ومجتمعهم والبلد ككل.

يمكن القول إن الصحة مفهوم معقد وشامل يشمل الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية، وليس فقط غياب المرض أو الإصابة. هناك العديد من الطرق لقياس الصحة والرفاهية، وأكثرها شيوعاً هو متوسط العمر المتوقع ومعدلات الوفيات والمرض.

الرعاية الصحية الأولية هي نهج يشمل المجتمع بأسره لتنظيم وتقوية النظم الصحية الوطنية بشكل فعال لجعل خدمات الصحة والرفاهية أقرب إلى المجتمعات. وتتكون من 3 مكونات:

- خدمات صحية متكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للأفراد طوال حياتهم.
- معالجة المحددات الأوسع للصحة من خلال سياسة وإجراءات متعددة القطاعات تمكّن الأفراد والأسر والمجتمعات من تولي مسؤولية صحتهم.
- تمكّن الرعاية الصحية الأولية الأنظمة الصحية من دعم الاحتياجات الصحية للفرد - من تعزيز الصحة إلى الوقاية من الأمراض والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية وغير ذلك.

تضمن هذه الاستراتيجية أيضاً تقديم الرعاية الصحية بطريقة تتمحور حول احتياجات الأشخاص وتحترم تفضيلاتهم. تعرف منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأولية "هي رعاية صحية أساسية تستند إلى أساليب وتقنيات عملية وسليمة علمياً ومقبولة اجتماعياً، ومتاحة عالمياً للأفراد والأسر في المجتمع من خلال مشاركتهم الكاملة وبتكلفة يستطيع المجتمع والبلد تحملها كل مرحلة من مراحل تطوّرهم بروح الاعتماد على الذات وتقرير المصير".

يعكس متوسط العمر المتوقع عند الولادة معدلات الوفيات الإجمالية للسكان وهو أحد المؤشرات الأساسية للحالة الصحية. يشير تقرير إحصاءات الصحة العالمية 2019 إلى أن متوسط العمر المتوقع في العالم في عام 2016 كان 72 عاماً. ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في متوسط العمر المتوقع داخل البلدان وفيما بينها. معدل وفيات الرضع أعلى بكثير عند الأطفال المولودين لأمهات غير متعلّقات مقارنة بأولئك اللائي التحقن بالمدرسة، ويختلف متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل كبير بناءً على معدلات وفيات الأمهات لدى الأستراليين الأصليين أعلى بكثير من تلك الخاصة بالأستراليين من غير السكان الأصليين.

حتى منتصف القرن العشرين، كانت الرعاية الصحية ذات التوجه الطبي الحيوي في العالم النامي تتكون إلى حد كبير من محاولات لاستيراد أو زراعة الأدوية التي تركز على المستشفيات كما تطورت في الدول الصناعية الأكثر ثراءً. بدأت هذه الجهود من قبل منظمات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم.

مكونات خدمات الرعاية الصحية:

في محاولة لتلبية الاحتياجات الصحية الرئيسية في العالم، كان على الرعاية الصحية الأولية توفير خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية تتكون على الأقل من المكونات الثمانية التالية:

- التثقيف الصحي الذي يمكن الناس من منع المشاكل والتعامل معها.
- الصرف الصحي الأساسي ومصدر مناسب للمياه المأمونة.
- التغذية الصحية وإمدادات الغذاء الآمنة.
- رعاية صحة الأم والطفل، بما في ذلك تنظيم الأسرة.
- التحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية.
- الوقاية من الأمراض المتوطنة.
- العلاج المناسب للأمراض الشائعة.
- توريد الأدوية الأساسية.

عناصر الرعاية الصحية الأولية:

هناك 8 عناصر للرعاية الصحية الأولية (PHC):

1. التعليم: فيما يتعلق بالمشكلات الصحية السائدة وطرق تحديدها والوقاية منها ومكافحتها.
2. الوقاية من الأمراض المتوطنة محلياً ومكافحتها.
3. برنامج موسع للتحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية.
4. رعاية صحة الأم والطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة.
5. ترتيب الأدوية الأساسية.
6. مكمل غذائي، إمداد كاف بالتغذية الأساسية الآمنة.
7. علاج الأمراض المعدية وغير المعدية وتعزيز الصحة النفسية.
8. المياه المأمونة والصرف الصحي.

العناصر الممتدة في القرن الحادي والعشرين:

- خيارات التحصين المستنفدة.
- احتياجات الصحة الإنجابية.
- توفير التقنيات الأساسية للصحة.
- تعزيز الصحة.
- الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.
- سلامة الغذاء وتوفير مكملات غذائية مختارة.

مبادئ الرعاية الصحية الأولية (PHC):

تكمن وراء العناصر سلسلة من الأهداف الأساسية التي ينبغي صياغتها في السياسات الوطنية لإطلاق الرعاية الصحية الأولية والحفاظ عليها كجزء من نظام صحي شامل والتنسيق مع القطاعات الأخرى.

1. تحسين مستوى الرعاية الصحية للمجتمع.
2. هيكل النمو السكاني الملائم.
3. الحد من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها والأمراض المعدية وغيرها.
4. خفض معدلات المرض والوفيات خاصة بين الرضع والأطفال.
5. توسيع الخدمات الصحية الأساسية مع إعطاء الأولوية للقطاعات المحرومة.
6. تحسين الصرف الصحي الأساسي.
7. تنمية قدرات المجتمع الهادفة إلى الاعتماد على الذات.
8. تعظيم مساهمة القطاعات الأخرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
9. التوزيع العادل للرعاية الصحية - وفقاً لهذا المبدأ، يجب توفير الرعاية الأولية والخدمات الأخرى لمواجهة المشكلات الصحية الرئيسية في المجتمع على قدم المساواة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس والعمر والطبقة الاجتماعية، والطبقة الحضرية / الريفية، والطبقة.
10. تعتمد الرعاية الصحية الشاملة بالمشاركة المجتمعية على أعداد كافية وتوزيع الأطباء المدربين والمرضات والمهن الصحية المساعدة والعاملين في صحة المجتمع وغيرهم ممن يعملون كفريق صحي ويتم دعمهم على المستوى المحلي ومستوى الإحالة.
11. نهج متعدد الأقسام - الاعتراف بأن الصحة لا يمكن تحسينها بالتدخل داخل قطاع الصحة الرسمي فقط؛ القطاعات الأخرى لها نفس القدر من الأهمية في تعزيز صحة المجتمعات والاعتماد على الذات.
12. استخدام التكنولوجيا المناسبة - يجب توفير التكنولوجيا الطبية التي يمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة، ومجدية، ومقبولة ثقافياً للمجتمع.

المؤشرات الصحية الأساسية:

تستخدم المؤشرات لقياس الوضع الصحي لمجتمع ما ولمقارنة الحالة الصحية لبلد مع حالة أخرى.

خصائص المؤشرات:

- صالحة.
- موثوقة وموضوعية.
- حساسة.
- محددة.
- مجدية.
- ذات صلة.

أنواع المؤشرات:

1. مؤشرات الوفيات:

وتشمل معدل الوفيات الإجمالي - توقع الحياة - معدل وفيات الأمهات - معدل وفيات الرضع - معدل وفيات الأطفال - معدل وفيات أقل من 5 سنوات - الوفيات النوعية المرض - معدل الوفيات النسبي.

2. مؤشرات المرض:

تستخدم لتكملة بيانات الوفيات. مثل معدلات المرض المستخدمة لتقييم اعتلال الصحة في المجتمع وهم: الحوادث - الانتشار - معدل الإخطار - معدل الحضور في العيادات الخارجية والمراكز الصحية وما إلى ذلك - معدلات القبول وإعادة القبول والتسريح - نوبات المرض.

3. معدلات الإعاقة.

مؤشرات نوع الحدث: عدد أيام النشاط المقيّد - أيام العجز في السرير - أيام خسارة العمل خلال فترة محددة مؤشرات نوع الشخص: قيود التنقل - تقييد النشاط (ADL).

مؤشر سوليفان: توقع حياة خالية من الإعاقة.

HALE (متوسط العمر المتوقع للصحة): العدد المعادل للسنوات في حالة صحية كاملة التي يمكن أن يتوقعها المولود الجديد استنادًا إلى المعدلات الحالية لاعتلال الصحة والوفيات.

DALY (سنة الحياة المعدلة حسب الإعاقة): عدد السنوات المفقودة بسبب اعتلال الصحة أو الإعاقة.

QALY (سنة الحياة المصححة بالجودة): عدد سنوات الحياة التي سيضيفها التدخل الطبي.

4. مؤشرات الحالة التغذوية:

وتشمل: قياس الأنثروبومترية لأطفال ما قبل المدرسة - ارتفاع الأطفال عند دخول المدرسة - انتشار نقص الوزن عند الولادة.

5. مؤشرات تقديم الرعاية الصحية:

وهي تشمل: نسبة الأطباء إلى عدد السكان - نسبة الطبيب إلى الممرضة - نسبة السكان إلى نسبة السرير.

6. معدلات الاستخدام:

معبرًا عنها كنسبة من الأشخاص المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية الذين يتلقونها بالفعل في فترة معينة.

- نسبة الأطفال الذين تم تحصينهم بالكامل ضد أمراض برنامج التحصين الموسع السبعة.

- نسبة السكان الذين يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

7. مؤشرات الصحة الاجتماعية والعقلية:

تعد تدابير غير مباشرة وتشمل مؤشرات علم الأمراض الاجتماعية مثل: الانتحار - القتل - أعمال العنف الأخرى - جرائم أخرى وما إلى ذلك - تعاطي الكحول والمخدرات.

8. المؤشرات البيئية.

يعكس جودة البيئة الفيزيائية والبيولوجية.

نسبة السكان الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب – نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي – المؤشرات المتعلقة بتلوث الهواء والماء، والإشعاع، والنفايات الصلبة، والضوضاء.

9. المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية:

انخفاض معدل السكان – نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي – مستوى البطالة – نسبة الإعاقة.

10. مؤشرات السياسة الصحية:

مؤشر هام للالتزام السياسي. مثل: نسبة الناتج القومي الإجمالي التي يتم إنفاقها على الخدمات الصحية – نسبة الناتج القومي الإجمالي التي يتم إنفاقها على الأنشطة المتعلقة بالصحة – نسبة إجمالي الموارد الصحية المخصصة للرعاية الصحية الأولية.

11. مؤشرات أخرى:

المؤشرات الاجتماعية – مؤشرات الاحتياجات الأساسية – مؤشرات الصحة للجميع.

الفريق الصحي:

البشر اجتماعيون بطبيعتهم ويربطون معاً في عائلات ومجموعات صغيرة وقبائل. بينما نحاول الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، تميل سلوكياتنا إلى عكس سلوكيات مجموعتنا العائلية ومجموعات الأقران والمجموعات المهنية. عندما ننضج، يتم إنشاء إحساسنا بالذات جزئياً من خلال تفاعلاتنا مع هذه المجموعات وردود الفعل التي نتلقاها.

يتمتع أعضاء فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات بعلاقات إبلاغ وأنظمة قيم متعددة. حيث يجدون أنفسهم يعملون في هياكل تنظيمية وسياسية متزايدة التعقيد. عرّف درينكا وكلاارك فريق الرعاية الصحية متعدد التخصصات (IHCT) بأنه "مجموعة من الأفراد ذوي التدريب والخلفيات المتنوعة الذين يعملون معاً كوحدة أو نظام محدد".

تعني القيادة في فريق الرعاية الصحية بين المهنيين أن كل من القائد المعين والأعضاء يجب أن يكونوا مستعدين لمشاركة مسؤوليات قيادة الفريق وأن يكونوا مدركين لديناميكيات المجموعة من أجل العمل بمهارات وقيم واهتمامات متنوعة على نطاق واسع.

يعد إنشاء ثقافة تعاونية والحفاظ عليها جانباً مهماً من جوانب التوجه المهني - بغض النظر عن الانضباط أو المنصب في المنظمة. يرى أعضاء الفرق عالية الأداء أن بيئة عملهم تتمتع بمستويات عالية من المرونة والمسؤولية والمعايير والمكافآت والوضوح والتزام الفريق. إنهم يشعرون أن الأفكار الجديدة مرحب بها، وخبراتهم موثوقة، والمساءلة والتميز هي القاعدة، والتوقعات واضحة، وهناك هدف مشترك.

خصائص الفريق الصحي:

في قطاع الرعاية الصحية، تزداد الحاجة إلى فرق رعاية صحية فعالة بشكل كبير. هناك الكثير من الحوادث التي تحدث حيث لا يتم علاج المرضى بشكل مناسب. بسبب نقص الموظفين. معدل الحالات الطبية لعامة السكان آخذ في الازدياد. الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة آخذ في الازدياد أيضًا. كل هذه الأسباب، تؤكد أن فرق الرعاية الصحية الفعالة مهمة للغاية. تتمتع فرق الرعاية الصحية الفعالة الآن بالعديد من الخصائص المهمة، بما في ذلك:

- التواصل الفعال ثنائي الاتجاه.
- القيم المشتركة، الأهداف / المهام.
- الأدوار المحددة مسبقًا.
- المعرفة والمهارات المشتركة.
- الاحترام المتبادل.
- موقف متفائل وإيجابي تجاه العمل المعين.
- العمل متعدد التخصصات في ظل ظروف عبء العمل القاسية.

الصفة القيادية:

1. الثقة.
2. الاستماع الجيد.
3. التأثير بالآخرين.
4. تقبل المسؤولية.
5. الهدوء عند الضغوط.
6. الحماس والإيجابية.

رعاية الطفولة والأمومة وتنظيم الأسرة

مقدمة:

تعتمد قدرة الشخص على عيش حياة مُرضية والمشاركة الكاملة في المجتمع بشكل كبير على حالته الصحية. وينطبق هذا بشكل خاص على النساء، فهنّ عادةً ما يتحملن مسؤولية ليس فقط صحتهن، بل أيضًا صحة الآخرين: أطفالهن وأسرهن. لذلك، من المهم التركيز على صحة المرأة وأسرته.

يمكن أن يكون للعادات والممارسات التي تُكتسب أثناء الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة آثار عميقة على صحة الشخص ومرضه طوال حياته. وكمجتمع، يُعدّ بناء جيل يهتم بالمرأة وأسرته ويعزز الرعاية الصحية السليمة وخيارات نمط الحياة السليمة أمرًا بالغ الأهمية. تشمل رعاية الأم والوليد نطاقًا واسعًا من الممارسات المرتبطة عادةً بالإنجاب. وتشمل رعاية المرأة قبل الحمل، ورعاية المرأة وجنينها أثناء الحمل، ورعاية المرأة بعد الحمل، وتعزيز الأمومة الآمنة، ورعاية المولود الجديد، عادةً خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. والهدف العام من رعاية الأم والوليد هو تعزيز والحفاظ على صحة مثالية للمرأة وأسرته.

المفاهيم الأساسية لتمرّض صحة الأم والوليد والمرأة:

يُقدّم تمرّض صحة الأم والوليد والمرأة رعايةً قائمةً على الأدلة للعميل ضمن إطار الأسرة. تتضمن هذه الرعاية تنفيذ خطة متعددة التخصصات بطريقة تعاونية لضمان استمرارية الرعاية الفعالة من حيث التكلفة، والموجهة نحو الجودة، والتركيز على النتائج. كما تتضمن رعايةً مُركزةً على الأسرة، وقائمةً على الأدلة، ومُدارة لكل حالة.

الرعاية المُركزة على الأسرة:

هي تقديم رعاية صحية آمنة ومرضية وعالية الجودة، تُركز على الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية للأسرة وتتكيف معها. وتقوم على الثقة المتبادلة والتعاون بين المرأة وأسرته ومُقدم الرعاية الصحية. إنها نهج قائم على الشراكة بين الأسر ومُقدمي الرعاية، يُدرك قوة الأسرة وتماسكها. ومن المبادئ الأساسية للرعاية المتمركزة حول الأسرة:

- تُعتبر الولادة حدثًا طبيعيًا وصحيًا في حياة الأسرة.
- تؤثر الولادة على الأسرة بأكملها، وستتغير العلاقات.
- تستطيع الأسر اتخاذ قرارات بشأن رعايتها إذا أُتيحت لها المعلومات الكافية والدعم المهني.
- تُدرك فلسفة الرعاية المتمركزة حول الأسرة أن الأسرة هي الركيزة الأساسية.
- تؤثر صحة الأسرة وأدائها على صحة المريض وأفرادها الآخرين.

تتطلب الرعاية المتمركزة حول الأسرة من الممرضة مراعاة معتقدات المريض وأسرته، بالإضافة إلى معتقدات من يدعمون ثقافتهم. يتضمن ذلك الاستماع إلى احتياجات الأسرة وتحويل الدور السلطوي للممرضة إلى الأسرة لتمكينها من اتخاذ قراراتها الخاصة في بيئة داعمة.

ينبغي تطبيق منظور عائلي حقيقي في رعاية الأمومة، والنظر إلى الوالدين الجدد كوحدة عائلية، وليس كحالة طبية. إن تقديم الممرضات للرعاية المتمحورة حول الأسرة يعني أنهن يحددن ويحترمن ويهتمن باختلافات المريض وقيمه وتفضيلاته واحتياجاته المُعبر عنها؛ ويخففن الألم والمعاناة؛ وينسقين الرعاية المستمرة؛ ويستمنعن إلى المرضي ويُلغّنه بوضوح ويتواصلن معهم ويتفقدنهم؛ ويشاركن في صنع القرار والإدارة؛ ويدافعن عنهم باستمرار.

اضطرابات الدورة الشهرية:

تمر العديد من النساء بدوراتهن الشهرية بسلسلة تامة دون أي قلق يُذكر. مع قلة الأعراض التي تستدعي القلق، تكون دورتهن الشهرية منتظمة، تبدأ وتنتهي في نفس الأوقات تقريباً كل شهر. أما بالنسبة لأخريات، فتُسبب الدورة الشهرية أعراضاً جسدية ونفسية تستدعي زيارة الطبيب/ة لاستشارته/ا. ومن الحالات التالية المتعلقة بالدورة الشهرية: انقطاع الطمث، وعسر الطمث، والنزيف الرحمي غير الطبيعي، ومتلازمة ما قبل الحيض، واضطراب ما قبل الحيض، وبطانة الرحم المهاجرة.

انقطاع الطمث:

يعني ببساطة غياب الحيض. يُعد انقطاع الطمث أمراً طبيعياً لدى النساء قبل البلوغ، والحوامل، وبعد الولادة، وبعد انقطاع الطمث. يجب أن يعمل الرحم، وبطانة الرحم، والمبايض، والغدة النخامية، والوطاء بشكل سليم ومتناسق لحدوث الدورة الشهرية. ويُصنف انقطاع الطمث إلى نوعين:

- انقطاع الطمث الأولي: يُعرّف انقطاع الطمث الأولي بأنه:

- 1- غياب الحيض في سن الرابعة عشرة، مع غياب نمو وتطور الخصائص الجنسية الثانوية.
- 2- غياب الحيض في سن السادسة عشرة، مع تطور طبيعي للخصائص الجنسية الثانوية.

مسببات انقطاع الطمث الأولي:

- زيادة أو نقصان شديد في الوزن.
- تشوهات خلقية في الجهاز التناسلي.
- الإجهاد الناتج عن حدث مهم في الحياة.
- الإفراط في ممارسة الرياضة.
- اضطرابات الأكل (فقدان الشهية العصابي أو الشره المرضي).
- داء كوشينغ.
- متلازمة تكيس المبايض.
- قصور الغدة الدرقية.
- متلازمة تيرنر - خلل في نمو الغدد التناسلية (المبيض أو الخصيتين).
- غشاء البكارة غير المثقوب.
- الأمراض المزمنة - داء السكري، أمراض الغدة الدرقية، الاكتئاب.
- الحمل.
- التليف الكيسي.
- أمراض القلب الخلقية (زرقعة).
- أورام المبيض أو الغدة الكظرية.

- انقطاع الطمث الثانوي: هو غياب الحيض المنتظم لمدة ثلاث دورات أو عدم انتظامه لمدة 6 أشهر لدى النساء اللواتي سبق لهن الحيض بانتظام.

مسببات انقطاع الطمث الثانوي:

- الحمل.
- الرضاعة الطبيعية.
- الإجهاد العاطفي.
- أورام الغدة النخامية، أو المبيض، أو الغدة الكظرية.
- الاكتئاب.
- فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.
- سوء التغذية.
- فرط بروتين الدم.
- زيادة أو نقصان الوزن بسرعة.
- العلاج الكيميائي أو الإشعاعي لمنطقة الحوض.
- التمارين الرياضية الشاقة، مثل الجري لمسافات طويلة.
- الفشل الكلوي.
- التهاب القولون.
- استخدام المهدئات أو مضادات الاكتئاب.
- نخر الغدة النخامية بعد الولادة (متلازمة شيهان).
- انقطاع الطمث المبكر.

يجب على الممرضات مراعاة أسباب انقطاع الطمث في إحدى المناطق التشريحية الأربع: منطقة تدفق الدم في الرحم والمهبل، أو المبايض، أو الغدة النخامية، أو الجهاز العصبي المركزي.

عسر الطمث:

يُشير عسر الطمث إلى ألم الدورة الشهرية، وهو مشكلة شائعة في فترة المراهقة. وتُعرف هذه الحالة أيضًا بألم ما قبل الدورة الشهرية الدوري. يبدأ الألم عادةً مع بدء النزيف ويستمر لمدة 48 إلى 72 ساعة. يُشتق مصطلح عسر الطمث من الكلمتين اليونانيتين dys، وتعني "صعب، مؤلم، أو غير طبيعي"، و rhea، وتعني "تدفق". وبناءً على نتائج دراسات وبائية واسعة النطاق، يُقدر أنه قد يُصيب أكثر من نصف النساء في فترة الحيض. وهو السبب الرئيسي للتغيب عن العمل والدراسة، وله آثار سلبية على جودة حياة الشابات. يُصنف عسر الطمث إلى أولي (تشنجي) أو ثانوي (احتقاني).

نزيف الرحم غير الطبيعي:

تظهر اضطرابات نزيف الدورة الشهرية في مجموعة واسعة من الأعراض. النزيف الرحمي غير الطبيعي هو المصطلح الشامل المستخدم لوصف أي انحراف عن الدورة الشهرية الطبيعية أو عن نمط الدورة الشهرية الطبيعي. يمكن أن يحدث لدى النساء في أي عمر.

تتمثل السمات الرئيسية في انتظام وتواتر وحجم أو غزارة التدفق ومدته، ولكن قد يُظهر كل منها تباينًا كبيرًا. النزيف الرحمي غير الطبيعي هو اضطراب يحدث بشكل متكرر لدى النساء في بداية ونهاية سنوات الإنجاب. يُعرّف بأنه نزيف بطانة الرحم غير مؤلم، ويكون مطولاً، ومفرطاً، وغير منتظم، ولا يُعزى إلى أي مرض هيكلي أو جهازية كامن. غالبًا ما يرتبط بنزيف عدم الإباضة، وهو أمر شائع في السنة الأولى بعد بدء الحيض، ويرتبط بعدم نضج محور الغدة النخامية-المبيض تحت المهاد. كما يحدث في وقت لاحق

من الحياة مع اقتراب النساء من سن اليأس وتعرضهن لدورات شهرية غير منتظمة. ترتبط الفيزيولوجيا المرضية لمتلازمة انقطاع الطمث المبكر باضطراب هرموني. مع انقطاع التبويض، ترتفع مستويات هرمون الإستروجين كالمعتاد في المرحلة المبكرة من الدورة الشهرية.

مسببات نزيف الرحم غير الطبيعي: تشمل الأسباب المحتملة لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات ما يلي:

- العضال الغدي.
- الحمل.
- اختلال التوازن الهرموني.
- الأورام الليفية.
- سلائل أو سرطان بطانة الرحم.
- بطانة الرحم.
- اللولب الرحمي (IUS).
- متلازمة تكيس المبايض.
- السمنة المفرطة.
- العضال الغدي.
- العلاج بالستيرويد.
- قصور الغدة الدرقية.
- اضطرابات تخثر الدم.
- الأورام الخبيثة وفرط التنسج.
- سلائل الرحم.

الحمل:

يُعد التكاثر البشري أحد أكثر جوانب حياة الفرد حميمية. يحدث الحمل عندما تنطلق بويضة سليمة من المبيض، وتمر عبر قناة فالوب المفتوحة، وتبدأ رحلتها إلى أسفل. يُودع الحيوان المنوي من الذكر في المهبل ويسبح لمسافة 7 بوصات تقريباً ليلتقي بالبويضة في الجزء الخارجي من قناة فالوب، وهي المنطقة التي يحدث فيها الإخصاب. تحدث هذه العملية في حوالي ساعة.

عندما يخترق حيوان منوي واحد الغشاء الخارجي السميكة للبويضة، تتشكل خلية حية جديدة تختلف عن خلايا أي من الوالدين. وسرعان ما تندمج النواتان، لتجمعا معاً حوالي 25,000 جين لتوجيه النمو البشري. يحتاج الممرضون الذين يعتنون بالأسرة التي تُنجب الأطفال إلى فهم أساسي للحمل والنمو قبل الولادة حتى يتمكنوا من تحديد المشاكل أو الاختلافات، ويمكنهم بدء التدخلات المناسبة في حالة حدوث أي مشاكل.

إرشادات للرعاية ما قبل الحمل:

- المسؤولية الفردية على مدار العمر: ينبغي تشجيع كل امرأة ورجل وزوجين على وضع خطة حياة إنجابية.
- التوعية: زيادة الوعي العام بأهمية السلوكيات الصحية قبل الحمل وخدمات رعاية ما قبل الحمل من خلال استخدام المعلومات والأدوات المناسبة لمختلف الأعمار.

- الزيارات الوقائية: كجزء من زيارات الرعاية الأولية، توفير تقييم المخاطر والاستشارات التثقيفية والصحية لجميع النساء في سن الإنجاب للحد من مخاطر الإنجاب وتحسين نتائج الحمل.
- التدخلات للمخاطر المحددة: زيادة نسبة النساء اللواتي يتلقين تدخلات كمتابعة لفحص مخاطر ما قبل الحمل، مع التركيز على التدخلات ذات الأولوية العالية (أي تلك التي تثبت فعاليتها وأكبر تأثير محتمل).
- رعاية ما قبل الحمل: استخدام فترة ما قبل الحمل لتوفير تدخلات مكثفة إضافية للنساء اللواتي مررن بحمل سابق انتهى بنتائج سلبية (مثل وفاة الرضيع، أو فقدان الجنين، أو العيوب الخلقية، أو انخفاض الوزن عند الولادة، أو الولادة المبكرة).
- فحص ما قبل الحمل: توفير زيارة واحدة قبل الحمل، كجزء من رعاية الأمومة، للأزواج والأشخاص الذين يخططون للحمل.
- تغطية التأمين الصحي للنساء ذوات الدخل المحدود: زيادة تغطية التأمين الصحي العام والخاص للنساء ذوات الدخل المحدود لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الوقائية للمرأة ورعاية ما قبل الحمل وما بعده.
- برامج واستراتيجيات الصحة العامة: دمج مكونات صحة ما قبل الحمل في برامج الصحة العامة المحلية القائمة والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك التركيز على تدخلات ما قبل الحمل للنساء اللواتي تعرضن لنتائج سلبية سابقة.
- البحث: زيادة قاعدة الأدلة وتعزيز استخدامها لتحسين صحة ما قبل الحمل.
- تحسينات المراقبة: تعظيم مراقبة الصحة العامة وآليات البحث ذات الصلة لمراقبة صحة ما قبل الحمل.

آلام الحمل:

- آلام الثلث الأول من الحمل: خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، يمر جسم المرأة بتغيرات عديدة. بعض النساء يعانين من العديد من الآلام، بينما يعاني البعض الآخر من القليل منها. تحدث هذه الآلام نتيجة التغيرات التي تحدث في الجسم، وتزول مع تقدم الحمل.
- آلام الثلث الثاني من الحمل: عادةً ما يتميز الثلث الثاني من الحمل بشعور بالراحة لدى معظم النساء. بحلول هذا الوقت، يخفّ التعب والغثيان والقيء، وتكون التغيرات المزعجة للثلث الثالث على بُعد بضعة أشهر. لا تعاني كل امرأة من نفس الآلام خلال هذه الفترة، لذا يجب تخصيص تقييمات وتدخلات التمريض لكل حالة على حدة.
- آلام الثلث الثالث من الحمل: مع دخول النساء الثلث الثالث من الحمل، تعاني الكثيرات من عودة آلام الثلث الأول من الحمل، كالتعب، وتكرار التبول، وسيلان الدم، والإمساك. هذه الآلام ناتجة عن تضخم الرحم الذي يضغط على الأعضاء المجاورة، وارتفاع مستويات الهرمونات، ومتطلبات الجنين الأيضية. بالإضافة إلى هذه الآلام، تعاني العديد من النساء من ضيق في التنفس، وحرقة في المعدة، وعسر هضم، وتورم، وتقلصات براكستون هيكس.

عملية المخاض والولادة:

تتضمن أكثر من مجرد ولادة طفل حديث الولادة. تحدث العديد من الأحداث الفيزيولوجية والنفسية التي تؤدي في النهاية إلى ولادة طفل حديث الولادة وتكوين أو توسيع الأسرة. المخاض حدث فيزيولوجي يتضمن مجموعة متسلسلة ومتكاملة من التغيرات في عضلة الرحم، والسائل المبطّن للرحم، وعنق الرحم، تحدث تدريجيًا على مدى أيام إلى أسابيع بهدف إخراج الجنين من الرحم. من الصعب تحديد سبب بدء المخاض بدقة وما الذي يُحفّزه. على الرغم من طرح العديد من النظريات لتفسير بدء المخاض واستمراره، إلا أنه لم يُثبت أي منها علميًا. للانقباضات الرحمية وظيفتان رئيسيتان: توسيع عنق الرحم ودفع الجنين عبر قناة الولادة.

مرحلة حديثي الولادة:

عندما يولد الطفل، ينتهي إرهاق وضغط المخاض بالنسبة للوالدين، ولكن يجب على المولود الجديد الآن أن يبدأ عملية التكيف الفيزيولوجي والسلوكي مع البيئة الجديدة. قد تكون الساعات الأربع والعشرون الأولى من الحياة هي الأكثر خطورة. تُعرف فترة حديثي الولادة بأنها أول 28 يومًا من الحياة. إنها فترة تشهد تغيرات فيزيولوجية سريعة ودراماتيكية لدى البشر. بعد الولادة، يتعرض المولود الجديد لعالم جديد تمامًا من الأصوات والألوان والروائح والأحاسيس. المولود الجديد، الذي كان محصورًا سابقًا في بيئة الرحم الدافئة والمظلمة والرطبة، يُدفع الآن إلى بيئة أكثر إشراقًا وبرودة.

الانتقال الفيزيولوجي:

يعدّ تكيف المولود من بيئة داخل الرحم إلى بيئة خارج الرحم أمرًا معقدًا وصعبًا، ولكنه ضروري لجميع البشر. يمكن أن يكون للظروف الطبية للأم والجنين تأثيرٌ بالغٌ على نجاح هذا الانتقال. تتطلب آليات الولادة تحولًا في المولود الجديد للبقاء على قيد الحياة خارج الرحم. فور الولادة، يجب أن يحدث تبادل غازات الجهاز التنفسي، إلى جانب تعديلات في الدورة الدموية، للحفاظ على الحياة خارج الرحم. خلال هذه الفترة، وبينما يسعى المواليد الجدد جاهدين لتحقيق التوازن الداخلي، فإنهم يمرون أيضًا بتغيرات معقدة في أجهزة أعضائهم الرئيسية. تحدث أكثر عمليات الانتقال خارج الرحم دراماتيكية وسرعة لدى المولود الجديد في أربعة مجالات مترابطة: الجهاز التنفسي، والجهاز الدوري، والتنظيم الحراري، والقدرة على تثبيت مستويات السكر في الدم. يجب أن تُنجز جميع هذه المجالات الأربعة انتقالات ناجحة حتى يتكيف المولود الجديد مع الحياة خارج الرحم. على الرغم من أن الانتقال يحدث عادةً خلال أول 6 إلى 10 ساعات من الحياة، إلا أن العديد من عمليات التكيف تستغرق أسابيع حتى تصل إلى النضج الكامل.

توفير الرعاية العامة لحديثي الولادة:

- الاستحمام والنظافة: بعد الولادة مباشرة، قد يُقلل تجفيف المولود الجديد وإزالة الدم منه من خطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي ب، وفيروس الهربس، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، إلا أن الفوائد المحددة لهذه الممارسة لا تزال غير واضحة. إلى أن يُحمّم المولود الجديد جيدًا، يجب اتباع الاحتياطات القياسية عند التعامل معه. يجب على الممرضات اتباع سياسات المستشفى المتعلقة بتوقيت وإجراءات استحمام المولود الجديد والنظافة. يُحمّم حديثو الولادة في المقام الأول لأسباب جمالية، ويُؤجّل الاستحمام حتى يتم ضمان استقرار درجة الحرارة والجهاز القلبي التنفسي. الأسباب

التقليدية التي تدفع الممرضات إلى تحميم المولود الجديد هي إجراء تقييم بدني، وتقليل تأثير انخفاض حرارة الجسم، والسماح للأُم بالراحة.

- إخراج الفضلات والعناية بمنطقة الحفاضات: تختلف أنماط إخراج الفضلات لدى حديثي الولادة بشكل كبير. عادةً ما يكون لون البول كهرماني فاتح. يشير اتساخ 6 إلى 12 حفاضة يوميًا إلى ترطيب كافٍ. يمكن أن يتغير لون البراز وملامسه وتكرار خروجه دون الإشارة إلى أي مشكلة.
- العناية بالحبل السري: يبدأ الحبل السري بالجفاف في غضون ساعات من الولادة، ويذبل ويسود بحلول اليوم الثاني أو الثالث. في غضون 7 إلى 10 أيام، ينسلخ وتلتئم السرة. خلال هذه الفترة، من الضروري إجراء فحوصات دورية للمنطقة للكشف عن أي نزيف أو علامات عدوى. يُعدّ نزيف الحبل السري غير طبيعي، وقد يحدث إذا تم فكّ مشبك الحبل السري. كما يُعدّ أي تصريف غير طبيعي للحبل السري، وعادةً ما يكون ناتجًا عن عدوى، مما يتطلب علاجًا فوريًا.
- الختان والعناية بالقضيب يُعد الختان من أقدم العمليات الجراحية وأكثرها شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ولكنه لا يزال مثيرًا للجدل. يُجرى لأسباب طبية ودينية وثقافية واجتماعية. الختان هو الإزالة الجراحية لكل أو جزء من قلفة القضيب (القلفة).
- الوقاية من العدوى: تلعب الممرضة دورًا رئيسيًا في الوقاية من العدوى في بيئة حديثي الولادة. ومن طرق السيطرة على العدوى ما يلي:

- 1- تقليل تعرض حديثي الولادة للكانينات الحية.
 - 2- اغسل يديك قبل وبعد تقديم الرعاية، وأصر على أن يغسل جميع الموظفين أيديهم قبل التعامل مع أي مولود جديد.
 - 3- لا تسمح للموظفين أو الزوار المرضى بزيارة أو التعامل مع حديثي الولادة.
 - 4- تجنب مشاركة أي مستلزمات خاصة بالرضع مع رضيع آخر.
 - 5- راقب جذع الحبل السري وموقع الختان بحثًا عن أي علامات عدوى.
 - 6- قدّم الوقاية من التهابات العين عن طريق وضع دواء موصوف بعد الولادة مباشرة.
 - 7- تنقيف الآباء حول التدابير المنزلية المناسبة للوقاية من العدوى.
- الاحتياجات الغذائية لحديثي الولادة: مع نمو المواليد الجدد، تتغير احتياجاتهم من الطاقة والمغذيات لتلبية احتياجات أجسامهم المتغيرة. خلال مرحلة الرضاعة، تكون احتياجات الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن لكل رطل من وزن الجسم أعلى من أي وقت آخر في الحياة. هذه المستويات العالية ضرورية لتغذية النمو والتطور السريع خلال هذه المرحلة من الحياة. بشكل عام، يتضاعف وزن الرضيع عند الولادة في الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى من عمره، ويتضاعف ثلاث مرات خلال السنة الأولى.

الصحة المدرسية

تعريف الصحة المدرسية:

هي مجموعة المفاهيم والمبادئ والأنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطلاب في السن المدرسية وتعزيز صحة المجتمع من خلال المدارس، وهي جهود شاملة لتطوير وتنفيذ وتقييم الخدمات، سواء داخل المدرسة أو المجتمع ككل.

تعد المدرسة من المؤسسات التعليمية التي تحاول مواكبة الصحة وتكملها، حيث يجب أن يتضمن برنامج يهدف إلى تطوير المدارس من خلال الإصلاح التربوي والجانب الصحي للطلاب من الوقاية حتى العلاج. وتساعد على تحقيق نمو صحي وجسدي وتنمية قدراتهم، وتؤكد على أهمية المدرسة في العمل الذي يقوم به كل من الأطباء والمديرين والمعلمين والرؤساء في تحقيق الأهداف الصحية. والعمل معًا على تحسين صحة الطلاب.

يلعب المدير دورًا مهمًا في الوقاية والعلاج في التثقيف الصحي المدرسي، من خلال وضع مجموعة من المفاهيم والمبادئ والأنظمة والخدمات التي تهدف إلى كل ذلك. ويعمل على تحسين صحة الطلاب من خلال التركيز على تعزيز مشاركة الطلاب، ومتابعة الأنشطة والبرامج الصحية والتوعية بالصحة والبيئة والنظافة الشخصية، وتحسين الحالة الصحية والتغذية للمجتمع ودور المعلمين لا يقل عن دور المدير ونقل المبادئ الأساسية في التثقيف الصحي من خلال التعليم.

تعد الصحة ثروة الناس، ومسؤولية الحفاظ على الصحة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، وهذا من الحقوق الأساسية التي يقتضيها العهد الدولي. هكذا يؤكد على وجوب تلبية جميع احتياجات الأطفال، وتحسين شخصياتهم. حيث يواجه المجتمع العديد من التحديات التي تؤثر على صحة الأطفال وخاصة الأطفال في سن المدرسة مما يجعل المؤسسات الاجتماعية وخاصة المدارس مسؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة للطلاب. والتعامل مع الأساليب التي تتميز بالرعاية لتوفير الصحة البدنية والنفسية. فهي تساعد بشكل فعال في بناء شخص يمكنه التعامل بنجاح مع المشاكل المستقبلية وحلها.

أهمية الصحة المدرسية:

- خدمة المجتمع وخاصة الطلاب ورفع الوعي الصحي لديهم.
- الطلاب في البيئة المدرسية أكثر عرضة للمخاطر الصحية (الأمراض السارية، الإصابات والحوادث).
- اكساب الطلاب السلوكيات الصحية السليمة المتعلقة بالحياة.
- الاكتشاف المبكر والعلاج الفوري للعديد من الأمراض.
- يشكل الطلاب نسبة عالية من المجتمع.

أهداف الصحة المدرسية:

- رفع الوعي الصحي للطلاب وبالتالي للمجتمع.
- تحديد أولويات المشاكل الصحية في المجتمع المدرسي وتعريف التربويين بها.
- تدريب المعلمين على أعمال الصحة المدرسية مثل الاكتشاف المبكر للأمراض والتوعية الصحية ومراقبة البيئة المدرسية.

- تقديم الخدمات الصحية لقطاع كبير من المجتمع (الطلاب ومنسوبي التعليم).
- اكتساب مهارات التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج الصحة المدرسية.
- توفير وتحسين البيئة المدرسية الصحية بالتنسيق والتعاون مع الأسرة التربوية.

مكونات الصحة المدرسية:

- التوعية الصحية المدرسية.
- الخدمات الصحية المدرسية العلاجية والوقائية.
- البيئة الصحية المدرسية.
- البيئة وسلامة الغذاء من حيث الكم والنوع والمراقبة الغذائية والسلوك الغذائي للطلاب.
- التربية البدنية والترفيه.
- البرامج الصحية الموجهة للمجتمع.
- الوقاية من الحوادث (التعاون مع المرور والدفاع المدني) والتطعيمات الموسمية والطارئة، والمشاركة في المناسبات الصحية المختلفة.

تنظيمات الصحة المدرسية في القطر العربي السوري:

وفقاً لورقة عمل الجمهورية العربية السورية لقمة تحويل التعليم 2022 فإنه تم الإشارة إلى:

1. التزام جميع المشرفين والمسؤولين والمعلمين والإداريين العاملين في المدارس بدعم الخطط المعززة للصحة في مدارسهم:

- المشرفون والمنسقون الصحيون:
- تكليف مشرفين أو منسقين صحيين في كافة المدارس لتقديم بعض الخدمات الصحية البسيطة وتحديد مهامهم وتدريبهم عليها ومتابعتهم بشكل دائم. وقد بلغ عدد المشرفين الصحيين المكلفين والمدرسين 5994 حيث غطى هذا العدد 66% من عموم مدارس التعليم الأساسي والثانوي في القطر والبالغ 9068 مدرسة.

- التدريب الصحي للكادر المدرسي والصحي:
- تدريب وتأهيل متقنين صحيين إضافة إلى تدريب الكوادر التعليمية والموجهين على البرامج الصحية المدرسية ولاسيما المتعلقة بالنتقيف الصحي. وقد تم تدريب 1178 مثقف صحي و2538 من الإداريين و15000 من المعلمين في المدارس و2950 من المشرفين على المراكز الامتحانية على الإجراءات الوقائية الصحية للوقاية من فيروس كورونا ولنشر المعرفة الصحية لدى الطالب لتبني السلوكيات الصحية السليمة خلال الجائحة عام 2021م.

2. قبول مبادرات المجتمع المحلي الداعمة للمدارس المعززة للصحة وتشجيعها:

التعاون بين وزارة التربية والجمعيات الأهلية التي تعنى بالصحة العامة مثل جمعية تنظيم الأسرة وجمعية الرازي لدعم ذوي الإعاقة وغيرها إضافة إلى المنظمات الشعبية مثل منظمة طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة، والتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خاصة خلال الامتحانات

العامة وتأمين الوجبات والنقل للطالب في مراكز الاستضافة القادمين من المناطق غير المستقرة والراغبين بتقديم امتحاناتهم النهائية في المناطق الآمنة ، كما تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم المساعدات العينية وجلسات التنقيف والدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الطلاب.

3. الالتزام بمنهاج مدرسي يدعم صحة الأطفال الجسدية والنفسية والاجتماعية العاطفية ورفاهيتهم:

- برنامج التنقيف الصحي:
تطوير برنامج التنقيف الصحي الذي تم وضعه في العام 2020م المتضمن أهم المواضيع الصحية التنقيفية مثل: التغذية، النشاط البدني، التدخين، الأمراض المعدية، دمج المعاقين، السلامة والأمان، أنماط الحياة الصحية، الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، وباء كوفيد 19-والوقاية منه- وإدراجه ضمن أنشطة التنقيف الصحي في المدارس ووضع برنامج تنفيذه له من خلال الجولات المدرسية. وتم خلال العام الدراسي 2020-2021م تنفيذ 17700 جلسة تنقيف لـ 1765252 تلميذا.
- مشاريع المنهج الصحي:
تطبيق مشاريع المنهج الصحي المدرسي في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى وهي: النظافة الشخصية، صحة الفم والأسنان، التغذية وصحة جهاز الهضم، الأمراض المعدية والوقاية منها، السلامة والأمان، الأمراض التنفسية وتلوث الهواء، أمراض العين، الأمراض الجلدية، التدخين، التلوث بالضجيج، الرياضة واللعب والنوم، صحة جهاز الإطراح، الإسعافات الأولية، العناية بنباتات البيئة، العناية بالحيوانات وعلاقتها بالإنسان، الصحة الإنجابية، العناية بالمسنين، اللقاح والمناعة.
- التدريب على البرنامج الصحي:
 - يتم سنويا تنفيذ ورشات محلية في المحافظات لتدريب معلمي الحلقة الأولى والموجهين التربويين على مشاريع المنهج الصحي المدرسي للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس للتعليم الأساسي حيث تم خلال عام 2021 تدريب 1260 معلما وموجها تربويا.
 - تنفيذ ورشات محلية سنوية للمساعدات والمثقفات الصحيات في جميع المحافظات على المواضيع التنقيفية المهمة. وتحديث الحقيبة التدريبية وفق الاحتياجات وتم خلال عام 2021 تدريب 420 مثقفا صحيا.
 - تشكيل فرق للتنقيف الصحي والتوعية الصحية والتي تشمل المدارس والمجتمع المحلي معا.
 - تم تشكيل فرق تنقيف حول الليشمانيا في ريف حماه وحلب وإدلب ودير الزور إضافة للكشف الدوري عن الليشمانيا في المدارس من خلال فرق الترصد في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحماه وإدلب ودير الزور وحلب والرقعة. حيث تم رصد 400 حالة في حلب - 65 حالة في ريف دمشق - 14 حالة في دير الزور خلال العام الدراسي 2020-2021م.
- دمج التنقيف الصحي في المنهاج:
اعتماد مناهج تربوية مطورة تدعم التوعية والتنقيف الصحي مع التحديث المستمر للمعلومات الصحية فيها بما يتوافق مع التطور العلمي.
- الترويج الإعلامي للقضايا الصحية:
الترويج الإعلامي للقضايا الصحية المهمة في المجتمع وإشراك الإعلام في التنقيف الصحي والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهتم بها فئة الشباب بهدف ردم الفجوة بالتنقيف الصحي لدى المراهقين.

- التنسيق بين الوزارات حول القضايا الصحية:
التشبيك مع الشركاء من الوزارات والمنظمات الشعبية والدولية والمجتمع المحلي.

4. تأمين بيئة مدرسية آمنة وداعمة من الناحية النفسية والاجتماعية:

عملت وزارة التربية على تأمين بيئة مدرسية آمنة وداعمة نفسيا من خلال فرز مرشدين نفسيين واجتماعيين في كافة المدارس وتطوير مهاراتهم بإخضاعهم لورشات تدريبية متنوعة كما تم تدريب العاملين في الصحة المدرسية على برامج الصحة النفسية لتقديم الرعاية الصحية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لأبنائنا التلاميذ والطلاب. حيث استهدف: تدريب 413 مرشد نفسي واجتماعي على برنامج الصحة العقلية المدرسية. منذ العام 2017؛ تدريب 300 من أطباء الصحة المدرسية على برنامج راب الفجوة بالصحة النفسية والعقلية منذ العام 2019؛ تدريب 419 مساعد ومثقف صحي على برنامج مهارات الدعم النفسي الأساسية منذ العام 2019.

البناء المدرسي:

عندما تكون البيئة المعمارية للمدارس انعكاسا لصورة المجتمع المحلي وللثقافة والبيئة الطبيعية، والأسرة، تصبح المدارس أكثر من مجرد هياكل أو بنى مادية لتكون أماكن تفاعلية للتعليم والتعلم، أي أماكن ييسر فيها المعلمون عملية التعليم ويديرونها، ويتعلم فيها الطالب ويكتشفون إمكانيات جديدة تتطابق مع قدراتهم وإمكانياتهم. وتصبح المدرسة نظاما متكاملًا وشاملاً يغذي نفسه بأثر رجعي من العناصر المحيطة ويمنحها هوية ما.

1. أقسام البناء المدرسي:

المعايير الأساسية لتخطيط وتصميم المرافق التعليمية:

- الخصائص الطبوغرافية.
- مصادر المياه الآمنة.
- مصادر الطاقة (الكهرباء - الطاقة البديلة).
- النواحي المناخية الطبيعية والصناعية.
- شروط السلامة.
- شروط الصحة.
- إشراك المجتمع المحلي.

يجب تصميم وبناء المواقع والمنشآت وأنظمة البناء من أجل:

- توفير بيئات آمنة وصحية للتعليم.
- توفير عملية فعالة من حيث التكلفة.
- تتطلب الحد الأدنى من الصيانة.
- أن تكون صلبة ومتينة.

- استخدام مواد آمنة خالية من الأسبستوس والرصاص وثابتة ضد انبعاثات الغاز وتصريف البخار.
- استخدام دهانات منخفضة الثقل وقابلة للغسل وسهلة المطابقة ومتينة.

تصميم المدارس الحديثة:

- توفير نماذج تصميم جديدة لمساحات التعلم قابلة للتخصيص من قبل المتعلم ويتم من خلال هذه النماذج ربط التعليم بمصالح المتعلمين وحياتهم المستقبلية.
- توفر هذه النماذج الجديدة للمتعلمين إمكانيات تعلم واسعة استنادا إلى مهارات القرن الحادي وعشرين.
- توفير تصميمات فعالة من حيث الجودة والتكلفة لوظائف مشاريع المدارس ورياض الأطفال.
- الحصول على تصاميم تفي بالمتطلبات المحلية وتعكس الاحتياجات الفعلية لمختلف الأطراف ذات الصلة.
- نموذج ذكي ومتطور يواكب طبيعة المنهاج الحديث المطور.
- خلق غرف صفية محفزة تدعم التعلم الفعال للجميع.
- توافر المرافق والخدمات والتجهيزات التي تفي بالغرض والمستدامة بيئيا والتي تدعم احتياجات الطفل ككل بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة الحركية.
- نماذج صديقة للطفولة ومرنة وقابلة للتكيف وملائمة.
- توفر بيئات تعليمية تمكينية، بما في ذلك البيئات الملائمة للأطفال ذوي الإعاقات الجسدية والحسية/التعليمية.
- إيجاد نوع من التوافق بين المباني، والساحات المدرسية، والبيئة كما يتفاعل الأطفال معها.

2. غرف الدراسة من حيث الأثاث والمقاعد والشروط الصحية والسكنية:

يجب أن تدعم المرافق البرامج والمناهج التعليمية الحالية للمنطقة. بناء القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية في المرافق في:

- الاحتياجات التعليمية والتوجيهية والوظيفية/البرامجية، بما في ذلك استخدام المجتمع.
- قيد الطالب (التوسع والانكماش).
- التكنولوجيا.
- ملائم للموارد المشتركة (مركز إعلامي، كافيتريا، منشأة PE).
- استخدم الضوء الطبيعي لتقليل تكاليف الإضاءة أثناء النهار، وتحقيق التوازن بين طيف الإضاءة المتاح وتوفير المناظر.
- التوازن صوتيًا لسماع الصوت في الغرف وحجب الضوضاء من خارجها.
- قم بترتيب الأثاث الأساسي للسماح بخطوط رؤية جيدة للوحات التدريس من جميع المكاتب والطاولات.
- خزانة للسماح بالتخزين للعناصر الكبيرة الأخرى.
- توفير مساحة تخزين إضافية للمعلمين خارج المسار.
- الألواح البيضاء القياسية وألواح التنبيت مع شريط ربط في الأعلى وحاملات عمود العلم.

- مساحة للمعاطف لا تسبب الفوضى في الفصل وتجنب مشاكل السلامة من الخطافات في مناطق الازدحام الشديد.
- توفير حجرات لكل طفل لرياض الأطفال.
- التقليل من مساحات السجاد قدر الإمكان.
- يفضل استخدام الأرضيات الخرسانية المصقولة في جميع الأنحاء وخاصة في المناطق الرطبة. قد تكون مناطق التخزين خرسانية محكمة الإغلاق.

3. المرافق الصحية:

- يجب أن تكون منطقة الممرضة متاخمة ودخولها عن طريق منطقة التحكم في المكتب المركزي للمدرسة.
- توفير ما لا يقل عن 6 كراسي في منطقة الاستقبال ورف جداري للمواد التعليمية.
- فحص البصر.
- توفير مساحة عميقة 20 قدمًا لإجراء فحوصات العين.
- توفير مكتب خاص لمرضة المدرسة ليشمل على الأقل منفذين مزدوجين، وهاتف به خط مخصص، وكمبيوتر متصل بالإنترنت، وآلة تقطيع الأوراق، ونافذة لمنطقة سرير الأطفال. تصميم جدران / نافذة لاختبار السمع (كعازل للصوت قدر الإمكان).
- غرفة العلاج / سرير الأطفال تشمل مساحة تتسع لسرير واحد لكل 250 طالب مع منضدات بين المعدات.
- توفير وتركيب ستائر مثبتة بالأسقف للخصوصية.
- منافذ مزدوجة وقطرات بيانات عند كل سرير للمعدات التي قد تكون مطلوبة.
- وحدة أحواض عميقة بالماء الساخن والبارد.
- خزانة تخزين بطول 7 أقدام للمعدات الكبيرة.

4. أمكنة الطعام:

- يجب أن يكون خط التقديم خاليًا من أي مخاطر على الطلاب (مثل الأسطح الساخنة). ويشمل المطبخ المساحات التالية:
- منطقة تحضير الطعام مع حوض خضروات.
- منطقة غسيل الأطباق / الأواني ومصيدة شحوم موجودة في الخارج.
- على مستوى النظام المنسق، يتم تضمين حوض مكون من 4 حجرات مع جهاز التخلص من القمامة.
- يجب أن تكون أبعاد حوض المغسلة كافية لأحواض الخبز ذات الألواح الكاملة.
- منطقة الطهي / التحضير / التقديم مع مغسلة يدوية وموزع صابون، وموزع المناشف الورقية - مثبت على السطح، من الفولاذ المقاوم للصدأ، وعملية رافعة (تستقبل مناشف لفة).
- معدات التخزين البارد والساخن.
- غرفة التجميد / الثلجة مع رفوف سلكية. إخفاء خطوط الصرف، أو تحديد موقع خارج مناطق المرور.
- تضمين 2 إلى 4 ناقلات للطعام الساخن.

- توفير وحدات وصول للأطعمة الساخنة مزودة برفوف عالمية.
- يتم توفير وحدات تمرير للأطعمة الباردة مزودة بوحدات أرفف ذات رفوف سلكية.
- تخزين جاف.
- توفير عرض للأبواب للسماح بعربات التدحرج.
- يجب أن يكون قادرًا على الحفاظ على درجة حرارة تتراوح بين 50 - 70 درجة.
- مرحاض للموظفين مع منطقة منفصلة لخزائن الموظفين وغسالة كهربائية / وحدات تجفيف.
- مطبخ الحمام يجب أن يكون به باب أقرب.
- حدد موقع خزائن الموظفين خارج مرحاض المطبخ، وليس داخل الحمام.
- مكتب بهاتف وفاكس وبيانات. وفر نافذة لعرضها في المطبخ.
- منطقة الحراسة في المطبخ مع حوض ممسحة. توفير رف للنظام الكيميائي.
- خط التقديم.
- الأرضيات والجدران والسقوف والأبواب يجب أن تكون قابلة للتطهير.
- يتم توريد الصلب غير القابل للصدأ خلف مناطق الطهي والغسيل (من الأرضية إلى السقف أو حتى ارتفاع الجهاز). استخدم الألواح المقواة بالألياف الزجاجية (FRP) على الجدران المتبقية حتى 8 أقدام في جميع أنحاء المطبخ.

5. الملاعب ووسائل الراحة الأخرى:

- موقع الملعب:
- يجب أن يكون موقع الملعب مناسبًا للطلاب مع مراعاة السلامة. وتوفير أشجار الظل بالإضافة إلى هياكل التظليل الدائمة، إن أمكن، وتشمل مقاعد وطاولات في منطقة الظل المثبتة على الرصيف أو الأرض.
- ساحة رياض الأطفال:
- توفير روضة أطفال منفصلة ومسيجة و / أو ملاعب لمرحلة ما قبل الروضة في مكان قريب من المبنى مع المعدات المناسبة التي تتناسب مع استخدام رياض الأطفال. وتوفير مسار دائري للدراجة ثلاثية العجلات وتخزين خارجي لمعدات اللعب.
- سلامة الملاعب:
- توفير طرق يمكن الوصول إليها لمناطق اللعب. وتوفير مواد ردع لألواح التزلج على جميع الجدران المنخفضة، والأرصعة، والمقاعد.
- مناطق اللعب ذات الأسطح الصلبة:
- يجب أن تشمل المناطق: وسادة خرسانية واحدة مع مرمى كرة سلة (ارتفاع منخفض) إذا سمحت المساحة بذلك. ومنطقة لعب الأسفلت بخطوط لعبة مطلية. ومضمار مسطح للركض / المشي. وملعب العشب. والإشراف على الملاعب حيث يجب أن تكون مواقع الملاعب ذات خطوط رؤية جيدة للإشراف الجيد.

صحة الطالب في المدرسة:

1. صحة الطالب الفردية وأهميتها ومراقبتها:

يستغرق دوام التلميذ اليومي في المدرسة فترة تتراوح بين ست وثمان ساعات، ما يستوجب من إدارة المدرسة وقسم الطب الوقائي فيها، أو ما يعرف حالياً بالصحة المدرسية، تأمين رعاية صحية داخل حرم المدرسة، تبدأ عند وصول التلميذ إلى الملاعب لتنتهي على مقاعد الدراسة، مروراً بفترات الفرص القصيرة حتى خروجه من المدرسة.

يفضل تخصيص ملاعب مسقوفة لصفوف الروضات والحضانة لالتقاء تقلبات الطقس، ومفروشة بنوع من الموكيت الطري لمنع تزلج الأطفال لتجنب الكسور والصدمات؛ هذا طبعاً مع المحافظة على النظافة العامة للملاعب.

من ناحية أخرى تبدو المراقبة الصحية الدائمة لكافيتيريا أو بوفية المدرسة ضرورية إذ يتوجب على القائمين على شؤونها والذين يبيعون المأكولات السهر على نظافة اليدين وتقليم الأظفار وارتداء قفازات وقبعة على الرأس وعدم تعريض المأكولات للهواء منعاً لتلويثها عن طريق الذباب أو الحشرات مع العمل على القضاء عليها. هذا إلى حفظ المأكولات سريعة الفساد في البرادات، مع مراقبة انتهاء مدة صلاحية الأصناف المغلفة منها.

من المهم جداً السهر على نظافة وتعقيم خزانات مياه الشفة التي يشرب منها التلاميذ يومياً في المدرسة، والقيام بمراقبتها دورياً مع إضافة المواد المعقمة تفادياً لأي تلوث أو عدوى، ويفضل استعمال حنفيات الشرب الخاصة التي توفر الماء على شكل نافورة مباشرة إلى الفم، للوقاية من تفشي العدوى بين التلاميذ.

أما تلاميذ صفوف الروضات والحضانة فتجب مرافقتهم من قبل حاضنات الأطفال إلى المراحيض ومراقبتهم لمنعهم من الشرب من حنفيات دورات المياه والوقاية في الوقت نفسه من السقوط أو التعرض لأي خطر.

إلى ذلك من المهم الطلب من الموظف المسؤول عن النظافة العامة في المدرسة، الانتباه إلى تأمين قواعد النظافة الدائمة في المراحيض ودورات المياه ورش المبيدات منعاً لتكاثر الحشرات واستخدام المطهرات تفادياً لانتشار الجراثيم بين التلاميذ.

ومن الأهمية بمكان توفير الإنارة اللازمة داخل الصفوف - كماً ونوعاً - لتأمين الرؤية الواضحة تجنباً لأي إصابة في النظر مع الوقت. والسهر على تهوية الصفوف دورياً للمحافظة على جو سليم وصحي داخلها.

ينبغي التأكد من سلامة وراحة الطاولات ومقاعد الجلوس بشكل لا يعيق حركة التلميذ ويحافظ على صحة عموده الفقري، لأن أي وضعية جلوس بطريقة خاطئة أو محشورة قد تعرض الطفل لإصابة سلسلة فقرات ظهره بالاعوجاج، كما يحصل أيضاً مع الوزن الزائد لمحفة التلميذ عندما ينوء تحت ثقلها.

من أهم مسؤوليات المدرسة أيضاً، العمل بشكل دائم ومنتظم للوقاية من انتشار الأمراض داخلها، من خلال الطلب من كل تلميذ تغيب عن المدرسة لدواع مرضية، تزويد الإدارة بتقرير من الطبيب المعالج، مشخصاً المرض ومعللاً سبب التغيب؛ وفي حال حصول عدوى داخل الصف الواحد لمرض معين، يرسل التلميذ المصابون إلى بيوتهم للعزل الصحي، العلاج والراحة، ليعاودوا الدوام بعد الشفاء. ونضرب مثلاً على ذلك ما كان يجري منذ بضع سنوات عند الإصابة بمرض جذري الماء، وكان اللقاح قد أدخل حديثاً، حيث ينتشر

المرض بشكل واسع في المدارس، أما الآن فقد خفت نسبة هذا المرض بطريقة ملحوظة بعد التلقيح وخفوت نسبة الإصابات بين التلاميذ وتدنيها إلى نسبة 10 % بعد أن كانت 30 - 35 %، لأن عملية التلقيح تحمي التلميذ من المضاعفات الخطيرة (التهاب الدماغ) في بعض الحالات النادرة، وتؤمن للطالب عدم الغياب عن متابعة الدروس والعطاء المدرسي، نظراً لطول فترة النقاهة التي تعقب الإصابة.

كما يفضل أن تعتمد إدارة المدرسة وبالتنسيق والتشاور مع طبيب الصحة المدرسية المعتمد لديها، القيام بإرسال النصائح والإرشادات الصحية للأهل، وإنزالها على صفحة موقع المدرسة على الأنترنت، عند حصول وباء عام في البلد (وهذا ما حصل خلال وباء الأنفلونزا أخيراً) وليس في المدرسة فقط؛ نصائح تنبه الأهل لعلامات المرض وسبل الوقاية، وتطلب منهم استشارة طبيبهم المعالج، في حال حصول إصابة بين أفراد العائلة.

الوقاية من الأمراض التي تشاهد في المدارس:

يعد الحفاظ على صحة الأطفال والكبار الذين يعتنون بهم هو هدف للمعلمين والأسر ومسؤولي الصحة العامة والمهنيين الصحيين. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل البقاء بصحة جيدة تحدياً. واحد من هؤلاء هو ذلك عندما يدخل الأطفال لأول مرة سواء إلى المركز أو في دار رعاية الأطفال الأسرية، فإنهم يتعرضون للمزيد الأمراض المعدية مما كانت عليه عندما تم الاعتناء بهم بشكل فردي. قد يكون هذا هو أول تعرض لهم لبعض الجراثيم التي تسبب التهابات شائعة.

المعلمون / مقدمو الرعاية الذين يعملون مع مجموعات من الأطفال غالباً ما يكون لديهم المزيد من الإصابات في السنة الأولى من العمل من البالغين الآخرين الذين لا يشاركون في الرعاية الأطفال الصغار. زيادة تواتر الالتهابات عادة ما يتحسن الأطفال والبالغون بشكل ملحوظ في السنة الثانية من العمل مع الرعاية الجماعية. ومن طرق انتقال العدوى:

- الجهاز التنفسي.
- لمس الأشخاص أو أغراضهم.
- الطريق الفموي.
- طريق الإطراح.
- اللعب، الدم، البول.

يتعلم الأطفال في رعاية المجموعة التفاعلات الاجتماعية المرغوبة مع الأطفال الآخرين والبدء في دمج آمن والروتين الصحي. ومع ذلك، فإن الأطفال الصغار فضوليون وكثيراً ما تلمس بعضها البعض والأسطح البيئية ويضعون أيديهم في أفواههم وأنوفهم.

يتم الاعتماد على مقدمي الرعاية البالغين في دمجهم وتعليمهم تدابير مكافحة العدوى والوقاية مثل الإعداد والحفاظ على بيئة آمنة، وتطبيق النظافة المتكررة لليدين، والتقليل من التلوث أثناء تغيير الحفاضات والمرحاض.

العيادة الطبية المدرسية:

تشكل الصحة المدرسية إحدى دعائم الطب الوقائي الذي يشهد تطوراً سريعاً في عصرنا الحاضر، محاولاً التخفيف من إصابة عدد كبير من الأمراض أو الوقاية من تداعياتها، مستنداً في ذلك إلى التقدم العلمي والبحثي في مجالات علوم الأحياء والتكنولوجيا.

تبرز أهمية الطب الوقائي المدرسي، أو الصحة المدرسية كما يعتمد كمصطلح حالياً، في الدور الذي يؤديه من ناحية مراقبة صحة التلميذ داخل المدرسة. فهو يحاول تأمين البيئة الصحية السليمة الخالية من عدوى الأمراض ومن الملوثات، وذلك من خلال المحافظة على قواعد النظافة العامة، ومراقبة اللقاحات والوقاية من الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ، تضاف إلى كل ذلك مهمته الإرشادية للأهل.. من هنا تكمن أهمية وجود الأطباء المتخصصين في الصحة المدرسية داخل كل مدرسة مع تأمين الهيكلية الكاملة لتحقيق هذا الهدف.

شمل هذه الهيكلية طبيباً وممرضة وقسماً ترميضياً مؤلفاً من عدة غرف مجهزة بمعدات عيادة طبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، إلى غرفة مجهزة بسرير أو أكثر للحالات الطارئة التي تستدعي الراحة أو الاسترخاء، بانتظار نقل التلميذ المتوكل إلى الطوارئ في أقرب مستشفى، أو المستشفى الذي اختاره الأهل حسب ما أشاروا في الإضبارة عند تسجيل ولدهم في المدرسة، أو انتظار وصول الأهل إلى المدرسة لاصطحاب ولدهم المريض.

عمل الطبيب والمساعد الصحي في الصحة المدرسية:

يعتمد الفحص الطبي المدرسي، السنوي أو الفصلي، حسب المدارس، على إخضاع جميع التلاميذ ومن كل المستويات لفحص سريري يهدف إلى اكتشاف أي علة أو عاهة، ليصار بعدها إلى إعلام الأهل بضرورة متابعتها من خلال مراجعة طبيب الأطفال المتابع أو طبيب العائلة، أو طبيب أخصائي لحالات خاصة (مشكلة في النظر، اعوجاج في العمود الفقري...). أما الأمراض التي يسعى طبيب المدرسة إلى إدراكها في الفحص الطبي المدرسي فهي:

- تسوس الأسنان، وهي آفة متفشية في كثير من المجتمعات، خصوصاً لدى تلامذة الصفوف الابتدائية، وقد بدأ الأهل منذ سنوات يستجيبون للنصائح الطبية من ناحية العناية بأسنان الحليب، لاعتقادهم فيما مضى أن هذه العناية لا تنفع طالما أن الطفل سيبدل أسنانه فيما بعد، لذا نلاحظ حالياً التدني الملحوظ بإصابة الأسنان بالتسوس بين تلاميذ المدارس، بعدما كانت هذه الإصابات تشكل من 15 إلى 30 % (حسب المستوى الصحي والاجتماعي).
- خلل في النظر، كقصر النظر مثلاً، الذي يأتي بالدرجة الثانية بعد تسوس الأسنان من حيث الإصابات الشائعة، وقد شكل نسبة 15 إلى 20 % فيما مضى، وهو في عصرنا الحاضر على ازدياد مضطرد، برغم العناية، وهو عائد إلى مدة فترات الجلوس الطويلة أمام التلفاز والإبحار الطويل المدى في مواقع الأنترنت والفيديو... وغيرها من تقنيات العصر الحديث! لذا يفضل تصحيح الخلل باكراً كي لا يتفاقم ويؤثر على قدرة التلميذ على الاستيعاب وأثره على عطائه المدرسي فيما بعد.
- فحص القلب، للتأكد من عدم وجود أية نفخة قلبية، ربما تكون فيزيولوجية من دون أي علامة مرضية أو مضاعفات لاحقة تؤثر على نمو الطفل أو نشاطه البدني أو المدرسي. وهذا الخلل الوظيفي معروف عادة من قبل طبيب العائلة، وقد تكون النفخة القلبية مكتسبة وناتجة عن مضاعفات مرضية (منها

وأهمها الالتهاب البكتيري الحاد في اللوزتين والذي لم يعالج بشكل صحيح، واكتفى الأهل بمعالجة ولداهم ذاتياً دون استشارة الطبيب، وقد تؤدي مضاعفات هذه الحالة إلى إصابة أحد صمامات القلب). ومن الإصابات القلبية الأخرى التي يمكن لطبيب المدرسة أن يكتشفها، عدم الانتظام في ضربات القلب، أو تسرع النبضات بغياب أي جهد جسدي أو علامات مرضية أو انفعال عصبي أو نفسي، مما يشير إلى خلل عضوي في القلب أو في غيره من الأعضاء (كالإفراط في إفراز هرمون الغدة الدرقية على سبيل المثال).

- فحص العمود الفقري للتأكد من عدم وجود أي اعوجاج على مستوى فقرات الظهر والأكثر شيوعاً حالة الجنف. ومن الملاحظ الازدياد في نسبة هذا الخلل نتيجة ثقل وزن الحقيبة المدرسية في أغلب الأحيان، مما يؤدي مع الوقت إلى هذا الاعوجاج وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية لاحقة على وظائف القلب والرتنين.
- التفصي عن أمراض معدية أخرى كانتشار القمل والصبيان في الصفوف أو بعض الأمراض الجلدية، والمحافظة على نظافة الأظفار وتقليمها دورياً. هذا ما يمكن أن تقوم به الممرضة في زياراتها الدورية للصفوف.
- اكتشاف بعض حالات النقص في السمع من خلال مراقبة واستنتاجات المعلمين والمعلمات للتلاميذ في الصف.
- مراقبة نمو التلميذ (من خلال الوزن والطول) واستنتاج سوء التغذية، أو فقر الدم، أو اكتشاف مرض من أمراض العصر الحديث كالوزن الزائد الناتج غالباً عن تناول وجبات الأكل السريع وما يستتبع ذلك من أمراض السمنة التي يمكن أن تؤدي مستقبلياً إلى مضاعفات بيولوجية خطيرة أو مرض السكري، أو إصابة القلب والشرابين والدماغ لاحقاً.
- التأكد من حصول التلميذ على جميع اللقاحات اللازمة والطلب من الأهل (من خلال الرجوع إلى الملفات الصحية المدرسية للتلاميذ بصورة دورية) بضرورة تحصين أولادهم (جرعات أو حقن تذكيري) ضد شلل الأطفال والكزاز خاصة، ومراجعة طبيب العائلة عن مواعيد التلقيح التذكيري.
- يسترعي انتباه طبيب المدرسة إلى بعض العلامات الظاهرة للعيان والتي لها علاقة بالنمو العضوي والجنسي للطلاب والطالبات، وهي علامات خارجية تنم عن اضطرابات أو تأخر فيما يخص عملية البلوغ، ويبدو من خلال التأخر في جهورية الصوت أو عدم بروز شعر الذقن لدى الذكور في سن 14 - 15 عاماً؛ وغيرها من العلامات التي تطبع أثرها على عملية الإنجاب أو العقم في بعض الحالات في فترة لاحقة من العمر؛ كما يلاحظ الطبيب كثافة الوبر أو الشعر في مناطق محددة من الجسم لدى الفتاة في هذا العمر، إلى جانب انتشار بثور حب الصبا في الوجه وعلى مستوى الظهر وبشكل لافت للنظر، وغيرها من الظواهر ذات العلاقة بوظيفة المبيض والهرمونات التي يفرزها، ما يطبع أثره السيئ على عملية الإنجاب لدى الفتيات في بعض الحالات مستقبلاً. وعلى طبيب المدرسة إرسال ملاحظاته هذه إلى الأهل كي يراقبوا ويتابعوا وضع أولادهم في هذا المجال لدى طبيب العائلة أو الطبيب المختص.

دور المطعم في الصحة المدرسية:

عندما نتحدث عن دورة الحياة عند الإنسان، إنما نشير إلى أهمية التوازن المتوجب أخذه في الاعتبار بين نشاط الجسم، أكان جسدياً أو فكرياً أو نفسياً، وبين فترة الراحة اللازمة للمثابرة ومتابعة العمل بعدها. وهذان

الأمران، النشاط والراحة، هما على علاقة وثيقة بعامل التغذية المتوازنة كما ونوعاً وذلك من أجل الاكتفاء بالضرورات الغذائية اليومية للجسم وحاجاته الوظيفية.

هذه الأمور الثلاثة: النشاط - الراحة - التغذية، تمثل ركيزة مثلثة القوائم للدورة البيولوجية لأجسامنا والتي تدعى: **الدورة اليومية**، المتأتية عن تناوب وتواتر فترات النهار والليل، وهذه العوامل الثلاثة تتفاعل فيما بينها ويتأثر بعضها ببعضها الآخر، حتى أن حصول خلل أو نقص ما في أحدها يؤدي إلى اضطرابات تترك بصماتها على العطاء المدرسي للتلميذ، ونعني خصوصاً نوعية العمل وقدراته (نوعية النوم والراحة، تصرفات التلميذ والاضطراب في العلاقات مع أهله في البيت وأترابه في المدرسة..).

إن إلقاء نظرة على الغذاء الصحي السليم، يظهر لنا مدى أهمية التغذية المتوازنة والمنظمة، كي تفي بحاجاتنا اليومية من السعرات الحرارية، وكل بحسب نشاطه، ومن خلال هذا الغذاء ينبغي تأمين المواد الأولية الضرورية التي يتكون منها جسم الإنسان وهي:

- مائيات الكربون المتمثلة بالمواد السكرية والنشويات الموجودة في كثير من مصادر التغذية كالحبوب (القمح، الذرة، الأرز..)، الخبز، المعجنات، السكر، الفواكه والمربيات... ونسبة هذه المواد الواجب احتواؤها في الوجبة اليومية للتلميذ هي بحدود 50 - 55 % من موارد الطاقة اللازمة للجسم.
- المواد الدهنية الموجودة في الزيوت، السمن، الزبدة، الحليب ومشتقاته من الأجبان، البيض والدهون الحيوانية.. والتي تمثل ما مجموعه 25 - 30% من المورد الغذائي اليومي.
- الأحماض الأمينية والتي تشكل مجموعة البروتينات، حيث تتربط بعضها ببعض لتؤلف سلاسل متواصلة وتدخل في تكوين جسمنا (العضل والأعضاء وغيرها)، نجدها خصوصاً في اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الحبوب (كالفول والفاصوليا).
- يضاف إلى هذه العوامل الثلاثة الرئيسية، مادة الحياة الأولى وهي الماء، ما يتوجب المحافظة على الكمية اليومية المستهلكة منها للإبقاء على وظائف الجسم البيولوجية (الداخلية منها والخارجية)؛
- الفيتامينات والأملاح المعدنية (الصوديوم، المكون الأساسي لمالح الطعام، كالسيوم، بوتاسيوم، منغنيز، حديد، نحاس، زنك، يود، فلور) التي تنساب إلى الجسم من خلال الوجبات اليومية وهو بحاجة إليها بكميات فائقة الندرة، وكما هي مواد ذات قيمة وضرورية لحياتنا الفيزيولوجية.

من هنا نستنتج أهمية التغذية المنتظمة، المتنوعة والمتكاملة للتلميذ ليتمكن من تأمين الكمية اللازمة من السعرات الحرارية لتغطية النشاطات الجسدية والفكرية خلال يومه الدراسي؛ ويبدأ ذلك بتناول وجبة الفطور الصباحية، بعد النهوض من النوم وقبل الذهاب إلى المدرسة، على أن تكون هذه الوجبة مدروسة بشكل علمي وعلمي ما يحرر التلميذ من تكرار شراء المأكولات السريعة التحضير، والمشكوك بنوعيتها أو قيمتها الغذائية.

الصحة الريفية

مقدمة:

تشمل التمثيلات العالمية للريف: البرية، والمناطق النائية، والقرى، والأدغال، أو المساحات المفتوحة، وجميعها ترتبط بمفهوم المجتمع. يعتمد ازدهار المجتمع الريفي على فهم المواجهات الريفية الاجتماعية والثقافية والديموغرافية والاقتصادية والفريدة.

من الواضح أن المحددات الاجتماعية للصحة، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، عوامل مهمة تشكل النتائج الصحية، بما في ذلك أفراد المجتمع الذين يشاركون في استجابات إبداعية لتنمية المجتمع. ويُعدّ متعلمو التمريض أحد هؤلاء المشاركين المنخرطين في تنمية المجتمع، والذين أثبتت مساعيهم الإبداعية فائدتها للمجتمعات الريفية. ويسترشد عملهم بنموذج تقييم الصحة المجتمعية والتعليم المستدام.

تفسيرات الريف:

هناك تمثيلات عديدة للريف، وتشمل هذه التفاعل مع الطبيعة؛ والحياة الزراعية، بما في ذلك الحيوانات؛ والمساحات الزراعية؛ والمساحات المُستأنسة والبرية. تُفهم المناطق الريفية على أنها مُنتجة، على سبيل المثال، لإنتاج الغذاء والوقود والمعادن. كما تُفسّر الزراعة ونمط الحياة الصحي البسيط، والهواء النقي، والعزلة على أنها جوانب إيجابية للإنتاج الاقتصادي المرتبط بالأرض. تُعدّ الأسرة محورًا مهمًا آخر في الإنتاج الاقتصادي، حيث يعيش أفرادها ويعملون بالقرب من بعضهم البعض.

كما أصبحت المناطق الريفية مناطق ترفيهية، وأماكن لقضاء العطلات، ومساحة للاستمتاع بحياة أكثر هدوءًا. ترتبط أفكار المغامرة والاستجمام والحرية بالريف، وتتجلى في سياحة المغامرات. وتُعرف أيضًا بمصطلح "الريف". ومن الجوانب الإيجابية المرتبطة بالريف الشعور القوي بالانتماء للمجتمع.

تُبنى المجتمعات الريفية من خلال سياقها الريفي، وسكانها، ومعانيها المجتمعية، وممارساتها، ومساحتها. الأماكن الريفية تتجاوز مجرد مواقع جغرافية؛ فهي تمتد من العلاقات الاجتماعية والإنسانية إلى العلاقات غير الإنسانية.

المجتمعات الريفية:

يتشابك المجتمع والمكان باستمرار. وتنطوي المجتمعات على علاقات اجتماعية قائمة باستمرار في الأماكن، مع تطور التفاعلات وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين الناس. وترتبط هذه العلاقات الاجتماعية من خلال العائلة والأصدقاء والوظائف والولاء المتبادل، بالإضافة إلى عضوية المجتمع. وتستند العلاقات الاجتماعية إلى روابط الصداقة والقربة الشخصية، والاستقرار بين الأجيال، وحالة من التقارب مع التفاعلات المفيدة المرتبطة بها. ويعطي المكان صورة إيجابية مرتبطة بالريف، وشعورًا بالانتماء والتماسك الاجتماعي فيما يتعلق بمجتمعات السكان بناءً على مكان إقامتهم، لذا فإن مفهوم المجتمع بحد ذاته يتلاءم بشكل أفضل مع الإطار الريفي منه الحضري. نادرًا ما نسمع مصطلح "المجتمع الحضري".

المجتمعات هي مساحات من الشبكات الاجتماعية حيث يعمل السكان ويعيشون ويلعبون، ويرتبطون ببعضهم البعض من خلال روابط والتزامات ومسؤوليات مشتركة. كما أنها أماكن يعيش فيها أشخاص، بخلاف سكان الريف؛ والمجتمعات الريفية هي أماكن يزورها غير الريفيين لقضاء العطلات والترفيه.

يرتبط مفهوم المجتمع عمومًا بالأشخاص الذين يتشاركون قيمًا ومعتقدات متشابهة، تجمعهم معًا في قضية مشتركة. تشمل المجتمعات الريفية سكان الريف كمجموعة اجتماعية، ولا يعني وجود مجموعة اجتماعية أن جميع الناس يتشاركون القيم نفسها، إذ توجد مجموعة متنوعة من الآراء بين سكان الريف؛ وقد يحدث الصراع والتماسك. تُعرف المجتمعات الريفية بأنها تحمل دلالات سلبية وإيجابية، ويعتبر الريف أحيانًا متخلفًا، على عكس الصور الإيجابية المرتبطة بـ"الريف المثالي"، ويشار إلى أن البيئة تُعدّ مكانًا جذابًا ورومانسيًا للعيش فيه أو زيارته من قبل الغرباء.

تشمل الخصائص الإيجابية التماسك المجتمعي، الذي يربط بالعمل الجماعي الاجتماعي والنشاط في المناطق الريفية. بالإضافة لوجود شعور أكبر بالتماسك كلما أصبحت المجتمعات الريفية أكثر بُعدًا عن المراكز الحضرية. فالبعد المكاني يبني المرونة والاعتماد على الذات بين سكان الريف ويعزز استدامة المجتمع.

صحة سكان الريف:

يُشكل سكان الريف ما يقرب من نصف إجمالي سكان العالم. وتواجه هذه المجتمعات الريفية صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية، وصعوبة في الوصول إلى الخدمات التخصصية في المستشفيات الجامعية الحضرية. ويعاني سكان المناطق الريفية من زيادة في أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة والسكتة الدماغية، أو يموتون بسبب إصابات إضافية غير مقصودة. ويميل السكان الأصليون إلى التعرض لمعدلات أعلى من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري والربو وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة واضطرابات الصحة العقلية، مقارنةً بسكان المناطق الحضرية.

توفير الرعاية الصحية الريفية:

يتعرض توفير خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية للخطر. ويُعد هذا التهديد مصدر قلق عالمي، وقد تم الاعتراف به على مدار العقود الماضية. ووفقًا لشبكة WONCA الريفية (وهي شبكة نشطة تضم أطباء الأسرة الريفيين والأكاديميين الريفيين من جميع مناطق العالم)، يُعد الحصول على الرعاية الصحية القضية الرئيسية في مجال الصحة الريفية حول العالم. وتشمل العوائق للوصول للخدمات الصحية محدودية الوصول إلى وسائل النقل، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق، ومحدودية الاتصالات، بما في ذلك تغطية الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت عريض النطاق.

قد يواجه سكان الريف كل هذه العوائق أو بعضها في محاولاتهم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ويتفاقم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب انخفاض عدد ممارسي الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى نقص الممارسين ذوي الخبرة، وما يقابله من نقص في التخطيط الريفي والتمويل المخصص. على مستوى العالم، هناك توزيع غير متكافئ للعاملين في مجال الصحة لكل فرد من السكان في المناطق الريفية، مقارنةً بالمناطق الحضرية. ويتمثل التحدي الذي يواجه الأطباء والمرضات والقابلات والصيادلة الريفيين،

الذين يشكلون معظم المهنيين الريفيين الممارسين حالياً، في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وتسهيل الضوء على هذه القضايا أمام مخططي الصحة والهيئات التنظيمية والحكومات على مستوى العالم. غالباً ما يفترض مخططو الرعاية الصحية أن خدمات وسياسات الرعاية الصحية المُصممة للبيئات الحضرية يمكن تكييفها بسهولة مع المناطق الريفية، معتقدين أن الفارق الوحيد يكمن في توزيع السكان. وبالمثل، تعد موارد الرعاية الصحية لسكان الريف مركزة على البيئات الحضرية، وهذه الحقائق تثير مخاوف كبيرة لدى ممارسي الرعاية الصحية الريفية، الذين يسعون إلى تعزيز تخطيط خدمات الرعاية الصحية الريفية، ويشترطون أن يتم توزيع الموارد بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية للمجتمعات الريفية الفردية والحواز المرتبطة بها عند الوصول إلى الرعاية الصحية.

المجتمعات الريفية والتثقيف الصحي:

يُؤلّد تركيز نموذج CHASE على المجتمعات الريفية وعلى الاحتياجات الصحية للمجتمع اعتبارات إضافية لمتعلمي التمريض. تتطلب ممارسة التمريض الريفي من الممرضات تقديم خدمة صحية سريعة الاستجابة ومبتكرة وتعاونية. علاوة على ذلك، وفي كثير من النواحي، تُعيد مشاركة متعلمي التمريض في هذه المشاريع المجتمعية الريفية النظر إلى المعلم كميسّر، في شراكة متساوية مع ميسّري التمريض الريفيين المحليين كأصحاب مصلحة في المجتمع.

الصحة المهنية

مقدمة:

تم إدخال وتطوير تشريعات الصحة والسلامة على مر السنين لتشمل مجموعة شاملة من:

- القوانين.
- اللوائح.

غالبًا ما يُدعم هذا التشريع بمجموعة شاملة ومفصلة من قواعد الممارسة والتوجيهات المعتمدة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة (HSE). وعلى أصحاب العمل واجبات عامة تجاه: الموظفين؛ غير الموظفين الذين قد يتأثرون بأنشطة عمل صاحب العمل، مثل الجمهور أو المقاولين الذين قد يقومون بأعمال نيابة عن صاحب العمل.

تُحدد المسؤوليات بموجب القانون والتشريعات الفرعية أحيانًا بعبارة "بقدر الإمكان". هذا يعني أن على صاحب العمل موازنة المخاطر التي يتعرض لها الموظفون بالوقت والجهد والنفقات اللازمة للسيطرة على تلك المخاطر. يتحمل العاملون لحسابهم الخاص واجبات تجاه أنفسهم وتجاه الأشخاص الذين قد يتأثرون بأنشطتهم العملية. ويتحمل الموظفون مسؤوليات مماثلة. يتحمل الأشخاص الذين يتحكمون في المباني، مثل الملاك أو وكلاء الإدارة، مسؤولية ضمان سلامة ما يلي:

- المباني ووسائل الوصول والخروج؛ أي معدات أو منشآت متوفرة في مكان العمل، مثل المصاعد أو إضاءة الطوارئ. يتحمل المصنعون والموردون والمصممون والمستوردون، وغيرهم، واجبات ضمان سلامة أي مواد أو سلع، بقدر الإمكان، عند استخدامها في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم ضمان توفر معلومات كافية للمستخدم لتمكينه من استخدامها بأمان. يُنفذ إجراءات الصحة والسلامة مفتشو الصحة والسلامة، الذين يعملون إما لدى الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة أو المجلس المحلي. ويتمتع المفتشون بصلاحيات واسعة، منها:
 - إصدار إشعارات التحسين التي تتطلب إجراء تحسينات؛
 - حظر ممارسات العمل غير الآمنة؛
 - مصادرة المواد أو الأشياء.
- قد تُفرض المخالفات إلى غرامات باهظة. أما العقوبة القصوى في حال نظر القضية في محكمة الصلح فهي غرامة غير محدودة أو السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (أو كليهما).

القوانين واللوائح:

يُسنّ البرلمان البريطاني القوانين واللوائح، ويفرض على الأفراد واجبات صارمة. ويُعدّ عدم الامتثال لهذه المتطلبات جريمةً جنائية.

مدونات الممارسات المعتمدة:

تُصدر مدونات الممارسات المعتمدة (ACOPs) من خلال الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة، وتُقدّم إرشادات حول كيفية الامتثال لمتطلبات مُعيّنة من القوانين أو اللوائح. ورغم أنها لا تتمتع بقوة القانون، إلا أنه يُمكن استخدامها لتوضيح ما يجب على صاحب العمل فعله لأداء واجباته. في حال عدم الامتثال لمدونة

الممارسات المعتمدة، يتعين على صاحب العمل إثبات اتخاذ تدابير فعّالة بنفس القدر لأداء واجبه. لذلك، ولأغراض عملية، يُعتبر مدونات الممارسات المعتمدة امتداداً للقانون.

ملاحظات إرشادية:

تُصدر الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة الملاحظات الإرشادية، وتحتوي على نصائح وإرشادات حول كيفية الامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة، ولكن ليس لها صفة قانونية. عادةً ما تعكس الإرشادات الواردة في هذه الوثائق الممارسات الصناعية الجيدة، ولذلك ينبغي على أصحاب العمل اتباعها. لا يحمي الالتزام بهذه الإرشادات بالضرورة صاحب العمل من الملاحقة القضائية، مع أن مثل هذه الإجراءات نادرة. في حال عدم التزام صاحب العمل بالإرشادات الواردة في هذه الوثائق، ينبغي اتخاذ تدابير بديلة وفعالة بنفس القدر للسيطرة على المخاطر.

القانون المدني:

بالإضافة إلى المتطلبات القانونية، يتعين على أصحاب العمل ضمان الصحة والسلامة وفقاً للقانون المدني، حيث يتعين عليهم واجب الرعاية تجاه الموظفين وغيرهم ممن قد يتأثرون بأنشطتهم العملية. يمكن تحميل أصحاب العمل المسؤولية بموجب نوعين من المسؤولية:

- 1- المسؤولية الفعلية: حيث يكون صاحب العمل مسؤولاً بشكل مباشر عن أفعاله أو تقصيره.
- 2- المسؤولية التبعية: حيث يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفعال مرؤوسيه (مثل الموظفين) حيث تكون هذه الأفعال أو التقصيرات إهمالاً. يجب أن يكون المرؤوسون ضمن نطاق عملهم، ويجب ألا يكون الموظفون في "مقامرة" خاصة بهم. يجب أن تكون هناك صلة بين واجبات الموظف والجريمة. لذلك، يظل صاحب العمل مسؤولاً إذا كان صاحب العمل يؤدي واجباته بطريقة غير مصرح بها.

تقتصر المسؤولية على مصطلح "القدرة المعقولة على التنبؤ". لا يوجد تعريف تشريعي لهذا المصطلح، ولكن هناك العديد من السوابق القضائية التي سعت إلى تعريفه.

الواجبات العامة لأصحاب العمل:

يتعين على صاحب العمل الالتزام ليس فقط بالواجبات العامة الواردة في قانون الصحة والسلامة في العمل، بل أيضاً بالعديد من الأحكام القانونية ذات الصلة. الواجبات العامة المفروضة على أصحاب العمل هي:

- ضمان صحة وسلامة ورفاهية الموظفين؛
- توفير المعدات وما إلى ذلك مجاناً؛
- تقديم بيان مكتوب لسياسة الصحة والسلامة؛
- تشكيل لجان السلامة (في الحالات المحددة)؛
- ضمان صحة وسلامة الآخرين المتأثرين بأنشطة العمل.

الواجبات العامة للأشخاص المسؤولين عن إدارة المباني:

تشمل هذه الواجبات ضمان ما يلي:

- أن تكون المباني آمنة وخالية من المخاطر الصحية؛
- أن تكون جميع وسائل الدخول والخروج آمنة وخالية من المخاطر الصحية؛
- أن تكون جميع المعدات أو المواد المخصصة للاستخدام في المباني آمنة قدر الإمكان عملياً وخالية من المخاطر الصحية.

إذا كان على الشخص التزام بموجب اتفاقية أو عقد إيجار يُعامل هذا الشخص بصفته "المسؤول" بما يلي:

- صيانة أو إصلاح هذه المباني؛
- أن تكون وسائل الدخول والخروج من هذه المباني؛
- أن تكون سلامة المعدات أو المواد في هذه المباني،

وتشمل هذه الواجبات أي شخص يزاول مهنة أو مشروعاً، سواءً كان ربحياً أم لا. لهذا الواجب آثارٌ خاصة على مُلاك العقارات أو مُديرِها.

عمليات تفتيش الصحة والسلامة:

- قبل الزيارة: يجب على صاحب العمل التأكد من الامتثال لجميع الأحكام القانونية ذات الصلة، واتخاذ كل ما هو ممكن عملياً لضمان صحة وسلامة ورفاهية الأشخاص المتأثرين بأنشطة العمل. سيركز المفتشون على المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها، وسيؤكدون مما إذا تم تحقيق سيطرة فعالة على المخاطر. لذلك، يجب على أصحاب العمل التخطيط بفعالية لأي زيارة من خلال التأكد، على سبيل المثال، مما يلي:

- تحديث جميع السجلات والتقييمات؛
- وضع ترتيبات اتصال فعالة، ووعي الموظفين بمسؤولياتهم؛
- كحد أدنى، السيطرة على جميع المخاطر المهمة؛
- إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمكان العمل؛
- إجراء تدقيقات منتظمة لأنظمة إدارة السلامة؛
- الحصول على تفاصيل المذكرات الإرشادية ذات الصلة بأنشطة العمل؛
- وجود ثقافة سلامة إيجابية داخل المؤسسة.

قد يجد أصحاب العمل أنه من المفيد، في حال العمل من عدة مواقع، إعداد مجموعة من التعليمات لمديري المواقع حول إدارة تفتيش الصحة والسلامة.

- أثناء الزيارة: يجب تذكر أن للمفتشين الحق في زيارة أي منشأة في جميع الأوقات المعقولة (وفي أي وقت، إذا لزم الأمر) دون إذن قضائي. من المهم ضمان نقل الانطباعات الصحيحة للمفتش، الذي يجب معاملته بلباقة في جميع الأوقات. ومع ذلك، من حق صاحب العمل طلب الاطلاع على هويته وتقويضه. إذا تم إجراء المكالمات في وقت غير مناسب ولم يكن الشخص المناسب متاحاً، فيجب تفويض مهمة

التواصل مع المفتش إلى شخص مؤهل للتعامل مع أي مواضيع تُثار أثناء التفتيش. أثناء الزيارة يجب تفويض مهمة التواصل مع المفتش إلى شخص مؤهل للتعامل مع أي مواضيع تُثار أثناء التفتيش. عادةً ما يرغب المفتش في الاطلاع على وثائق معينة تتعلق بالصحة والسلامة داخل الشركة، مثل:

- بيان سياسة الصحة والسلامة؛
- تقييمات المخاطر لأنشطة العمل؛
- نسخ من أي تقييمات للضوضاء؛
- نسخ من أي سجلات تفتيش قانونية؛
- سجلات التدريب؛
- سجلات عمليات التفتيش الكهربائية؛
- دفاتر وسجلات الحوادث؛
- أي وثائق أخرى.

بعد اطلاع المفتش على الوثائق اللازمة، عادةً ما يرغب في القيام بجولة في المبنى. يجب أن يكون برفقته أحد كبار المديرين أو شخص مؤهل للإجابة على أسئلته. كما يُنصح بالتأكد من إبلاغ الموظفين الرئيسيين بحضوره وتواجدهم عند الحاجة. أثناء التفتيش، يرغب مفتشو الصحة والسلامة في التأكد من:

- التحدث مع ممثلي الموظفين؛
 - مشاورة صاحب العمل بانتظام مع الموظفين وممثليهم.
- لذلك، يجب على الموظفين ضمان توفير إمكانية الوصول، مثل غرفة يمكنهم التحدث فيها على انفراد. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات قد لا يكون من المناسب فيها للمفتشين مقابلة ممثلي الموظفين، بما في ذلك:
- عندما لا تؤثر النصيحة التي يقدمها المفتش على صحة الموظفين وسلامتهم.
 - في الحالات ذات الطبيعة الفنية، مع ضرورة إبلاغ الموظفين بأي معلومات ذات صلة.

إدارة إجراءات التنفيذ:

بعد انتهاء الزيارة، تتوفر للمفتش عدة مسارات عمل ممكنة، وذلك بناءً على المشكلات التي تم تحديدها وموقف الإدارة:

- تقديم نصائح شفوية وتوصيات لتحسين أداء الصحة والسلامة؛
- إصدار خطابات أو تقارير استشارية؛
- إصدار إشعارات تحسين أو حظر؛
- النظر في المقاضاة؛
- مصادرة المواد؛
- اختبار المعدات وفحصها للتأكد من سلامتها.

يعتمد الإجراء المُتخذ على نوع إجراءات التنفيذ التي اختارها المفتش. سيستخدم المفتشون "نموذج إدارة التنفيذ" الخاص بهم، والمُصمم لتوفير قدر من الموضوعية والاتساق في عملية اتخاذ القرار.

الشيخوخة ورعاية المسنين

مقدمة:

الشيخوخة هي عامل الخطر الرئيسي للإصابة بمرض السكري، والسرطان، وتصلب الشرايين، والسكتة الدماغية، والخرف، والتهاب المفاصل، وغيرها من الأمراض المزمنة التي تُشكل مجتمعةً الجزء الأكبر من الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

يُشكل كبار السن شريحة سكانية سريعة النمو، حيث تنتشر الأمراض المزمنة في كل مكان تقريبًا. ولمواجهة أعداد متزايدة من المرضى المسنين، قد يستفيد الطب الحديث من دراسة استراتيجيات تستهدف آليات الشيخوخة الأساسية. توجد الآن أدلة دامغة تدعم أن الشيخوخة ليست ثابتة. بل على العكس، يُمكن للتدخلات التي تستهدف آليات الشيخوخة الأساسية أن تُطيل العمر والصحة لدى الكائنات الحية والثدييات. هذه الآليات، بما في ذلك الشيخوخة الخلوية، والالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وتراكم الضرر الجزيئي الكبير، وخلل وظائف الخلايا السلفية، هي أيضًا آليات مسببة للأمراض المرتبطة بالأمراض المزمنة الرئيسية المرتبطة بالشيخوخة.

قد يؤدي استهداف آليات الشيخوخة الأساسية هذه إلى تأخير أو منع أو تخفيف أو عكس الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر كمجموعة، بدلاً من استهداف مرض واحد في كل مرة عند ظهوره. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لتعديل آليات الشيخوخة تأثير كبير على الصحة العامة للأفراد وتأثيرات بعيدة المدى على صحة السكان والاقتصاد.

تُلقي الشيخوخة عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا على المجتمع. وتُشكل زيادة متوسط العمر المتوقع، إلى جانب تزايد انتشار الأمراض المزمنة، عبئًا هائلًا على أنظمة الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وللعيش حياة طويلة، غالبًا ما يتعين على الأفراد تقبّل وجود مرض مزمن واحد أو أكثر، والذي يؤدي معظمه إلى سنوات من المعاناة، أو فقدان الحيوية، أو الضعف. لذلك، على الرغم من زيادة متوسط العمر في القرن الماضي، إلا أن متوسط العمر الصحي لم يزداد.

متوسط العمر الصحي هو الفترة التي يقضيها الفرد في حياة خالية من المرض أو الإعاقة، وتتميز بالاستقلالية والإنتاجية والرفاهية. يهتم كبار السن بتمديد متوسط العمر الصحي أكثر من زيادة متوسط العمر. إن القدرة على التقدم في السن بصحة جيدة من شأنها أن تُسخر الفرصة التي يُتيحها تمديد متوسط العمر. على مدار العقد الماضي، حوّل مجال بيولوجيا الشيخوخة الأساسية تركيزه نحو متوسط العمر الصحي، بدلاً من التركيز فقط على إطالة متوسط العمر. وقد دفع هذا التحول في الأولويات المجال إلى التفكير بجدية في جدوى الترجمة السريرية، والبدء في تصميم التجارب السريرية الأولية.

التقييم الشامل للشيخوخة:

التقييم الوظيفي:

يُعدّ تحديد ومعالجة القصور الوظيفي أساس التقييم الوظيفي الشامل، وذلك للحفاظ على الأداء الوظيفي وجودة الحياة. يُنبئ التدهور الوظيفي في أواخر العمر بزيادة معدلات الاعتلال والوفيات، ويُهدد القدرة على العيش باستقلالية. من أمثلة المقاييس الشاملة المُبلّغ عنها ذاتيًا للحالة الوظيفية: استبيان التقييم الوظيفي متعدد الأبعاد لموارد وخدمات كبار السن الأمريكيين (OARS)، ومؤشرات كاتز للأنشطة اليومية

المساعدة (ADL) والأنشطة اليومية المساعدة (IADL). تُوفر هذه المقاييس معلومات بالغة الأهمية تُسهم في تطوير خطط الرعاية المُركزة على الشخص.

التقييم الطبي:

يتجاوز التقييم الطبي، كجزء من التقييم الشامل للشيخوخة، التاريخ الطبي والفحص البدني التقليدي ليشمل تقييم المتلازمات الشائعة لدى كبار السن. قد يعتبر العديد من كبار السن هذه المشاكل جزءًا من الشيخوخة الطبيعية، وقد لا يلجأون إلى الطبيب دون فحص دقيق.

التقييم الاجتماعي:

بدون تقييم العوامل الاجتماعية المؤثرة في حياة كل مريض ومراعاة هذه العوامل، لن تكون التدخلات الرامية إلى تحسين الجوانب الوظيفية والطبية مثالية. يرتبط الحرمان الاجتماعي بضعف الصحة؛ وبالمثل، يمكن أن يؤثر تحسين العوامل الاجتماعية إيجابًا على الصحة.

التقييم الروحي:

تُعدّ الروحانية جزءًا مهمًا من حياة الكثيرين، وغالبًا ما تلعب دورًا محوريًا في وضع خطة رعاية تُركّز على الشخص. بالنسبة لبعض كبار السن، يمكن أن يكون وسيلةً مهمةً لمعالجة اضطرابات المزاج، والشعور بالوحدة، والحزن. تُقدّم أداة التقييم الروحي FICA أربعة أسئلة يُمكنها تقييم التاريخ الروحي للمريض بكفاءة: (1) ما هو إيمانك أو معتقدك؟ (2) هل هو مهمٌ لحياتك؟ (3) هل أنت جزء من مجتمع روحي أو ديني، و(4) كيف تُريد أن يُعالج مُقدّم الرعاية هذه القضايا في رعايتك الصحية؟. يُمكن أن يُعزّز إجراء التقييم الروحي ثقة المرضى بمُقدّمي الرعاية، مما يجعل مناقشات أهداف الرعاية أكثر فائدة.

المشاكل الصحية الشائعة لدى كبار السن:

الحركة والسقوط:

يُعد السقوط شائعًا جدًا لدى كبار السن المقيمين في المجتمع، حيث تقترب معدلات السقوط السنوية من 50% لدى المرضى مع اقترابهم من العقدين الثامن والتاسع من العمر. يساهم التقدم في السن، وتراجع الوظائف الإدراكية، وزيادة العجز الحسي في السقوط. كما أن العوامل الخارجية، مثل بيئة المنزل (ضعف الإضاءة، والمساحات المحدودة أو الضيقة للتنقل باستخدام الأجهزة المساعدة، والسجاد، وما إلى ذلك) والأحذية غير المناسبة، تزيد من المخاطر. ووفقًا لإطار عمل MS4، من المهم السؤال عن الحركة والسقوط في كل زيارة للرعاية الأولية.

الإدراك:

يُعد مرض الزهايمر (AD) الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، والذي يُمثل ما يقرب من 60-80% من الحالات. كما تُلاحظ أسباب أخرى للخرف، مثل الخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، وإن كانت أقل شيوعًا. وقد يُصاب المريض أيضًا بمرض مختلط، وخاصةً مرض الزهايمر والخرف الوعائي.

الاكتئاب:

الاكتئاب شائع جدًا، حيث يصل معدل انتشاره إلى 40% لدى كبار السن المصابين بأمراض مصاحبة مثل السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب والسرطان، ويرتبط بزيادة معدلات الإصابة والوفيات لدى كبار

السن. وعلى الرغم من انتشاره، غالبًا ما يكون تشخيص الاكتئاب في أواخر العمر غير كافٍ، وخاصةً لدى كبار السن من الرجال وكبار السن من السود واللاتينيين.

ضعف البصر:

يُبلغ عن ضعف حدة البصر لدى ما يقرب من 10% من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وما يصل إلى 15-20% لدى من تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. ويرجع ذلك في أغلب الأحيان إلى طول النظر الشيخوخي وإعتام عدسة العين، على الرغم من أن أسبابًا أخرى، بما في ذلك الجلوكوما (المياه الزرقاء)، واعتلال الشبكية السكري، والتكس البقعي المرتبط بالعمر، شائعة أيضًا لدى كبار السن.

ضعف السمع:

يُعد فقدان السمع أمرًا شائعًا مع التقدم في السن، حيث يُعاني ما يصل إلى 80% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا من ضعف السمع. يُعزى هذا عادةً إلى ضعف السمع الشيخوخي والتعرض للضوضاء العالية أو المواد السامة للأذن. تشمل الأسباب الأخرى العوامل الوراثية، والتهابات الأذن السابقة، والأسباب الجهازية مثل داء السكري، ومن المهم إجراء فحص بدني للقناة السمعية الخارجية لاستبعاد انحسار شمع الأذن كسبب لفقدان السمع.

إساءة معاملة كبار السن:

يمكن أن تشمل إساءة المعاملة الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي، والإهمال (الذي قد يشمل أيضًا إهمال الذات)، والتخلي، والاستغلال المالي. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 14% من البالغين يتعرضون لشكل من أشكال إساءة معاملة كبار السن، مع معدلات تصل إلى 40% لدى كبار السن المصابين بالخرف.

السلامة أثناء القيادة:

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 75% من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا ما زالوا يقودون، والعمر وحده ليس سببًا كافيًا لتوصية المريض بالتوقف عن القيادة. يزداد خطر القيادة لدى المرضى الذين تعرضوا للسقوط خلال العام أو العامين الماضيين، أو يعانون من ضعف بصري أو إدراكي، أو تعرضوا لحوادث تصادم سابقة، وخاصةً خلال الأشهر الستة السابقة، أو يتناولون أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وخاصةً البنزوديازيبينات، التي تزيد من خطر حوادث المرور بنسبة تصل إلى 50% في الأسبوع الأول بعد بدء العلاج.

الحفاظ على نمط حياة صحي:

النشاط البدني بالنسبة لكبار السن:

يمكن للنشاط البدني أن يقلل من خطر السقوط، ويعزز الاستقلالية، ويحسن الصحة العقلية. كما تشير الأدلة إلى أن ممارسة الرياضة قد تحسن الإدراك، على الرغم من عدم ثبوت فعاليتها في الوقاية من الخرف. ومن اللافت للنظر أنه حتى الشخص قليل الحركة الذي يبدأ بممارسة الرياضة في مرحلة متقدمة من العمر يجني فوائد مقارنةً بمن لا يمارسها. على الرغم من هذه الفوائد المعروفة للنشاط البدني، لا يلتزم العديد من كبار السن بالكمية الموصى بها من النشاط البدني الأسبوعي. توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHSS) بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني الهوائي متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط البدني عالي الشدة على مدار الأسبوع. لا تتطلب الأنشطة المعتدلة مثل المشي فحصًا من قبل طبيب الرعاية الأولية

إلا إذا ظهرت على المريض أعراض. مع ذلك، يُنصح المريض باستشارة طبيبه قبل ممارسة أي نشاط بدني شاق، والنظر في إجراء فحص طبي إذا كان معرضاً لخطر كبير للإصابة بمضاعفات قلبية وعائية. بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر السقوط، فقد ثبت أن التاي تشي يُحسن التوازن ويُقلل من خطر السقوط.

التغذية:

تُعدّ مراقبة وزن المرضى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً عنصراً مهماً في الرعاية الصحية الأولية. ويُستخدم مؤشر كتلة الجسم (BMI) غالباً لمراقبة السمنة وتقديم المشورة بشأنها لدى البالغين، ولدى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، تكون أدنى معدلات الوفيات لدى المرضى الذين يتراوح مؤشر كتلة جسمهم بين 25 و29. يمكن أن يؤدي فقدان كتلة العضلات إلى انخفاض الوزن، وبالتالي، فإن التركيز على فقدان الوزن وحده ليس عادةً الهدف لدى المرضى الأكبر سناً. ومع ذلك، فإن فقدان الوزن عند اقترانه بزيادة النشاط البدني قد يكون مفيداً لكبار السن الذين يعانون من السمنة لارتباطه بتحسين الأداء الوظيفي وكتلة العضلات.

تعاطي الكحول:

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر يستهلكون الكحول، ويستهلك ما يقرب من 15% منهم كميات أكبر من الكميات الأسبوعية الموصى بها. مع التقدم في السن، تزداد مخاطر الكحول على الصحة والوظائف، خاصةً عند تناوله مع أدوية معينة. توصي الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة بأن يقوم الأطباء بفحص تعاطي الكحول سنوياً لدى المرضى كبار السن.

الإقلاع عن التدخين:

يُعدّ السؤال عن استخدام التبغ وتقديم المشورة لكبار السن بشأن الإقلاع عنه جزءاً مهماً من الفحص الدوري. في حين أن معدلات استخدام التبغ أقل لدى كبار السن مقارنةً بالفئات الأصغر سناً، إلا أن هناك نتائج صحية كبيرة مرتبطة بالتدخين لدى كبار السن، بما في ذلك سرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض القلب. الإقلاع عن التدخين في أي عمر يُقلل من معدلات النتائج الصحية السيئة المرتبطة بالتدخين. هناك ندرة في البيانات المتعلقة بفوائد العلاج ببدائل النيكوتين لدى كبار السن؛ ومع ذلك، يمكن تجربة ذلك بالإضافة إلى الاستشارة كوسيلة لتحسين معدلات الإقلاع عن التدخين. يمكن استخدام عوامل أخرى مثل البوبروبيون والفارينيكلين، ولكن بحذر ومراقبة للأثار الجانبية نظراً لمخاطر إضافة أي أدوية لدى كبار السن.

الأمراض المنقولة جنسياً:

توصي فرقة العمل للخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) بإجراء فحص روتيني للأمراض المنقولة جنسياً لجميع البالغين حتى سن 65 عاماً، وفحص البالغين فوق سن 39 عاماً. على الرغم من المفاهيم الخاطئة الشائعة، لا يزال العديد من كبار السن (أكثر من 25%) نشطين جنسياً حتى سن الثمانين. من المهم سؤال كبار السن عن صحتهم وممارساتهم الجنسية سنوياً للمساعدة في تحديد عوامل الخطر للأمراض المنقولة جنسياً، ولتحديد التحديات المرتبطة بالضعف الجنسي التي يمكن أن تساعد التدخلات. توصي فرقة العمل للخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF) بالاستشارة السلوكية لجميع البالغين النشطين جنسياً.

المراجع:

- د. أنس سعيد العاصي, (2018), "صحة الفرد والمجتمع", جامعة حماه – كلية التمريض.
- هيفاء أورفه لي, (2019), " أكثر عشرة أمراض تكرر في سورية لعام 2019", موقع وزارة الصحة السورية.
- موقع وزارة الصحة السورية, برامج صحية, (تم الدخول 10 تشرين الأول 2022).
- عواد علي, أ., بإشراف: د. عواد, ع., د. حسن, ع., (2019), "أثر سلوكيات الصمت التنظيمي على الاحتراق الوظيفي – دراسة ميدانية على الشركة المصرية للاتصالات", جامعة عين شمس – كلية التجارة, (ص. 5-6).
- موقع بعيد, (2022), " دليل التعامل مع الاحتراق الوظيفي Occupational Burnout".
- د. عبد الفتاح عبدربه قرمان, (2018), "الصحة والبيئة", جامعة الإسراء.
- موقع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ, (2018), "أضرار التدخين على صحة الإنسان", المملكة العربية السعودية, (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- موقع منظمة الصحة العالمية, (2022), "الكحول", (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- موقع جامعة تكريت – كلية العلوم السياسية, "تأثير المخدرات ومخاطرها الصحية", (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- موقع منظمة الصحة العالمية, (2017), " الأمراض القلبية الوعائية", (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- موقع منظمة الصحة العالمية, (2021), " أنواع العدوى المنقولة جنسياً", (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- موقع منظمة الصحة العالمية, (2022), " السرطان", (تم الدخول 12 أيلول 2022).
- منظمة الصحة العالمية, (2015), " الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحالات الإصابة المحتملة أو المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية", إرشادات مبدئية WHO/MERS/IPC/15.1, (ص. 1-2).
- د. ابراهيم حسين حسني, (2019), "الادارة المستدامة للنفايات والمخلفات – دراسة بحثية عن التوجه العالمي لتوطين الاستدامة", مشاريع الاستثمار في اهداف التنمية المستدامة, (ص. 4-11).
- إدارة التعليم بمحافظة الخواة, "الصحة المدرسية", وزارة التعليم السعودية.
- وزارة التربية السورية, (2022), "تحويل التعليم في ظل الحروب والكوارث: التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية مثالا", ورقة عمل الجمهورية العربية السورية لقمة تحويل التعليم التي عقدت في نيويورك في أيلول 2022م على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
- World health Organization, (2017), "Primary Health Care", WHO Website, (Accessed 8 Nov. 2022).
- Coreil, J., Mul, J., D., (2018), "Anthropology and Primary Health Care", Routledge, (Section 1).
- Mona, M., (2016), "Key Elements of Primary Health Care (PHC)", Nursing Exercise Website, (Accessed 8 Nov. 2022).
- Dr. NAVPREET, (2018), "Indicators of Health", Govt. Medical College & Hospital, Chandigarh.
- Weiss, D., Tilin, F., J., (2018), "The Interprofessional Health Care Team Leadership and Development - SECOND EDITION", Jones & Bartlett Learning, (pp. 27-35).
- Faris, M., Ibrahim, R., Al-Mukhtar, S., (2021), "Anatomy of the urinary system", ResearchGate, (Lecture 6).
- Flores-Mireles, A., Walker, J., Caparon, M., Hultgren, S., (2015), "Urinary tract infections: Epidemiology, mechanisms of infection and treatment options", Nature Reviews Microbiology, (P. 1).

- NIH: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, (2017), **“Urologic Diseases”**, *U.S. Department of Health and Human Services*, (Accessed 3 Nov. 2022).
- Cassel, G., H., (2021), **“The Eye Book - A Complete Guide to Eye Disorders and Health – Second Edition”**, *Johns Hopkins University Press*, (Chapter 3).
- Balkany, T., J., Brown, K., D., (2017), **“THE EAR BOOK - A Complete Guide to Ear Disorders and Health”**, *Johns Hopkins University Press*, (P. 1).
- World Health Organization, (2017), **“Ear Health”**, (Accessed 6 Nov. 2022).
- Mays S., (2021), **“THE ARCHAEOLOGY OF HUMAN BONES Third edition”**, *Routledge*.
- Harvey, N., C., Cooper, C., (2018), **“OSTEOPOROSIS A Lifecourse Epidemiology Approach to Skeletal Health”**, *CRC Press*, (Cha. 1, P.1).
- Patel, V., B., Preedy, V., R., (2017), **“Biomarkers in Bone Disease”**, *Springer*, (P. 26).
- NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases ~ National Resource Center, **“Bone Health for Life: Health Information Basics for You and Your Family”**, *National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases*, (Accessed 20 Oct. 2022).
- Gray, S., H., (2015), **“The Circulatory System”**, *The Child’s World*, (Chapter 2).
- Dixit, A., Kumar, P., (2017), **“HYPERTENSION: AN OVERVIEW”**, *European Chemical Bulletin*, (pp. 393-395).
- Fischer, W., L., (2004), **“How to Fight Heart Disease & Win”**, *Agora Health Books*, (pp. 14-21).
- GOPALAN, C., KIRK, E., (2022), **“BIOLOGY OF CARDIOVASCULAR AND METABOLIC DISEASES”**, *Academic Press*, (P. 86).
- Sizer, F., Whitney, E., (2023), **“Nutrition Concepts & Controversies 16e”**, *Cengage Learning, Inc.*, (pp. 103-299)
- U.S. Department of Agriculture (USDA), U.S. Department of Health and Human Services (HHS), (2020), **“Make Every Bite Count with the Dietary Guidelines Ninth Edition”**, *Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. 9th Edition*, (P. 18).
- Bray, G., A, Temple, N., J., Wilson, T., (2022), **“Nutrition Guide for Physicians and Related Healthcare Professionals”**, *Springer*, (P.3).
- Doley, J., Marian, M., J., (2023), **“Adult Malnutrition Diagnosis and Treatment”**, *CRC Press*, (pp. 18-25).
- Teitelbaum, J., (2020), **“From Fatigued to Fantastic! – A Clinical Proven Program to Regain Vibrant Health and Overcome Chronic Fatigue and Fibromyalgia – Fourth Edition”**, *An imprint of Penguin Random House*.
- Whitten, A., (2022), **“Eat for Energy: How to Beat Fatigue, Supercharge Your Mitochondria, and Unlock All-Day Energy”**, *Hay House*.
- Harvard Business Review Press, (2021), **“HBR guide to beating burnout”**, *Harvard Business School*, (pp. 67-68).
- Leschziner, G., (2022), **“OXFORD HANDBOOK OF Sleep Medicine”**, *Oxford University Press*, (pp. 33 / 70 / 74).
- Gray, S., H., (2015), **“The Respiratory System”**, *The Child’s World*, (pp. 6-13).

- Racz, L., Yamamoto, D., P., Eninger, R., M., (2018), **“Handbook of Respiratory Protection Safeguarding against Current and Emerging Hazards”**, *CRC Press*, (pp. 11-16 / 336-338).
- Khatri, S., B., Pennington, E., J., (2022), **“Lung Health and the Exposome How Environmental Factors Influence Lung Health”**, *Springer*, (pp. 52-67).
- Poitras, P., CO-Editors: Bilodeau, M., Bouin, M., Ghia, J., (2022), **“The Digestive System: From Basic Sciences to Clinical Practice”**, *Springer*, (pp. 5/33/69/127/174/207/227/251).
- Khanna, S., **“Digestive Health – How to prevent and treat common stomach and gut problems – Fourth Edition”**, *Mayo Clinic Press*, (Chapter 3).
- Waite, C., E., (1951), **“A HANDBOOK OH PERSONAL HYGIENE AND GOOD GROOMING”**, *the Faculty of the School of Education - the University of Southern California*, (pp. 10-46).
- Rovesti, M., Fioranelli, M., Petrelli, P., Satolli, F., Roccia, M., Gianfaldoni, S., Tchernev, G., Wollina, U., Lotti, J., Feliciani, C., Lotti, T., (2018), **“Health and Illness in History, Science and Society”**, *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, (pp. 163–165).
- Conti, A., (2018), **“Historical evolution of the concept of health in Western medicine”**, *Acta Biomed*, (pp. 352-354).
- Scrimshaw, S. C., Lane, S. D., Rubinstein, R. A., Fisher, J., (2022), **“The SAGE Handbook of Social Studies in Health and Medicine”**, *SAGE Publications*, (P. 19).
- World Health Organization Health promotion glossary. WHO/HPR/HEP/98.1 Distr.: Limited. WHO (1998)
- World Health Organization, **A glossary of technical terms on the economics and finance of health services”**
- Cameron, N., Schell, L., (2022), **“Human Growth and Development Third Edition”**, *Academic Press*, (P. 245)
- Sandage, S. J., Rupert, D., Stavros, G. S., Devor N. G., (2020), **“Relational Spirituality in Psychotherapy: Healing Suffering and Promoting Growth”**, *American Psychological Association*, (P. 3).
- World Health Organization Website, (2019), **“Communicable and noncommunicable diseases, and mental health”**, (Accessed 12 Sep. 2022).
- Arora, C., Sinha, B., Malhotra, A., Ranjan, P., (2017), **“Development and Validation of Health Education Tools and Evaluation Questionnaires for Improving Patient Care in Lifestyle Related Diseases”**, *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, (pp. 6/9).
- Bruening, R. A., Coronado, F., Auld, M. E., Benenson, G., Simone, P. M., (2018), **“Health Education Workforce: Opportunities and Challenges”**, *National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion*, (pp. 1\2).
- Leila Salem, L., (2024), **“The negative impact of inadequate housing on public health”**, *PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2024) 61(11): 2156-2163 ISSN:1553-6939*, (pp. 2156-2161).
- Yang, W., (2021), **“Prevention and Control of Infectious Diseases in BRI Countries”**, *Springer – ISBN 978-981-33-6958-0*, (pp. 35-57).

- Srinath Reddy, K., (2015), “**11.2 Prevention and control of non-communicable diseases**”, *Oxford Textbook of Global Public Health*, 6 ed., Oxford Academic, (pp. 1476–1483).
- Ricci, S., S., (2017), “**ESSENTIALS of Maternity, Newborn, AND Women’s Health Nursing FOURTH EDITION**”, Wolters Kluwer, LCCN 2016021183 - ISBN 9781451193992.
- Albuquerque Public Schools, (2021), “**School Design Standards**”, *APS Facilities Design and Construction*.
- Aronson, S., Shope, T., (2020), “**Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools A Quick Reference Guide, 5th Edition**”, *American Academy of Pediatrics*, (pp. 6-8).
- Ross, J., Mann, S., Whiddon, K., (2023), “**Rural Landscapes of Community Health the Community Health Assessment Sustainable Education (CHASE) Model in Action**”, Springer - ISBN 978-3-031-43200-2, (pp. 2-117).
- Bollans, I., Preece, D., (2024), “**Occupational Health & Safety Solutions - Practical Compliance**”, *Informa Law from Routledge - Taylor & Francis Group*, (pp. 1-21).
- Busby-Whitehead, J., Durso, S., C., Arenson, Ch., Elon, R., Palmer, M., H., Savage, K., D., (2022), “**Reichel’s Care of the Elderly - Clinical Aspects of Aging - Eighth Edition**”, Cambridge University Press, (pp. 1-37).

1447-1448 هـ

2025-2026 م